

Buku Ajar
**KEPERAWATAN
MATERNITAS**

Hairunnisa • Yuli Erlina • Suryani Hartati
Sestu Retno Dwi Andayani • Ety Nurhayati • Bestfy Anitasari

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.



Buku Ajar :

Keperawatan Maternitas

Penulis:

Ns. Hairunnisa, S.Kep., M.Kep.

Ns. Yuli Erlina, S.Kep., M.Kes.

Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.

Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat

Ns. Bestfy Anitasari, M.Kep.

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.



Buku Ajar: Keperawatan Maternitas

Penulis:

Ns. Hairunnisa, S.Kep., M.Kep.
Ns. Yuli Erlina, S.Kep., M.Kes.
Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.
Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat
Ns. Bestfy Anitasari, M.Kep.

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-52-7

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar yang berjudul “Buku Ajar Keperawatan Maternitas” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan maternitas secara komprehensif, khususnya pada masa persalinan, nifas, kegawatdaruratan maternal, perawatan neonatus, serta perencanaan pulang pasca persalinan.

Keperawatan maternitas merupakan salah satu bidang keilmuan penting dalam pendidikan keperawatan karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Dalam praktiknya, perawat dituntut tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan proses keperawatan secara tepat, aman, humanis, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai asuhan keperawatan pada ibu dan bayi dalam berbagai kondisi klinis.

Materi dalam buku ini disajikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Bab 1 membahas asuhan keperawatan persalinan kala I, meliputi pengkajian, pemantauan kemajuan persalinan, kebutuhan ibu bersalin, serta intervensi keperawatan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan ibu. Bab 2 menguraikan asuhan keperawatan kala IV dan nifas dini, dengan penekanan pada observasi kondisi ibu setelah persalinan, pencegahan komplikasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar ibu pada masa awal nifas.

Selanjutnya, Bab 3 membahas asuhan keperawatan nifas lanjut, khususnya laktasi dan kesehatan mental ibu. Pembahasan ini penting karena keberhasilan menyusui dan kondisi psikologis ibu sangat memengaruhi kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga. Bab 4 mengangkat kegawatdaruratan maternal, terutama perdarahan postpartum dan syok, yang memerlukan kemampuan perawat dalam melakukan deteksi dini, tindakan cepat, serta kolaborasi dengan tim kesehatan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas maternal.

Bab 5 membahas keperawatan neonatus, mencakup adaptasi bayi baru lahir dan asuhan dasar yang diperlukan untuk mendukung transisi kehidupan bayi dari intrauterin ke ekstrauterin. Adapun Bab 6 menguraikan perencanaan pulang dan pelayanan kesehatan reproduksi pasca persalinan, termasuk edukasi kepada ibu dan keluarga, tanda bahaya masa nifas, perawatan bayi di rumah, konseling menyusui, serta perencanaan kesehatan reproduksi setelah persalinan.

Buku ajar ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, maupun praktik klinik. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh dosen dan praktisi keperawatan sebagai bahan referensi dalam memperkuat pemahaman mengenai asuhan keperawatan maternitas yang berorientasi pada keselamatan pasien, pendekatan keluarga, dan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan ibu serta bayi.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keperawatan maternitas serta mendukung terbentuknya calon perawat yang kompeten, profesional, beretika, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB 1 ASUHAN KEPERAWATAN PERSALINAN KALA I.....	1
A. Pendahuluan.....	5
B. Definisi dan Tahapan Kala 1.....	5
C. Tanda dan Gejala Kala 1.....	5
D. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan (5P).....	5
E. Manajemen Asuhan Keperawatan (Kala 1).....	5
F. RINGKASAN.....	29
Referensi	33
BAB 2 ASUHAN KEPERAWATAN KALA IV DAN NIFAS DINI	34
A. DEFINISI KALA IV.....	38
B. ADAPTASI FISILOGIS PADA KALA IV.....	38
C. ADAPTASI PSIKOLOGIS PADA KALA IV.....	39
D. PATOFISIOLOGI KALA IV.....	39
E. KOMPLIKASI KALA IV.....	39
F. ASUHAN KEPERAWATAN KALA IV.....	40
G. DEFINISI NIFAS DINI.....	42
H. ADAPTASI FISILOGIS.....	42
I. ADAPTASI PSIKOLOGIS NIFAS DINI.....	42
J. PATOFISIOLOGI NIFAS DINI.....	43
K. KOMPLIKASI NIFAS DINI.....	43
L. PARAMETER KLINIS PRIORITAS KALA IV DAN NIFAS DINI.....	43
M. IDENTIFIKASI MASALAH NIFAS DINI.....	44
N. Ringkasan.....	67
Referensi	72
BAB 3 ASUHAN KEPERAWATAN NIFAS LANJUT: LAKTASI DAN KESEHATAN MENTAL IBU	73
A. Konsep Dasar Masa Nifas.....	78
B. Adaptasi Fisiologis Dan Psikologis.....	78
C. Tanda dan gejala pada masalah psikologis / mental ibu post partum.....	79
D. Manajemen Laktasi.....	80

E. Asuhan Keperawatan Berbasis Sdki–Slki–Siki	81
F. KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).....	88
G. Dokumentasi.....	89
H. RINGKASAN	112
Referensi	117

BAB 4 KEGAWATDARURATAN MATERNAL: PERDARAHAN POSTPARTUM DAN SYOK	119
A. Teori	123
B. Asuhan Keperawatan	126
C. Ringkasan.....	144
D. Latihan Evaluasi Bab.....	146
Referensi	149

BAB 5 KEPERAWATAN NEONATUS: ADAPTASI BAYI BARU LAHIR DAN ASUHAN DASAR	150
A. PENDAHULUAN	154
B. TUJUAN INSTRUKSIONAL	157
C. URAIAN MATERI	157
D. MASALAH KEPERAWATAN NEONATUS	163
E. INTEGRASI DENGAN DIAGNOSIS SDKI.....	171
F. Pendekatan Asuhan Keperawatan Neonatus.....	176
G. PENDEKATAN ASUHAN KEPERAWATAN MODERN PADA NEONATUS	176
H. PATHWAY KLINIS NEONATUS	182
I. PENUTUP.....	185
J. RINGKASAN	211
Referensi	216

BAB 6 PERENCANAAN PULANG DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PASCA PERSALINAN	219
A. Definisi dan Prinsip Perencanaan Pulang	223
B. Tujuan Perencanaan Pulang.....	225
C. Komponen Utama Perencanaan Pulang.....	227
D. Waktu dan Tahapan Perencanaan Pulang	230
E. PENGKAJIAN IBU SEBELUM PULANG	232
F. PENGKAJIAN BAYI SEBELUM PULANG	239
G. LAKTASI DAN MENYUSUI DALAM PERENCANAAN PULANG	244
H. KESIAPAN PSIKOLOGIS DAN SOSIAL	249

I. PERAWATAN DIRI DI RUMAH	254
J. TANDA BAHAYA YANG HARUS DIWASPADAI.....	258
K. Konsep Pelayanan Kesehatan Reproduksi Postpartum.....	259
L. Keluarga Berencana Pascapersalinan.....	263
M. Jarak Kehamilan dan Perencanaan Reproduksi	265
N. TINDAK LANJUT DAN SISTEM RUJUKAN	266
O. DOKUMENTASI DAN ASPEK LEGAL ETIK.....	272
P. PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PERENCANAAN PULANG	277
Q. RINGKASAN	300
Referensi	305
Profil Penulis.....	308

BAB 1

ASUHAN KEPERAWATAN PERSALINAN KALA I

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Asuhan Keperawatan Persalinan Kala I	1.1 Melaksanakan pemantauan kemajuan kala I dan pencatatan kemajuan persalinan secara sistematis.	1.2 Memberikan intervensi kenyamanan, pencegahan infeksi, dan komunikasi terapeutik pada kala I.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE pengkajian + checklist	Kelengkapan komponen pengkajian; ketepatan stratifikasi risiko; ketepatan prioritas masalah (skor checklist)	15	Checklist OSCE; format pengkajian
CPMK-4	Tugas rencana asuhan (care plan)	Kesesuaian masalah–luaran–intervensi; keterukuran luaran; ketepatan prioritas; konsistensi rasional	15	Dokumen care plan terstruktur
CPMK-5	OSCE/simulasi keterampilan + penilaian komunikasi	Ketepatan langkah tindakan; keselamatan prosedur; kualitas komunikasi terapeutik; kualitas edukasi (teach-back)	20	Checklist keterampilan; rekaman/video simulasi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat ≤50% elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat ≥85% elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien & etik pada skenario maternitas	Identifikasi risiko & tindakan aman ≤50%; keputusan tidak sesuai prinsip.	Identifikasi 51–69%; tindakan aman ada namun belum lengkap.	Identifikasi 70–84%; keputusan aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	Identifikasi ≥85%; keputusan aman, preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak terencana ($\leq 50\%$ memadai).	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan	Langkah benar/aman	Langkah benar/aman 51–	Langkah benar/aman 70–	Langkah benar/aman $\geq 85\%$;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
pelaksanaan intervensi keperawatan	≤50%; terdapat tindakan berisiko.	69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	84%; pelaksanaan aman dan efektif.	sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi (≤50%).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal (≥85%).

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah (≤50% keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif (≥85% tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif (≤50% sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan (≥85%).

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data (≤50% komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data (≥85%).
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat (≤50% komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur (≥85%).

Teori Dasar

A. Pendahuluan

Persalinan Kala 1 (kala pembukaan) adalah tahap pertama dalam proses persalinan, dimulai dari kontraksi uterus yang teratur hingga pembukaan lengkap. Ini adalah tahap terlama dalam persalinan, di mana peran perawat maternitas sangat krusial dalam memberikan dukungan fisik dan emosional, serta memantau kesejahteraan ibu dan janin untuk mencegah komplikasi.

B. Definisi dan Tahapan Kala 1

Kala 1 dibagi menjadi dua fase:

Fase Laten: Dimulai dari awal kontraksi hingga pembukaan serviks mencapai (atau pada pedoman terbaru). Kontraksi masih ringan, tidak terlalu sering, dan berlangsung selama 7-8 jam.

Fase Aktif: Dimulai dari pembukaan hingga pembukaan lengkap (). Kontraksi lebih kuat, lebih lama, dan frekuensi meningkat.

C. Tanda dan Gejala Kala 1

1. Kontraksi Uterus (His): Teratur, meningkat frekuensi dan intensitasnya.
2. Penipisan dan Pembukaan Serviks: Diperiksa melalui vaginal toucher (periksa dalam).
3. Pengeluaran Lendir Darah (Show): Pecahnya pembuluh darah kapiler di serviks.
4. Pecah Ketuban: Bisa terjadi spontan atau sengaja dipecahkan (amniotomi).

D. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan (5P)

Keberhasilan kala 1 dipengaruhi oleh:

1. Passenger: Janin dan plasenta.
2. Passage: Jalan lahir (panggul ibu).
3. Powers: Kekuatan kontraksi dan mengejan.
4. Position: Posisi ibu saat bersalin.
5. Psychological Response: Kesiapan psikologis ibu dan dukungan keluarga.

E. Manajemen Asuhan Keperawatan (Kala 1)

1. Pengkajian (Assessment)
 - a. Anamnesa: Riwayat kehamilan, tanda-tanda inpartu (nyeri perut, keluar lendir darah/air ketuban).

- b. Pemeriksaan Fisik: Tanda-tanda vital, pemeriksaan Leopold (posisi janin), DJJ (Denyut Jantung Janin).
 - c. Pemeriksaan Dalam (VT): Menilai pembukaan, penipisan, posisi serviks, selaput ketuban, dan penurunan kepala.
 - d. Partograf: Penggunaan alat pantau persalinan.
2. Diagnosa Keperawatan
- a. Nyeri melahirkan berhubungan dengan dilatasi serviks dan kontraksi uterus.
 - b. Ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang proses persalinan.
 - c. Risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kurang asupan oral, peningkatan metabolisme.
3. Intervensi Keperawatan (Manajemen)
- a. Manajemen Nyeri: Mengajarkan teknik relaksasi, napas dalam, teknik massage effleurage (pijatan ringan di punggung/perut) untuk mengurangi nyeri.
 - b. Pendampingan: Memberikan dukungan psikologis bersama keluarga.
 - c. Monitoring: Memantau DJJ, kontraksi, dan TTV setiap 30-60 menit.
 - d. Pemenuhan Kebutuhan: Membantu posisi nyaman ibu, memfasilitasi kebutuhan nutrisi/hidrasi, dan memfasilitasi ibu untuk berkemih secara mandiri (kandung kemih penuh dapat menghambat penurunan kepala).
4. Evaluasi
- a. Ibu mampu beradaptasi dengan nyeri.
 - b. Tidak terjadi komplikasi (misal: gawat janin).
 - c. Persalinan berlanjut ke kala 2 (pembukaan lengkap) dengan lancar.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Seorang Perempuan, umur 24 tahun, G1P0A0, datang ke ruang bersalin pukul 14.00 WIB. Ia mengeluh mulas yang kuat dan sering sejak 4 jam yang lalu. Ibu tampak sangat tegang, menggenggam tangan suaminya dengan kencang, dan berulang kali bertanya, "Apakah bayi saya baik-baik saja? Kenapa rasanya sangat sakit?"

Hasil Pengkajian:

- TTV: TD 120/80 mmHg, Nadi 88 x/menit, Suhu 36,8°C.
- Abdomen: Kontraksi 3x dalam 10 menit, durasi 35 detik.
- DJJ: 148 x/menit (Reguler).
- Pemeriksaan Dalam (VT): Portio tipis lunak, pembukaan 5 cm, ketuban utuh (+), penurunan kepala Hodge II.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi :

1. Berada dalam persalinan Kala 1 fase apakah kasus tersebut?
2. Bagaimana status kesejahteraan janin saat ini, jelaskan?
3. Sebutkan diagnosa keperawatan utama pada kasus tersebut?
4. Sebutkan rencana keperawatan non-farmakologis (Asuhan Sayang Ibu) yang paling tepat pada kasus tersebut?
5. Pada pukul berapakah perawat harus melakukan pemeriksaan dalam (VT) selanjutnya sesuai standar?

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Kunci Jawaban & Panduan Fasilitator (Untuk Dosen):

1. Jawaban 1: Fase Aktif (Karena pembukaan sudah 4 cm).
2. Jawaban 2: Sejahtera/Normal (DJJ 148 x/menit berada dalam rentang normal 120-160 x/menit).
3. Jawaban 3: Nyeri Melahirkan b.d dilatasi serviks (atau Ansietas b.d kurang terpapar informasi/krisis situasional).
4. Jawaban 4: Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, Menganjurkan posisi miring kiri atau berjalan-jalan (mobilisasi), Memberikan dukungan emosional dan hidrasi (minum).
5. Jawaban 5: Pukul 18.00 WIB (4 jam setelah pemeriksaan awal).

Catatan untuk Penulis:

Aktivitas ini memastikan mahasiswa tidak hanya "hafal langkah", tetapi paham logika di balik setiap tindakan. Keberhasilan di tahap ini sangat menentukan kelancaran mereka saat melakukan simulasi fisik di Skill Lab nanti.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala 1

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Tujuan: Mahasiswa mendemonstrasikan asuhan Kala 1 dengan mengintegrasikan keterampilan teknis, komunikasi empati, dan prinsip keselamatan pasien.

1. Skenario Simulasi

Konteks: Seorang Perempuan, umur 24 tahun, G1P0A0, datang ke ruang bersalin pukul 14.00 WIB. Mengeluh mulas kuat dan sering sejak 4 jam yang lalu. Ibu tampak sangat tegang, menggenggam tangan suaminya dengan kencang, dan bertanya: "Apakah bayi saya baik-baik saja? Kenapa rasanya sangat sakit?"

2. Panduan Langkah "Naik Tangga" (Prosedur)

Mahasiswa harus mendemonstrasikan 3 aspek utama secara simultan:

A. Urutan Tindakan (Flow)	B. Komunikasi Empati	C. Prinsip Keselamatan (Safety)
Pemeriksaan Abdomen: Melakukan Leopold I-IV untuk mencari punggung janin (Punctum Maximum).	Menjawab kecemasan ibu: "Ibu, saya periksa dulu ya. Kita akan pastikan kondisi bayi Ibu sehat."	Mencuci tangan 6 langkah sebelum menyentuh perut ibu.
Pemantauan DJJ: Menghitung DJJ menggunakan Doppler/Laennec selama 1 menit penuh.	Menginformasikan hasil: "Alhamdulillah, detak jantung bayi Ibu normal, 144 kali per menit. Bayinya sehat, Bu."	Memastikan alat (Doppler) bersih dan menggunakan gel secukupnya.
Manajemen Nyeri: Menginstruksikan ibu	Mengarahkan suami: "Bapak, tolong bantu usap	Membantu ibu merubah posisi ke miring kiri untuk

teknik napas dalam saat kontraksi datang.	punggung Ibu pelan-pelan ya agar Ibu lebih rileks."	mencegah kompresi vena cava.
Pemeriksaan Dalam (VT): Melakukan VT untuk menilai pembukaan (Hasil simulasi: 5 cm).	Menjelaskan prosedur: "Ibu, saya akan periksa jalan lahir ya. Sedikit tidak nyaman, silakan tarik napas panjang."	Critical: Melakukan vulva hygiene dan menggunakan handscoon steril dengan teknik yang benar.

3. Instruksi Kerja untuk Mahasiswa

- Observasi Awal: Jangan langsung melakukan tindakan fisik. Respon dulu kecemasan ibu secara verbal.
- Demonstrasi Alat: Siapkan phantom panggul dan bayi. Lakukan VT dengan mata tertutup (opsional) untuk melatih sensitivitas jari menentukan pembukaan.
- Integrasi Partograf: Setelah simulasi tindakan selesai, langsung plot hasil (pembukaan 5 cm, DJJ 144, Kontraksi 3x10") ke lembar Partograf.

4. Catatan untuk Penulis & Dosen (Instruktur)

- Jangan Langsung Ujian: Gunakan sesi ini sebagai Latihan Terbimbing. Jika mahasiswa melakukan kesalahan (misal: lupa cuci tangan atau jawaban ketus pada ibu), instruktur boleh menghentikan simulasi sejenak untuk memberikan koreksi (Immediate Feedback).
- Membangun Refleks: Mahasiswa sering "lupa bicara" saat fokus melakukan tindakan teknis (VT/DJJ). Tekankan bahwa pada manusia nyata, diamnya perawat menambah kecemasan pasien.
- Keamanan Pasien adalah Prioritas: Jika mahasiswa melanggar prinsip steril (menyentuh area tidak steril dengan handscoon steril), mereka harus mengulang langkah tersebut dari awal. Ini menanamkan disiplin Patient Safety.

Checklist Evaluasi Mandiri (Self-Reflect)

Setelah simulasi, mahasiswa menjawab:

- Apakah saya sudah menjawab pertanyaan ibu tentang kondisi bayinya?
- Apakah saya menjaga kesterilan saat melakukan pemeriksaan dalam?
- Apakah saya sudah membantu ibu melakukan teknik manajemen nyeri?

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Persalinan Kala 1

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
- OSCE logis, bukan dipaksakan

1. Level: KNOWS / KNOWS HOW (Kognitif & Analisis)

Metode: Self-check Mandiri + Analisis Mini-case Tertulis.

Self-Check (Kesiapan Teori):

- a. Saya dapat menjelaskan perubahan fisiologis serviks pada pembukaan 5 cm.
- b. Saya tahu bahwa cemas/tegang dapat menghambat kontraksi (teori fear-tension-pain).
- c. Saya memahami prinsip aseptik saat melakukan pemeriksaan dalam (VT).

Analisis Mini-Case (Penalaran Klinis):

- Data Fokus: Ibu tegang, genggam tangan suami, bertanya "bayi saya baik?".

Pertanyaan Analisis:

- Apa diagnosis keperawatan prioritas? (Jawaban: Ansietas atau Nyeri Melahirkan).
- Mengapa ibu bertanya tentang kondisi bayinya? (Jawaban: Respon psikologis primigravida terhadap nyeri dan ketidaktauhan).
- Apa interpretasi jika kontraksi 3x dalam 10 menit durasi 35 detik? (Jawaban: Adekuat untuk fase aktif).

2. Level: SHOWS HOW (Psikomotor & Performa)

- Metode: OSCE (Objective Structured Clinical Examination) — Simulasi pada Phantom.
- Skenario Ujian: "Lakukan pengkajian janin dan manajemen nyeri pada klien yang sedang cemas dan kesakitan."

Rubrik Penilaian (Checklist OSCE):

Komponen	Indikator Kompetensi (Skor 0-2)	Bobot
Komunikasi	Merespon Kecemasan: Menenangkan ibu, menjawab "Bayi Ibu akan kita periksa, mari kita dengarkan detak jantungnya bersama."	20%
Safety (Critical)	Teknik Aseptik: Cuci tangan dan menggunakan handscoon steril dengan benar saat melakukan VT.	Wajib
Skill Teknis	Pemeriksaan DJJ: Menghitung DJJ 1 menit penuh (Normal: 120-160x/m) untuk membuktikan bayi baik-baik saja.	30%

Manajemen Nyeri	Edukasi & Tindakan: Mengajarkan napas dalam dan meminta suami melakukan pijatan effleurage (pijatan ringan di perut).	30%
Dokumentasi	Partograf: Melakukan plotting data pembukaan (5 cm) dan DJJ ke dalam Partograf.	20%

Catatan Penulis (Pedoman Evaluasi):

- Integrasi Respon: Mahasiswa dianggap kompeten jika sambil melakukan tindakan teknis (pasang Doppler), mereka tetap berkomunikasi menenangkan ibu. Tidak boleh diam saja.
- Tangga Kompetensi: Jika mahasiswa gagal di level Knows How (salah menginterpretasikan DJJ normal), mereka tidak diizinkan maju ke OSCE untuk mencegah malpraktik simulasi.
- Bukti Performa: Hasil OSCE ini (berupa lembar penilaian ber-TTD penguji) menjadi bukti fisik pertama dalam Portofolio mahasiswa sebelum praktik ke pasien nyata.

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

No	Critical Items (Keamanan Pasien & Janin)	Mengapa Wajib?
1	Prinsip Sterilitas VT: Melakukan vulva hygiene dan menggunakan sarung tangan steril dengan teknik yang benar (tidak terkontaminasi).	Mencegah infeksi asendens pada ibu dan janin.
2	Akurasi Hitung DJJ: Menghitung DJJ selama 1 menit penuh dan menyebutkan angka yang akurat.	Deteksi dini gawat janin; durasi <1 menit berisiko salah interpretasi.
3	Interpretasi Normal/Abnormal: Mampu menyatakan apakah DJJ normal (120-160x/m) atau tidak.	Dasar pengambilan keputusan klinis (Eskalasi).
4	Ketepatan Plotting Partograf: Memasukkan data pembukaan dan DJJ pada grafik yang benar (Garis Waspada).	Mencegah keterlambatan penanganan persalinan macet.
5	Identifikasi Tanda Bahaya: Merespon jika ditemukan air ketuban hijau/mekonium atau DJJ abnormal.	Keselamatan nyawa janin.

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Persalinan Kala 1
3	Waktu	13 Menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian janin (DJJ), pemantauan kontraksi, manajemen nyeri non-farmakologis, dan edukasi teknik relaksasi pada ibu bersalin.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian (DJJ & His) 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi (Manajemen Nyeri) 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Aman dan nyaman 2. Psikososial 3. Seksualitas dan Reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan, umur 24 tahun, G1P0A0, datang ke ruang bersalin pukul 14.00 WIB. Mengeluh mulas kuat dan sering sejak 4 jam yang lalu. Ibu tampak sangat tegang, menggenggam tangan suaminya dengan kencang, dan bertanya: "Apakah bayi saya baik-baik saja? Kenapa rasanya sangat sakit?" TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus (DJJ dan Kontraksi) pada manekin. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan (intervensi) pada lembar jawab. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi teknik relaksasi napas dalam serta pengaturan posisi untuk mengurangi nyeri kepada pasien.
8	Instruksi Untuk Penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan, umur 24 tahun, G1P0A0, datang ke ruang bersalin pukul 14.00 WIB. Mengeluh mulas kuat dan sering sejak 4 jam yang lalu. Ibu tampak sangat tegang, menggenggam tangan suaminya dengan kencang, dan bertanya: "Apakah bayi saya baik-baik saja? Kenapa rasanya sangat sakit?" TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus (DJJ dan Kontraksi) pada manekin. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan (intervensi) pada lembar jawab. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi teknik relaksasi napas dalam serta pengaturan posisi untuk mengurangi nyeri kepada pasien.

		Instruksi Untuk Penguji 1. Menilai ketepatan pengkajian DJJ selama 1 menit penuh (Normal: 144x/mnt) dan penghitungan kontraksi (3x10 menit, durasi 35 dtk). 2. Menilai Diagnosis: Nyeri Melahirkan atau Ansietas. 3. Menilai Perencanaan: Monitor DJJ, monitor kontraksi, fasilitasi posisi miring kiri, dan ajarkan teknik non-farmakologis. 4. CRITICAL ITEM: Menilai ketepatan menghitung DJJ (harus 1 menit) dan respon terapeutik terhadap kecemasan ibu. 5. Menilai edukasi: Napas dalam saat puncak kontraksi dan melibatkan suami untuk massage punggung. 6. Monitor perilaku profesional (Sopan, menjaga privasi).
9	Instruksi Klien Standar (KS)	Hal – hal yang perlu di cantumkan diantaranya 1. Identitas: Perempuan, 24 th, G1 (hamil pertama). KS berperan sebagai pasien (atau pendamping jika manekin digunakan sebagai pasien utama). 2. Riwayat: Mulas sejak pagi, keluar lendir darah, belum keluar air ketuban. 3. Ekspresi: Tampak meringis kesakitan setiap 3 menit, wajah cemas, memegang tangan suami erat. 4. Respon: Jika ditanya gerakan janin, jawab "Masih terasa aktif". Jika ditanya nyeri, jawab "Sakit sekali di perut bawah menjalar ke pinggang". 5. Harapan: Ingin bayinya selamat dan nyeri berkurang.
10	Setting station	Ruang Bersalin (VK) 1. Tempat tidur dengan manekin panggul/ibu hamil. 2. Kursi untuk suami (KS/Pendamping). 3. Meja dan kursi penguji. 4. Wastafel/Handrub di dekat pintu. 5. Troli alat di samping tempat tidur.
11	Peralatan yang di butuhkan	1. Doppler atau Stetoskop Laennec & Jelly. 2. Jam tangan dengan jarum detik (Penting). 3. Lembar Partograf & Alat tulis. 4. Handrub & Sarung tangan bersih. 5. Lembar balik edukasi (opsional). Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Hairunnisa S.Kep., M.Kep
13	Referensi	• Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2019). Maternity and Women's Health Care (12th ed.). Missouri: Elsevier. (Fokus pada asuhan keperawatan maternitas holistik). • Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. • Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

		• Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. • Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
--	--	--

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI TEHNIK RELAKSASI PADA PERSALINAN KALA 1

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra-interaksi				
1	Mengecek catatan medis (G/P/A, usia kehamilan, hasil VT terakhir)				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Handrub/sabun cuci tangan b. Media edukasi (lembar balik/brosur relaksasi) c. Jam dengan jarum detik (untuk kontraksi) d. Minyak pijat/lotion (bila perlu untuk effleurage)				
3	Mencuci tangan 6 langkah				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (Nama dan Tanggal Lahir/Umur) secara aktif				
7	Menyampaikan maksud, tujuan, dan kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				

9	Memulai tindakan dengan baik (Bismillah/Berdoa)				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu (Tutup sampiran)				
C	Tahap Kerja (Sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Mengidentifikasi tingkat nyeri, lokasi nyeri, dan kecemasan ibu				
13	Mengidentifikasi frekuensi dan durasi kontraksi serta kesejahteraan janin (DJJ)				
14	Mengidentifikasi kesiapan ibu dan pendamping (suami) menerima edukasi				
15	Mengatur posisi ibu yang nyaman (Miring kiri sangat disarankan)				
16	Menjelaskan tujuan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri dan ketegangan otot				
17	Mendemonstrasikan Teknik Napas Dalam: Tarik napas lewat hidung (3-4 dtk) dan hembuskan lewat mulut pelan (6 dtk)				
18	Menganjurkan ibu melakukan napas dalam setiap kali kontraksi datang				
19	Mendemonstrasikan Teknik Pijatan Punggung (Counter-pressure): Menekan area sakrum saat kontraksi memuncak				
20	Mendemonstrasikan Teknik Usapan Perut (Effleurage): Usapan ringan melingkar pada perut bawah				

21	Menjelaskan pentingnya tetap bergerak/mobilisasi (goyang panggul/berjalan bila mampu)				
22	Melibatkan suami dalam melakukan pijatan atau memberikan dukungan verbal				
23	Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga asupan nutrisi dan hidrasi (minum di sela mulas)				
24	Menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan: ketuban pecah berbau/hijau, perdarahan hebat, atau pusing hebat				
25	Meminta ibu mengulang kembali penjelasan/napas dalam yang diajarkan				
26	Meminta suami mendemonstrasikan kembali teknik pijatan yang diajarkan				
27	Merapikan pasien dan lingkungan sekitar				
28	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons ibu secara subjektif (skala nyeri) dan objektif (wajah rileks)				
31	Memberikan reinforcement positif (Pujian atas kerjasama ibu)				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya (Misal: Pemantauan pembukaan 4 jam lagi)				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				

E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, tindakan relaksasi yang diberikan, respon ibu, dan kemajuan persalinan				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif, dan empati				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PERSALINAN KALA 1

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Melakukan pengkajian fokus: Kontraksi (frekuensi, durasi), Denyut Jantung Janin (DJJ) 1 menit penuh, pemeriksaan dalam (pembukaan, ketuban, Hodge), dan respon nyeri/cemas ibu.					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan relaksasi, mendemonstrasikan teknik napas dalam (hidung-mulut) saat kontraksi, melakukan/mengajarkan pijatan punggung (counter-pressure), serta menjelaskan tanda bahaya persalinan.					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PERSALINAN KALA 1

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada ibu bersalin Kala 1, meliputi: Pemantauan Kemajuan Persalinan: Mengkaji kontraksi uterus (frekuensi, durasi, dan intensitas) secara tepat. Kesejahteraan Janin: Melakukan pemeriksaan Denyut Jantung Janin (DJJ) selama 1 menit penuh (akurat dan sistematis). Status Fisik Ibu: Melakukan pemeriksaan dalam (Vaginal Toucher) untuk menilai pembukaan serviks, penipisan, status ketuban, dan penurunan kepala (Hodge). Kebutuhan Dasar: Mengidentifikasi asupan nutrisi/hidrasi, pengeluaran urin (kandung kemih), serta tanda-tanda vital ibu. Respon Psikososial: Mengkaji tingkat nyeri, kecemasan, serta kemampuan coping ibu dan dukungan pendamping (suami/keluarga). Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis, menerapkan prinsip aseptik (saat pemeriksaan dalam), dan membaca hasil temuan klinis dengan benar untuk dimasukkan ke dalam lembar Partograf.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik dengan persalinan kala 1 serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Keperawatan : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan demonstrasi tehnik relaksasi dengan persalinan kala 1 disertai langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi pasien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan pasien, menjaga kenyamanan dan keamanan pasien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus persalinan kala 1.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda persalinan kala 1 secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting kontraksi uterus, DJJ, pembukaan serviks, kemajuan persalinan, status hidrasi dan partograf, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi kontraksi uterus, DJJ, pembukaan serviks, kemajuan persalinan, status hidrasi dan partograf, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegaskan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan ibu pada persalinan kala 1.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi teknik relaksasi, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi teknik relaksasi secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, cara teknik relaksasi, tindakan saat HIS muncul, tanda bahaya, serta

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
				verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Persalinan Kala 1
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Persalinan Kala 1

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala 1
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada ibu dengan persalinan kala 1.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang persalinan kala 1, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi ibu, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang perempuan, umur 24 tahun, G1P0A0, datang ke ruang bersalin pukul 14.00 WIB. Mengeluh mulas kuat dan sering sejak 4 jam yang lalu. Ibu tampak sangat tegang, menggenggam tangan suaminya dengan kencang, dan bertanya: "Apakah bayi saya baik-baik saja? Kenapa rasanya sangat sakit?"
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa kontraksi HIS, DJJ, pemeriksaan dalam, menjelaskan kemajuan persalinan, lalu menyampaikan rencana pemantauan partograf, mengajarkan tehnik relaksasi, serta edukasi tentang tanda bahaya persalinan kala 1.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali frekuensi HIS, DJJ, pemeriksaan dalam, mengenali tanda bahaya persalinan kala 1,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala 1
	penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	menjelaskan tehnik relaksasi dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya nyeri melahirkan, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada pasien dan keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi kontraksi HIS, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian frekuensi dan durasi kontraksi dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya persalinan kala 1.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus persalinan kala 1, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1. 1 Portofolio pada Asuhan Keperawatan Persalinan Kala 1

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala 1
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan.	Pada asuhan Kala 1, portofolio memuat bukti mahasiswa mampu melakukan pemantauan DJJ, kontraksi, pengisian partograf, manajemen nyeri, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan ia pernah merawat ibu bersalin, tetapi juga bagaimana ketrampilannya (misal: akurasi pemeriksaan dalam/VT) berkembang setelah bimbingan.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio sebagai bukti keterampilan terstruktur di lab dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE: Hasil ujian simulasi VT dan hitung DJJ pada phantom. DOPS: Hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan sayang ibu dan pemantauan partograf di ruang VK.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus pasien, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus seorang perempuan (G1P0A0) pembukaan 5 cm, data DJJ, frekuensi kontraksi, diagnosis nyeri melahirkan, intervensi relaksasi napas, dan evaluasi kemajuan persalinan.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya sterilitas saat VT untuk mencegah infeksi, ketelitian hitung DJJ 1 menit penuh untuk deteksi gawat janin, dan ketepatan plotting partograf.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI/dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam asuhan sayang ibu (pijat punggung), tetapi perlu meningkatkan ketajaman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala 1
	kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	palpasi Leopold untuk menentukan posisi janin.
Karakteristik penilaian	Bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang. Penekanan pada konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai bukan dari satu pasien bersalin saja, tetapi dari beberapa pengalaman yang menunjukkan ia konsisten mampu memantau persalinan secara aman dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan dan waktu berbeda.	Dari OSCE dan DOPS, terlihat mahasiswa secara konsisten mampu menjaga sterilitas, melakukan komunikasi terapeutik, dan melakukan deteksi dini tanda bahaya persalinan.
Makna dalam OBE	Bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi tampak dalam performa yang berulang dan terdokumentasi.	Portofolio menunjukkan mahasiswa tidak hanya paham fase persalinan secara teori, tetapi konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik yang aman (Level Does pada Piramida Miller).

Tabel 1. 2 Case Report pada Asuhan Keperawatan Persalinan Kala 1

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala 1
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa. Berfungsi sebagai bukti kemampuan memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang Perempuan, 24 tahun, G1P0A0, yang dirawat dengan keluhan mulas kuat, tampak tegang, cemas, dan berada dalam pembukaan serviks 5 cm (fase aktif).
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pembukaan serviks, tetapi juga menjelaskan analisis kesejahteraan janin (DJJ), manajemen nyeri yang diberikan, dan kemajuan persalinan setelah intervensi.
Isi laporan	Mencakup identitas pasien, keluhan utama, data subjektif/objektif, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan data kontraksi (frekuensi/durasi), DJJ 144x/mnt, pembukaan 5 cm, diagnosis Nyeri Melahirkan, intervensi teknik relaksasi napas dalam, dukungan suami, dan evaluasi respon nyeri serta kemajuan pembukaan.
Fokus penilaian	Difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kontraksi dengan kemajuan persalinan, memilih teknik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala 1
		relaksasi yang tepat, dan akurasi dalam melakukan plotting data pada Partograf.
Nilai edukatif	Membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik secara ilmiah.	Dari kasus Kala 1, mahasiswa belajar bahwa pemantauan DJJ secara konsisten, sterilitas saat pemeriksaan dalam (VT), dan asuhan sayang ibu sangat krusial dalam keberhasilan persalinan.
Makna dalam OBE	Bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami fase-fase persalinan secara teoritis, tetapi mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan maternitas secara utuh dan aman.

Tabel 1. 3 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Persalinan Kala 1

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala 1
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada persalinan Kala 1, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan deteksi gawat janin atau infeksi akibat pemeriksaan dalam (VT) yang tidak steril dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien (maternal-neonatal) merupakan bagian inti dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti tidak menghitung DJJ selama 1 menit penuh atau mengabaikan garis waspada pada partograf, dapat berakibat fatal pada luaran persalinan.
Fokus refleksi	Meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada fase ini adalah gawat janin, infeksi intrapartum, dan kelelahan ibu yang berdampak pada kontraksi tidak adekuat.
Risiko yang diidentifikasi	Menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan ibu dan janin.	Risiko yang diidentifikasi: DJJ abnormal, air ketuban pecah berwarna hijau/mekonium, partus lama (melewati garis waspada), dan trauma serviks akibat VT yang terlalu sering/kasar.
Tindakan pencegahan	Menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien selama persalinan.	Mahasiswa menuliskan pentingnya menjaga kesterilan saat VT, melakukan observasi DJJ sesuai interval (30 menit pada fase aktif), mencatat partograf secara real-time, dan memastikan hidrasi ibu terjaga.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala 1
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari dan bagaimana hal itu memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa dalam asuhan Kala 1, ketelitian dalam pemantauan fisik, kepatuhan pada protokol aseptik, dan ketajaman interpretasi partograf adalah kunci keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan berpikir kritis terhadap keselamatan pasien secara berkelanjutan.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia mampu mengevaluasi risiko klinis secara mandiri dan melakukan eskalasi tepat waktu jika ditemukan tanda bahaya pada ibu maupun janin.

F. RINGKASAN

1. Pendahuluan & Fokus Utama

Bab ini menekankan bahwa persalinan Kala 1 merupakan proses fisiologis yang dinamis dan dapat berkembang cepat menjadi kondisi berisiko bagi ibu maupun janin apabila tidak dipantau secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan adalah mempertahankan kesejahteraan janin (DJJ), memantau kemajuan persalinan, mengelola nyeri persalinan secara non-farmakologis, memenuhi kebutuhan hidrasi dan eliminasi, serta memberikan dukungan psikologis (asuhan sayang ibu) kepada ibu dan pendamping.

2. Pengkajian Fokus

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian tidak hanya berhenti pada keluhan mulas (kontraksi), tetapi harus dilanjutkan dengan penilaian kondisi umum ibu, frekuensi dan durasi kontraksi, pemeriksaan dalam (pembukaan, penipisan serviks, status ketuban, penurunan Hodge), serta pemantauan Denyut Jantung Janin (DJJ). Tanda-tanda seperti DJJ abnormal (<120 atau >160 x/mnt), air ketuban hijau/mekonium, kontraksi yang tidak adekuat, atau ibu yang sangat rewel dan kelelahan merupakan petunjuk penting yang harus diidentifikasi sejak awal.

3. Alur Asuhan Keperawatan

Alur dimulai dari pengkajian cepat kondisi ibu dan janin saat masuk (penerimaan), kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap pola kontraksi, kemajuan serviks, dan tanda-tanda vital. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya Nyeri Melahirkan, Ansietas, atau Risiko Cedera pada Janin. Langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan pemantauan Partograf, observasi DJJ setiap 30 menit (fase aktif), dukungan hidrasi, pengaturan posisi (miring kiri), serta manajemen nyeri melalui teknik relaksasi.

4. Implementasi & Edukasi

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus menunjukkan keterampilan klinik yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang krusial meliputi:

Melakukan pemeriksaan dalam (VT) dengan prinsip aseptik/steril.

Menghitung DJJ selama 1 menit penuh untuk akurasi data.

Mendemonstrasikan teknik relaksasi napas dalam dan pijatan (counter-pressure) untuk mengurangi nyeri.

Mengajarkan suami/pendamping cara memberikan dukungan fisik dan emosional.

Edukasi mengenai tanda bahaya seperti perdarahan hebat atau ketuban pecah dini.

5. Evaluasi & Eskalasi

Evaluasi dilakukan dengan melihat kemajuan persalinan pada kurva Partograf (pembukaan serviks bertambah), DJJ tetap dalam batas normal, dan ibu mampu melakukan teknik relaksasi untuk mengontrol nyerinya. Namun, apabila ditemukan Red Flags seperti pembukaan melewati Garis Waspada, gawat janin, perdarahan pervaginam, atau ibu mengalami kejang/hipertensi, mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, bidan senior, atau dokter spesialis sesuai sistem pelayanan.

6. Kesimpulan

Inti bab ini adalah asuhan persalinan Kala 1 harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa dituntut tidak hanya mampu secara teknis (pemeriksaan fisik), tetapi juga mampu memberikan edukasi kepada keluarga dan peka terhadap tanda kegawatdaruratan maternal-neonatal.

Tabel 1. 4 Red Flags & Eskalasi Asuhan Keperawatan Persalinan Kala 1

Red Flags (Tanda Bahaya)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
DJJ <120 atau >160 x/menit (menetap)	Menunjukkan gawat janin (fetal distress) akibat hipoksia atau gangguan sirkulasi utero-plasenta	Segera lapor dokter/bidan senior, posisikan ibu miring kiri, berikan O2, siapkan resusitasi intrauterin
Air ketuban hijau kental atau berbau	Indikasi adanya mekonium (stres janin) atau infeksi intrauterin (amnionitis)	Eskalasi segera untuk evaluasi metode persalinan, pantau DJJ ketat, siapkan tim perinatologi
Garis pembukaan melewati Garis Waspada	Menunjukkan persalinan lama/macet (prolonged/obstructed labor), risiko kelelahan ibu & gawat janin	Laporkan ke dokter spesialis (Obgyn), evaluasi kontraksi (His), siapkan kemungkinan augmentasi/SC
Perdarahan pervaginam hebat (darah segar)	Mencurigakan adanya solusio plasenta atau laserasi jalan lahir yang tidak lazim	Panggil bantuan segera, pantau TTV ibu (risiko syok), siapkan akses IV jalur ganda
Tekanan Darah		
140/90 mmHg + Pusing/Pandangan Kabur	Tanda gejala Preeklampsia Berat (PEB) yang berisiko menjadi Eklampsia	Segera laporkan, pasang pengaman tempat tidur, siapkan protokol MgSO ₄ sesuai instruksi medis

Red Flags (Tanda Bahaya)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Ibu mengalami kejang	Kondisi darurat Eklampsia yang mengancam nyawa ibu dan janin	Eskalasi emergensi segera (Code Blue), bebaskan jalan napas, lindungi ibu dari trauma fisik
Nyeri perut hebat di luar kontraksi (uteri tegang)	Risiko ruptura uteri (rahim robek) atau solusio plasenta	Hentikan semua stimulasi (jika ada), lapor segera, siapkan tindakan operatif cito
Kontraksi >5 kali dalam 10 menit (Takisistol)	Hiperstimulasi uterus yang dapat menyebabkan kelelahan otot rahim dan gawat janin	Eskalasi untuk evaluasi penggunaan obat pacu (jika ada), anjurkan relaksasi maksimal
Tali pusat menumbung (teraba saat VT)	Kegawatdaruratan di mana tali pusat terjepit bagian bawah janin, menghentikan aliran oksigen	Jangan tarik tangan saat VT, tahan bagian bawah janin agar tidak menekan tali pusat, siapkan SC segera
Demam tinggi (Suhu >38°C)	Indikasi infeksi maternal atau korioamnionitis	Laporkan, monitor DJJ (sering terjadi takikardi janin), berikan hidrasi, siapkan pemberian antibiotik
Tanda Syok: Nadi cepat lemah, Akral dingin, CRT >2 dtk	Menunjukkan perdarahan dalam atau kegagalan sirkulasi sistemik	Panggil bantuan, berikan oksigen, guyur cairan infus sesuai instruksi, pantau kesadaran

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Persalinan Kala 1

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian dan fase-fase persalinan Kala 1 (Laten & Aktif).	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada ibu bersalin Kala 1 secara sistematis.	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi uterus (His).	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mencari Punctum Maximum dan menghitung DJJ selama 1 menit penuh.	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
5	Saya sudah bisa mengenali tanda-tanda bahaya pada ibu dan janin selama Kala 1.	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas (misal: Nyeri Melahirkan atau Ansietas).	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan (Manajemen Nyeri & Asuhan Sayang Ibu).	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan dalam (VT) dengan prinsip aseptik/steril.	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi dan mendemonstrasikan Teknik Relaksasi Napas Dalam.	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan/mengajarkan teknik pijatan punggung (Counter-pressure) pada suami/keluarga.	☐	☐	
11	Saya sudah bisa memfasilitasi posisi yang nyaman bagi ibu (misal: miring kiri atau mobilisasi).	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau lapor berdasarkan Garis Waspada.	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dan memberikan dukungan emosional kepada ibu dan suami.	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi pemantauan persalinan ke dalam Lembar Partograf.	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan empati saat merawat ibu bersalin.	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education
- DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- DPP PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR). (2017). *Asuhan persalinan normal: Bahan pelatihan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2019). *Maternity and women's health care* (12th ed.). Elsevier
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience*. World Health Organization. apps.who.int

BAB 2

ASUHAN KEPERAWATAN KALA IV DAN NIFAS DINI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Asuhan Keperawatan Kala IV dan Nifas Dini	2.1 Melaksanakan pemantauan kala IV/nifas dini dan pencatatan parameter klinis prioritas.	2.2 Mengidentifikasi masalah nifas dini dan menyusun tindak lanjut edukasi–observasi–rujukan.	CPMK-7	CPMK-5; CPMK-6

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	OSCE/simulasi keterampilan + penilaian komunikasi	Ketepatan langkah tindakan; keselamatan prosedur; kualitas komunikasi terapeutik; kualitas edukasi (teach-back)	20	Checklist keterampilan; rekaman/video simulasi
CPMK-6	Simulasi kegawatdaruratan (drill) + skenario tertulis	Kecepatan identifikasi tanda bahaya; ketepatan urutan stabilisasi awal; ketepatan keputusan kolaborasi/rujukan	20	Checklist drill; laporan respons skenario
CPMK-7	Portofolio klinik/proyek perencanaan pulang	Kelengkapan dokumentasi evaluasi; kelengkapan rencana pulang; kesesuaian rencana layanan reproduksi pascapersalinan	10	Portofolio; format dokumentasi & discharge plan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat $\leq 50\%$ elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat $\geq 85\%$ elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien & etik pada skenario maternitas	Identifikasi risiko & tindakan aman $\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	Identifikasi 51–69%; tindakan aman ada namun belum lengkap.	Identifikasi 70–84%; keputusan aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	Identifikasi $\geq 85\%$; keputusan aman, preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak terencana ($\leq 50\%$ memadai).	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

A. DEFINISI KALA IV

Kala IV adalah bagian dalam proses persalinan yang dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir dua jam setelah itu, atau periode dua jam pertama setelah plasenta lahir (Cunningham et al., 2020).

B. ADAPTASI FISIOLOGIS PADA KALA IV

Adaptasi Fisiologis terjadi dari kontraksi uterus selama kala empat umumnya berfungsi menutup pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta, kontraksi uterus tetap kuat dengan amplitudo sekitar 60 sampai 80 mmHg, kekuatan kontraksi ini tidak diikuti oleh interval pembuluh darah tertutup rapat atau vasokonstriksi pembuluh darah dan terjadi kesempatan membentuk trombus dan aktivasi sistem koagulasi, ini disebut dengan fase hemostatis. Melalui kontraksi yang kuat dan pembentukan trombus terjadi penghentian pengeluaran darah postpartum. Pada kala IV ini terjadi perubahan hemodinamik yang ditandai dengan perubahan system kardiovaskuler melalui penurunan curah jantung secara bertahap, peningkatan aliran balik vena dan resiko syok jika terjadi perdarahan. Pemantauan tanda vital sangat penting untuk mendeteksi dini ketidakstabilan kondisi ibu. Kekuatan his dapat diperkuat dengan memberi obat uterotonika. Kontraksi ikutan saat menyusui bayi sering dirasakan oleh ibu postpartum, karena pengeluaran oksitosin oleh kelenjar hipofisis posterior. Pengeluaran oksitosin sangat penting yang berfungsi untuk merangsang otot polos yang terdapat disekitar alveolus kelenjar mammae, sehingga ASI dapat dikeluarkan, oksitosin merangsang kontraksi uterus dan mempercepat involusi uteri dan kontraksi otot uterus yang disebabkan oksitosin mengurangi perdarahan postpartum, sedangkan hormon prolaktin berperan dalam produksi ASI. Stimulasi melalui inisiasi menyusui dini (IMD) dapat meningkatkan pelepasan oksitosin dan mempercepat involusi uterus (Victoria et al., 2023).

C. ADAPTASI PSIKOLOGIS PADA KALA IV

Pada proses persalinan

Menurut teori Reva Rubin, ibu pada kala IV berada dalam fase taking -in yang ditandai dengan : focus pada diri sendiri, mengulang pengalaman persalinan, membutuhkan istirahat serta ketergantungan pada tenaga Kesehatan. Pada fase ini penting dalam pembentukan ikatan awal ibu dan bayi serta kesiapan menuju peran ibu (Mercer, 2021).

D. PATOFISIOLOGI KALA IV

Kala IV merupakan periode dua jam pertama setelah plasenta lahir yang menjadi fase kritis dalam periode postpartum karena tingginya resiko terjadinya perdarahan postpartum (PPH). Setelah plasenta lahir maka dinding uterus akan terbentuk luka terbuka pada tempat imlantasi plasenta yang menyebabkan pembuluh darah, terutama arteri spiral terbuka yang beresiko terjadi perdarahan (Cunningham et al.,2020).

Secara fisiologis tubuh ibu akan melakukan mekanisme hemostasis untuk menghentikan peradahan tersebut dengan kontraksi dan retraksi otot uterus yang akan menekan pembuluh darah sehingga aliran darah terhenti. Selain itu tubuh akan mengaktifkan system koagulasi melalui aktivasi trombosit dan pembentukan fibrin yang mempercepat pembekuan darah pada tempat implantasi plasenta (Cunningham et al.,2020).

Pada ibu postpartum kala IV bisa saja terjadi perdarahan postpartum apabila mekanisme secara fisiologis tidak berjalan dengan baik. Ini bisa disebabkan karena atonia uteri, restensio plasenta yang menghambat kontraksi uterus. Trauma jalan lahir seperti robekan serviks atau perineum juga dapat menyebabkan perdarahan meskipun uterus dalam kondisi berkontraksi baik. Perdarahan yang berlangsung terus menerus akan menyebabkan penurunan volume darah secara signifikan sehingga mengganggu system kardiovaskuler yang berpotensi menyebabkan syok hipovolemik sehingga beresiko terjadi kegagalan organ hingga kematian.

E. KOMPLIKASI KALA IV

Pada kala IV paling sering terjadi perdarahan postpartum, yaitu pada 2 jam pertama postpartum yang merupakan fase paling kritis dalam masa postpartum. Perdarahan postpartum Adalah kehilangan darah lebih dari dan sama dengan 500 ml setelah persalinan normal. Masalah/komplikasi yang dapat muncul pada kala empat adalah perdarahan yang mungkin disebabkan oleh atonia uteri, laserasi jalan lahir dan sisa plasenta. Oleh karena itu pada fase ini, ibu memerlukan pemantauan

yang intensif untuk memastikan stabilitas hemodinamik dan kontraksi uterus yang adekuat untuk mencegah perdarahan pervaginam (WHO,2022). Selain perdarahan postpartum syok hipovolemik juga merupakan komplikasi yang terjadi pada kala IV ini, hal ini terjadi karena kehilangan darah yang tidak tertangani dengan baik, infeksi dini juga bisa terjadi di fase ini yang bisa disebabkan karena trauma jala lahir atau prosedur yang tidak aseptik (Sheldon et al., 2021).

Penelitian global menunjukkan bahwa sekitar 60% kejadian perdarahan postpartum terjadi dalam 2 jam pertama setelah persalinan, sehingga kala IV menjadi periode yang sangat menentukan keselamatan ibu (Sheldon et al.,2021; Tuncalp et al.,2022). Atonia uteri (kegagalan kontraksi uterus) merupakan penyebab utama perdarahan postpartum dengan angka kejadian 70-80% kasus (WHO,2022) Pemantauan pada kala IV dilakukan:

- a. Setiap 15 menit pada satu jam pertama pascapersalinan.
- b. Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan.
- c. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan penatalaksanaan atonia uteri yang sesuai.

Parameter yang dinilai melalui tanda vital, kontraksi uterus, pemeriksaan tinggi fundus uteri, jumlah perdarahan dan pengosongan kandung kemih.

F. ASUHAN KEPERAWATAN KALA IV

1. Pengkajian kala IV

a. Aktivitas Istirahat: tampak kelelahan, keletihan, mengantuk atau berenergi.

b. Sirkulasi

Nadi biasanya lambat (50-70) karena hipersensitivitas vaginal

TD mungkin rendah terhadap respon anastesi atau meningkat terhadap pemberian oksitosin atau hipertensi karena kehamilan.

Mungkin edema pada ekstremitas dan wajah

Kehilangan darah selama persalinan 400-500 ml.

c. Integritas ego

1) Reaksi emosional bervariasi, seperti eksitasi tidak berminat (lelah), kecewa

2) Takut mengenai kondisi bayi baru lahir dan perawatan segera pada neonatal.

d. Eliminasi

1) Hemoroid sering ada dan menonjol

2) Kandung kemih mungkin teraba di atas simpisis pubis atau terpasang kateter

3) Diuresis terjadi jika tekanan bagian presentas menghambat aliran urine.

e. Makanan/cairan: haus/lapar, mual

f. Neurosensasi

- 1) Sensasi dan gerakan ekstremitas bawah menurun pada anestesi spinal
- 2) hiperfleksi

g. Nyeri/ketidaknyamanan: mengeluh nyeri pada trauma epiostomi

h. Keamanan

- 1) Suhu tubuh sedikit meningkat (dehidrasi, pengerahan tenaga)
- 2) Perbaikan epiostomi utuh

i. Seksualitas

- 1) Fundus keras berkontraksi
- 2) Drainase vagina/loklea jumlahnya sedang, merah gelap dengan bekuan kecil
- 3) Perineum bebas dari kemerahan, edema dan ekimosis
- 4) Striae mungkin ada pada abdomen, paha dan payudara
- 5) Payudara lunak, puting tegang

2. Diagnosa Keperawatan (SDKI), Luaran (SLKI) serta Intervensi (SIKI).

NO	DIAGNOSA	LUARAN	INTERVENSI
1	Resiko Perdarahan (D.0012) Faktor Resiko 1. Atonia uteri 2. Retensio plasenta 3. Trauma jalan lahir 4. Multi paritas 5. Persalinan lama Data Pendukung 1. Uterus lembek 2. TFU tidak berkontraksi baik 3. Perdarahan meningkat	Status perdarahan membaik Indikator 1. Frekuensi perdarahan menurun 2. Jumlah perdarahan dalam batas normal (<500 ml) 3. Uterus berkontraksi baik (keras) 4. Tidak ada bekuan darah berlebih 5. Tanda vital stabil Kriteria Hasil 1. Dalam 1-2 jam postpartum, uterus keras dan perdarahan normal 2. Tidak ada tanda perdarahan aktif	Observasi 1. Monitor jumlah, warna dan karakteristik perdarahan 2. Palpasi fundus uteri (keras/lembek) 3. Monitor TTV (TD, nadi, RR) 4. Identifikasi tanda syok Terapeutik 1. Lakukan massage fundus uteri 2. Anjurkan ibu BAK (kosongkan kandung kemih) 3. Pertahankan posisi nyaman Edukasi 1. Ajarkan ibu/keluarga tanda perdarahan 2. Edukasi pentingnya kontraksi uterus Kolaborasi 1. Pemberian uterotonika (oksitosin) 2. Pemasangan infus.

2	Resiko Syok (D.0009) Faktor Resiko 1. Perdarahan postpartum 2. Hypovolemia Data Pendukung 1. Tekanan Darah menurun 2. Nadi Meningkat 3. Pusing/lemah	Tingkat syok menurun (L.03032) 1. Kekuatan nadi meningkat 2. Output urine meningkat 3. Tingkat kesadaran meningkat 4. Akral dingin menurun 5. Pucat menurun	Observasi 1. Monitor status kardiopumonal 2. Monitor status oksigen 3. Monitor status cairan 4. Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil Terapeutik 1. Persiapan intubasi dan ventilasi mekanis 2. Pasang jalur IV 3. Pasang kateter urine
---	---	---	--

G. DEFINISI NIFAS DINI

Nifas dini adalah periode 0-7 hari setelah persalinan dimana terjadi pemulihan organ reproduksi dan adaptasi fisiologis serta psikologis ibu terhadap peran baru. Pada fase ini, tubuh mengalami berbagai perubahan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik ibu sebelum hamil, terutama melalui proses involusi uterus dan adaptasi sistem hormonal

H. ADAPTASI FISILOGIS

Secara fisiologis, uterus akan mengalami involusi, yaitu proses pengecilan ukuran uterus akibat kontraksi dan autolysis serabut otot. Tinggi fundus uteri akan menurun sekitar 1 cm per hari hingga Kembali ke dalam rongga panggul. Proses ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang dilepaskan selama menyusui, sehingga menyusui dini dapat mempercepat involusi uterus (Victora et al, 2023). Selain itu, pada nifas dini terjadi pengeluaran lochea sebagai hasil perlepasan jaringan sisa kehamilan. Lochea rubra muncul pada hari 1-3, lochea serosa pada hari 4-10 dan lochea alba setelahnya.

Pada sistem laktasi, terjadi peningkatan hormon prolactin yang merangsang produksi ASI, serta oksitosin yang membantu pengeluaran ASI (let-dwon-reflex). Namun, jika terjadi bendungan ASI akibat pengosongan payudara yang tidak adekuat, dapat timbul pembengkakan payudara bahkan mastitis.

I. ADAPTASI PSIKOLOGIS NIFAS DINI

MENURUT Reva Rubin terbagi atas tiga tahapan yaitu : Fase Taking In (1-2 hari pertama) ditandai dengan ibu pasif, fokus pada diri sendiri, banyak bercerita pengalaman persalinan dan bergantung pada orang lain. Selanjutnya Fase Taking

Hold (hari 3-10) ditandai dengan mulai aktif merawat bayi, belajar menyusui, mulai percaya diri namun masih ragu. Fase yang ketiga Fase letting Go yaitu fase setelahnya dengan ciri ibu menerima peran sebagai ibu, adaptasi dengan perubahan hidup dan ikatan bayi-ibu kuat.

J. PATOFISIOLOGI NIFAS DINI

Patofisiologi nifas dini merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi antara penurunan hormon kehamilan, peningkatan hormon laktasi, involusi uterus, serta penyembuhan jaringan, ketidakseimbangan dalam proses tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi, sehingga pemantauan yang adekuat sangat diperlukan untuk memastikan kondisi ibu tetap stabil dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut.

K. KOMPLIKASI NIFAS DINI

Secara patologis, gangguan pada nifas dini dapat terjadi apabila proses involusi tidak berjalan optimal, misalnya subinvolusi uterus yang dapat menyebabkan perdarahan lanjutan. Infeksi puerperium juga dapat terjadi akibat masuknya mikroorganisme melalui luka jalan lahir, ditandai dengan demam, lochea berbau dan nyeri. Perubahan hormonal juga dapat memicu gangguan psikologis seperti baby blues yang sering terjadi dengan ciri sedih mudah menangis, cemas sampai sensitive yang muncul pada hari ke 3-5 hingga depresi postpartum yang ditandai dengan tidak mau merawat bayi, menarik diri sampai gangguan tidur serta bisa menyebabkan halusinasi maupun perilaku tidak wajar.

L. PARAMETER KLINIS PRIORITAS KALA IV DAN NIFAS DINI

1. Parameter utama (Prioritas Tinggi) Kala IV
 - a. Perdarahan : Jumlah < 500 ml normal, warna merah segar, ada bekuan/tidak
 - b. Kontraksi uterus : konsistensi keras / lembek, tinggi fundus uteri, posisi uterus ditengah dan keras
 - c. Tanda Vital : Tekanan darah Normal jika hipotensi deteksi syok, nadi takikardi
 - d. Kandung Kemih : penuh bisa menghambat kontraksi
 - e. Kesadaran : sadar / gelisah / penurunan merupakan tanda syok awal
2. Parameter utama nifas dini
 - a. Involusi uterus : TFU turun 1 cm/hari, uterus keras, mencegah subinvolusi
 - b. Lochea : warna (rubra, serosa dan alba), Bau (normal / tidak), jumlah (deteksi infeksi / perdarahan)

- c. Payudara dan Laktasi : Produksi ASI, Bendungan ASI, puting lecet (keberhasilan menyusui)
- d. Tanda vital dalam batas normal
- e. Eliminasi : sudah BAK atau BAB
- f. Psikologis : Baby Blues, depresi postpartum.

M. IDENTIFIKASI MASALAH NIFAS DINI

1. Masalah Fisilogis
 - a. Perdarahan (subinvolusi) : perdarahan banyak, TFU tidak turun, uterus lembek (masalah subinvolusi uterus).
 - b. Infeksi puerperium : Demam. Lochea bau, nyeri perut (masalah infeksi nifas)
 - c. Bendungan ASI/gangguan menyusui : Payudara bengkak, ASI tidak lancer, bayi tidak menyusu efektif (Masalah gangguan laktasi)
 - d. Gangguan eliminasi : Tidak BAK/BAB, Nyeri saat BAK (Masalah Retensi urin/konstipasi)
2. Masalah Psikologis
 - a. Baby Blues : sedih, mudah menangis, cemas
 - b. Depresi Postpartum : Tidak mau merawat bayi, menarik diri, gangguan tidur
3. Tindak lanjut
 - a. Edukasi : (Perawatan diri, Menyusui, Nutrisi, Tanda bahaya)
 - b. Observasi : TFU, Lochea, TTV, Payudara, Luka Perineum
 - c. Rujukan : Kondisi darurat, Infeksi berat, Gangguan laktasi berat, Psikologis

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Identifikasi tanda kala IV, nifas dini risiko dan red flags

Kasus 1

Ny. Li, usia 35 tahun, P3A0, post partum 2 jam yang lalu secara normal, saat ini pasien dirawat di ruang rawat kebidanan dan mengeluh pusing, lemah serta darah banyak keluar dari vagina. Ibu juga mengatakan proses persalinan anak ketiga berbeda dengan anak sebelumnya, karena banyak keluhan. Hasil pengkajian menunjukkan :

- Tekanan darah : 90/60 mmHg
- Nadi : 115x/menit
- RR 20x/menit
- TFU : setinggi pusat, lembek
- Perdarahan : $\pm$ 620 cc
- Kandung kemih : penuh
- Ibu tampak pucat.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Lakukan pengkajian yang berfokus pada kala IV
2. Sebutkan diagnose keperawatan yang mungkin terjadi pada ibu berdasarkan data pengkajian.
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi ibu
4. Jelaskan tindakan prioritas yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Kasus 2

Ny. S usia 23 tahun, P1A0, postpartum hari ke-3 dengan kelahiran normal. Pasien datang ke poli kebidanan dengan keluhan : Payudara bengkak dan nyeri, ASI belum lancar/keluar sedikit, Bayi sulit menyusui, Bingung dan takut saat mau menyusui.

Hasil pengkajian didapatkan :

- Payudara tegang dan keras
- Putting menonjol dan tampak lecet
- TD: 120/80 mmHg, Nadi 90x/menit, RR: 20x/menit, suhu 37,5°C
- TFU : keras, 3 jari dibawah pusat
- Lochea : Rubra

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. lakukan pengkajian yan lengkap pada kasus diatas
2. Sebutkan diagnose keperawatan yang mungkin terjadi pada ibu berdasarkan data pengkajian.
3. Jelaskan tindakan prioritas yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.
4. Berikan Edukasi pada pasien tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — *Shows How*

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

1.	Nomor station	1
2.	Judul station	Asuhan Keperawatan pada ibu nifas dini
3.	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian focus, menentukan diagnose keperawatan, perencanaan keperawatan serta edukasi serta demonstrasikan Teknik menyusui yang benar
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dankonseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan Perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku Professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairandan Elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitasdan Istirahat 9. Seksualdan Reproduksi
7.	Instruksi untuk Peserta Ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang wanita 23 tahun primipara melahirkan spontan, bayi dengan berat badan 3800 gram 3 hari yang lalu.hasil pemeriksaan. TD 110/70 mmHg, nadi 90x/menit, napas 20x/menit, suhu badan 37o C, tidak ada perdarahan, kontraksi (+), Involusi 3 jari di bawah pusat, payudara tegang dan keras, putting menonjol dan lecet. klien mengatakan Payudara bengkak dan nyeri, ASI belum lancar/keluar sedikit, Bayi sulit menyusui, Bingung dan takut saat mau menyusui. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pengkajian focus berdasarkan scenario tersebut pada ks 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi Teknik menyusui yang benar

8.	Instruksi untuk Penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang wanita 23 tahun primipara melahirkan spontan, bayi dengan berat badan 3800 gram 3 hari yang lalu. hasil pemeriksaan. TD 110/70 mmHg, nadi 90x/menit, napas 20x/menit, suhu badan 37o C, tidak ada perdarahan, kontraksi (+), Involusi 3 jari di bawah pusat, payudara tegang dan keras, putting menonjol dan lecet. klien mengatakan Payudara bengkak dan nyeri, ASI belum lancar/keluar sedikit, Bayi sulit menyusui, Bingung dan takut saat mau menyusui. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pengkajian focus berdasarkan scenario tersebut pada ks 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi Teknik menyusui yang benar <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Penguji melakukan penilaian dan mengamati penampilan klinik peserta 2. Penguji tidak boleh melakukan interupsi, ataupun bertanya baik secara verbal maupun maupun non verbal 3. Penguji menilai kemampuan peserta uji dalam melakukan pengkajian focus (kaji kondisi payudara, kaji Teknik menyusui, kaji frekuensi menyusui, kaji nyeri dan kaji tanda infeksi) 4. Penguji menilai kemampuan peserta uji dalam menentukan diagnose keperawatan menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI 5. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti : identifikasi kesiapan dan kemmpuan menerima informasi, jadwalkan penkes sesuai kesepakatan. 6. Penguji menilai peserta uji melakukan implementasi edukasi dan demonstrasi Teknik menyusui yang tepat secara terstruktur, benar dan sistematis / konseling laktasi 7. Monitor perilaku professional peserta
9.	Instruksi untuk klien standar/ manekin	Nama : NY. M Usia : 23 Tahun Jenis kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Status : Menikah Pendidikan terakhir : SMA

		Riwayat penyakit sekarang: Klien seorang ibu rumah tangga yang baru pertama kali melahirkan 3 hari yang lalu secara spontan, datang ke poli kebidanan untuk control dan mengeluh Payudara bengkak dan nyeri, ASI belum lancar/keluar sedikit, Bayi sulit menyusui, Bingung dan takut saat mau menyusui. Riwayat penyakit dahulu: Klien tidak memiliki riwayat penyakit , dan pengalaman melahirkan anak pertama dan baru pertama kali menyusui sehingga masih terlihat bingung dan kaku Riwayat penyakit keluarga: Klien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit apa pun di keluarga Riwayat kebiasaan sosial: Di dalam keluarga klien terbiasa di lakukan pijat pasca melahirkan di hari ketiga sampai hari ke tujuh Peran yang harus dilakukan: Berperan sebagai ibu pasca melahirkan hari ketiga, Klien tampak meringis karena payudara keras dan lecet. Klien mengikuti intruksi dari perawat
10	<i>Setting Station.</i>	Ruang Poli Kebidanan - Manekin bayi - Kursi / Tempat tidur - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur, kursi KS dan 2. manekin bayi 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub
11	Peralatan yang dibutuhkan	a. Kapas dalam wadah/kom b. Air hangat atau air bersih c. Waslap: 2 buah d. Bengkok e. Sabun cuci tangan / handscrub

		f. Bantal
12	Penulis	Ns. Yuli Erlina, M.Kes
13	Referensi	Isro'in, L & Andarmoyo, S. (2012). Personal Hygiene Konsep, Proses Dan Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan. Graha Ilmu. Kemenkes R.I.(2020). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementrian dan Kesehatan Indonesia Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

DEMONSTRASI TEKNIK MENYUSUI YANG TEPAT

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Handrub/sabun cuci tangan b. Bantal c. Washlap d. Kapas e. Air hangat / air bersih f. Bengkok				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Bersihkan puting susu dan areola dengan kapas DTT				
13	ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan sekitar areola				
14	Bayi diletakan menhgadap payudara				
15	Ibu duduk atau berbaring santai				
16	Bayi dipegang dengan satu tangan / satu lengan, kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu dan bokong bayi ditangan dengan telapak tangan ibu				

17	Satu tangan bayi diletakan di belakang badan ibu dan yang satu didepan				
18	Perut ibu menempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap payudara				
19	Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus				
20	Ibu menatap bayi dengan penuh kasih sayang				
21	Payudara dipegang dengan ibu jari dan jari lain menopang dibawah				
22	Bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut dengan menyentuh pipi bayi dengan putting susu atau menyentuh sisi mulut bayi				
23	Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat bayi didekatkan ke payudara ibu dengan putting serta areola dimasukan dalam mulut bayi				
24	Usahkan Sebagian besar areola dapat masuk dalam mulut bayi sehingga putting susu berada dibawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI yang terletak dibawah areola				
25	Setelah Menyusu pada satu payudara sampai terasa kosong, sebaiknya Ganti menyusui dengan payudara lain.				
26	Lepas isapan bayi dengan jari kelingking ibu dimasukan dalam mulut bayi melalui sudut mulut bayi atau dagu bayi ditekan kebawah				
27	Setelah menyusui ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada putting susu dan areola sekitarnya. Biarkan kering dengan sendirinya				
28	Sendawakan bayi supaya bayi tidak muntah dengan bayi digendong tegak dan bersandar pada bahu ibu kemudian punggung bayi ditepuk perlahan-lahan atau bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu dan perlahan-lahan menepuk punggung bayi.				
29	Menjelaskan tanda – tanda bahaya seperti : Demam tinggi, payudara merah & nyeri (mastitis), Lokia bau dan perdarahan banyak.				
30	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
31	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah				

D	Tahap Terminasi				
32	Menyimpulkan kegiatan				
33	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
34	Memberikan reinforcement positif				
35	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
36	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
37	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi Teknik menyusui yang tepat				
F	Penampilan Profesional				
38	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA NIFAS DINI / GANGGUAN PROSES
MENYUSUI

II. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Payudara nyeri / bengkak. ASI tidak lancar, putting susu lecet, bendungan ASI, Produksi ASI, lochea sesuai rubra, TFU sesuai 3 jari di bawah pusat, ibu tidak ada komplikasi.					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan pemberian ASI, menyiapkan bahan untuk mendemonstrasikan Teknik menyusui yang benar dan tepa, serta menjelaskan tanda bahaya					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU NIFAS DINI

II. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada ibu dengan nifas dini , meliputi. Payudara nyeri / bengkak. ASI tidak lancar, putting susu lecet, bendungan ASI, Produksi ASI, lochea sesuai rubra, TFU sesuai 3 jari di bawah pusat, ibu tidak ada komplikasi. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik ibu dengan nifas dini serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi Keperawatan : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan demonstrasi Teknik menyusui yang tepat dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi ibu nifas dini dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu, menjaga kenyamanan dan keamanan ibu dan bayi, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus ibu dengan nifas dini.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda gangguan menyusui secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti Payudara nyeri / bengak. ASI tidak lancar, putting susu lecet masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi Payudara nyeri / bengak. ASI tidak lancar, putting susu lecet, bendungan ASI, Produksi ASI, serta respons bayi dan ibu saat menyusui, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan ibu dengan nifas dini / gangguan proses menyusui
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi Teknik menyusui yang tepat, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi Teknik menyusui yang tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, Teknik menyusui yang tepat, tanda bahaya, serta verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional,	Menunjukkan sebagian kecil	Menunjukkan perilaku profesional	Menunjukkan perilaku profesional secara

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematisa tindakan.	konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan bayi serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....
Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan ibu dengan nifas dini / gangguan proses menyusui
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan ibu dengan nifas dini

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada ibu dengan nifas dini dan bayi dengan gangguan proses menyusui di ruang poli kebidanan .
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang nifas dini, masalah laktasi, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan tentang laktasi, dan menyampaikan rencana asuhan kepada ibu
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang wanita 23 tahun primipara melahirkan spontan, bayi dengan berat badan 3800 gram 3 hari yang lalu. hasil pemeriksaan. TD 110/70 mmHg, nadi 90x/menit, napas 20x/menit, suhu badan 37o C, tidak ada perdarahan, kontraksi (+), Involusi 3 jari di bawah pusat, payudara tegang dan keras, puting menonjol dan lecet. klien mengatakan Payudara bengkak

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
		dan nyeri, ASI belum lancar/keluar sedikit, Bayi sulit menyusui, Bingung dan takut saat mau menyusui
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa payudara ibu, menjelaskan Teknik menyusui yang benar, lalu menyampaikan rencana cek payudara ibu lebih lanjut, tinggi fundus uteri, lochea serta edukasi tentang laktasi dan Teknik menyusui yang tepat dan tanda bahaya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi ibu dan keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali Payudara nyeri / bengkak. ASI tidak lancar, puting susu lecet, bendungan ASI, Produksi ASI, lochea rubra, TFU 3 jari di bawah pusat, ibu tidak ada komplikasi dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan ibu.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya gangguan proses menyusui, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi gangguan proses menyusui, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian nifas dini dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus ibu nifas dini dengan gangguan proses menyusui, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

PORTOFOLIO

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 2. 1 Portofolio pada Asuhan Keperawatan ibu dengan nifas dini

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian	Pada asuhan keperawatan ibu dengan nifas dini (gangguan proses menyusui), portofolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
	kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat ibu dengan nifas dini dengan gangguan proses menyusui, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi Teknik menyusui yang benar, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada ibu dengan nifas dini (gangguan proses menyusui) di poli kebidanan..
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pada ibu dengan nifas dini dengan gangguan proses laktasi 23 tahun dengan payudara tegang dan keras, puting menonjol dan lecet. klien mengatakan Payudara bengkak dan nyeri, ASI belum

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
		lancar/keluar sedikit, Bayi sulit menyusui, Bingung dan takut saat mau menyusui , diagnosis keperawatan prioritas, intervensi Teknik menyusui yang benar , edukakasi laktasi, dan evaluasi respons ibu
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau bendungan ASI dan kemungkinan resiko mastitis dengan teliti, memastikan ibu sudah bisa menyusui dengan teknik yang tepat, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu dan edukasi Teknik menyusui yang tepat, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian focus pada ibu nifas dini dan gangguan proses menyusui dan dokumentasi kondisi ibu
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus gangguan proses menyusui, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan pada ibu nifas dini dengan gangguan proses

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
		menyusui secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian ibu nifas dini dengan gangguan proses menyusui, dan komunikasi terapeutik dengan ibu dan keluarga
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan ibu dengan nifas dini dengan gangguan proses menyusui, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep pada bayi laktasi, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 2. 2 Case Report pada Asuhan Keperawatan ibu dengan nifas dini

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu primipara usia 23 tahun yang datang ke poli kebidanan dengan gangguan proses menyusui, dengan payudara tegang dan keras, puting menonjol dan lecet. klien mengatakan Payudara bengkak dan nyeri, ASI belum lancar/keluar sedikit, Bayi sulit

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
		menyusui, Bingung dan takut saat mau menyusui ,
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi ibu setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ibu nifas dini dengan gangguan proses menyusui, mahasiswa menuliskan hasil pengkajian payudara tegang dan keras, puting menonjol dan lecet. klien mengatakan Payudara bengkak dan nyeri, ASI belum lancar/keluar sedikit, Bayi sulit menyusui, Bingung dan takut saat mau menyusui ,intervensi dokumentasi Teknik menyusui dengan benar, edukasi Teknik menyusui dengan tepat, dan evaluasi perbaikan Teknik menyusui.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data bendungan ASI dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons ibu setelah praktek Teknik menyusui yang tepat.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan	Dari kasus ibu nifas dini, mahasiswa belajar bahwa pengkajian pada ibu nifas terkait

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
	kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	dengan lochea, tinggi fundus uteri dan laktasi, dan edukasi ibu dan keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pada ibu dengan nifas dini.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep ibu nifas dengan gangguan proses laktasi tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 2. 3 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan ibu dengan nifas dini

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus ibu dengan nifas dini (gangguan proses menyusui), mahasiswa merefleksikan bahwa gangguan proses menyusui dapat menyebabkan bendungan ASI yang dapat berubah menjadi mastitis dan gangguan nutrisi bayi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau bendungan payudara atau terlambat mengenali tanda mastitis, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan gangguan nutrisi pada bayi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan nifas dini
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah mastitis, gangguan proses menyusui, dan gangguan nutrisi pada bayi bila ibu tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan proses menyusui, berkurangnya produksi ASI, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda bendungan ASI secara berkala, mencatat produksi ASI, menjelaskan Teknik menyusui yang benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada ibu nifas dini dengan gangguan proses menyusui, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada ibu dan keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan maternitas secara berkelanjutan.

N. Ringkasan

Asuhan Keperawatan Kala IV dan Nifas Dini (Gangguan Proses Menyusui)

Bab ini menekankan bahwa gangguan proses menyusui pada ibu merupakan masalah klinis yang sangat sering dijumpai dan dapat berkembang cepat menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan kala IV dan nifas dini dengan gangguan proses menyusui adalah . Payudara nyeri / bengkak. ASI tidak lancar, puting susu lecet, bendungan ASI, Produksi ASI, lochea sesuai rubra, TFU sesuai 3 jari di bawah pusat, ibu tidak ada komplikasi. pengkajian lanjutan bisa ditambahkan dengan tambahan tanda bahaya

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat kondisi umum kala IV dan Nifas dini, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya Risiko perdarahan, Risiko syok, nyeri akut, retensi urine atau ansietas ibu atau masalah pada nifas dini yaitu gangguan proses menyusui, Risiko infeksi atau gangguan koping. . Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan tentang cara mengajarkan posisi menyusui yang benar, membantu ibu mempraktikkan perlekatan, memberikan kompres hangat dan menganjurkan menyusui rutin, serta edukasi tentang tanda bahaya.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain memantau kondisi payudara ibu, ada atau tidaknya bendungan ASI, produksi ASI meningkat dan mampu mendemonstrasikan Teknik menyusui dengan tepat serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami ibu. Edukasi ibu menjadi bagian yang sangat penting, terutama mengenai Teknik menyusui yang tepat, pentingnya memahami kondisi payudara, tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, dan kapan ibu perlu segera dievaluasi lebih lanjut.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan kondisi ibu dengan nifas dini dengan gangguan proses menyusui , misalnya ibibisa melakukan Teknik menyusui dengan tepat , payudara tidak keras, puting susu tidak lecet, tidak ada bendungan ASI serta produksi ASI meningkat dan ibu mampu menjelaskan kembali perawatan yang harus dilakukan. Namun, apabila ditemukan tanda bahaya seperti mastitis, abses payudara, gangguan nutrisi pada bayi, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, preseptor, atau dokter sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan kala IV dan nifas dini dengan gangguan proses menyusui harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi pada ibu dan keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada Keperawatan Maternitas.

Tabel 2. 4 Red Flags & Eskalasi Asuhan Keperawatan kala IV dan nifas dini

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pendarahan banyak (> 500 ml/pembalut penuh < 1 jam	Perdarahan postpartum subinvolusi	Massage uterus, Monitor TTV, kolaborasi oksitosin, segera rujuk
Uterus lembek, TFU tidak turun	Atonia uteri/subinvolusi	Massage fundus, kosongkan kandung kemih, rujuk jika tidak membaik
Tekanan darah menurun, nadi meningkat, pucat, pusing	Syok hipovolemik	Posisi syok, infus cairan, oksigen dan rujuk emergensi
Demam > 38 derajat celcius	Infeksi puerperium	Monitor suhu, Kolaborasi antibiotic, Rujuk jika berat
Lochea bau busuk	Infeksi uterus	Observasi lochea, edukasi hygiene, rujuk
Nyeri perut hebat	Infeksi/komplikasi intrauterin	Observasi, analgetik, rujuk
Payudara merah,panas, nyeri dan demam	Mastitis	Kompres hangat, tetap menyusui, antibiotic, rujuk jika berat
Benjolan berisi nanah dipayudara	Abses payudara	Jangan dipijat, rujuk untuk drainase
Putting lecet berat	Resiko infeksi	Perbaiki Teknik menyusui, perawatan puting
Tidak BAK > 6-8 jam	Retensi urine	Anjurkan BAK, Katetersasi, Rujuk jika gagal
Tidak BAB 3 hari	Konstipasi	Diet serat, cairan, kolaboratif laksatif

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Sedih berlebihan / menangis terus	Baby blues	Dukungan emosional, edukasi
Tidak mau merawat bayi	Depresi postpartum	Konseling, rujuk psikolog/psikiater

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian kala IV dan nifas dini	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada ibu dengan nifas dini gangguan proses menyusui	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji payudara ibu, bendungan ASI	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya mastitis pada ibu dengan nifas dini	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada nifas dini	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada ibu dengan nifas dini, gangguan proses menyusui	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada ibu dengan nifas dini, gangguan proses menyusui	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memantau status bendungan ASI pada ibu	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang Teknik menyusui yang tepat	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menganjurkan kelanjutan dari gangguan proses menyusui karena bendungan ASI	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada ibu dengan gangguan proses menyusui	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan ibu dan keluarga	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan ibu dengan nifas dini, gangguan proses menyusui	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat ibu dengan nifas dini, gangguan proses menyusui	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan ibu nifas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care*. Geneva: WHO.
- Perkumpulan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: PPNI
- Perkumpulan Perawat Nasional Indonesia. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*. Jakarta: PPNI.
- Perkumpulan Perawat Nasional Indonesia. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)*. Jakarta: PPNI.
- Cunningham, F. G., et al. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2020). *Maternity Nursing*. Mosby.
- Weeks, A.(2020). *The retained placenta. Best Practice & Research Clinical Obstetrics*
- Victora., et al (2016) *Breastfeeding in the 21 st century: epidemiology, mechanisme, and lifelong effect*

BAB 3

ASUHAN KEPERAWATAN NIFAS LANJUT: LAKTASI DAN KESEHATAN MENTAL IBU

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Asuhan Keperawatan Nifas Lanjut: Laktasi dan Kesehatan Mental Ibu	3.1 Melaksanakan konseling laktasi dan penanganan masalah menyusui yang sering ditemukan.	3.2 Melakukan skrining kesehatan mental postpartum dan intervensi dukungan dasar serta rujukan.	CPMK-5	CPMK-7; CPMK-1

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (MCQ/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar pada blueprint konsep (ruang lingkup, CoC, keselamatan pasien)	10	Lembar jawaban ujian
CPMK-5	OSCE/simulasi keterampilan + penilaian komunikasi	Ketepatan langkah tindakan; keselamatan prosedur; kualitas komunikasi terapeutik; kualitas edukasi (teach-back)	20	Checklist keterampilan; rekaman/video simulasi
CPMK-7	Portofolio klinik/proyek perencanaan pulang	Kelengkapan dokumentasi evaluasi; kelengkapan rencana pulang; kesesuaian rencana layanan reproduksi pascapersalinan	10	Portofolio; format dokumentasi & discharge plan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat ≤50% elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat ≥85% elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien	Identifikasi risiko & tindakan aman	Identifikasi 51–69%; tindakan	Identifikasi 70–84%; keputusan	Identifikasi ≥85%; keputusan aman,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
& etik pada skenario maternitas	$\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	aman ada namun belum lengkap.	aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	terencana ($\leq 50\%$ memadai).			

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

A. Konsep Dasar Masa Nifas

Postpartum/ masa nifas merupakan masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari pada keadaan sebelum hamil (Chang et al., 2017). Post partum merupakan jangka waktu antara bayi dengan kembalinya organ reproduksi ke keadaan normal, periode ini sering disebut dengan masa nifas. (Cashion et al., 2019). Masa nifas merupakan periode krisis adaptasi karena ibu mengalami perubahan peran menjadi orang tua (Reeder et al., 2012).

Tujuan:

1. Memastikan involusi uterus berjalan normal
2. Mencegah komplikasi
3. Mendukung keberhasilan menyusui
4. Menjaga kesehatan mental ibu

B. Adaptasi Fisiologis Dan Psikologis

1. Perubahan Fisiologis Umum

Perubahan tanda-tanda vital seperti denyut nadi, tekanan darah mengalami peningkatan setelah beberapa jam melahirkan, kembali normal hari ke dua. Suhu sedikit meningkat hingga 37,2°C seiring ditandai: menggigil, berkeringat, atau diaforesis dalam 24 jam pertama. Berat badan menurun sebesar 5 hingga 6 kg karena keluarnya produk kehamilan dan kehilangan darah yang menyertainya, kondisi ini akan berlanjut hingga 6 bulan setelah melahirkan (Gaurav Chauhan & Prasanna Tadi, 2022).

Sistem Reproduksi : payudara terjadi pembesaran, keras dan nyeri ditandai dengan adanya pembengkakan dan timbulnya air susu sehingga terjadi proses menyusui dimulai. Involusi uterus, serviks mengalami pengerutan rahim atau mengalami perubahan dimana rahim kembali ke kondisi semula. vagina dan vulva mengalami peregangan dan penekanan yang sangat besar selama proses melahirkan, perineum terjadi kendur, terdapat lochea yaitu cairan yang keluar berwarna merah karena berisi darah segar, sisa mekonium, sisa-sisa plasenta, rambut lanugo.

2. Adaptasi Psikologis

a. Perubahan / Adaptasi psikologis postpartum

- 1) Adaptasi maternal mempunyai tiga fase terjadi pada ibu post partum yang disebut Rubin Maternal Phases, yaitu a) *Taking in* (fase ketergantungan) terjadi antara satu sampai tiga hari setelah persalinan ibu masih berfokus pada diri sendiri, bersikap tidak aktif dan masih ketergantungan. b) *Taking*

Hold Pada fase taking hold, secara bergantian timbul kebutuhan ibu untuk mendapatkan perawatan dan penerimaan dari orang lain dan keinginan untuk bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri. Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini ibu sudah mulai menunjukkan kepuasan (terfokus pada bayinya). Ibu mulai terbuka untuk menerima pendidikan bagi dirinya dan juga bayinya. c) *Letting Go* Fase ini merupakan fase penerimaan tanggung jawab akan peran barunya, berlangsung setelah hari ke 10 pasca melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Keinginan ibu untuk merawat diri dan bayinya sangat meningkat pada fase ini. Terjadi penyesuaian dalam hubungan keluarga untuk mengobservasi bayi. Hubungan antar pasangan memerlukan penyesuaian karena adanya anggota keluarga baru. (Cohen et al., 2018).

Bagi sebagian perempuan, *transition to motherhood* adalah suatu kebahagiaan. 15- 20% perempuan mengalami kecemasan dan depresi pada tahun pertama setelah melahirkan (NICE) 2014. Studi Knigth et al, 2017 melaporkan kematian ibu karena bunuh diri menjadi penyebab utama kematian langsung yang terjadi dalam satu tahun setelah akhir kehamilan. Menjadi seorang ibu berarti melakukan internalisasi dirinya sebagai seorang ibu (Mercer). Seorang ibu dapat mengalami beberapa tingkat kesulitan yang sangat normal dan umum Ketika dirinya membangun identitas baru sebagai seorang ibu(Nugroho, 2021).

C. Tanda dan gejala pada masalah psikologis / mental ibu post partum

1. Postpartum Blues

Postpartum blues adalah gangguan emosional ringan pada hari ke-3 hingga ke-14 postpartum(Nurbaeti et al., 2018) Gejala meliputi: Mudah menangis, Mood labil, kecemasan, gangguan tidur, dan kembali normal kembali dalam dua minggu.

2. Depresi Postpartum

Gangguan Mood yang disebut depresi pasca persalinan terjadi setelah melahirkan, mencerminkan ketidakseimbangan mental yang merupakan indikator gejala depresi berat, gangguan ini biasanya terjadi pada 2-6 minggu setelah melahirkan biasanya 2-6 minggu setelah melahirkan dengan karakteristik yaitu perasaan depresi dan kecemasan yang berlebihan, imsonia dan terjadi perubahan berat badan)(Pratiwi, Liliek, Qomariyah, Albertin, Mahfuzhob, Cristien, 2024).

Depresi postpartum (PPD) adalah gangguan suasana hati yang memengaruhi individu dalam periode satu tahun setelah melahirkan. Dalam

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi ke-5 (DSM-5), PPD kini digolongkan sebagai bagian dari depresi perinatal, yaitu gangguan mood yang terjadi selama periode kehamilan hingga setelah kelahiran (Nurbaeti et al., 2018) (Radoš et al., 2024).

Jika gejala menetap >2 minggu disertai: kehilangan minat, perasaan tidak berharga, gangguan nafsu makan, pikiran menyakiti diri maka dicurigai depresi postpartum dan perlu rujukan.

3. Faktor Risiko

- Kurang dukungan sosial
- Masalah ekonomi
- Riwayat gangguan psikologis
- Kegagalan menyusui

4. Dampak

- Gangguan bonding
- Gangguan produksi ASI
- Risiko gangguan tumbuh kembang ibu postpartum

5. Skrining Psikologis ibu postpartum

- a. Definisi : Skrining psikologis ibu postpartum adalah proses penilaian dini untuk mendeteksi gangguan emosional atau masalah kesehatan mental yang dapat muncul setelah persalinan. Skrining ini penting karena perubahan hormonal, kelelahan, serta tuntutan merawat bayi dapat mempengaruhi kondisi psikologis ibu (Kholifah et al., 2022).
- b. Gangguan psikologis yang sering terjadi pada masa postpartum antara lain postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum.
- c. Tujuan Skrining Psikologis Ibu Postpartum
 - 1) Mendeteksi dini masalah psikologis pada ibu setelah melahirkan.
 - 2) Mencegah komplikasi kesehatan mental yang lebih berat.
 - 3) Meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi.
 - 4) Menentukan intervensi atau rujukan yang tepat jika ditemukan masalah psikologis

D. Manajemen Laktasi

1. Konsep Dasar

Manajemen laktasi adalah upaya sistematis untuk memastikan keberhasilan pemberian ASI sejak antenatal hingga postpartum. Produksi ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Stres dan kecemasan dapat menghambat refleks oksitosin (Anik, 2015).

2. Tahapan Laktogenesis
 - a. Laktogenesis I (kehamilan akhir)
 - b. Laktogenesis II (2–3 hari postpartum)
 - c. Laktogenesis III (galaktopoiesis)
3. Komponen Manajemen Laktasi
 - a. Edukasi teknik menyusui
 - b. Perlekatan efektif
 - c. Menyusui on demand
 - d. Pencegahan bendungan ASI
 - e. Penanganan mastitis
 - f. Konseling laktasi
4. Masalah Umum Laktasi

Masalah	Intervensi
Bendungan ASI	Kompres hangat, pengosongan payudara
Puting lecet	Evaluasi perlekatan
Mastitis	Antibiotik kolaboratif
ASI kurang	Peningkatan frekuensi menyusui

E. Asuhan Keperawatan Berbasis Sdki–Slki–Siki

1. Pengkajian Lanjutan
 - a. Kaji tanda vital tiap 4 – 8 jam, nadi dan suhu diatas normal dapat menunjukkan kemungkinan adanya infeksi. Tekanan darah mungkin sedikit meningkat karena upaya untuk persalinan dan keletihan. Tekanan darah yang menurun perlu diwaspadai kemungkinan adanya perdarahan postpartum.
 - b. Lakukan pemeriksaan postpartum yang terfokus tiap 4 – 8 jam
 - c. Kaji rasa ketidaknyamanan, nyeri, kelelahan dan status emosi ibu
 - d. Awasi asupan dan keluaran
 - e. Amati hasil uji laboratorium, terutama hemoglobin dan hematokrit, kumpulkan sampel urine untuk urinalisis rutin kultur atau sensitivitas, amati status rubella (Nia Risa Dewi et al., 2022).
2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosis keperawatan didapatkan setelah perawat melakukan pengkajian, yang mana diagnosis keperawatan ini terdiri dari aktual, risiko dan promosi kesehatan (Reeder et al., 2012). Diagnosis keperawatan terbagi menjadi 5 kategori yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional dan lingkungan. Berikut adalah masalah

keperawatan yang mungkin didapatkan berdasarkan kategori (INNA, 2017a; Nanda, 2021) adalah :

Diagnosis Fisiologis (Tim Pokja SDKI DPP PPNI., 2017)

a. Menyusui tidak efektif (D.0029)

Kondisi dimana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesukaran pada proses menyusui. Masalah ini dapat disebabkan karena berhubungan dengan : a) Ketidakadekuatan suplai ASI, b) hambatan pada neonatus mis. premature, c) anomali payudara ibu (putting inverted), d) ketidak adekuatan refleks oksitosin, e) ketidakadekuatan refleks menghisap bayi, f) payudara bengkak, g) riwayat operasi payudara, h) kelahiran kembar. Menyusui tidak efektif ditandai dengan gejala dan tanda (Mayor) data subyektif : kelelahan maternal, kecemasan maternal, tanda obyektif : Bayi tidak mampu melekat pada payudara ibu, tidak ada tanda-tanda pelepasan oksitosin, BAK bayi kurang dari 8x/ 24 jam, Nyeri dan lecet terus menerus setelah minggu kedua. Gejala dan tanda minor data subjektif tidak tersedia, sedangkan data obyektif didapatkan : intake bayi tidak adekuat, bayi menghisap tidak terus menerus, bayi rewel dan menangis terus dalam jam-jam pertama setelah menyusui, bayi menangis saat disusui, menolak untuk menghisap . Kondisi klinis terkait dengan masalah ini adalah Abses payudara, Mastitis, carpal tunnel syndrome.

Diagnosis Psikologis

b. Ketidaknyamanan pasca partum (D.0075)

Ketidaknyamanan pasca partum merupakan perasaan tidak nyaman yang berhubungan dengan kondisi setelah melahirkan. Dapat disebabkan karena (berhubungan dengan) a) trauma perineum selama persalinan dan kelahiran, b) involusi uterus, c) proses pengembalian ukuran rahim ke ukuran semula, d) pembengkakan payudara dimana alveoli mulai terisi ASI, e) kekurangan dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan, f) Ketidaktepatan posisi duduk, g) faktor budaya.

Ketidaknyamanan pasca partum di tandai dengan gejala dan tanda mayor, yaitu mengeluh tidak nyaman (sebagai data subjektif) dan a) tampak meringis, b) terdapat kontraksi uterus, c) luka episiotomi, d) payudara bengkak (sebagai data obyektif). Gejala dan tanda minor tidak ada untuk data subjektif, sedangkan untuk data obyektifnya adalah a) tekanan darah meningkat, b) frekuensi nadi meningkat, c) Berkeringat berlebihan; d) menangis/merintih, e) haemorroid. Kondisi klinis terkait dengan masalah ini adalah kondisi pasca persalinan.

c. Intervensi Keperawatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI., 2018).

Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan, perawat berwenang untuk merencanakan tindakan keperawatan atau yang kita sebut dengan intervensi keperawatan yang sesuai untuk klien berdasarkan *clinical judgment*, dimana intervensi ini dapat dibuat berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dari penentuan masalah keperawatan (INNA, 2017b) dan luaran keperawatan yang ingin di dapat berdasarkan standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) untuk melihat level keberhasilan intervensi keperawatan (INNA, 2017c). Berikut ini adalah luaran keperawatan utama dan intervensi keperawatan utama pada ibu postpartum

1) Menyusui tidak efektif (D.0029)

Tujuan dan luaran keperawatan utama

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 3x24 Jam, maka status menyusui efektif (L.03029).

Dengan kriteria hasil :

- a) Perlekatan bayi pada payudara ibu meningkat
- b) Kemampuan ibu memposisikan bayi dengan benar meningkat
- c) Miksi bayi lebih dari 8 kali/24 jam meningkat
- d) Berat badan bayi meningkat
- e) Putting tidak lecet setelah 2 minggu melahirkan meningkat
- f) Kepercayaan diri ibu meningkat
- g) Payudara ibu tidak bengkak
- h) Hisapan bayi meningkat secara adekuat
- i) Lecet pada puting menurun
- j) Bayi rewel menurun
- k) Bayi menangis setelah menyusu menurun

Intervensi keperawatan utama ada tiga, yaitu konseling laktasi, promosi ASI eksklusif dan promosi laktasi.

Konseling laktasi (I.03093)

Definisi : Memberikan bimbingan teknik menyusui yang tepat dalam pemberian makanan bayi.

Tindakan :

Observasi

- a) Identifikasi keadaan emosional ibu saat akan dilakukan konseling menyusui
- b) Identifikasi keinginan dan tujuan menyusui
- c) Identifikasi permasalahan yang ibu alami selama proses menyusui

Terapeutik

a) Gunakan Teknik mendengarkan aktif (duduk sama tinggi, dengarkan permasalahan ibu)

b) Berikan pujian terhadap perilaku ibu yang benar

Edukasi

a) Ajarkan perawatan payudara dan teknik menyusui yang tepat sesuai kebutuhan ibu

Promosi ASI eksklusif (I.03135)

Definisi : meningkatkan kemampuan ibu dalam memberikan ASI secara eksklusif

Tindakan :

Observasi

a) Identifikasi kebutuhan laktasi bagi ibu pada antenatal, intranatal dan postnatal

Terapeutik

a) Fasilitasi ibu melakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini)

b) Fasilitasi ibu untuk rawat gabung atau *rooming in*

c) Gunakan sendok dan cangkir jika bayi belum bisa menyusui

d) Dukung ibu menyusui dengan mendampingi ibu selama kegiatan menyusui berlangsung

e) Diskusikan dengan keluarga tentang ASI eksklusif

f) Siapkan kelas menyusui pada masa prenatal minimal 2 kali dan periode postpartum minimal 4 kali

Edukasi

a) Jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi

b) Jelaskan pentingnya menyusui di malam hari untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi ASI

c) Jelaskan tanda-tanda bayi cukup ASI (mis. berat badan meningkat, BAK lebih dari 10 kali/hari, warna urine tidak pekat)

d) Jelaskan manfaat rawat gabung (*rooming in*)

e) Anjurkan ibu menyusui sesegera mungkin setelah melahirkan

f) Anjurkan ibu memberikan nutrisi kepada bayi hanya dengan ASI

g) Anjurkan ibu menyusui sesering mungkin setelah lahir sesuai kebutuhan bayi

h) Anjurkan ibu menjaga produksi ASI dengan memerah, walaupun kondisi ibu atau bayi terpisah.

Promosi laktasi (I.03138)

Definisi : Meningkatkan cakupan ASI eksklusif dan lanjutkan sampai 2 tahun.

Tindakan :

Observasi

- a) Identifikasi kebutuhan laktasi bagi ibu dan bayi

Terapeutik

- a) Fasilitasi ibu saat melakukan IMD
- b) Fasilitasi Ibu untuk rawat gabung atau *rooming in*
- c) Gunakan sendok dan cangkir saat bayi belum bisa menyusu
- d) Dampingi ibu selama kegiatan menyusui berlangsung, jika perlu

Edukasi

- a) Jelaskan pentingnya menyusui sampai 2 tahun
- b) Jelaskan manfaat rawat gabung atau *rooming in*
- c) Anjurkan menyusui minimal 2 kali selama hamil, dan setelah melahirkan 3-4 kali
- d) Adakan kelas edukasi tentang manfaat dan posisi menyusui pada masa preratal dan periode postpartum
- e) Anjurkan Ibu menjaga produksi ASI dengan memerah ASI
- f) Anjurkan ibu untuk memberikan nutrisi kepada bayi hanya dengan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun
- g) Anjurkan ibu memberi makanan pendamping ASI setelah 6 bulan
- h) Anjurkan ibu untuk menyusui sesering mungkin segera setelah lahir sesuai kebutuhan bayi.

2) Ketidaknyamanan pasca partum (D.0075)

Tujuan dan luaran keperawatan utama

Setelah dilakukan intervensi keperawatan 3x24 Jam, maka status kenyamanan pasca partum meningkat (L.07061).

Dengan kriteria hasil :

- a) Keluhan tidak nyaman menurun
- b) Meringis menurun
- c) Luka episiotomi membaik
- d) Kontraksi uterus membaik
- e) Berkeringat menurun
- f) Menangis menurun
- g) Merintih menurun
- h) Hemoroid membaik
- i) Tekanan darah 110/70mmHg -120/80mmHg
- j) Frekuensi nadi 60-100x/menit

Intervensi keperawatan utama ada dua, yaitu manajemen nyeri dan terapi relaksasi.

Manajemen nyeri (I.08238)

Definisi : mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan.

Tindakan :

Observasi

- a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri
- b) Identifikasi skala nyeri
- c) Identifikasi respons nyeri non verbal
- d) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri
- e) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- f) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
- g) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup
- h) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- i) Monitor efek samping penggunaan analgetik

Terapeutik

- a) Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri
- b) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri
- c) Fasilitasi istirahat dan tidur
- d) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

Edukasi

- a) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri
- b) Jelaskan strategi meredakan nyeri
- c) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
- d) Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat
- e) Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

Kolaborasi

- a) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

Terapi relaksasi (I.09326)

Definisi : menggunakan teknik peregangan untuk mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, atau kecemasan.

Tindakan :

Observasi

- a) Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif
- b) Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan

- c) Identifikasi kesediaan, kemampuan dan penggunaan teknik sebelumnya
- d) Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, suhu sebelum dan sesudah latihan

e) Monitor respon terhadap terapi relaksasi

Terapeutik

- a) Ciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan
- b) Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi
- c) Gunakan pakaian longgar
- d) Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama
- e) Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lain, jika sesuai

Edukasi

- a) Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi yang tersedia
- b) Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih
- c) Anjurkan mengambil posisi nyaman
- d) Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi
- e) Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih
- f) Demonstrasikan dan latih teknik relaksa

Mood Postpartum

Definisi: kondisi umum akibat perubahan hormon drastis, kelelahan, dan penyesuaian peran baru. Kondisi ini bisa berupa *baby blues* (sementara, 1-2 minggu) hingga *postpartum depression* (lebih berat & lama). Gejalanya meliputi sedih, cemas, mudah marah, sulit tidur, dan merasa kewalahan

Tindakan :

- a) Skrining EPDS ([*Edinburgh Postnatal Depression Scale*](#)) tujuannya : mengidentifikasi risiko depresi, bukan alat diagnosis final, dan berfokus pada suasana hati dalam 7 hari terakhir.
- b) Konseling suportif : bentuk terapi psikologis yang berfokus pada pemberian dukungan emosional, penguatan kepercayaan diri, dan peningkatan mekanisme koping (penanganan masalah) untuk membantu individu mengelola stres, krisis kehidupan, atau gangguan mental ringan.
- c) Relaksasi napas dalam
- d) Kolaborasi rujukan

Terapeutik

- a) Ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman
- b) Berikan informasi terkait perubahan peran menjadi ibu

- c) Berikan dukungan Sosial: Jangan ragu menerima bantuan dari keluarga, teman, atau pasangan dalam merawat bayi
- d) Berikan Edukasi: Memahami bahwa *baby blues* adalah hal wajar karena perubahan hormon.
- e) Fasilitasi Kelompok Dukungan (*Support Group*): Berbagi pengalaman dengan ibu lain yang mengalami hal serupa dapat mengurangi rasa terisolasi
- f) Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang Edukasi
- g) Jelaskan tujuan, manfaat, batasan perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu

F. KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

KIE terhadap Kesehatan mental dan laktasi

Penelitian menunjukkan bahwa KIE yang komprehensif, terstruktur, dan didukung oleh konseling, efektif dalam meningkatkan kesehatan mental ibu dan keberhasilan laktasi (DilyEkasari, Ahmad Wasis, Liya Ni'matul, Febrina Dwi, 2024)

1. Psikoedukasi: Menormalkan emosi nifas, deteksi dini postpartum blues dan depresi menggunakan instrumen seperti EPDS (Edinburgh Postpartum Depression Scale).
2. Dukungan Sosial & Keluarga: Melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan nifas untuk mengurangi beban mental.
3. Mekanisme Laktasi: Menjelaskan bahwa rasa tenang dan relaksasi merangsang hormon oksitosin untuk pengeluaran ASI.
4. Nutrisi & Istirahat: Pentingnya istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan fisik dan mental

Pada masa nifas di periode awal ibu cenderung menghadapi hambatan dalam menyusui dan juga adanya perubahan psikologis, hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan menyusui sekaligus meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, oleh karena itu dibutuhkan layanan postpartum komprehensif yang terpadu. Hasil penelitian Anita dkk, 2026 membuktikan penguatan layanan nifas awal perlu menekankan integrasi dukungan menyusui dan dukungan psikologis aktif, dengan keterlibatan/ suport sistem keluarga, serta menyediakan alur tindak lanjut dan rujukan yang jelas agar keberlanjutan menyusui dan kesehatan mental ibu lebih terjaga, dan menurunkan angka kejadian depresi pada ibu post partum (Anita Dewi, Tri Yuniarti, Dwi Lestari, Andriani Noerlita Ningrum, 2026).

G. Dokumentasi

Dokumentasi asuhan keperawatan ibu *postpartum* (nifas) adalah catatan sistematis meliputi pengkajian (fisik/psikologis), diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi (SOAP). Fokus utamanya mencakup pemantauan TTV, kontraksi uterus, lochea, penyembuhan luka perineum/SC, serta edukasi laktasi dan *bonding attachment*. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti legal, alat komunikasi tim medis, dan indikator kualitas layanan (Hartati, 2016)

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Contoh:

Seorang Perempuan, 22 tahun, P1A0, postpartum spontan hari kedua, dirawat di Rumah Bersalin, mengeluh ASI keluar sedikit disertai payudara bengkak, ibu terlihat cemas dan sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data : kondisi fisik normal, payudara membesar areola hitam, puting susu inverted, TFU 1 jari dibawah pusat, lochea rubra. Perawat datang mengajari teknik perawatan payudara dan menyusui bayi dengan benar.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. ASI keluar sedikit
2. Payudara bengkak
3. Puting susu inverted
4. Ibu terlihat cemas dan sedih

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi :

1. Identifikasi perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu terkait masalah menyusui
2. Identifikasi masalah yang menunjukkan ASI berkurang
3. Tentukan masalah laktasi dan psikologis ibu yang mungkin terjadi pada ibu berdasarkan data pengkajian.
4. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
- OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian perawatan payudara
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Nifas Lanjut :Laktasi Dan Kesehatan Mental Ibu
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi perawatan payudara
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Reproduksi 2. Aman dan nyaman 3. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang Perempuan, 22 tahun, P1A0, postpartum spontan hari kedua, dirawat di Rumah Bersalin, mengeluh ASI keluar sedikit disertai payudara bengkak, ibu terlihat cemas dan sedih karena tidak bisa berbuat apa apa karena kondisinya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data : kondisi fisik normal, payudara membesar areola hitam, puting susu inverted, TFU 1 jari dibawah pusat, lochea rubra. Perawat datang mengajari teknik perawatan payudara dan menyusui bayi dengan benar TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan utama(2Dx kep) pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus.

No.	Komponen	Isi
		3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara perawatan payudara dengan benar kepada ibu
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang Perempuan, 22 tahun, P1A0, postpartum spontan hari kedua, dirawat di Rumah Bersalin, mengeluh ASI keluar sedikit disertai payudara bengkak, ibu terlihat cemas dan sedih karena tidak bisa berbuat apa apa karena kondisinya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data : kondisi fisik normal, payudara membesar areola hitam, puting susu inverted, TFU 1 jari dibawah pusat, lochea rubra. Perawat datang mengajari teknik perawatan payudara dan menyusui bayi dengan benar TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara perawatan payudara dengan benar kepada ibu. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu, kondisi pembengkakan payudara yang terjadi, pengeluaran ASI, dan perubahan psikologis terhadap perubahan peran menjadi ibu 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: manajemen laktasi tidak efektif ditandai pembengkakan payudara, ASI keluar sedikit, puting susu inverted, dan masalah psikologis : cemas ditandai perubahan peran menjadi ibu 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti kaji skala nyeri, observasi

No.	Komponen	Isi
		pembengkakan payudara, observasi pengeluaran ASI , lakukan perawatan payudara, dan edukasi perawatan payudara dan cara menyusui dengan benar, serta atasi kecemasan ibu dengan pemberian edukasi 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi perawatan payudara, meliputi cuci tangan, menjelaskan tujuan, menjelaskan cara perawatan, menjelaskan cara menyusui dengan benar, serta menjelaskan masalah terkait payudara yang harus segera dilaporkan. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: ibu post partum sudah 2-3 hari perawatan. KS berperan sebagai pasien (ibu postpartum hari ke 2) 2. Riwayat penyakit sekarang: payudara bengkak, ASI berkurang, anomaly payudara (putting inverted) 3. Rawat inap saat ini adalah hari kedua, dan ini merupakan rawat inap kedua. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: ibu tampak cemas,ASI keluar sedikit, sehingga tidak bisa menyusui dengan benar 6. Harapan terhadap penyakit: ibu berharap bisa memberikan ASI , payudara tidak bengkak, putting susu eksverted dan ibu tidak merasakan nyeri dan tidak cemas. 7. Bila peserta menanyakan tentang nyeri jawaban KS: payudara bengkak dan terasa nyeri dengan skala 4. 8. Bila peserta menanyakan, jawaban KS: ibu merasa cemas karena tidak bisa menyusui bayinya karena payudara bengkak , ASI keluar sedikit, 9. KS tidur di tempat tidur dan akan duduk jika dianjurkan. payudara dapat digambarkan melalui manekin. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.

No.	Komponen	Isi
10	Setting station	Ruang Rawat ibu post partum - Tempat tidur pasien - Manekin payudara - KS berperan sebagai pasien postpartum - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin payudara 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok 5. Pengalas 7. baby oil 8. handuk 9. waslap 10. baskom 2 berisi air hangat dan air biasa 11. Lembar jawaban peserta Laboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Suryani Hartati, M.Kep.,Sp.Kep.Mat

No.	Komponen	Isi
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

**SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PERAWATAN PAYUDARA PADA NIFAS,
LANJUT LAKTASI, DAN KESEHATAN MENTAL IBU**

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. Baby oil d. Baskom berisi air hangat dan air biasa e. Waslap 2 buah f. Handuk 2 buah g. Tisu h. Bengkok/pengalas bila perlu				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama ibu postpartum dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
10	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu postpartum				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Buka pakaian bagian atas dan bra kemudian anjurkan pasien untuk duduk dengan posisi senyaman mungkin kemudian letakkan handuk besar dipangkuan pasien serta kaji kondisi payudara pasien (ada pembengkakan / lecet pada puting payudara / puting susu menonjol atau tidak)				
13	Bersihkan puting susu dengan kapas dan baby oil untuk mencegah adanya sumbatan pada lubang puting susu, jika puting masuk ajarkan niple puller				
14	Tuangkan baby oil ditelapak tangan secukupnya dan ratakan pada kedua telapak tangan				
15	Lakukan pengurutan pada kedua payudara secara melingkar mulai dari tengah payudara, keatas, samping kiri/kanan lalu kebawah kemudian angkat payudara dan lepaskan. Lakukan hal tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali.				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
16	Sokong payudara kiri dengan tangan kiri dan lakukan massage payudara kearah puting susu dengan menggunakan sisi jari kelingking tangan kanan sebanyak 15 kali. Lakukan tindakan yang sama pada payudara kanan sebanyak 15 kali.				
17	Posisikan pasien duduk dikursi dan lipat tangan pasien diatas meja / diatas kasur / pada sandaran kursi dengan posisi kepala menyandar diatas tangan dan payudara dibiarkan menggantung, sementara perawat / bidan melakukan pijatan didaerah punggung pasien dengan cara : kedua ibu jari memberi tekanan memutar disepanjang tulang belakang (mulai dari leher sampai punggung) kearah bawah selama 3 (tiga) menit.				
18	Kompres kedua payudara dengan handuk kecil air hangat dan dingin secara bergantian selama 5 (lima) menit, tujuannya untuk merangsang keluarnya ASI serta untuk mengurangi nyeri saat dilakukan massage agar payudara lebih lunak (bila payudara terasa bengkak).				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
19	Anjurkan pasien untuk melakukan / mencoba setiap tahapan gerakan perawatan payudara				
20	Anjurkan pasien untuk melakukan / mencoba setiap tahapan gerakan perawatan payudara.				
21	Observasi respon pasien selama tindakan dilakukan				
22	Meminta ibu mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan				
23	Meminta ibu mendemonstrasikan kembali cara perawatan payudara dengan benar				
24	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
25	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
26	Menyimpulkan kegiatan				
27	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
28	Memberikan reinforcement positif				
29	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
30	Mengakhiri tindakan dengan baik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
E	Tahap Dokumentasi				
31	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi perawatan payudara, respons ibu, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
32	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali tingkat nyeri ibu akibat pembengkakan payudara, pengeluaran ASI, masalah psikologis : cemas ibu					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi perawatan payudara	Menjelaskan tujuan perawatan payudara, menyiapkan alat alat dengan benar, mendemonstrasikan cara perawatan payudara					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada ibu Nifas, masalah Laktasi, perubahan psikologis peran menjadi ibu, meliputi: tingkat nyeri ibu akibat pembengkakan payudara, pengeluaran ASI, masalah psikologis : cemas ibu serta respons ibu postpartum. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas nifas tentang masalah Laktasi dan perubahan psikologis peran menjadi Ibu serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan demonstrasi perawatan payudara dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi ibu postpartum dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan ibu postpartum, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus ibu postpartum.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi kondisi payudara ibu secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti tingkat nyeri ibu akibat pembengkakan payudara, pengeluaran ASI, masalah psikologis : cemas ibu serta respons ibu postpartum., tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi, tingkat nyeri ibu akibat pembengkakan payudara, pengeluaran ASI, masalah psikologis : cemas serta respons ibu postpartum, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		sangat terbatas dan tidak relevan.	spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	kebutuhan ibu post partum
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi perawatan payudara, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi perawatan payudara secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, tindakan saat ibu postpartum cemas, serta verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematisa tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan ibu postpartum, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
30

(Kota),

.....
Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada ibu postpartum yang mengalami pembengkakan payudara, ASI keluar sedikit di ruang perawatan ibu postpartum.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang perubahan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
	mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	fisiologis dan psikologis ibu postpartum, tetapi juga kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi ibu postpartum dan menyampaikan rencana asuhan kepada ibu pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang ibu postpartum usia 22 tahun dirawat habis melahirkan dua hari yang lalu, pembengkakan payudara, sehingga ASI keluar sedikit dan mengalami kecemasan karena perubahan peran menjadi ibu.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat, terarah, memeriksa dan menjelaskan kondisi pembengkakan payudara, lalu menyampaikan rencana perawatan payudara, mengatasi nyeri dan kecemasan ibu.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengkaji skala nyeri yang dirasakan akibat adanya pembengkakan payudara dan perubahan peran menjadi ibu dengan bahasa sederhana, serta menjaga komunikasi yang baik.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya masalah manajemen laktasi, serta mampu memberikan edukasi yang tepat terkait perubahan perannya menjadi ibu.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan terkait pembengkakan payudara, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian pengeluaran ASI dan menjelaskan perubahan peran menjadi ibu
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus ibu postpartum, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3. 1 Portofolio pada Asuhan Keperawatan Ibu postpartum dengan masalah pembengkakan payudara

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan ibu post partum, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat ibu postpartum, dan Kesehatan mental ibu terkait perubahan peran menjadi ibu, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi perawatan payudara, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada ibu postpartum.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu postpartum usia 22 tahun dengan postpartum, kondisi payudara, pengeluaran ASI, adanya tanda-tanda kecemasan, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi perawatan payudara,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
		edukasi ibu, dan evaluasi respons ibu postpartum.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya perawatan payudara dan terjadinya perubahan peran menjadi ibu dengan teliti dengan cara yang benar.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu postpartum, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian terkait kesehatan mental(perubahan menjadi ibu)
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus postpartum dengan kondisi pembengkakan payudara, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan ibu postpartum secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian masalah laktasi, psikologis ibu dan komunikasi terapeutik dengan ibu postpartum.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan postpartum, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep postpartum, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 3. 2 Case Report pada Asuhan Keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu postpartum usia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
	ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	22 tahun yang dirawat karena habis melahirkan anak pertama dengan masalah laktasi dan psikologis cemas karena perubahan peran menjadi ibu .
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi ibu postpartum setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ibu postpartum, mahasiswa menuliskan skala nyeri, pembengkakan payudara, pengeluaran ASI, masalah psikologis ibu, intervensi perawatan payudara dan evaluasi kondisi payudara terkait manajemen laktasi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data pembengkakan payudara dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons ibu postpartum setelah dilakukan perawatan payudara.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus postpartum, mahasiswa belajar bahwa pengkajian kondisi payudara, manajemen laktasi, dan edukasi terkait perubahan menjadi ibu merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan ibu postpartum.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep postpartum, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 3. 3 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan tindakan pencegahan.	Pada kasus postpartum, mahasiswa merefleksikan bahwa pembengkakan payudara dapat menghambat pengeluaran ASI yang dapat menyebabkan bayi rewel bila tidak ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau kondisi payudara pada proses masalah laktasi dapat berdampak pada ibu dan bayinya.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah pembengkakan payudara, manajemen laktasi dan masalah psikologis ibu terkait kecemasan.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain pengeluaran ASI sedikit pembengkakan payudara, tanda-tanda adanya postpartum blues.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau pengeluaran ASI dengan teliti, menjelaskan cara perawatan payudara yang benar, serta mengedukasi ibu tentang perubahan menjadi ibu
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada ibu postpartum yang mengalami masalah laktasi dan kecemasan yang dirasakan, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada ibu, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan ibu postpartum secara berkelanjutan.

H. RINGKASAN

Asuhan Keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu

Bab ini menekankan bahwa masalah manajemen laktasi dan psikologis pada ibu postpartum merupakan masalah klinis yang sangat sering dijumpai dan dapat menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan Nifas Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu adalah manajemen laktasi, perubahan fisiologis dan psikologis peran menjadi ibu dan terkait masalah yang muncul seperti postpartum blues, gangguan mood dan depresi postpartum), menjaga kenyamanan ibu postpartum, serta memberikan edukasi KIE yang benar kepada ibu postpartum.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada ibu post partum tidak hanya fisiologis (system reproduksi) pada pembengkakan payudara, tetapi harus dilanjutkan dengan psikologis terkait kecemasan yang terjadi karena adanya perubahan peran menjadi ibu, pengeluaran ASI sedikit karena kondisi payudara yang bengkak, serta respons ibu akibat ASI yang keluar sedikit. Tanda-tanda seperti ASI sedikit, kondisi payudara yang bengkak, puting susu inverted, perubahan peran menjadi ibu sehingga ibu mengalami kecemasan merupakan petunjuk penting yang harus diidentifikasi sejak awal.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian perubahan fisiologis system reproduksi, psikologis (peran ibu) dan manajemen laktasi, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap kondisi payudara : bengkak dan puting susu inverted. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya manajemen laktasi tidak efektif, ketidaknyamanan pasca partum, kecemasan karena perubahan peran menjadi ibu. Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan pada perawatan payudara, pemberian ASI, serta edukasi tentang Kesehatan mental dan manajemen laktasi : cara menyusui dengan benar pada ibu postpartum.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain perawatan payudara, manajemen laktasi : pemberian ASI, serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami terkait perubahan peran menjadi ibu. Edukasi kepada ibu post partum menjadi bagian yang sangat penting, terutama mengenai cara perawatan payudara, manajemen laktasi dan Kesehatan mental ibu, kapan perlu dievaluasi lebih lanjut.

Evaluasi asuhan keperawatan ibu post partum dilakukan dengan melihat kondisi perubahan fisiologis dan psikologis ibu postpartum, misalnya ibu postpartum dapat menyusui dengan baik dan benar sehingga ASI tercukupi,

payudara sudah tidak bengkak lagi dan ibu mampu menjelaskan kembali perawatan yang harus dilakukan. Namun, apabila ditemukan masalah laktasi pada ibu seperti masih kesakitan karena kondisi payudaranya, ASI keluar sedikit, ibu tampak cemas karena tidak bisa menyusui sampai menimbulkan gangguan mood, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, preseptor, atau dokter sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu harus dilakukan secara benar, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi pada ibu postpartum, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada Keperawatan Ibu postpartum.

Tabel 3. 4 Red Flags & Eskalasi Asuhan Keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Ibu postpartum mengalami nyeri akibat pembengkakan payudara	Menunjukkan kondisi umum ASI tidak dapat dikeluarkan secara maksimal, ibu tidak bisa menyusui	laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, lakukan observasi, siapkan tindakan lanjutan
Managemen laktasi inefektif	Ketidakmampuan ibu untuk memberikan nutrisi ASI secara adekuat kepada bayi, yang sering kali ditandai dengan ketidakpuasan proses baik dari sisi ibu maupun bayi.	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Putting susu inverted	Kondisi ketika puting payudara tidak menonjol keluar, melainkan rata atau masuk ke dalam (terbalik/tenggelam) ke arah areola.	Segera laporkan dan lakukan tindakan teknik Hoffman (menekan dan memutar area areola), dan gunakan pompa ASI atau <i>nipple puller</i>
ASI keluar sedikit	Kondisi ketika produksi ASI tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bayi, ditandai dengan berat badan bayi lambat naik,	Laporkan segera, pantau status nutrisi, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
	buang air kecil jarang kali/24 jam), dan bayi rewel/lesu.	
Produksi ASI berhenti	Produksi ASI dikendalikan didalam payudara itu sendiri karena tidak adanya stimulasi/hisapan bayi	Laporkan segera, lakukan stimulasi pada bayi
Menolak menyusu/ <i>nursing strike</i>	kondisi ketika bayi yang biasanya menyusu langsung pada payudara ibu tiba-tiba menolak atau berhenti menyusu secara mendadak.	Laporkan segera, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut
Mastitis	Peradangan pada jaringan payudara yang ditandai dengan nyeri, bengkak, kemerahan, dan rasa panas, sering kali disertai demam	laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, observasi kondisi payudara, siapkan penanganan lanjutan untuk perawatan payudara

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan perubahan fisiologis (system reproduksi) dan psikologis pada ibu postpartum secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian awal fokus pada Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji tingkat/ skala nyeri karena adanya pembengkakan payudara	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu	☐	☐	
6	Saya sudah bisa melakukan perawatan payudara ibu postpartum	☐	☐	
7	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang perawatan payudara dan menyusui dengan benar	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menganjurkan kelanjutan pemberian ASI ibu postpartum	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menjelaskan perubahan peran menjadi ibu pada Nifas	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
11	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan ibu postpartum	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat Nifas, Lanjut Laktasi, Dan Kesehatan Mental Ibu	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Anik, M. (2015). *Inisiasi Menyusu Dini, ASI EKSklusif dan Manajemen Laktasi* (A. M (ed.); 1st ed.). CV Trans Info Media.
- Anita Dewi, Tri Yuniarti, Dwi Lestari, Andriani Noerlita Ningrum, I. N. (2026). Intervensi terintegrasi laktasi dan kesehatan mental pada ibu nifas awal: Scoping review. *Journal of Health Research*, 9(1), 164–182. <https://doi.org/10.36419/avicenna.v9i1.1755>
- Cashion, K., Perry, S. E., Alden, K. R., Olshansky, E., & Lowdermilk, D. L. (2019). *Maternity and Women's Health Care E-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Chang, Y., Coxon, K., Gerarda, A., Furuta, M., & Bick, D. (2017). Author ' s Accepted Manuscript between maternity care staff and women in labour: To appear in: Midwifery. *Midwifery.Elsevier*, 17(30659–9), 01–32. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.12.014>
- Cohen, S. S., Alexander, D. D., Krebs, N. F., Young, B. E., Cabana, M. D., Erdmann, P., Hays, N. P., Bezold, C. P., Levin-spargenberg, E., Turini, M., & Saavedra, J. M. (2018). Factors Associated with Breastfeeding Initiation and Continuation: *The Journal of Pediatrics*. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.08.008>
- DilyEkasari, Ahmad Wasis, Liya Ni'matul, Febrina Dwi, E. (2024). PENGARUH INFORMATION EDUCATION DAN COMMUNICATION (IEC) CARA MENYUSUI TERHADAP KETERAMPILAN DAN EFIKASI DIRI PADA IBU NIFAS. *Journal of Language and Health*, 5(3), 1335–1346. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JLH>
- Gaurav Chauhan & Prasanna Tadi. (2022). *Fisiologi, Perubahan Pascapersalinan*. Klinik Cleveland 2 Perguruan Tinggi Kedokteran Asram, Eluru, India. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/>
- Hartati, S. (2016). *PENERAPAN TEORI SELF CARE OREM DAN COMFORT KOLCABA PADA IBU POST PARTUM SEKSIO SESAREA DENGAN TUBEKTOMI* *Aplication Theory Self Care of Orem and Theory Comfort of Colcaba for Postpartum Women with Caesarean Section Tubectomy*. 7, 146–155.
- INNA. (2017a). *Indonesian Nursing Diagnosis Standards*. Indonesian National Nurses Association.
- INNA. (2017b). *Indonesian Nursing Intervention Standards*. Indonesian National Nurses Association.
- INNA. (2017c). *Indonesian Nursing Outcome Standards*. Indonesian National Nurses Association.
- Kholifah, E., Azzahroh, P., & Suciawati, A. (2022). *Hubungan Pengetahuan Perubahan Fisik dan Psikologis dengan Penyesuaian Diri Wanita Premenopause* *The*

Relationship of Knowledge , Physical and Psychological Changes with the Adjustment of Premenopausal. 11(2), 70–78.

Nanda. (2021). *Nursing Diagnoses Definitions and Classification 2021-2023* (Twelfth). Thieme Medical Publishers, Inc.

Nugroho, A. (2021). *Teori keperawatan ramona t mercer* ". 1–29.

Nurbaeti, I., Deoisres, W., & Hengudomsub, P. (2018). Postpartum Depression in Indonesian Mothers : Its Changes and Predicting Factors. *Pacific Rim Int J Nurs Res*, 22(2), 93–105.

Pratiwi, Liliek, Qomariyah, Albertin, Mahfuzhob, Cristien, A. (2024). *Kesehatan mental postpartum* (Hani wijayanti (ed.); 1st ed.). CV Jejak. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iOwCEQAAQBAJ>

Reeder, Martin, & Koniak-Griffin. (2012). *Keperawatan Maternitas Vol 2* (18th ed.). EGC.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik*. Dewan Pengurus PPNI.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan* (II (ed.); 1st ed.). DPP PPNI.

BAB 4

KEGAWATDARURATAN MATERNAL: PERDARAHAN POSTPARTUM DAN SYOK

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Kegawatdaruratan Maternal: Perdarahan Postpartum dan Syok	4.1 Melakukan penilaian cepat perdarahan postpartum dan syok berdasarkan prioritas ABC dan hemodinamik.	4.2 Melaksanakan stabilisasi awal, koordinasi tim, dan rujukan kegawatdaruratan maternal sesuai protokol.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-7

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	OSCE/simulasi keterampilan + penilaian komunikasi	Ketepatan langkah tindakan; keselamatan prosedur; kualitas komunikasi terapeutik; kualitas edukasi (teach-back)	20	Checklist keterampilan; rekaman/video simulasi
CPMK-6	Simulasi kegawatdaruratan (drill) + skenario tertulis	Kecepatan identifikasi tanda bahaya; ketepatan urutan stabilisasi awal; ketepatan keputusan kolaborasi/rujukan	20	Checklist drill; laporan respons skenario
CPMK-7	Portofolio klinik/proyek perencanaan pulang	Kelengkapan dokumentasi evaluasi; kelengkapan rencana pulang; kesesuaian rencana layanan reproduksi pascapersalinan	10	Portofolio; format dokumentasi & discharge plan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat $\leq 50\%$ elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat $\geq 85\%$ elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien & etik pada skenario maternitas	Identifikasi risiko & tindakan aman $\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	Identifikasi 51–69%; tindakan aman ada namun belum lengkap.	Identifikasi 70–84%; keputusan aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	Identifikasi $\geq 85\%$; keputusan aman, preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas;	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup;	Rasional baik; prioritas jelas;	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	evaluasi tidak terencana ($\leq 50\%$ memadai).	evaluasi parsial (51–69%).	evaluasi sesuai luaran (70–84%).	komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

Pendahuluan

Perdarahan Postpartum dan syok adalah materi yang merupakan bagian dari kegawatdaruratan maternal. Mahasiswa diminta mampu mendeteksi gejala Perdarahan Postpartum dan syok dengan cepat, melakukan asuhan keperawatan secara profesional karena sangat mengancam nyawa ibu postpartum.

A. Teori

1. Definisi

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi setelah proses persalinan dengan jumlah darah yang melebihi batas normal. Perdarahan postpartum umumnya didefinisikan sebagai kehilangan darah lebih dari 500 ml setelah persalinan pervaginam atau lebih dari 1000 ml setelah persalinan dengan operasi sesar. Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi obstetri yang sering terjadi dan menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu apabila tidak segera ditangani secara tepat (Febriyanti, Sanjaya, & Maulani, 2021).

Syok adalah kondisi medis yang terjadi ketika aliran darah ke organ-organ tubuh tidak mencukupi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Syok dapat menyebabkan kerusakan organ dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat (American College of Surgeons, 2018).

2. Etiologi

Penyebab perdarahan postpartum dapat diklasifikasikan dalam beberapa faktor utama, yaitu:

a. Atonia uteri

Atonia uteri merupakan penyebab paling sering dari perdarahan postpartum. Kondisi ini terjadi ketika uterus tidak mampu berkontraksi dengan baik setelah persalinan sehingga pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta tidak tertutup dengan sempurna.

b. Retensio plasenta

Retensio plasenta terjadi ketika sebagian atau seluruh plasenta tertinggal di dalam uterus setelah proses persalinan. Keadaan ini dapat menghambat kontraksi uterus dan menyebabkan perdarahan.

c. Trauma jalan lahir

Trauma atau robekan pada serviks, vagina, atau perineum yang terjadi selama proses persalinan juga dapat menyebabkan perdarahan setelah melahirkan.

d. Gangguan pembekuan darah

Gangguan pada sistem koagulasi dapat menyebabkan proses penghentian perdarahan tidak berjalan dengan baik sehingga perdarahan berlangsung lebih lama.

Selain faktor tersebut, beberapa kondisi seperti anemia pada ibu hamil, persalinan lama, dan paritas tinggi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan postpartum.

3. Faktor risiko

Menurut ACOG, 2020 yang menjadi Risiko terjadinya perdarahan postpartum adalah:

- a. Riwayat perdarahan postpartum sebelumnya.
- b. Persalinan lama
- c. Persalinan dengan tindakan (vakum atau forceps).
- d. Kehamilan ganda.
- e. Plasenta previa.
- f. Hipertensi.
- g. Gangguan koagulasi (hemofilia).
- h. Anemia.
- i. Usia ibu (Usia ibu >35 tahun atau <20 tahun).
- j. Obesitas. : Obesitas dapat meningkatkan risiko PPP.

4. Patofisiologi

Setelah bayi dan plasenta lahir, uterus normalnya akan berkontraksi untuk menutup pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta. Kontraksi ini berfungsi sebagai mekanisme alami tubuh untuk menghentikan perdarahan.

Apabila uterus tidak mampu berkontraksi dengan baik atau terjadi atonia uteri, maka pembuluh darah tetap terbuka sehingga darah terus keluar dari tempat

implantasi plasenta. Kehilangan darah yang berlebihan akan menyebabkan penurunan volume darah dalam sirkulasi tubuh.

Penurunan volume darah tersebut dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, serta penurunan perfusi jaringan. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat berkembang menjadi syok hipovolemik yang dapat mengancam keselamatan ibu.

5. Klasifikasi

Perdarahan postpartum dibagi menjadi dua yaitu perdarahan postpartum primer yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan perdarahan postpartum sekunder yang terjadi setelah 24 jam hingga beberapa minggu setelah persalinan (Fegita, 2022).

6. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala yang dapat ditemukan pada ibu dengan perdarahan postpartum antara lain:

- a. Perdarahan berlebihan setelah persalinan
- b. Uterus lembek atau tidak berkontraksi dengan baik
- c. Tekanan darah menurun
- d. Denyut nadi meningkat (takikardia)
- e. Kulit pucat dan berkeringat dingin
- f. Pusing, lemah, dan penurunan kesadaran pada kondisi berat

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit untuk menilai tingkat kehilangan darah.
- b. Pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, frekuensi nadi, dan respirasi.
- c. Ultrasonografi (USG) untuk mengetahui adanya sisa jaringan plasenta dalam uterus.
- d. Pemeriksaan sistem pembekuan darah untuk mengetahui adanya gangguan koagulasi.

8. Komplikasi

Apabila tidak segera ditangani, perdarahan postpartum dapat menyebabkan berbagai komplikasi, antara lain:

- a. Anemia berat
- b. Syok hipovolemik
- c. Gangguan fungsi organ
- d. Kematian ibu

Syok adalah kondisi medis yang terjadi ketika aliran darah ke organ-organ tubuh tidak mencukupi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Syok dapat menyebabkan kerusakan organ dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Syok Hipovolemik: terjadi karena kehilangan darah atau cairan tubuh yang berlebihan, seperti pada kasus perdarahan postpartum.

9. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan perdarahan postpartum bertujuan untuk menghentikan perdarahan serta mempertahankan kondisi hemodinamik ibu. Penanganan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Masase uterus untuk merangsang kontraksi uterus.
- b. Pemberian obat uterotonik seperti oksitosin atau misoprostol.
- c. Pemberian cairan intravena untuk menggantikan kehilangan cairan.
- d. Transfusi darah apabila terjadi kehilangan darah yang cukup banyak
- e. Tindakan pembedahan apabila perdarahan tidak dapat dihentikan dengan terapi konservatif.

B. Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

- a. Kaji Perdarahan: perdarahan berlebihan setelah persalinan (>500 cc)
- b. Lakukan pemeriksaan Uterus: Uterus lembek atau tidak berkontraksi dengan baik menunjukkan adanya perdarahan.
- c. Kaji tanda vital khususnya Tekanan darah dan nadi: Tekanan darah yang menurun, denyut nadi meningkat (takikardia) perlu diwaspadai kemungkinan adanya perdarahan postpartum,
- d. Awasi warna kulit: warna kulit pucat dan berkeringat dingin menunjukkan tanda perdarahan.
- e. Tanyakan keluhan yang dirasakan oleh pasien: Pusing, lemah, dan penurunan kesadaran pada kondisi berat
- f. Periksa hasil uji laboratorium, terutama hemoglobin dan hematokrit, Laju endap darah (Nia Risa Dewi et al., 2022).

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosis keperawatan didapatkan setelah perawat melakukan pengkajian, yang mana diagnosis keperawatan ini terdiri dari aktual, risiko dan promosi kesehatan. Menurut Tim Pokja Keperawatan DPP PPNI, 2018, Diagnosis keperawatan terbagi menjadi 5 kategori yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional dan lingkungan. Berikut adalah masalah keperawatan yang mungkin didapatkan berdasarkan kategori adalah :

a. Hipovolomia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif (D.0023)

Definisi: penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, dan/atau intaseluler.

Penyebab:

- 1) Kehilangan cairan aktif
- 2) Kegagalan mekanisme regulasi
- 3) Peningkatan permeabilitas kapiler
- 4) Kekurangan intake cairan
- 5) Evaporasi

Gejala dan tanda mayor:

Subyektif: tidak tersedia

Obyektif :

- 1) Frekuensi nadi meningkat
- 2) Nadi teraba lemah
- 3) Tekanan darah menurun
- 4) Tekanan nadi menyempit
- 5) Turgor kulit menurun
- 6) Membran mukosa menggering
- 7) Volume urin menurun
- 8) Hematokrit meningkat

Gejala dan tanda minor

Subyektif: Pasien merasa lemah, dan haus

Obyektif:

- 1) Pengisian vena menurun
- 2) Perubahan status mental
- 3) Suhu tubuh meningkat
- 4) Konsentrasi urine meningkat
- 5) Berat badan turun tiba tiba

b. Perfusi Perifer tidak Efektif berhubungan dengan Penurunan Konsentrasi Hemoglobin (D.0009)

Definisi: penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh.

Penyebab:

- 1) Hiperglikemi
- 2) Penurunan konsentrasi hemoglobin
- 3) Peningkatan tekanan darah
- 4) Penurunan volume cairan
- 5) Penurunan aliran arteri

6) Kurangnya terpapar informasi tentang faktor penggerak

7) Kurangnya terpapar informasi tentang proses penyakit

8) Kurang aktifitas fisik

Gejala dan tanda mayor:

Subyektif: Nyeri ekstremitas

Obyektif :

1) Waktu pengisian kapiler >3 detik

2) Nadi perifer menurun/tdk teraba

3) Akral teraba dingin

4) Warna kulit pucat

5) Turgor kulit menurun

Gejala dan tanda minor:

Subyektif: Parastesia

Obyektif :

1) Edema

2) Penyembuhan luka lambat

3) Indeks ankle-brakial <0,90

4) Bruit femoral

c. Risiko Infeksi dibuktikan dengan Kerusakan Jaringan Integritas Kulit (D.0142)

Definisi: berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.

Faktor risiko:

1) Penyakit kronis

2) Efek prosedur infasif

3) Malnutrisi

4) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan

5) Ketidak adekuatan pertahanan tubuh primer atau sekunder

d. Ansietas berhubungan dengan Krisis Situasional (D.0080).

Definisi: kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terdapat obyek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman.

Penyebab:

1) Krisis situasional

2) Kebutuhan tidak terpenuhi

3) Krisis maturasional

4) Ancaman terhadap konsep diri

Gejala dan tanda mayor:

Subyektif: Merasa pusing

Obyektif :

1) Gelisah

2) Tampak lemah

Gejala dan tanda minor:

Subyektif: pusing, tidak berdaya

Obyektif :

1) Frekuensi nafas dan nadi meningkat

2) Muka pucat

3) Tremor

4) Palpitasi

5) Tegang

3. Intervensi dan Implementasi

Berikut adalah intervensi dan implementasi keperawatan pada pasien dengan perdarahan postpartum berdasarkan Tim POKJA SIKI PPNI (2018):

Tabel 4. 1 Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosa Keperawatan (SDKI)	SLKI		SIKI	
		Out come	Kriteria hasil	Intervensi	Aktivitas
1.	Hipovolomia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dibuktikan dengan Pasien kemudian mengeluh merasa pusing, lemas, dan pandangannya berkunang-kunang. Pasien juga mengatakan tubuhnya terasa dingin dan tidak memiliki tenaga. Nadi teraba lemah 80 kali/menit. TD 90/60 mmHg Volume urine 98ML/24 jam	Status Cairan (L.03028)	Setelah diberikan asuhan keperawatan diharapkan: 1. Kekuatan nadi meningkat, 2. Turgor kulit meningkat, 3. Output urine meningkat, 4. Dispnea menurun, 5. Perasaan lemah menurun, 6. Konsentrasi urine menurun, 7. Frekuensi Nadi membaik, 8. Tekanan Darah membaik 9. Tekanan nadi membaik,	Manajemen Syok Hipovolemik (1.02050)	Observasi: - Memonitor status kardiopulmonal (frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD, MAP) - Memonitor status oksigenasi (Oksimetri nadi, AGD) - Memantau tingkat kesadaran dan respon pupil Terapeutik: - Mempertahankan jalan napas paten - Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94% - Melakukan penekanan langsung (direct pressure) pada perdarahan eksternal - Berikan posisi syok (modified trendelenberg)

	Suhu 38,3 °C Hematokrit 52% Pasien tampak lemah Pengisian vena menurun (jumlah darah yang keluar ±800 mL). (D.0023)		10. Membran mukosa Membaik, 11. Kadar Hb membaik, 12. Kadar Ht membaik, 13. Suhu Tubuh membaik		- Pasangkan kateter urine untuk menilai produksi urine - Ambilkan sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit Kolaborasi: - Memberikan infus cairan kristaloid 1-2L pada dewasa - Memberikan transfusi darah
2.	Perfusi Perifer tidak Efektif berhubungan dengan Penurunan Konsentrasi Hemoglobin dibuktikan dengan Pasien kemudian mengeluh merasa pusing, lemas, dan pandangannya berkunang-kunang. Nadi teraba lemah 80 kali/menit, Elastisitas turgor kulit menurun, Kulit Pucat	Tingkat Pendarahan (L.12111)	Setelah diberikan asuhan keperawatan diharapkan: 1.Pendarahan vagina menurun 2.Hemoglobin membaik 3.Hematokrit Membaik 4.Tekanan darah membaik 5.Frekuensi nadi membaik 6.Suhu Tubuh membaik	Manajemen Syok (1.02048)	Observasi - Memonitor status kardiopulmonal (frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD, MAP) - Memonitor status oksigenasi (oksimetri nadi, AGD) - Memonitor status cairan (masukan dan haluan, turgor kulit CRT) - Memonitor tingkat kesadaran dan respon pupil - Memeriksa seluruh permukaan tubuh terhadap adanya DOTS (luka terbuka, tenderness/nyeri tekan, swelling/bengkak) Terapeutik - Mempertahankan jalan napas paten - Memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94% - Memberikan posisi syok (modified Trendelenberg) - Memasang jalur IV - Memasang kateter urine untuk menilai produksi urine Kolaborasi

					-Mengkolaborasi pemberian infus cairan kristaloid 1 – 2zL pada dewasa -Mengkolaborasi pemberian transfusi darah
3.	Risiko Infeksi dibuktikan dengan Kerusakan Jaringan Integritas Kulit	Integritas Kulit dan Jaringan (L.14125)	Setelah diberikan asuhan keperawatan diharapkan: 1. Elastisitas meningkat 2. Kerusakan jaringan cukup menurun 3. Nyeri Menurun 4. Pendarahan menurun 5. Suhu Kulit membaik	Perawatan Perineum (1.07226)	Observasi - Menginspeksi insisi atau robekan perineum (mis. episiotomi) Terapeutik - Memfasilitasi dalam membersihkan perineum pertahankan perineum tetap kering - Memberikan posisi nyaman - Membersihkan area perineum secara teratur - Memberikan pembalut yang menyerap cairan Edukasi - Mengajarkan pasien dan keluarga mengobservasi tanda abnormal pada perineum (mis. infeksi, kemerahan, pengeluaran cairan yang abnormal) Kolaborasi -Mengkolaborasi pemberian antiinflamasi -Mengkolaborasi pemberian analgesik
4.	Ansietas berhubungan dengan Krisis Situasional dibuktikan dengan pasien juga tampak gelisah, selama dilakukan observasi, pasien tampak tegang, sering memegang tangan perawat, dan beberapa kali menarik napas		Setelah diberikan asuhan keperawatan diharapkan: 1. Vebraliasi kebingungan menurun 2. Vebraliasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi cukup menurun	Terapi Relaksasi (1.09326)	Observasi -Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif - Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan

	dalam. Wajah pasien terlihat cemas dan pasien mengatakan merasa takut dengan kondisi yang sedang dialaminya. Tampak Gelisah, Tampak Tegang, Merasa Khawatir dengan dari kondisi yang dihadapi, Wajah tampak pucat, Respirasi 24 kali per menit		3. perilaku gelisah menurun 4. perilaku tegang cukup menurun 5. pucat menurun 6. Frekuensi pernapasan membaik 7. Frekuensi nadi membaik 8. Tekanan Darah membaik 9. Pola berkemih cukup membaik		- Memonitor respons terhadap terapi relaksasi Terapeutik - Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman - Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama - Menggunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lain, jika sesuai Edukasi - Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif) - Menganjurkan mengambil posisi nyaman - Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi - Menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih - Mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi (napas dalam, peregangan)
--	--	--	--	--	---

4. Dokumentasi

Dokumentasi asuhan keperawatan ibu perdarahan postpartum adalah catatan sistematis meliputi pengkajian (fisik/psikologis), diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi (SOAP). Fokus utamanya mencakup pemantauan jumlah perdarahan (lochea), TTV, kontraksi uterus, sumber perdarahan, keluran yang dirasakan, akral. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti legal, alat komunikasi antara perawat dengan tim medis maupun dengan keluarga.

Aktivitas 1-*Knows How*

Mini-case tertulis

Contoh kasus:

Seorang Perempuan, 28 tahun, P2A0, dirawat diruang bersalin, karena baru saja melahirkan secara spontan 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian: tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110 kali/menit, TFU setinggi pusat, kontraksi uterus lembek, wajah tampak pusat, gelisah dan ibu merasa pusing, observasi luaran pembalut penuh dalam waktu singkat.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi :

1. Identifikasi kondisi ibu postpartum yang mengalami perdarahan.
2. Identifikasi masalah yang menunjukkan perdarahan postpartum.
3. Tentukan masalah keperawatan yang terjadi pada kasus tersebut berdasarkan data pengkajian.
4. Tentukan diagnosa keperawatan yang utama pada kasus tersebut.
5. Tentukan intervensi keperawatan yang utama pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab rujukan.

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Tabel 4. 2 Asesmen

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Rujukan pasien

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
- OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian rujukan
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	
2	Judul station	Perdarahan postpartum
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi penanganan perdarahan postpartum.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Reproduksi 2. Aman dan nyaman 3. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang Perempuan, 22 tahun, P1A0, postpartum spontan 1jam yang lalu dirawat di ruang bersalin, mengalami perdarahan per vagina sekitar 700 cc. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data : tekanan darah 80/60 mmHg, denyut nadi 120 x/mnt, TFU setinggi pusat, lochea rubra, wajah tampak pucat. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan utama pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan tindakan keperawatan dalam menangani perdarahan postpartum dengan benar.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang Perempuan, 22 tahun, P1A0, postpartum spontan 1jam yang lalu dirawat di ruang bersalin, mengalami perdarahan per vagina sekitar 700 cc. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data : tekanan darah 80/60 mmHg, denyut nadi 120 x/mnt, TFU setinggi pusat, lochea rubra, wajah tampak pucat. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS.

		2. Tuliskan diagnosis keperawatan utama pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan tindakan keperawatan dalam menangani perdarahan postpartum dengan benar. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan yang utama : Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif (D.0023) 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam penanganan perdarahan . 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: ibu post partum 2. Riwayat penyakit sekarang: perdarahan postpartum. 3. Bila peserta menanyakan tentang pusing jawaban KS: merasa pusing. 4. Bila peserta menanyakan kecemasan jawaban KS: ibu merasa cemas. 5. KS tidur di tempat tidur dengan kondisi lemah .
10	Setting station	Ruang Rawat ibu post partum - Tempat tidur pasien - Manekin payudara - KS berperan sebagai pasien postpartum - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin payudara 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu

		4. Bengkok 5. Pengalas 7. cairan infus 8. abocath 9. kasa 10.plester 11. turnikuit 12. Lembar jawaban pesertaLaboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP PEMASANGAN INFUS

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A1.	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2 2.	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a Baki yang telah dialas berisi 1. Infus set 2. Cairan yang diperlukan 3. Abocath, semprit/jarum 4. Kasa steril dalam tempat yang steril 5. Kapas alcohol dan tempatnya 6. Bethadine 7. Plester 8. Gunting Verban/kassa gulung, 9. Torniket 10. Bengkok 11. Perlak kecil dan alasnya 12. Tiang infus 13. Gantungan infus, spalk dan lain-lain kalau perlu.				
33	Mencuci tangan				
4	Tahap Orientasi				
45	Menyampaikan salam terapeutik				
56	Menyampaikan nama dan peran perawat				
67	Mengecek identitas pasien, minimal nama ibu postpartum dan tanggal lahir/umur secara aktif				
78	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
89	Memberi kesempatan bertanya				
910	Tahap kerja: Memulai tindakan dengan baik 1. Mencuci tangan				

2. Alat-alat yang telah disiapkan dibawa kedekat klien 3. Perlak dan alasnya dipasang dibawah anggota badan (Ekstremitas) yang akan dipasang infuse 4. Siapkan infuse set, pastikan klem dalam keadaan terkunci, lalu dipasangkan pada botol cairan 5. Botol cairan digantung pada tiang infuse 6. Isi tabung tetesan secukupnya jangan terlalu penuh 7. Buka klem dan aliran cairan dalam selang infuse, kemudian tutup kembali (jangan sampai ada udara dalam selang infus) 8. Lengan pasien bagian atas dibendung dengan tourniquet dan klien diminta untuk mengpalkan tangan seperti mau tinju) 9. Tentukan daerah/vena yang akan dipasang infus 10. Daerah/tempat menusuk vena tersebut didesinfeksi dengan kapas alkohol 11. Kemudian tusukkam jarum/abokat ke vena tersebut hingga berhasil 12. Bila berhasil, darah akan keluar, jarum ditarik sedikit, kemudian abokat dimasukkan hingga penuh 13. Tourniquet dilepas, minta klien untuk melepaskan kepala tangannya,				
--	--	--	--	--

14. Jarum abokat ditarik, ujung abokat pada tempat tusukan ditekan 15. Kemudian sambung/pasang selang infus, dengan abocath yang telah terpasang tersebut (keluarkan cairan sedikit biar udara diujung selang tidak masuk vena) 16. Klem dilonggarkan untuk melihat kelancaran tetesan/cairan 17. Bila tetesan lancar, beri bethadine pada daerah yang ditusuk jarum kemudian viksasi dengan plester 18. Jarum dan tempat tusukan ditutup dengan kassa steril lalu dilester 19. Tetesan diatur sesuai dengan yang ditentukan (dosis pemberian) 20. Bila perlu pasang spalk (untuk anak-anak) agar jarum infus tidak bergeser 21. Bila pemberian infus selesai cara melepas : infus distop plester dilepas kemudian jarum dicabut, bekas tusukan ditekan dengan kapas alkohol, lalu ditutup dengan plester 22. Bereskan alat-alat yang telah digunakan 23. Pasien dirapikan dan posisi diusahakan senyaman mungkin 24. Perhatikan kelancaran cairan dan jumlah tetesan harus tepat 25. Bila terjadi phlebitis dihentikan segera &				
--	--	--	--	--

	dipindahkan pemasangannya ke bagian ekstremitas yang lain 26. Catat tanggal pemasangan pada botol infus/plester yang telah melekat diatas abocath				
11	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu postpartum				
12	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
13	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
4	Tahap Terminasi				
15	Menyimpulkan kegiatan				
16	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
17	Memberikan reinforcement positif				
18	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
19	Mengakhiri tindakan dengan baik				
	Tahap Dokumentasi				
20	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan pemasangan infus. serta tindak lanjut				
22	Penampilan Profesional				
23	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

RUBRIK PENILAIAN OSCE

STATION .. : PEMASANGAN INFUS DI RUANG RAWAT INAP

Rubrik

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Pelaksanaan pemasangan infus.	Peserta tidak melakukan tindakan pemasangan infus atau melakukannya salah total yaitu: 1. Tidak menentukan area yang akan dipasang infus 2. Gagal penusukan vena dengan benar. 3. Tidak memasang abocath dengan benar. 4. tidak dapat memasang slang infus dengan benar. 5. Tidak dapat mengatur cairan sesuai kebutuhan 6. Tidak melakukan fiksasi dengan rapi 7. Tidak menjelaskan cara menjaga area pemasangan infus.	Peserta melakukan pemasangan infus 2-4 prinsip dasar, namun masih terdapat banyak kesalahan teknis atau urutan tidak tepat 1. Menentukan area yang akan dipasang infus 2. Melakukan penusukan vena dengan benar. 3. Memasang abocath dengan benar. 4. Dapat memasang slang infus dengan benar. 5. Dapat mengatur cairan sesuai kebutuhan 6. Melakukan fiksasi dengan rapi 7. Menjelaskan cara menjaga area pemasangan infus.	Peserta melakukan pemeriksaan Leopold dengan memperhatikan 5-6 prinsip dasar, urutan sebagian besar benar, meskipun ada kesalahan kecil 1. Menentukan area yang akan dipasang infus 2. Melakukan penusukan vena dengan benar. 3. Memasang abocath dengan benar. 4. Dapat memasang slang infus dengan benar. 5. Dapat mengatur cairan sesuai kebutuhan 6. Melakukan fiksasi dengan rapi 7. Menjelaskan cara menjaga area pemasangan infus.	Peserta melakukan pemeriksaan Leopold dengan memperhatikan 5-6 prinsip dasar, urutan sebagian besar benar, meskipun ada kesalahan kecil 1. Menentukan area yang akan dipasang infus 2. Melakukan penusukan vena dengan benar. 3. Memasang abocath dengan benar. 4. Dapat memasang slang infus dengan benar. 5. Dapat mengatur cairan sesuai kebutuhan 6. Melakukan fiksasi dengan rapi 7. Menjelaskan cara menjaga area pemasangan infus.	6	

2. Evaluasi	Peserta tidak melakukan evaluasi hasil pemasangan infus: 1. Ketepatan Lokasi pemasangan. 2. Tetesan infus 3. Fiksasi yang aman dan rapi 4. Merapikan alat dan area tindakan 5 Melakukan cuci tangan sesuai prosedur	Peserta melakukan dengan memperhatikan 2-3 poin prinsip: 1. Ketepatan Lokasi pemasangan. 2. Tetesan infus 3. Fiksasi yang aman dan rapi 4. Merapikan alat dan area tindakan 5 Melakukan cuci tangan sesuai prosedur	Peserta melakukan evaluasi dengan memperhatikan 4 poin prinsip dari : 1. Ketepatan Lokasi pemasangan. 2. Tetesan infus 3. Fiksasi yang aman dan rapi 4. Merapikan alat dan area tindakan 5 Melakukan cuci tangan sesuai prosedur	Peserta melakukan evaluasi dengan memperhatikan semua 5 prinsip, dilakukan dengan runtut, tenang, dan empatik. 1. Ketepatan Lokasi pemasangan. 2. Tetesan infus 3. Fiksasi yang aman dan rapi 4. Merapikan alat dan area tindakan 5 Melakukan cuci tangan sesuai prosedur	2
3. Perilaku Profesional	1 Peserta ujian tidak meminta ijin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien	2 Peserta ujian meminta ijin secara lisan dan 1-2 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien	3 Peserta ujian meminta ijin secara lisan dan melakukan 3 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien	4 Peserta ujian meminta ijin secara lisan dan melakukan poin berikut secara lengkap: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien	2

	3. Melakukan tindakan sesuai prioritas	dan diri sendiri				
	4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien	2. Memperhatikan kenyamanan pasien				
		3. Melakukan tindakan sesuai prioritas				
		4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien				

Nilai : Jumlah total : 10

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

C. Ringkasan

Bab ini menekankan bahwa masalah perdarahan post partum yang bisa berlanjut menjadi syok hipovolemik dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian pada ibu.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada ibu postpartum dengan perdarahan diperlukan tindakan yang cepat dan tepat.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian yang meliputi tanda-tanda vital, kontraksi uterus, jumlah darah yang keluar dan keluhan yang dirasakan oleh ibu. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya

hipovolemi. Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan pada keselamatan pasien.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik pemasangan infus yang sistematis.

Evaluasi asuhan keperawatan ibu post partum dilakukan dengan melihat kondisi fisik (Tanda tanda vital) dan keluhan yang dirasakan ibu.

Tabel 4. 3 Red Flags & Eskalasi Perdarahan postpartum

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Ibu postpartum mengalami perdarahan	Menunjukkan kondisi umum ibu yang ditandai dengan Tensi turun, perdarahan lebih dari 500 cc.	laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, lakukan observasi, siapkan tindakan lanjutan
Fundus Uteri setinggi pusat	Menunjukkan kontraksi uterus yang kurang baik, sehingga terjadi perdarahan intra uteri yang menyebabkan gangguan penurunan uterus	Lakukan kolaborasi dengan medis dalam pemberian infus dan obat utero tonika
Syok	Kondisi medis yang terjadi ketika aliran darah ke organ-organ tubuh tidak mencukupi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Syok dapat menyebabkan kerusakan organ dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat	Segera laporkan dan lakukan tindakan emergency untuk mencegah kematian.

D. Latihan Evaluasi Bab

Pilihan Ganda.

Soal 1.

Seorang Perempuan, 28 tahun, P2A0, 1 jam setelah melahirkan normal mengalami perdarahan hebat. Pembalut penuh dalam waktu singkat. Ibu tampak pucat, gelisah, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110 kali/menit, fundus uteri setinggi pusat dan uterus teraba lembek.

Apakah yang terjadi pada kasus tersebut?

- A. Infeksi puerperium
- B. Perdarahan postpartum
- C. Preeklampsia postpartum
- D. Involusi uterus normal

Soal 2

Seorang perempuan, 28 tahun , P2A0, 2 jam setelah persalinan mengalami perdarahan sekitar 700 ml. Ibu mengeluh pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 85/60 mmHg, nadi 120 kali/menit, kulit dingin dan pucat.

Apakah Diagnosis keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Nyeri akut
- B. Gangguan pola tidur
- C. Defisit volume cairan (hipovolemik)
- D. Intoleransi aktivitas

Soal 3

Seorang perempuan, 28 tahun , P2A0, mengalami perdarahan aktif dan menunjukkan tanda-tanda hipovolemia. Perawat menilai pasien berisiko mengalami syok hipovolemik.

Apakah tindakan awal yang paling tepat yang harus dilakukan?

- A. Memberikan makanan tinggi zat besi
- B. Memantau suhu tubuh setiap 4 jam
- C. Memasang infus dan memberikan cairan intravena
- D. Mengajarkan teknik relaksasi

Soal 4

Seorang perempuan, 28 tahun , P2A0, mengalami perdarahan postpartum akibat atonia uteri. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya volume darah yang beredar sehingga berpotensi menimbulkan syok.

Apakah tanda awal yang harus diwaspadai pada kasus tersebut?

- A. Tekanan darah meningkat
- B. Kulit hangat dan kemerahan
- C. Nadi cepat dan lemah
- D. Pernapasan melambat

Soal 5

Seorang perempuan, 28 tahun , P2A0, postpartum dengan perdarahan aktif menunjukkan tanda pucat, akral dingin, dan kesadaran mulai menurun. Perawat mencurigai kondisi menuju syok hipovolemik.

Apakah tujuan utama penatalaksanaan pada kondisi tersebut?

- A. Mengurangi rasa nyeri pasien
- B. Menghentikan perdarahan
- C. Meningkatkan produksi ASI
- D. Mempercepat mobilisasi ibu

Kunci Jawaban

- 1. *Jawaban: B*
- 2. *Jawaban: C*
- 3. *Jawaban: C*
- 4. *Jawaban: C*
- 5. *Jawaban: B*

Rubrik Ringkas

RB-05 — Observasi Profesionalisme Dasar (Skala 1–4)

Dinilai saat diskusi/skills lab awal.

Aspek	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
Disiplin & tanggung jawab	sering terlambat/tidak siap	kadang terlambat	tepat waktu & siap	proaktif membantu & sangat siap
Komunikasi sopan	tidak sopan/meremehkan	kadang kurang tepat	sopan & jelas	empatik, menenangkan, menghargai
Menjaga privasi/etika belajar	melanggar	perlu diingatkan	konsisten	menjadi teladan
Keselamatan belajar (aturan lab)	mengabaikan	kadang lupa	patuh	sangat patuh + mengingatkan teman
Refleksi & perbaikan diri	menolak feedback	pasif	menerima & memperbaiki	reflektif, minta umpan balik

Kriteria: rata-rata ≥ 3 untuk “memenuhi”.

RB-06 — Refleksi Singkat (untuk portofolio)

Mahasiswa menulis 150–200 kata:

- “Tanda dan gejala perdarahan postpartum apa saja yang telah saya ketahui?”
- “Ketrampilan apa yang akan saya lakukan dalam penanganan perdarahan postpartum?”

Skor baik jika refleksi spesifik, ada rencana perbaikan, bukan sekadar cerita.

Referensi

- ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists). 2020. Postpartum Hemorrhage.
- American College of Surgeons. (2018). ATLS: Advanced Trauma Life Support.
- Dewi, I., Jubaedah, A., & Kusmawati, D. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian perdarahan postpartum. *Jurnal Ilmiah Bidan*.
<https://journal.stikespid.ac.id/index.php/jspid/article/view/54>
- INNA. (2017a). *Indonesian Nursing Diagnosis Standards*. Indonesian National Nurses Association.
- INNA. (2017b). *Indonesian Nursing Intervention Standards*. Indonesian National Nurses Association.
- INNA. (2017c). *Indonesian Nursing Outcome Standards*. Indonesian National Nurses Association.
- Febriyanti, H., Sanjaya, R., & Maulani, A. (2021). Faktor yang berhubungan dengan terjadinya perdarahan postpartum primer. *Jurnal Maternitas Aisyah*.
<https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/Jaman>
- Fegita, P. D. (2022). Faktor risiko kejadian perdarahan postpartum di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2018–2020. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*.
<https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/meditory/article/view/1445>
- Mufti, I. R., & Lestari, S. A. (2020). Hubungan anemia dengan kejadian perdarahan postpartum. *Jurnal Kesehatan Rajawali*.
<https://ojs.rajawali.ac.id/index.php/JKR/article/view/126>

BAB 5

KEPERAWATAN NEONATUS: ADAPTASI BAYI BARU LAHIR DAN ASUHAN DASAR

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Keperawatan Neonatus: Adaptasi Bayi Baru Lahir dan Asuhan Dasar	5.1 Melakukan penilaian adaptasi bayi baru lahir dan identifikasi kebutuhan dasar segera.	5.2 Menetapkan prioritas masalah serta melaksanakan asuhan dasar neonatus dan edukasi perawatan rumah.	CPMK-3	CPMK-5; CPMK-2

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian tulis berbasis kasus (vignette)	Akurasi analisis struktur–fungsi dan adaptasi kehamilan pada kasus (ketepatan alasan sebab–akibat)	10	Lembar jawaban ujian kasus
CPMK-3	OSCE pengkajian + checklist	Kelengkapan komponen pengkajian; ketepatan stratifikasi risiko; ketepatan prioritas masalah (skor checklist)	15	Checklist OSCE; format pengkajian
CPMK-5	OSCE/simulasi keterampilan + penilaian komunikasi	Ketepatan langkah tindakan; keselamatan prosedur; kualitas komunikasi terapeutik; kualitas edukasi (teach-back)	20	Checklist keterampilan; rekaman/video simulasi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat ≤50% elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat ≥85% elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien	Identifikasi risiko & tindakan aman	Identifikasi 51–69%; tindakan	Identifikasi 70–84%; keputusan	Identifikasi ≥85%; keputusan aman,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
& etik pada skenario maternitas	$\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	aman ada namun belum lengkap.	aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	terencana ($\leq 50\%$ memadai).			

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

A. PENDAHULUAN

Periode neonatus merupakan fase paling awal dalam kehidupan manusia yang berlangsung sejak lahir hingga usia 28 hari. Masa ini merupakan periode transisi kritis karena bayi mengalami perubahan besar dari kehidupan intrauterin menuju kehidupan ekstrauterin. Dalam kandungan, janin memperoleh oksigen dan nutrisi melalui plasenta, sedangkan setelah lahir bayi harus mampu berfungsi secara mandiri melalui sistem organ tubuhnya sendiri.

Proses adaptasi ini melibatkan berbagai sistem tubuh seperti sistem pernapasan, kardiovaskular, termoregulasi, metabolisme, dan sistem imun. Adaptasi tersebut harus berlangsung secara cepat dan efektif untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi. Kegagalan dalam proses adaptasi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti asfiksia, hipotermia, hipoglikemia, dan infeksi neonatal yang merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir (Taye et al., 2024; Zekarias et al., 2024).

Menurut World Health Organization (2023), terdapat sekitar 2,3 juta kematian neonatal setiap tahun di dunia, dan hampir 47% dari seluruh kematian anak di bawah usia lima tahun terjadi pada periode neonatus. Meskipun terjadi penurunan angka kematian anak secara global, penurunan angka kematian neonatal berjalan lebih lambat dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga periode ini menjadi fokus utama intervensi kesehatan global (World Health Organization, 2020, 2023). Penyebab utama kematian neonatal meliputi prematuritas, asfiksia saat lahir, infeksi, serta kelainan kongenital (OECD & World Health Organization, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas asuhan pada periode neonatal sangat menentukan keberlangsungan hidup bayi.

Sejalan dengan hal tersebut, Sustainable Development Goals melalui target 3.2 menetapkan bahwa pada tahun 2030 seluruh negara harus mampu menurunkan angka kematian neonatal hingga ≤ 12 per 1.000 kelahiran hidup (United Nations, 2021, 2022). Upaya pencapaian target ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk asuhan keperawatan neonatus yang komprehensif, aman, dan berbasis bukti ilmiah. Namun demikian, laporan global menunjukkan bahwa banyak negara masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target tersebut, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (United Nations, 2022).

Upaya global dalam menurunkan angka kematian anak sebenarnya telah dimulai sejak era Millennium Development Goals (MDGs), khususnya pada tujuan ke-4 yaitu menurunkan angka kematian anak (under-five mortality rate) sebesar dua pertiga dalam kurun waktu 1990–2015. Meskipun terjadi penurunan signifikan angka kematian anak secara global selama periode MDGs, penurunan angka kematian neonatal berlangsung lebih lambat dibandingkan kelompok usia lainnya. Hal ini menyebabkan proporsi kematian neonatal terhadap total kematian anak semakin meningkat (United Nations, 2015; World Health Organization, 2020).

Sebagai kelanjutan dari MDGs, Sustainable Development Goals (SDGs) menetapkan target yang lebih spesifik dan terukur melalui tujuan ke-3 (Good Health and Well-being), yaitu menurunkan angka kematian neonatal menjadi ≤ 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (United Nations, 2021, 2022). Target ini menekankan pentingnya intervensi berbasis bukti yang berfokus pada periode neonatal sebagai kunci dalam meningkatkan kelangsungan hidup anak secara global.

Di kawasan Asia Pasifik, angka kematian neonatal masih dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan seperti kualitas pelayanan antenatal, proses persalinan, berat badan lahir, serta praktik perawatan bayi baru lahir seperti inisiasi menyusui dini dan perawatan esensial neonatal (OECD & World Health Organization, 2024). Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa kematian neonatal masih menjadi penyumbang terbesar angka kematian bayi, dengan faktor utama meliputi bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia, dan infeksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta kompetensi tenaga kesehatan, termasuk perawat, masih menjadi prioritas utama.

Selain faktor medis, penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa faktor lingkungan perawatan memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas fisiologis dan perkembangan neonatus, terutama pada bayi prematur yang dirawat

di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Paparan kebisingan, pencahayaan berlebih, serta stimulasi yang tidak terkontrol dapat memicu stres fisiologis dan mengganggu perkembangan neurologis bayi (Pineda et al., 2017; Altimier & Phillips, 2018). Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa neonatus prematur memiliki kerentanan tinggi terhadap gangguan perkembangan akibat paparan lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi intrauterin.

Lebih lanjut, berbagai studi terkini menunjukkan bahwa prematuritas merupakan salah satu faktor risiko utama kematian neonatal, terutama di negara berkembang. Komplikasi akibat kelahiran prematur secara signifikan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas bayi, serta berdampak pada kualitas hidup jangka panjang (Fisseha et al., 2025). Penelitian berbasis rumah sakit juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti berat badan lahir rendah, infeksi neonatal, serta keterlambatan penanganan menjadi determinan utama kematian neonatus di unit perawatan intensif (Taye et al., 2024; Zekarias et al., 2024).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pendekatan *developmental care* berkembang sebagai strategi penting dalam meningkatkan kualitas asuhan neonatus. Pendekatan ini menekankan pada penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan bayi dengan mengatur pencahayaan, kebisingan, posisi tubuh, serta keterlibatan keluarga dalam perawatan. Evidence menunjukkan bahwa *developmental care* dapat meningkatkan stabilitas fisiologis, mempercepat pertumbuhan, serta memperbaiki outcome neurodevelopmental pada neonatus (Ohlsson & Jacobs, 2020; Smith et al., 2022).

Dalam konteks keperawatan, perawat memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan adaptasi neonatus melalui pengkajian yang komprehensif, deteksi dini terhadap komplikasi, serta pemberian intervensi yang tepat dan berbasis evidence. Perawat juga berperan sebagai edukator dalam meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai perawatan bayi baru lahir, termasuk praktik pemberian ASI eksklusif, perawatan tali pusat, serta pengenalan tanda bahaya pada neonatus. Dengan demikian, asuhan keperawatan neonatus tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga mencakup aspek promotif dan preventif yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup bayi secara menyeluruh. Pendekatan yang holistik, berbasis evidence, dan berpusat pada keluarga menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan neonatus serta mendukung pencapaian target kesehatan global dan nasional.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan neonatus serta menerapkan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir secara komprehensif dan berbasis evidence.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan konsep dasar neonatus dan proses adaptasi fisiologis bayi baru lahir
- b. Mengidentifikasi penyebab dan patofisiologi gangguan pada neonatus
- c. Melakukan pengkajian keperawatan neonatus secara sistematis
- d. Menetapkan diagnosis keperawatan sesuai SDKI
- e. Merencanakan intervensi keperawatan berdasarkan SIKI
- f. Mengimplementasikan tindakan keperawatan neonatus secara tepat
- g. Melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan keperawatan sesuai standar
- h. Memberikan edukasi dan konseling kepada keluarga neonatus
- i. Menganalisis kasus klinis neonatus secara kritis
- j. Melakukan keterampilan prosedural keperawatan neonatus sesuai SPO

C. URAIAN MATERI

1. KONSEP DASAR NEONATUS

Neonatus adalah bayi usia 0–28 hari yang mengalami perubahan fisiologis cepat. Neonatus diklasifikasikan berdasarkan usia kehamilan dan berat badan lahir. Bayi prematur memiliki risiko tinggi mengalami gangguan adaptasi karena organ tubuh yang belum matang. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi developmental care pada bayi prematur sangat dipengaruhi oleh kompetensi perawat dan budaya organisasi di unit perawatan .

Neonatus adalah bayi yang berada pada periode sejak lahir hingga usia 28 hari. Periode ini merupakan fase transisi paling kritis dalam kehidupan manusia karena terjadi perubahan fisiologis yang signifikan dari kehidupan intrauterin menuju ekstrauterin (Hockenberry & Wilson, 2021; Ricci et al., 2021).

Menurut World Health Organization, masa neonatus merupakan periode dengan risiko kematian tertinggi dalam siklus kehidupan manusia, di mana hampir setengah dari kematian anak di bawah lima tahun terjadi pada periode ini (World Health Organization, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perawatan pada masa neonatus sangat menentukan kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan jangka panjang bayi.

a. Klasifikasi Neonatus dan Konsep Dasar Fisiologis

Klasifikasi Neonatus

Neonatus dapat diklasifikasikan berdasarkan usia gestasi dan berat badan lahir. Klasifikasi ini sangat penting dalam praktik klinik karena berhubungan erat dengan tingkat kematangan organ, kemampuan adaptasi fisiologis, serta risiko komplikasi yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir.

Berdasarkan usia gestasi, neonatus dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu bayi prematur (*preterm*), bayi cukup bulan (*aterm*), dan bayi lewat waktu (*postterm*). Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Pada kelompok ini, sebagian besar sistem organ belum berkembang secara optimal, sehingga bayi memiliki risiko tinggi mengalami gangguan pernapasan, hipotermia, dan infeksi. Bayi aterm adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 hingga 42 minggu, yang umumnya telah memiliki kematangan organ yang lebih baik sehingga mampu beradaptasi secara optimal dengan lingkungan ekstrauterin. Sementara itu, bayi postterm adalah bayi yang lahir setelah usia kehamilan lebih dari 42 minggu, yang juga memiliki risiko tertentu seperti insufisiensi plasenta dan gangguan nutrisi intrauterin.

Selain berdasarkan usia gestasi, klasifikasi neonatus juga dilakukan berdasarkan berat badan lahir. Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram dikategorikan sebagai bayi berat badan lahir rendah (BBLR), sedangkan bayi dengan berat kurang dari 1500 gram termasuk dalam kelompok berat badan lahir sangat rendah (BBLSR), dan bayi dengan berat kurang dari 1000 gram dikategorikan sebagai berat badan lahir ekstrem rendah (BBLER). Bayi dengan kondisi prematur dan BBLR memiliki risiko yang jauh lebih tinggi terhadap gangguan adaptasi, infeksi, serta komplikasi jangka panjang, termasuk gangguan tumbuh kembang (Taye et al., 2024; Fisseha et al., 2025).

b. Karakteristik Fisiologis Neonatus

Neonatus memiliki karakteristik fisiologis yang unik dibandingkan kelompok usia lainnya, terutama karena sistem organ masih dalam tahap maturasi. Kondisi ini menjadikan neonatus sangat rentan terhadap perubahan lingkungan.

Pada sistem pernapasan, bayi baru lahir harus segera melakukan napas pertama setelah lahir. Paru-paru yang sebelumnya berisi cairan harus segera mengalami ekspansi dan berfungsi sebagai organ pertukaran gas. Produksi surfaktan oleh paru-paru berperan penting dalam menjaga stabilitas alveoli dan mencegah kolaps (Hockenberry & Wilson, 2021). Ketidakmatangan sistem ini, terutama pada bayi prematur, dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti *respiratory distress syndrome*.

Sistem kardiovaskular neonatus juga mengalami perubahan besar. Setelah lahir, terjadi transisi dari sirkulasi fetal menuju sirkulasi sistemik, yang ditandai dengan penutupan foramen ovale dan ductus arteriosus. Perubahan ini memungkinkan distribusi darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh (Ricci et al., 2021).

Dalam hal termoregulasi, neonatus memiliki kemampuan yang terbatas dalam mempertahankan suhu tubuh. Kehilangan panas dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Oleh karena itu, menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil menjadi prioritas utama dalam perawatan neonatal (World Health Organization, 2023).

Dari sisi metabolisme, neonatus memiliki cadangan glikogen yang terbatas sehingga berisiko tinggi mengalami hipoglikemia, terutama pada bayi prematur dan BBLR. Kondisi ini dapat berdampak serius terhadap fungsi neurologis jika tidak segera ditangani (Taye et al., 2024).

Selain itu, sistem imun neonatus belum berkembang secara sempurna. Bayi sangat bergantung pada antibodi maternal yang ditransfer selama kehamilan dan melalui ASI setelah lahir. Hal ini menyebabkan neonatus memiliki kerentanan tinggi terhadap infeksi (Fisseha et al., 2025).

c. Adaptasi Neonatus

Adaptasi neonatus merupakan proses penyesuaian fisiologis yang kompleks setelah bayi lahir dan harus hidup mandiri di luar rahim. Proses ini melibatkan adaptasi pada sistem respirasi, kardiovaskular, termoregulasi, dan metabolisme.

Adaptasi respirasi ditandai dengan kemampuan bayi untuk bernapas secara spontan dan mempertahankan pertukaran gas yang adekuat. Adaptasi kardiovaskular melibatkan perubahan aliran darah dan penutupan jalur sirkulasi fetal. Adaptasi termoregulasi berkaitan dengan kemampuan bayi mempertahankan suhu tubuh, sedangkan adaptasi metabolik mencakup kemampuan mengatur kadar glukosa darah.

Kegagalan dalam proses adaptasi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti asfiksia, hipotermia, hipoglikemia, dan infeksi neonatal, yang merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada neonatus (Zekarias et al., 2024).

Periode neonatus merupakan fase paling kritis dalam siklus kehidupan manusia karena terjadi transisi besar dari kehidupan intrauterin menuju kehidupan ekstrauterin. Pada masa ini, bayi harus beradaptasi secara cepat dan efektif untuk mempertahankan fungsi fisiologis secara mandiri. Adaptasi ini melibatkan perubahan pada berbagai sistem tubuh, terutama sistem

pernapasan, kardiovaskular, termoregulasi, metabolisme, dan sistem imun. Keberhasilan adaptasi ini sangat menentukan kelangsungan hidup bayi, khususnya pada 24 jam pertama kehidupan (Hockenberry & Wilson, 2021; Ricci et al., 2021).

1) Sistem Pernapasan

Sistem pernapasan merupakan sistem pertama yang harus berfungsi segera setelah lahir. Selama dalam kandungan, paru-paru janin tidak digunakan untuk pertukaran gas karena fungsi tersebut dilakukan oleh plasenta. Setelah lahir, bayi harus melakukan napas pertama untuk membuka alveoli dan memulai proses ventilasi paru. Proses ini melibatkan pengeluaran cairan paru melalui sistem limfatik dan kapiler, serta ekspansi alveoli yang dipertahankan oleh surfaktan.

Sekitar 5–10% bayi baru lahir membutuhkan bantuan untuk memulai pernapasan, baik berupa stimulasi sederhana maupun intervensi resusitasi (World Health Organization, 2023). Ketidakmampuan paru untuk beradaptasi secara optimal dapat menyebabkan gangguan pernapasan, seperti takipnea, retraksi dinding dada, dan sianosis, yang merupakan tanda adanya gangguan pertukaran gas.

Pada bayi prematur, produksi surfaktan sering kali belum adekuat, sehingga meningkatkan risiko terjadinya *respiratory distress syndrome* (RDS). Kondisi ini membutuhkan penanganan segera karena dapat menyebabkan hipoksia yang berdampak pada organ vital (Sweet et al., 2019; Hockenberry & Wilson, 2021).

3) Sistem Kardiovaskular

Perubahan sistem kardiovaskular neonatus merupakan proses transisi dari sirkulasi fetal ke sirkulasi sistemik. Pada masa intrauterin, darah kaya oksigen dari plasenta dialirkan melalui jalur khusus seperti foramen ovale dan ductus arteriosus. Setelah lahir, peningkatan kadar oksigen dan perubahan tekanan dalam pembuluh darah memicu penutupan struktur tersebut. Penutupan foramen ovale dan ductus arteriosus memungkinkan darah teroksigenasi mengalir secara optimal ke seluruh tubuh. Proses ini biasanya terjadi secara bertahap dalam beberapa jam hingga hari setelah kelahiran (Rudolph, 2020). Kegagalan adaptasi kardiovaskular dapat menyebabkan gangguan serius seperti *persistent pulmonary hypertension of the newborn* (PPHN), yang ditandai dengan hipoksia persisten.

4) Termoregulasi

Neonatus memiliki keterbatasan dalam mempertahankan suhu tubuh karena sistem termoregulasi yang belum matang. Bayi kehilangan panas

melalui empat mekanisme utama, yaitu evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Selain itu, proporsi luas permukaan tubuh yang lebih besar dibandingkan berat badan juga meningkatkan risiko kehilangan panas. Untuk mempertahankan suhu tubuh, neonatus mengandalkan mekanisme *non-shivering thermogenesis* melalui metabolisme lemak coklat (*brown fat*). Namun, mekanisme ini memiliki keterbatasan, terutama pada bayi prematur dan BBLR (World Health Organization, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi seperti *nesting care* dan kontak kulit ke kulit (*skin-to-skin contact*) efektif dalam menjaga stabilitas suhu tubuh serta meningkatkan kenyamanan dan stabilitas fisiologis neonatus (Boundy et al., 2016; WHO, 2023).

5) Sistem Metabolisme

Setelah lahir, neonatus harus mempertahankan keseimbangan metabolik secara mandiri, terutama dalam regulasi kadar glukosa darah. Selama dalam kandungan, janin memperoleh glukosa secara kontinu dari ibu. Namun setelah lahir, suplai tersebut terputus sehingga bayi harus menggunakan cadangan glikogen yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan neonatus berisiko mengalami hipoglikemia, terutama pada bayi prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, serta bayi dengan riwayat asfiksia (Taye et al., 2024). Hipoglikemia yang tidak ditangani dapat menyebabkan gangguan neurologis jangka panjang.

6) Sistem Imun

Sistem imun neonatus belum berkembang secara sempurna, sehingga bayi sangat rentan terhadap infeksi. Perlindungan awal diperoleh dari antibodi maternal, terutama imunoglobulin G (IgG), yang ditransfer melalui plasenta selama trimester terakhir kehamilan.

Selain itu, ASI memberikan perlindungan tambahan melalui kandungan imunoglobulin A (IgA), serta berbagai faktor imunologis lainnya yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi (Victoria et al., 2016). Meskipun demikian, risiko infeksi tetap tinggi, terutama pada lingkungan dengan higiene yang buruk.

2. Pengkajian Neonatus

Pengkajian neonatus merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses keperawatan untuk menilai kondisi bayi secara menyeluruh dan mendeteksi dini adanya gangguan adaptasi.

Pengkajian dilakukan secara sistematis meliputi:

a. Penilaian APGAR

APGAR score merupakan metode penilaian cepat yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah lahir untuk menilai kondisi bayi. Parameter yang dinilai meliputi warna kulit, denyut jantung, respons refleks, tonus otot, dan usaha napas.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh (*head-to-toe*) untuk menilai kondisi umum bayi, termasuk tanda vital, berat badan, warna kulit, serta adanya kelainan kongenital.

c. Pemeriksaan Refleks

Refleks primitif seperti refleks moro, rooting, dan sucking merupakan indikator penting dari integritas sistem saraf neonatus.

Pengkajian yang akurat memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini gangguan adaptasi dan memberikan intervensi yang tepat waktu.

3. Asuhan Dasar Neonatus

Asuhan dasar neonatus merupakan serangkaian intervensi esensial yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas fisiologis bayi serta mencegah komplikasi.

Komponen utama asuhan dasar meliputi:

a. Menjaga Jalan Napas

Membersihkan jalan napas dan memastikan bayi dapat bernapas dengan efektif merupakan prioritas utama setelah lahir.

b. Menjaga Kehangatan

Menjaga suhu tubuh bayi dengan metode seperti kontak kulit ke kulit (*skin-to-skin contact*) atau penggunaan inkubator.

c. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

IMD dilakukan segera setelah lahir untuk meningkatkan bonding antara ibu dan bayi, merangsang produksi ASI, serta meningkatkan stabilitas fisiologis bayi. Penelitian menunjukkan bahwa IMD dapat meningkatkan keberhasilan menyusui dan menurunkan risiko kematian neonatal (Victora et al., 2016).

d. Pencegahan Infeksi

Pencegahan infeksi dilakukan melalui praktik kebersihan yang baik, perawatan tali pusat yang benar, serta penggunaan teknik aseptik.

4. Kebutuhan Dasar Neonatus

Untuk mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan optimal, neonatus memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara adekuat. Kebutuhan oksigenasi merupakan kebutuhan utama karena berkaitan

langsung dengan fungsi vital tubuh. Neonatus harus mampu mempertahankan respirasi yang efektif untuk memastikan suplai oksigen ke jaringan tubuh.

Kebutuhan nutrisi juga sangat penting, di mana ASI merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi lengkap serta faktor imunologis yang membantu melindungi bayi dari infeksi (Hockenberry & Wilson, 2021).

Kebutuhan termoregulasi harus diperhatikan dengan menjaga suhu tubuh bayi dalam rentang normal, yaitu antara 36,5–37,5°C. Selain itu, kebutuhan keamanan dan perlindungan meliputi upaya pencegahan infeksi dan cedera.

Tidak kalah penting, kebutuhan kasih sayang atau *bonding* antara bayi dan orang tua melalui kontak kulit (*skin-to-skin contact*) sangat berperan dalam perkembangan emosional dan psikologis bayi.

5. Masalah Umum pada Neonatus

Beberapa masalah kesehatan yang sering terjadi pada neonatus meliputi asfiksia neonatorum, hipotermia, hipoglikemia, infeksi neonatal, dan prematuritas. Kondisi-kondisi ini merupakan penyebab utama kematian neonatal secara global, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2023).

6. Peran Perawat dalam Keperawatan Neonatus

Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan keperawatan neonatus secara komprehensif. Peran tersebut meliputi melakukan pengkajian secara menyeluruh, mendeteksi dini komplikasi, serta memberikan intervensi keperawatan yang tepat dan berbasis evidence.

Selain itu, perawat juga berperan sebagai edukator bagi keluarga dalam memberikan informasi terkait perawatan bayi baru lahir, serta mendukung pendekatan *family-centered care* yang menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan.

Peran ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup neonatus serta berkontribusi dalam menurunkan angka kematian bayi (OECD & World Health Organization, 2024).

D. MASALAH KEPERAWATAN NEONATUS

Periode neonatus merupakan masa paling rentan dalam kehidupan manusia karena bayi harus segera beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang sangat drastis. Setelah lahir, bayi tidak lagi memperoleh dukungan fisiologis dari plasenta sehingga seluruh fungsi organ tubuh harus bekerja secara mandiri. Proses adaptasi ini melibatkan perubahan kompleks pada sistem pernapasan, kardiovaskular, termoregulasi, metabolisme, dan imunologis.

Ketidaksempurnaan proses adaptasi tersebut seringkali memunculkan berbagai masalah keperawatan yang memerlukan penanganan segera. Masalah-masalah ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi patologis, tetapi juga dapat dipicu oleh ketidakmatangan organ, faktor lingkungan, maupun kondisi maternal selama kehamilan dan persalinan.

Periode neonatus merupakan fase kritis dalam kehidupan bayi yang berlangsung sejak lahir hingga usia 28 hari. Pada periode ini, bayi mengalami proses adaptasi fisiologis yang kompleks dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Kegagalan dalam proses adaptasi ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Masalah keperawatan neonatus umumnya berkaitan dengan ketidakmatangan sistem organ, terutama pada bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, faktor perinatal seperti asfiksia, infeksi, dan gangguan metabolisme juga berkontribusi terhadap munculnya masalah keperawatan pada neonatus. Dalam praktik keperawatan, identifikasi dini terhadap masalah neonatus sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Pendekatan asuhan keperawatan harus bersifat komprehensif, meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi secara berkesinambungan.

Dalam praktik keperawatan, masalah neonatus harus dipahami sebagai respons biologis yang dinamis. Kondisi bayi dapat berubah secara cepat, sehingga pengkajian kontinu dan intervensi yang tepat waktu menjadi kunci utama keberhasilan asuhan. Oleh karena itu, perawat dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Masalah keperawatan neonatus adalah respon bayi terhadap kondisi fisiologis atau patologis yang memerlukan intervensi keperawatan. Masalah ini dapat bersifat aktual maupun risiko. Karakteristik utama masalah neonates berkaitan dengan ketidakmatangan organ, perubahan kondisi cepat yang memerlukan tindakan segera, dan risiko komplikasi tinggi. Masalah keperawatan sering dirumuskan berdasarkan standar seperti SDKI, yang memfokuskan pada respons pasien terhadap kondisi kesehatan. Masalah yang sering muncul pada neonatus yaitu gangguan pola napas, hipotermia, hipoglikemia, infeksi

1. Gangguan Pola Napas

Gangguan pola napas merupakan salah satu masalah paling sering terjadi pada neonatus, terutama pada bayi prematur. Hal ini disebabkan oleh imaturitas paru-paru, kurangnya surfaktan, serta kegagalan adaptasi pernapasan setelah lahir. Secara fisiologis, neonatus harus segera memulai pernapasan spontan setelah lahir. Namun, pada kondisi tertentu seperti Asfiksia Neonatorum, proses ini terganggu sehingga bayi mengalami hipoksia.

Manifestasi Klinis yang muncul seperti Frekuensi napas >60x/menit (takipnea), retraksi dinding dada, sianosis, merintih (grunting) Gangguan pernapasan pada neonatus merupakan kondisi klinis yang sering ditemukan pada periode awal kehidupan dan menjadi indikator penting adanya kegagalan adaptasi terhadap lingkungan ekstrauterin. Manifestasi klinis yang muncul tidak hanya mencerminkan gangguan ventilasi, tetapi juga menggambarkan upaya kompensasi tubuh bayi dalam mempertahankan oksigenasi jaringan. Pada kondisi seperti Asfiksia Neonatorum, tanda-tanda klinis muncul secara cepat dan dapat berkembang menjadi kegawatan apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap setiap manifestasi klinis sangat penting bagi perawat untuk melakukan deteksi dini dan intervensi tepat.

a. Takipnea (Frekuensi Napas >60x/menit)

Takipnea merupakan salah satu tanda awal gangguan pernapasan pada neonatus. Secara fisiologis, peningkatan frekuensi napas terjadi sebagai mekanisme kompensasi tubuh terhadap hipoksia dan hiperkapnia. Ketika kadar oksigen dalam darah menurun, pusat pernapasan di medula oblongata akan merangsang peningkatan ventilasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Namun, pada neonatus, takipnea tidak selalu menunjukkan peningkatan efektivitas ventilasi. Sebaliknya, napas yang cepat sering kali dangkal dan tidak efektif, sehingga pertukaran gas tetap tidak optimal.

Makna klinis:

- Menunjukkan adanya gangguan oksigenasi
- Dapat menjadi tanda awal distress pernapasan
- Harus diobservasi bersama tanda lain

b. Retraksi Dinding Dada

Retraksi dinding dada terjadi akibat peningkatan usaha pernapasan. Pada neonatus, dinding dada masih lunak dan elastis, sehingga tekanan negatif yang meningkat saat inspirasi menyebabkan jaringan interkostal, subkostal, dan suprasternal tertarik ke dalam. Retraksi menunjukkan bahwa bayi mengalami kesulitan dalam mengembangkan paru-paru secara optimal, sehingga memerlukan usaha tambahan untuk menarik udara masuk.

Jenis retraksi:

- Interkostal
- Subkostal
- Suprasternal

Makna klinis:

- Menunjukkan peningkatan kerja napas
- Indikator distress pernapasan sedang hingga berat

- Berhubungan dengan penurunan compliance paru

c. Sianosis

Sianosis merupakan perubahan warna kulit menjadi kebiruan akibat peningkatan kadar hemoglobin terdeoksigenasi dalam darah. Pada neonatus, sianosis dapat dibedakan menjadi:

- **Sianosis perifer (akrosianosis):** biasanya normal pada awal kehidupan
- **Sianosis sentral:** menunjukkan gangguan oksigenasi serius

Sianosis sentral terjadi ketika saturasi oksigen menurun secara signifikan, sehingga jaringan tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen yang adekuat.

Makna klinis:

- Indikator hipoksemia berat
- Menunjukkan kegagalan oksigenasi sistemik
- Memerlukan intervensi segera

d. Merintih (Grunting)

Grunting adalah suara khas yang dihasilkan bayi saat ekspirasi, yang terjadi akibat penutupan sebagian glottis. Mekanisme ini merupakan upaya kompensasi untuk mempertahankan tekanan positif di dalam alveoli (positive end-expiratory pressure/PEEP), sehingga alveoli tidak kolaps.

Grunting sering ditemukan pada kondisi gangguan paru seperti sindrom gangguan napas.

Makna klinis:

- Menunjukkan usaha mempertahankan alveoli tetap terbuka
- Indikator distress pernapasan berat
- Sering berkaitan dengan penurunan surfaktan

e. Napas Cuping Hidung (Nasal Flaring)

Selain tanda-tanda utama, neonatus dengan gangguan pernapasan sering menunjukkan pelebaran cuping hidung saat inspirasi. Hal ini terjadi sebagai upaya untuk mengurangi resistensi jalan napas dan meningkatkan aliran udara.

Makna klinis:

- Tanda awal distress pernapasan
- Menunjukkan peningkatan usaha napas

f. Apnea

Apnea adalah kondisi berhentinya napas selama lebih dari 20 detik atau kurang dari itu tetapi disertai bradikardia atau desaturasi.

Apnea sering terjadi pada bayi prematur akibat ketidakmatangan pusat pernapasan.

Makna klinis:

- Indikator gangguan neurologis atau respirasi

- Berpotensi menyebabkan hipoksia berat

g. Perubahan Pola Napas

Neonatus normal memiliki pola napas yang tidak teratur. Namun, pada kondisi patologis, pola napas menjadi:

- Sangat cepat dan dangkal
- Tidak teratur ekstrem
- Disertai henti napas

Perubahan ini mencerminkan gangguan kontrol respirasi.

h. Penurunan Aktivitas dan Respons

Gangguan pernapasan sering disertai perubahan perilaku bayi, seperti:

- Letargi
- Tangisan lemah
- Penurunan refleks hisap

Hal ini terjadi karena hipoksia memengaruhi fungsi sistem saraf pusat.

Integrasi Klinis

Manifestasi klinis gangguan pernapasan pada neonatus jarang muncul secara tunggal. Biasanya tanda-tanda tersebut muncul secara kombinasi dan menunjukkan tingkat keparahan kondisi.

Sebagai contoh:

- Takipnea + retraksi → distress ringan–sedang
- Ditambah sianosis → distress berat
- Ditambah apnea → kondisi gawat darurat

Oleh karena itu, perawat harus mampu melakukan interpretasi klinis secara holistik, bukan hanya berdasarkan satu tanda.

Kesimpulan Klinis

Manifestasi klinis gangguan pernapasan pada neonatus merupakan refleksi dari:

- Upaya kompensasi tubuh terhadap hipoksia
- Ketidakmatangan sistem respirasi
- Gangguan mekanik atau metabolik

Pengenalan dini terhadap tanda-tanda ini sangat penting untuk:

- Mencegah perburukan kondisi
- Menentukan prioritas intervensi
- Menyelamatkan kehidupan neonatus

Manifestasi klinis pada neonatus harus dinilai secara komprehensif karena satu tanda saja tidak cukup untuk menentukan derajat keparahan. Kombinasi tanda klinis mencerminkan tingkat distress dan menjadi dasar pengambilan keputusan keperawatan.

Tabel 4. 4 Derajat Keparahan Gangguan Pernapasan Neonatus

Parameter	Ringan	Sedang	Berat
Frekuensi napas	60–70x/menit	70–80x/menit	>80x/menit atau apnea
Retraksi	Minimal/interkostal ringan	Jelas (interkostal + subkostal)	Berat (seluruh dinding dada)
Sianosis	Tidak ada / perifer	Intermiten	Sentral menetap
Grunting	Tidak ada	Kadang	Jelas dan terus-menerus
Nasal flaring	Tidak ada	Ada	Sangat jelas
Respons bayi	Aktif	Gelisah	Letargi / tidak responsif

Interpretasi Klinis

- **Ringan:**

Bayi masih mampu kompensasi → observasi ketat

- **Sedang:**

Kompensasi mulai gagal → intervensi diperlukan

- **Berat:**

Gagal napas → kondisi gawat darurat

Pada kondisi berat seperti Asfiksia Neonatorum, bayi memerlukan resusitasi segera.

Tatalaksana Keperawatan

Pendekatan keperawatan berfokus pada mempertahankan jalan napas dan meningkatkan oksigenasi.

Intervensi:

- Memposisikan bayi pada posisi sniffing
- Membersihkan jalan napas (suction bila perlu)
- Monitoring tanda vital secara ketat
- Pemberian oksigen sesuai indikasi
- Kolaborasi pemberian CPAP atau ventilasi mekanik

Perawat juga harus melakukan observasi kontinu terhadap perubahan pola napas karena kondisi dapat memburuk secara cepat.

2. Hipotermia

Hipotermia merupakan kondisi penurunan suhu tubuh di bawah 36,5°C yang sering terjadi pada neonatus, terutama pada bayi prematur dan BBLR. Hal ini

disebabkan oleh ketidakmampuan bayi dalam mempertahankan suhu tubuh akibat sistem termoregulasi yang belum matang.

Manifestasi Klinis

- Suhu tubuh rendah
- Kulit dingin dan pucat
- Letargi
- Penurunan aktivitas

Hipotermia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti hipoglikemia dan asidosis metabolik.

Tatalaksana Keperawatan

Penanganan hipotermia bertujuan untuk mengembalikan dan mempertahankan suhu tubuh normal.

Intervensi:

- Mengeringkan bayi segera setelah lahir
- Melakukan kontak kulit ke kulit (kangaroo mother care)
- Menggunakan inkubator atau radiant warmer
- Membungkus bayi dengan selimut hangat
- Monitoring suhu secara berkala

Pencegahan hipotermia merupakan langkah penting dalam menurunkan angka kematian neonatus.

3. Hipoglikemia

Hipoglikemia Neonatal merupakan kondisi penurunan kadar glukosa darah yang dapat terjadi akibat cadangan glikogen yang terbatas dan kebutuhan energi yang tinggi.

Kondisi ini sering terjadi pada bayi prematur, BBLR, dan bayi dari ibu dengan diabetes.

Manifestasi Klinis

- Tremor
- Kejang
- Letargi
- Tidak mau menyusu

Jika tidak segera ditangani, hipoglikemia dapat menyebabkan kerusakan otak permanen.

Tatalaksana Keperawatan

Penanganan difokuskan pada stabilisasi kadar glukosa.

Intervensi:

- Inisiasi menyusu dini (IMD)
- Pemberian ASI secara adekuat

- Monitoring kadar glukosa darah
- Kolaborasi pemberian infus glukosa

Perawat harus memastikan bayi mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sejak awal kehidupan.

4. Risiko Infeksi

Neonatus memiliki sistem imun yang belum matang sehingga sangat rentan terhadap infeksi, termasuk Sepsis Neonatorum.

Infeksi dapat berasal dari lingkungan, prosedur medis, maupun transmisi dari ibu.

Manifestasi Klinis

- Demam atau hipotermia
- Lemas
- Gangguan pernapasan
- Perubahan warna kulit

Tatalaksana Keperawatan

Pencegahan merupakan kunci utama dalam menangani risiko infeksi.

Intervensi:

- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak
- Teknik aseptik dalam tindakan
- Perawatan tali pusat bersih dan kering
- Monitoring tanda infeksi
- Kolaborasi pemberian antibiotik

Edukasi keluarga juga penting untuk mencegah infeksi setelah bayi pulang ke rumah.

5. Ketidakefektifan Menyusu

Ketidakefektifan menyusu merupakan masalah yang sering terjadi pada neonatus, terutama pada bayi prematur. Hal ini disebabkan oleh refleks hisap dan menelan yang belum matang.

Manifestasi Klinis

- Bayi sulit melekat (latch on)
- Menyusu tidak efektif
- Berat badan tidak naik

Tatalaksana Keperawatan

Intervensi difokuskan pada peningkatan kemampuan menyusu bayi.

Intervensi:

- Mengajarkan teknik menyusui yang benar
- Membantu posisi ibu dan bayi
- Memberikan stimulasi refleks hisap
- Kolaborasi dengan konselor laktasi

Dukungan emosional kepada ibu juga sangat penting dalam keberhasilan menyusui.

6. Hiperbilirubinemia

Hiperbilirubinemia Neonatal merupakan kondisi yang menyebabkan bayi mengalami ikterus (kuning).

Manifestasi Klinis

- Kulit dan sklera kuning
- Letargi
- Menyusu kurang

Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kernikterus.

Tatalaksana Keperawatan

Penanganan bertujuan menurunkan kadar bilirubin.

Intervensi:

- Monitoring kadar bilirubin
- Pemberian ASI adekuat
- Fototerapi
- Kolaborasi tindakan medis lanjutan

E. INTEGRASI DENGAN DIAGNOSIS SDKI

1. Gangguan Pola Napas

Definisi

Ketidakefektifan ventilasi akibat gangguan mekanisme pernapasan.

Data Mayor

- Takipnea
- Retraksi
- Sianosis
- Grunting

SLKI (Luaran)

Indikator	Target
Frekuensi napas	30–60x/menit
Pola napas	Teratur
Saturasi oksigen	≥95%
Warna kulit	Merah muda

SIKI (Intervensi Detail)

Observasi

- Monitor RR tiap 1 jam
- Pantau SpO₂ kontinu
- Identifikasi tanda distress

Terapeutik

- Posisi sniffing
- Bersihkan jalan napas
- Berikan oksigen

Edukasi

- Ajarkan keluarga tanda bahaya

Kolaborasi

- CPAP / ventilator

2. Gangguan Pertukaran Gas

Data Pendukung

- Sianosis
- SpO₂ <90%
- Gelisah / letargi

SLKI

Indikator	Target
Saturasi O ₂	≥95%
PaO ₂	Normal
Warna kulit	Normal

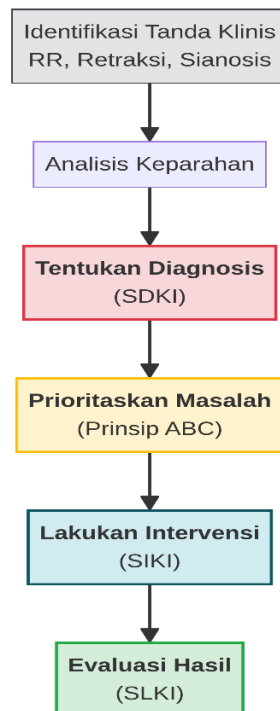
SIKI

- Oksigenasi
- Monitoring ABG
- Kolaborasi ventilator

CHECKLIST OSCE PEMERIKSAAN NEONATUS (SISTEM PERNAPASAN)

1. Persiapan
 - Cuci tangan
 - Gunakan APD
 - Pastikan bayi dalam posisi nyaman
2. Inspeksi
 - Hitung frekuensi napas (1 menit penuh)
 - Amati retraksi
 - Amati nasal flaring
 - Amati warna kulit (sianosis)
 - Dengarkan grunting
3. Palpasi
 - Simetri ekspansi dada
 - Getaran dada
4. Auskultasi
 - Suara napas vesikuler
 - Tambahan suara (ronki, wheezing)
5. Interpretasi
 - Tentukan derajat keparahan
 - Identifikasi masalah keperawatan
6. Dokumentasi
 - Catat semua temuan
 - Laporkan kondisi kritis

ALUR BERPIKIR KLINIS (CLINICAL REASONING)



Gambar 4. 1 flowchart alur asuhan keperawatan profesional yang menggunakan standar SDKI, SIKI, dan SLKI

CONTOH ANALISIS KLINIS

Kasus

Bayi RR 72x/menit, retraksi, SpO₂ 91%

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisa kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Lakukan analisis kasus
2. Tentukan diagnosis, intervensi dan kesimpulan analisa
3. Implikasikan Asuhan Keperawatan
4. Buat penerapan berdasarkan evidence base
5. Tentukan Peran perawat dalam tatalaksana
6. Discharge planning / Edukasi keluarga

Diskusikan Jawaban Bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi dikelas.

Jawaban

Analisis

- Takipnea + retraksi → distress sedang
- SpO₂ rendah → gangguan oksigenasi

Diagnosis

- Gangguan pola napas
- Gangguan pertukaran gas

Tindakan

- Oksigenasi
- Monitoring
- Posisi

KESIMPULAN

Manifestasi klinis gangguan pernapasan neonatus:

- Tidak berdiri sendiri
- Harus dinilai secara integratif
- Menjadi dasar diagnosis keperawatan
- Menentukan prioritas intervensi

Perawat harus mampu:

- Mengidentifikasi tanda dini
- Menilai tingkat keparahan
- Mengambil keputusan cepat

Pendekatan Asuhan Keperawatan Neonatus

Pendekatan keperawatan dilakukan secara sistematis melalui:

1. **Pengkajian** → identifikasi kondisi bayi
2. **Diagnosis** → penentuan masalah keperawatan
3. **Intervensi** → tindakan keperawatan
4. **Evaluasi** → penilaian hasil

Pendekatan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat karena kondisi neonatus dapat berubah dalam waktu singkat.

Peran Perawat dalam Penatalaksanaan

Perawat memiliki peran penting dalam:

1. Deteksi dini komplikasi
2. Stabilisasi kondisi bayi
3. Pencegahan infeksi

4. Edukasi keluarga
5. Kolaborasi dengan tim medis

Perawat juga harus memiliki keterampilan klinis yang baik serta kemampuan pengambilan keputusan yang cepat.

F. Pendekatan Asuhan Keperawatan Neonatus

Pendekatan keperawatan dilakukan secara sistematis melalui:

- 1) **Pengkajian** → identifikasi kondisi bayi
- 2) **Diagnosis** → penentuan masalah keperawatan
- 3) **Intervensi** → tindakan keperawatan
- 4) **Evaluasi** → penilaian hasil

Pendekatan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat karena kondisi neonatus dapat berubah dalam waktu singkat.

I. Peran Perawat dalam Penatalaksanaan

Perawat memiliki peran penting dalam:

- 1) Deteksi dini komplikasi
- 2) Stabilisasi kondisi bayi
- 3) Pencegahan infeksi
- 4) Edukasi keluarga
- 5) Kolaborasi dengan tim medis

Perawat juga harus memiliki keterampilan klinis yang baik serta kemampuan pengambilan keputusan yang cepat.

G. PENDEKATAN ASUHAN KEPERAWATAN MODERN PADA NEONATUS

Perkembangan praktik keperawatan modern pada bidang neonatologi tidak lagi hanya berorientasi pada penanganan kondisi akut dan pemenuhan kebutuhan fisiologis dasar, tetapi telah berkembang menjadi pendekatan yang holistik, integratif, dan berbasis bukti ilmiah. Dalam konteks ini, perawatan neonatus dipandang sebagai suatu proses yang tidak hanya bertujuan mempertahankan kelangsungan hidup, tetapi juga mengoptimalkan tumbuh kembang bayi serta memperkuat peran keluarga dalam proses perawatan. Oleh karena itu, pendekatan asuhan keperawatan modern menekankan integrasi tiga konsep utama, yaitu *developmental care*, *family centered care*, dan *evidence-based practice*, yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan neonatus.

Pendekatan *developmental care* muncul dari pemahaman bahwa bayi, khususnya bayi prematur, memiliki sistem saraf yang belum matang sehingga sangat rentan terhadap rangsangan lingkungan yang berlebihan. Lingkungan

perawatan di ruang neonatal, seperti ruang NICU, sering kali penuh dengan cahaya terang, suara alat medis, serta prosedur yang berulang, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan stres pada bayi. Stres ini dapat berdampak pada ketidakstabilan fisiologis, gangguan tidur, hingga hambatan perkembangan neurologis jangka panjang. Oleh karena itu, *developmental care* berupaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan bayi dengan meniru kondisi intrauterin yang relatif tenang, gelap, dan minim rangsangan. Dalam praktiknya, pendekatan ini diwujudkan melalui pengaturan pencahayaan yang redup, pengendalian kebisingan, serta pengelompokan tindakan keperawatan untuk mengurangi frekuensi manipulasi terhadap bayi.

Selain pengaturan lingkungan, *developmental care* juga menekankan pentingnya posisi tubuh bayi yang fisiologis. Posisi fleksi yang menyerupai posisi dalam rahim ibu membantu meningkatkan stabilitas fisiologis dan kenyamanan bayi. Intervensi seperti *kangaroo mother care* menjadi bagian penting dari pendekatan ini karena tidak hanya membantu mempertahankan suhu tubuh bayi, tetapi juga memberikan stimulasi sensorik yang positif dan mendukung perkembangan neurologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *developmental care* dapat meningkatkan berat badan bayi, mempercepat maturasi sistem saraf, serta mengurangi lama rawat di rumah sakit (Altimier & Phillips, 2020).

Sejalan dengan fokus pada bayi, pendekatan *family centered care* menempatkan keluarga sebagai bagian integral dari proses perawatan. Dalam paradigma ini, keluarga tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif, tetapi sebagai mitra aktif dalam memberikan asuhan kepada bayi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kehadiran dan keterlibatan orang tua, terutama ibu, memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas emosional dan fisiologis neonatus. Interaksi antara ibu dan bayi, seperti kontak kulit ke kulit dan menyusui, terbukti meningkatkan ikatan emosional (*bonding*), yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perkembangan psikologis dan neurologis bayi.

Pendekatan *family centered care* juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara tenaga kesehatan dan keluarga. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, menjelaskan kondisi bayi, serta melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keluarga dapat merasa lebih percaya diri dan memiliki kontrol terhadap proses perawatan bayi. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengurangi kecemasan dan stres yang sering dialami oleh orang tua dengan bayi yang dirawat di unit neonatal. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perawatan dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI, mempercepat pemulihan bayi, serta meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan (Gooding et al., 2021).

Sementara itu, *evidence-based practice* merupakan landasan ilmiah yang memastikan bahwa setiap intervensi keperawatan yang dilakukan didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia. Dalam praktik keperawatan neonatus, penggunaan pendekatan berbasis bukti menjadi sangat penting mengingat kondisi bayi yang sangat rentan dan perubahan klinis yang dapat terjadi secara cepat. *Evidence-based practice* mengintegrasikan hasil penelitian terkini, pengalaman klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tindakan keperawatan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Penerapan *evidence-based practice* dalam keperawatan neonatus mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur resusitasi, manajemen nyeri, hingga strategi pemberian nutrisi. Sebagai contoh, praktik *kangaroo mother care* tidak hanya merupakan bagian dari *developmental care* dan *family centered care*, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang menunjukkan efektivitasnya dalam menurunkan angka mortalitas neonatus. Demikian pula, penggunaan teknik minimal handling dan pengendalian lingkungan di ruang perawatan telah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi stres dan meningkatkan stabilitas fisiologis bayi (Melnik & Fineout-Overholt, 2023; World Health Organization, 2023).

Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berintegrasi dalam praktik keperawatan sehari-hari. *Developmental care* berfokus pada kebutuhan perkembangan bayi, *family centered care* menekankan keterlibatan keluarga, sedangkan *evidence-based practice* memastikan bahwa seluruh intervensi yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Integrasi ketiganya menghasilkan asuhan keperawatan yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga humanis dan berorientasi pada pasien serta keluarganya.

Dalam implementasinya, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis yang baik, serta literasi ilmiah yang memadai. Perawat harus mampu menginterpretasikan kondisi bayi secara cepat, memilih intervensi yang tepat, serta mengevaluasi hasil tindakan secara berkelanjutan. Selain itu, perawat juga berperan sebagai edukator dan advokat bagi keluarga, sehingga mampu menjembatani kebutuhan bayi dengan harapan dan nilai-nilai keluarga.

Dengan demikian, pendekatan asuhan keperawatan modern pada neonatus merupakan suatu sistem yang komprehensif dan berkesinambungan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelamatkan kehidupan bayi, tetapi juga memastikan kualitas hidup yang optimal melalui dukungan perkembangan, keterlibatan keluarga, dan penerapan praktik berbasis bukti. Implementasi yang konsisten dari ketiga pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan neonatal serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas bayi secara signifikan.

EDUKASI KELUARGA PADA NEONATUS

Edukasi kepada keluarga merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan neonatus yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat bayi secara mandiri di rumah. Edukasi ini sangat penting karena sebagian besar waktu perawatan bayi dilakukan oleh keluarga, khususnya ibu.

Keluarga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang tepat agar mampu:

- Menjaga kondisi bayi tetap stabil
- Mencegah terjadinya komplikasi
- Mengenali tanda bahaya secara dini

Dalam praktik keperawatan, edukasi harus diberikan secara bertahap, menggunakan bahasa sederhana, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman keluarga.

1. Edukasi Perawatan Bayi

Perawatan bayi baru lahir mencakup berbagai aspek dasar yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi fisiologis bayi agar tetap optimal.

a. Perawatan Tali Pusat

Tali pusat merupakan pintu masuk potensial bagi kuman, sehingga perawatannya harus dilakukan dengan benar.

Prinsip perawatan:

- Menjaga tali pusat tetap bersih dan kering
- Tidak mengoleskan bahan apa pun (alkohol, bedak, minyak)
- Membersihkan jika kotor dengan air bersih dan dikeringkan

Rasional:

Lingkungan yang lembap dapat meningkatkan risiko infeksi seperti Omfalitis, yang dapat berkembang menjadi sepsis jika tidak ditangani.

b. Menjaga Kebersihan Bayi

Bayi perlu dimandikan secara hati-hati untuk menjaga kebersihan kulit dan mencegah infeksi.

Hal yang perlu diajarkan:

- Memandikan bayi dengan air hangat ($\pm 37^{\circ}\text{C}$)
- Durasi mandi singkat (5–10 menit)
- Mengeringkan bayi segera setelah mandi

Rasional:

Kulit neonatus masih sangat tipis dan sensitif, sehingga mudah mengalami iritasi dan kehilangan panas.

c. Menjaga Kehangatan Bayi

Neonatus sangat rentan terhadap Hipotermia.

Edukasi meliputi:

- Membungkus bayi dengan kain bersih dan hangat
- Menghindari paparan angin langsung
- Melakukan kontak kulit ke kulit (skin to skin)

Rasional:

Hipotermia dapat menyebabkan gangguan metabolisme, hipoglikemia, bahkan kematian jika tidak segera ditangani.

d. Posisi Tidur Bayi

Keluarga perlu diberi pemahaman mengenai posisi tidur yang aman.

Anjuran:

- Bayi tidur dalam posisi terlentang
- Tidak menggunakan bantal tebal
- Tempat tidur rata dan aman

Rasional:

Posisi yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko Sudden Infant Death Syndrome.

2. Edukasi ASI Eksklusif

Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu intervensi paling penting dalam meningkatkan kesehatan neonatus.

a. Pengertian ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama 6 bulan pertama kehidupan.

b. Manfaat ASI

Bagi bayi:

- Meningkatkan daya tahan tubuh
- Mencegah infeksi
- Mendukung pertumbuhan optimal

Bagi ibu:

- Mempercepat involusi uterus
- Mengurangi risiko perdarahan postpartum

c. Teknik Menyusui yang Benar

Edukasi harus mencakup keterampilan praktis:

- Posisi ibu dan bayi nyaman
- Mulut bayi membuka lebar
- Sebagian besar areola masuk ke mulut bayi

Rasional:

Teknik yang salah dapat menyebabkan puting lecet dan bayi tidak mendapatkan ASI secara optimal.

d. Frekuensi dan Tanda Cukup ASI

- Menyusu 8–12 kali per hari
- Bayi tampak puas setelah menyusu
- Frekuensi BAK ≥ 6 kali/hari

e. Hambatan Menyusui

Perawat juga harus menjelaskan kemungkinan masalah:

- ASI belum keluar
- Puting lecet
- Bayi sulit menyusu

Pendekatan:

Memberikan dukungan emosional dan solusi praktis sangat penting untuk keberhasilan ASI eksklusif.

3. Edukasi Tanda Bahaya Neonatus

Pengenalan tanda bahaya merupakan bagian paling krusial dalam edukasi, karena berkaitan langsung dengan keselamatan bayi.

a. Pentingnya Deteksi Dini

Kondisi neonatus dapat memburuk dengan cepat. Oleh karena itu, keluarga harus mampu mengenali gejala awal gangguan.

b. Tanda Bahaya yang Harus Diwaspadai

1) Gangguan Pernapasan

- Napas cepat (>60 x/menit)
- Tarikan dinding dada (retraksi)
- Bunyi grok-grok

Menunjukkan kemungkinan gangguan seperti Distres Pernapasan Neonatal.

2) Gangguan Suhu Tubuh

- Demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$)
- Atau suhu rendah ($<36,5^{\circ}\text{C}$)

Dapat mengindikasikan infeksi atau Hipotermia.

3) Tidak Mau Menyusu

- Bayi lemah
- Refleks hisap menurun

Merupakan tanda awal kondisi serius seperti Sepsis Neonatorum.

4) Kejang

- Gerakan tidak terkontrol
- Mata melirik ke atas

Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan segera.

5) Kulit Kuning Berlebihan

- Kuning muncul <24 jam
- Menyebar cepat

Menunjukkan kemungkinan Hiperbilirubinemia.

c. Tindakan yang Harus Dilakukan Keluarga

Keluarga harus segera:

- Membawa bayi ke fasilitas kesehatan
- Tidak menunda penanganan
- Tidak melakukan pengobatan sendiri

Pendekatan Edukasi yang Efektif

Agar edukasi berhasil, perawat perlu:

- Menggunakan bahasa sederhana
- Demonstrasi langsung (misalnya cara menyusui)
- Memberikan leaflet/booklet
- Melibatkan anggota keluarga lain

H. PATHWAY KLINIS NEONATUS

Prematuritas → Imaturitas organ → Gangguan adaptasi →
Hipotermia + Hipoglikemia + Gangguan napas → Intervensi → Stabilitas

Pathway klinis neonatus merupakan gambaran alur proses terjadinya gangguan kesehatan pada bayi baru lahir yang dimulai dari faktor risiko, diikuti oleh gangguan adaptasi fisiologis, munculnya manifestasi klinis, hingga penetapan diagnosis dan intervensi keperawatan. Pemahaman terhadap pathway ini sangat penting bagi perawat karena menjadi dasar dalam melakukan clinical reasoning, menentukan prioritas masalah, serta memberikan asuhan keperawatan yang tepat dan cepat.

Pada periode neonatal, bayi berada dalam fase transisi dari kehidupan intrauterin menuju kehidupan ekstrauterin. Proses ini menuntut kesiapan berbagai sistem organ, seperti sistem pernapasan, kardiovaskular, metabolisme, dan termoregulasi. Namun, tidak semua bayi mampu beradaptasi secara optimal, terutama bayi dengan faktor risiko seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, asfiksia, atau paparan infeksi.

Faktor-faktor risiko tersebut menyebabkan imaturitas organ tubuh bayi. Imaturitas ini berdampak pada ketidakmampuan sistem tubuh dalam menjalankan fungsi fisiologis secara optimal. Sebagai contoh, paru-paru yang belum matang

pada bayi prematur menyebabkan produksi surfaktan yang tidak adekuat. Hal ini mengakibatkan alveoli sulit mengembang sehingga proses pertukaran gas menjadi tidak efektif. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi gangguan pernapasan, yang secara klinis dikenal sebagai Distres Pernapasan Neonatal.

Gangguan pernapasan tersebut ditandai dengan peningkatan frekuensi napas, retraksi dinding dada, dan terkadang sianosis. Secara fisiologis, kondisi ini menyebabkan penurunan kadar oksigen (hipoksia) dan peningkatan kadar karbon dioksida (hiperkapnia) dalam darah. Jika tidak segera ditangani, keadaan ini dapat berkembang menjadi asidosis respiratorik yang berdampak pada gangguan fungsi organ vital.

Selain sistem pernapasan, sistem termoregulasi juga menjadi salah satu aspek yang sering mengalami gangguan pada neonatus. Bayi, terutama yang lahir prematur atau dengan berat badan rendah, memiliki cadangan lemak subkutan yang terbatas dan permukaan tubuh yang relatif luas. Kondisi ini menyebabkan bayi sangat mudah kehilangan panas melalui mekanisme evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Akibatnya, bayi berisiko mengalami Hipotermia.

Hipotermia tidak hanya berdampak pada penurunan suhu tubuh, tetapi juga memicu peningkatan metabolisme sebagai upaya kompensasi tubuh untuk menghasilkan panas. Peningkatan metabolisme ini membutuhkan konsumsi oksigen dan glukosa yang lebih tinggi. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka bayi akan mengalami hipoksia dan hipoglikemia secara bersamaan. Kondisi ini memperburuk keadaan bayi dan dapat menyebabkan gangguan fungsi organ, termasuk otak.

Hipoglikemia sendiri merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada neonatus, terutama pada bayi dengan cadangan energi yang terbatas. Setelah lahir, bayi harus mempertahankan kadar glukosa darah secara mandiri, sementara asupan nutrisi mungkin belum optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan glukosa menyebabkan penurunan kadar gula darah atau yang dikenal sebagai Hipoglikemia Neonatal. Secara klinis, kondisi ini dapat ditandai dengan gejala seperti bayi tampak lemah, tremor, hingga kejang apabila tidak segera ditangani.

Selain itu, sistem imun neonatus yang belum matang menjadikan bayi sangat rentan terhadap infeksi. Paparan mikroorganisme dapat terjadi selama proses persalinan maupun setelah lahir melalui lingkungan. Ketidakmampuan sistem imun dalam melawan patogen menyebabkan infeksi mudah berkembang menjadi infeksi sistemik atau Sepsis Neonatorum. Kondisi ini seringkali ditandai dengan gejala non-spesifik seperti tidak mau menyusu, suhu tubuh tidak stabil, dan penurunan aktivitas.

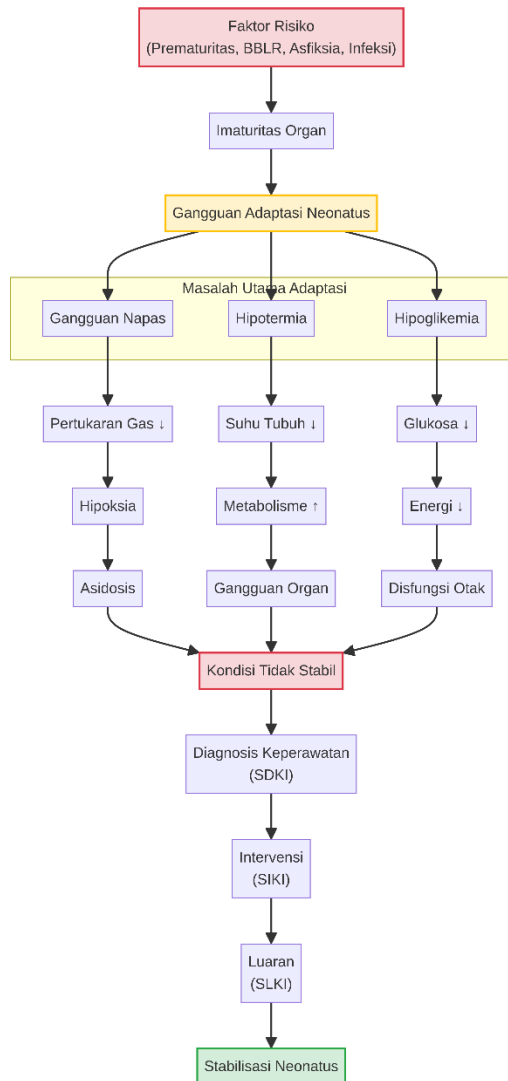
Gangguan lain yang juga sering terjadi adalah peningkatan kadar bilirubin akibat fungsi hati yang belum matang. Pemecahan sel darah merah yang meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan hati dalam mengkonjugasi bilirubin, sehingga terjadi penumpukan bilirubin dalam darah. Kondisi ini dikenal sebagai Hiperbilirubinemia, yang secara klinis ditandai dengan warna kuning pada kulit dan sklera.

Dalam praktik klinis, berbagai gangguan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, bayi prematur dapat mengalami hipotermia yang kemudian memicu hipoglikemia dan memperburuk gangguan pernapasan. Rangkaian kejadian ini dikenal sebagai cascade effect, di mana satu masalah memicu timbulnya masalah lain sehingga kondisi bayi semakin tidak stabil.

Berdasarkan kondisi tersebut, perawat perlu melakukan pengkajian secara komprehensif untuk mengidentifikasi masalah keperawatan yang muncul. Diagnosis keperawatan yang sering ditemukan antara lain gangguan pola napas, risiko hipotermia, risiko hipoglikemia, dan risiko infeksi. Setelah diagnosis ditegakkan, perawat kemudian merencanakan intervensi yang sesuai, seperti manajemen jalan napas, termoregulasi, pemberian nutrisi, serta pencegahan infeksi.

Tujuan utama dari seluruh intervensi tersebut adalah mencapai stabilisasi kondisi neonatus, yang ditandai dengan pernapasan yang efektif, suhu tubuh dalam batas normal, kadar glukosa yang stabil, serta tidak adanya tanda infeksi. Selain itu, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada keluarga agar mampu melanjutkan perawatan bayi secara mandiri di rumah.

Dengan demikian, pathway klinis neonatus memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara faktor risiko, gangguan fisiologis, dan kondisi klinis bayi. Pemahaman yang baik terhadap pathway ini akan membantu perawat dalam mengambil keputusan klinis yang tepat, cepat, dan berbasis evidence, sehingga dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatus.



Gambar 4. 2 Flowchart komprehensif untuk jalur klinis neonatus

I. PENUTUP

Periode neonatus merupakan fase transisi yang sangat penting dalam kehidupan bayi, di mana terjadi perubahan fisiologis dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Proses adaptasi ini melibatkan berbagai sistem tubuh, terutama sistem pernapasan, kardiovaskular, termoregulasi, metabolisme, dan sistem imun. Tidak semua bayi mampu beradaptasi secara optimal, terutama bayi dengan faktor risiko seperti prematuritas dan berat badan lahir rendah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti Distres Pernapasan Neonatal, Hipotermia, Hipoglikemia Neonatal, dan Sepsis Neonatorum.

Asuhan keperawatan neonatus berperan penting dalam mendukung keberhasilan adaptasi tersebut melalui pengkajian komprehensif, deteksi dini masalah, serta intervensi yang tepat dan berkelanjutan. Asuhan dasar seperti menjaga jalan napas, mempertahankan suhu tubuh, pemberian ASI melalui inisiasi

menyusu dini, serta pencegahan infeksi merupakan komponen utama dalam perawatan bayi baru lahir. Selain itu, edukasi kepada keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam asuhan keperawatan. Keluarga sebagai caregiver utama perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merawat bayi serta mengenali tanda bahaya sejak dini. Dengan demikian, keberhasilan perawatan neonatus merupakan hasil dari kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga.

RINGKASAN POIN PENTING

1. Periode neonatus (0–28 hari) merupakan fase kritis adaptasi dari intrauterin ke ekstrauterin.
2. Adaptasi fisiologis meliputi sistem pernapasan, kardiovaskular, termoregulasi, metabolisme, dan imun.
3. Gangguan adaptasi dapat menyebabkan masalah seperti:
 - a. Distres Pernapasan Neonatal
 - b. Hipotermia
 - c. Hipoglikemia Neonatal
 - d. Sepsis Neonatorum
4. Pengkajian neonatus dilakukan melalui APGAR, pemeriksaan fisik, dan refleksi neonatal.
5. Asuhan dasar meliputi:
 - a. Menjaga jalan napas
 - b. Menjaga kehangatan
 - c. Inisiasi menyusu dini (IMD)
 - d. Pencegahan infeksi
6. Edukasi keluarga sangat penting dalam keberlanjutan perawatan bayi di rumah.
7. Pendekatan keperawatan menggunakan SDKI, SIKI, dan SLKI untuk meningkatkan kualitas asuhan.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Kasus: Adaptasi Bayi Baru Lahir & Asuhan Dasar Neonatus

Seorang bayi laki-laki lahir spontan di ruang bersalin dengan usia gestasi 39 minggu. Bayi lahir menangis lemah, warna kulit agak kebiruan pada ekstremitas, dan tonus otot masih kurang baik. Berat badan lahir 3000 gram. Ibu tampak cemas karena bayi belum menyusui.

Hasil pengkajian awal menunjukkan:

- Frekuensi napas 50 x/menit
- Denyut jantung 140 x/menit
- Suhu 36,2°C
- Warna kulit akrosianosis
- Refleks menghisap lemah
- Bayi tampak sedikit hypotonia
- APGAR score menit pertama: 6
- Tali pusat sudah diklem dan dipotong
- Bayi belum dilakukan IMD

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan gangguan adaptasi pada bayi baru lahir.
2. Tentukan masalah utama pada fase transisi neonatus berdasarkan data.
3. Analisis faktor yang dapat memengaruhi proses adaptasi bayi.
4. Tentukan diagnosis keperawatan prioritas pada kasus ini.
5. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan.
6. Identifikasi tanda bahaya (red flags) pada neonatus.
7. Jelaskan pentingnya IMD dalam adaptasi neonatus.
8. Jelaskan rencana edukasi kepada ibu terkait perawatan bayi baru lahir.

Instruksi Diskusi

Diskusikan menggunakan **clinical reasoning** dengan langkah:

- Analisis data → masalah → prioritas → tindakan
- Presentasikan hasil diskusi kelompok

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi proses adaptasi neonates
- Mengenali gangguan adaptasi awal

- Menentukan prioritas asuhan keperawatan neonates
- Melakukan tindakan awal yang aman
- Mengembangkan clinical reasoning

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN (MODEL UKOM)

1. Identifikasi tanda gangguan adaptasi neonatus

Jawaban:

- Menangis lemah
- Akrosianosis
- Refleks menghisap lemah
- Hipotonia
- Suhu rendah (36,2°C)
- APGAR 6 (asfiksia ringan-sedang)

Pembahasan:

Bayi belum beradaptasi optimal terhadap kehidupan ekstrauterin.

Akrosianosis dan hipotonia menunjukkan adaptasi sirkulasi dan neurologis belum optimal.

2. Masalah utama adaptasi

Jawaban:

Gangguan adaptasi pernapasan dan termoregulasi

Pembahasan:

Neonatus harus beralih dari lingkungan intrauterin ke ekstrauterin → melibatkan:

- Sistem pernapasan
- Sirkulasi
- Termoregulasi

3. Faktor yang memengaruhi adaptasi

Jawaban:

- Proses persalinan
- Suhu lingkungan
- Keterlambatan IMD
- Kondisi bayi saat lahir

Pembahasan:

IMD sangat penting untuk stabilisasi suhu, respirasi, dan bonding.

4. Diagnosis keperawatan (SDKI)

Jawaban utama:

- 1) Gangguan pertukaran gas
- 2) Risiko hipotermia

- 3) Ketidakefektifan menyusu
- 4) Risiko infeksi
- 5. Tindakan keperawatan awal

Jawaban:

- Pengeringan bayi segera
- Menjaga kehangatan (skin to skin)
- Membersihkan jalan napas bila perlu
- Monitoring respirasi dan denyut jantung
- Inisiasi menyusu dini (IMD)
- Observasi tanda vital

Pembahasan:

Fokus utama: stabilisasi ABC + termoregulasi

- 6. Red flags neonatus

Jawaban:

- Tidak menangis
- Napas <30 atau >60 x/menit
- Sianosis sentral
- Tidak mau menyusu
- Hipotermia
- Kejang

- 7. Pentingnya IMD

Jawaban:

- Menstabilkan suhu
- Meningkatkan bonding
- Merangsang refleks menyusu
- Mencegah hipotermia

- 8. Edukasi ibu

Jawaban:

- Pentingnya ASI eksklusif
- Menjaga kehangatan bayi
- Tanda bahaya neonates
- Cara menyusui yang benar

KESIMPULAN MODEL UKOM

Kasus menunjukkan gangguan adaptasi awal neonatus ringan.

Prioritas utama:

1. Stabilkan pernapasan
2. Cegah hipotermia
3. Dukung menyusui dini
4. Monitoring ketat

POIN KUNCI UKOM (HIGH-YIELD)

1. APGAR <7 = gangguan adaptasi
2. Hipotermia = masalah utama neonates
3. IMD = intervensi kunci
4. ABC + kehangatan = prioritas

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi / Skill Lab Neonatus

Fokus: urutan tindakan klinik + komunikasi terapeutik + keselamatan bayi

Catatan untuk penulis:

- Tidak langsung ke ujian (OSCE)
- Mahasiswa harus melalui tahapan kompetensi bertahap (knowledge → skill → performance)
- Fokus utama: adaptasi fisiologis neonatus & patient safety

Alur Pembelajaran Skill Lab

Mahasiswa dilatih untuk:

- Melakukan pengkajian cepat neonatus (ABC: airway, breathing, circulation)
- Mengidentifikasi tanda adaptasi normal dan gangguan adaptasi bayi baru lahir
- Menentukan prioritas tindakan (airway dan termoregulasi)
- Melakukan tindakan awal asuhan dasar neonatus secara sistematis
- Menjaga kehangatan bayi (pengeringan, skin to skin)
- Mendukung inisiasi menyusui dini (IMD)
- Mengenali tanda bahaya neonatus (red flags)
- Melakukan eskalasi tepat waktu pada kondisi kegawatdaruratan
- Berkomunikasi efektif dengan ibu dan keluarga

Skenario Simulasi (Skill Lab)

Seorang bayi baru lahir usia 5 menit, lahir spontan, tampak menangis lemah, frekuensi napas 64x/menit, suhu tubuh 36°C, terdapat lendir di jalan napas, dan akrosianosis pada ekstremitas.

Mahasiswa diminta melakukan pengkajian awal dan tindakan asuhan dasar neonatus.

Langkah Keterampilan yang Dilatih

1. Persiapan
 - Melakukan hand hygiene
 - Menggunakan APD
 - Menyiapkan alat (kain hangat, penghisap lendir, selimut)
2. Pengkajian Awal (Primary Survey)
 - Menilai jalan napas (airway)
 - Menilai pernapasan (RR, usaha napas)
 - Menilai denyut jantung
 - Menilai warna kulit
 - Menilai refleks / tangisan
 - Melakukan penilaian APGAR

3. Tindakan Asuhan Dasar

- Membersihkan jalan napas jika terdapat lender
- Memposisikan bayi dengan benar (sniffing position)
- Mengeringkan bayi segera
- Menjaga kehangatan bayi (skin to skin contact)
- Menyelimuti bayi dengan kain hangat
- Mendukung IMD

4. Monitoring dan Evaluasi

- Memantau frekuensi napas dan denyut jantung
- Memantau suhu tubuh
- Menilai respons bayi (aktif / lemah)
- Mengevaluasi keberhasilan adaptasi

5. Komunikasi Terapeutik

- Memperkenalkan diri
- Menjelaskan kondisi bayi kepada ibu
- Memberikan edukasi tentang IMD dan tanda bahaya neonates
- Memberikan dukungan emosional

6. Keselamatan Pasien (Patient Safety)

- Menjaga kehangatan bayi (mencegah hipotermia)
- Memastikan jalan napas tidak terhambat
- Menghindari tindakan yang tidak perlu
- Melakukan tindakan secara aseptik

7. Eskalasi (Jika Ditemukan Kegawatan)

Mahasiswa harus mampu mengenali dan melakukan eskalasi bila terdapat:

- Tidak menangis / apnea
- RR > 60x/menit disertai retraksi
- Sianosis sentral
- Denyut jantung < 100x/menit
- Hipotermia berat

Tindakan: segera laporkan dan lakukan tindakan resusitasi sesuai prosedur

Output Pembelajaran (Shows How)

Mahasiswa mampu:

- Melakukan pengkajian awal neonatus secara sistematis
- Melakukan tindakan asuhan dasar bayi baru lahir dengan benar
- Menjaga keselamatan bayi (patient safety)
- Berkomunikasi efektif dengan ibu
- Menentukan prioritas tindakan dan eskalasi

Makna dalam Pembelajaran

Tahapan "Shows How" menekankan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep adaptasi bayi baru lahir, tetapi mampu menunjukkan keterampilan klinik secara langsung dalam simulasi, sebelum melanjutkan ke tahap OSCE dan praktik klinik nyata.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Mini-case, diskusi
Shows How	OSCE neonatus

- CP Bab = **mendemonstrasikan perawatan neonates**
- OSCE digunakan karena menilai keterampilan praktik (shows how)
- Penilaian tidak dipaksakan, tetapi **aligned dengan kompetensi**

Simulasi Skill Lab (Tahapan Tindakan)

1. Pra Interaksi
 - Menyiapkan alat neonatal
 - Cuci tangan
2. Orientasi
 - Perkenalan
 - Verifikasi bayi & ibu
 - Menjaga privasi
3. Tahap Kerja
 - a. Pengkajian cepat
 - Napas
 - Denyut jantung
 - Warna kulit
 - Tonus otot
 - b. Tindakan utama
 - Pengeringan bayi
 - Skin to skin contact
 - IMD
 - Menjaga suhu
 - Monitoring vital
 - c. Komunikasi
 - Menenangkan ibu
 - Edukasi sederhana

4. Terminasi

- Evaluasi kondisi bayi
- Dokumentasi

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene
- Menjaga kehangatan bayi
- Pengkajian respirasi
- IMD
- Identifikasi bayi
- Eskalasi bila distress

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen	Tepat	Cukup	Ragu	Salah
Tindakan	Sistematis	Cukup	Kurang	Tidak sesuai
Komunikasi	Empatik	Baik	Kurang	Buruk

Catatan Penting

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan
- Kesalahan critical items = otomatis tidak lulus

Kunci Pembelajaran Skill Lab Neonatus

- Jangan langsung fokus diagnosis → stabilisasi dulu
- Kehangatan = prioritas utama
- IMD wajib
- Observasi napas sangat penting
- Eskalasi cepat bila distress

Adaptasi Bayi Baru Lahir & Asuhan Dasar Neonatus

Disusun dengan model yang sama seperti kasus maternitas (APH), berbasis OBE + OSCE + DOPS + keselamatan pasien.

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Adaptasi Bayi Baru Lahir & Asuhan Dasar Neonatus
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian adaptasi neonatus, menentukan diagnosis keperawatan, serta melakukan tindakan dasar (termoregulasi, IMD, monitoring)
5	Kompetensi	Pengkajian Diagnosa dan perencanaan Implementasi Evaluasi Perilaku professional
6	Kategori	Neonatus Kegawatdaruratan Cairan Termoregulasi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang bayi laki-laki lahir spontan usia gestasi 39 minggu. Bayi menangis lemah, warna kulit akrosianosis, suhu 36,2°C, refleks menghisap lemah. Frekuensi napas 50x/menit, denyut jantung 140x/menit TUGAS: Lakukan pengkajian fokus pada neonatus Tentukan diagnosis keperawatan Susun rencana keperawatan Lakukan tindakan awal (penghangatan, IMD, monitoring) Berikan edukasi kepada ibu
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: (sama dengan peserta) Seorang bayi laki-laki lahir spontan usia gestasi 39 minggu. Bayi menangis lemah, warna kulit akrosianosis, suhu 36,2°C, refleks menghisap lemah. Frekuensi napas 50x/menit, denyut jantung 140x/menit TUGAS: (sama dengan peserta) Lakukan pengkajian fokus pada neonatus Tentukan diagnosis keperawatan Susun rencana keperawatan Lakukan tindakan awal (penghangatan, IMD, monitoring) Berikan edukasi kepada ibu Instruksi Penguji Menilai pengkajian: napas, suhu, warna, tonus Menilai diagnosis: hipotermia, gangguan adaptasi

No.	Komponen	Isi
		Menilai tindakan: IMD, penghangatan Menilai komunikasi & keselamatan
9	Instruksi untuk klien standar (Ibu)	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: Ibu cemas Bayi belum menyusui Bertanya: "Apakah bayi saya sehat?" Harapan: bayi segera stabil
10	Setting station	Tata letak ruang: Ruang bersalin Manekin bayi Tempat tidur Trolis alat Tempat tidur pasien Kursi KS Meja pengujian Kursi pengujian Trolis alat Wastafel/handrub Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan Handuk Kain hangat Stetoskop Termometer Pengalas bayi
12	Penulis	Ety Nurhayati, S.Kp.,M.Kep.,Ns.Sp.Kep.Mat
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017). <i>Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia</i> . Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019). <i>Standar Intervensi Keperawatan Indonesia</i> . Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019). <i>Standar Luaran Keperawatan Indonesia</i> . Cunningham, F. G., et al. (2022). <i>Williams Obstetrics</i> . World Health Organization. (2023). <i>Maternal and perinatal health guidelines</i> .

SOP ASUHAN KEPERAWATAN NEONATUS
SOP ASUHAN KEPERAWATAN NEONATUS : Adaptasi Bayi Baru Lahir &
Asuhan Dasar

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis				
2	Menyiapkan alat: 1. Handuk 2. Kain hangat 3. Stetoskop 4. Termometer 5. Pengalas bayi				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran				
6	Verifikasi identitas pasien				
7	Menjelaskan tujuan tindakan				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Menjaga privasi & kenyamanan				
10	Menyampaikan salam terapeutik				
C	Tahap Kerja (Sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bila perlu				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
13	Mengkaji nafas, karakteristik pernafasan				
14	Mengkaji suhu				
15	Mengkaji warna kulit				
16	Mengkaji reflex				
17	Pengeringan bayi				
18	Skin to skin				
19	IMD				
20	Monitoring tanda vital				
21	Edukasi Ibu				
22	Menjelaskan tanda bahaya				
23	Meminta pasien mengulang informasi				
24	Merapikan pasien dan alat				
25	Cuci tangan				
D	Tahap Terminasi				
26	Evaluasi				
E	Tahap Dokumentasi				
27	Mencatat hasil tindakan dan respon				
F	Perilaku Profesional				
35	Aman, teliti, sistematis, responsive				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION KEPERAWATAN NEONATUS: ADAPTASI BAYI BARU LAHIR &
ASUHAN DASAR

1. Form Penilaian

No	Kompetensi	Indikator	0	1	2	3	Bobot
1	Pengkajian	Menilai napas, suhu, warna					2
2	Diagnosis	Menentukan diagnosis					2
3	Implementasi	Penghangatan, IMD					4
4	Profesional	Komunikasi & keamanan					2

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: KEPERAWATAN NEONATUS: ADAPTASI BAYI BARU LAHIR &
ASUHAN DASAR

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian awal neonatus meliputi penilaian pernapasan, denyut jantung, warna kulit, refleks, suhu tubuh, serta melakukan penilaian APGAR secara tepat dan sistematis.					1	
2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai kondisi neonatus (misalnya gangguan pola napas, risiko hipotermia, risiko hipoglikemia) serta menyusun rencana keperawatan yang tepat berdasarkan prioritas masalah dan hasil pengkajian. Peserta menuliskan diagnosis dan rencana secara jelas dan logis.					2	
3. Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan tindakan asuhan dasar bayi baru lahir secara benar, meliputi menjaga jalan napas, mengeringkan bayi, menjaga kehangatan (skin to skin), posisi bayi, dukungan IMD, serta perawatan tali pusat. Tindakan dilakukan secara aman, tepat, sistematis, dan sesuai kondisi bayi.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan sikap profesional sesuai prinsip etik dan legal, antara lain memperkenalkan diri, menjelaskan tindakan kepada ibu/keluarga, meminta persetujuan, berkomunikasi terapeutik, menjaga					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
kenyamanan dan keamanan bayi, menjaga privasi, serta bekerja dengan teliti dan responsif.						

DESKRIPSI PERFORMA TIAP SKOR

Asuhan Keperawatan Neonatus: Adaptasi Bayi Baru Lahir & Asuhan Dasar

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan Neonatus	Tidak melakukan pengkajian, atau pengkajian tidak relevan dengan kondisi bayi baru lahir.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, tidak sistematis, hanya menilai sebagian kecil data, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda adaptasi neonatal (napas, suhu, warna kulit, refleks).	Melakukan pengkajian cukup baik dan cukup sistematis, mampu menilai sebagian besar data seperti frekuensi napas, suhu, warna kulit, tangisan, refleks, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum tepat.	Melakukan pengkajian lengkap, sistematis, dan relevan meliputi penilaian adaptasi respirasi, termoregulasi, sirkulasi (warna kulit), refleks neonatal, aktivitas, dan kemampuan menyusu, serta mampu menyampaikan hasil dengan tepat.
2. Diagnosis & Perencanaan Keperawatan	Tidak mampu menegaskan diagnosis keperawatan atau diagnosis tidak sesuai dengan kondisi neonatus. Tidak	Menegakkan diagnosis tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau tidak sesuai dengan data. Rencana keperawatan	Menegakkan diagnosis yang cukup tepat sesuai kondisi bayi (misalnya gangguan adaptasi suhu atau risiko	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data (misalnya risiko

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	mampu menyusun rencana perawatan.	sangat terbatas dan tidak relevan.	hipotermia), dan menyusun rencana yang cukup sesuai namun kurang lengkap atau belum spesifik.	hipotermia, pola napas tidak efektif, risiko infeksi), serta menyusun rencana perawatan yang lengkap, sistematis, spesifik, dan sesuai kebutuhan neonatus.
3. Implementasi Keperawatan (Asuhan Dasar Neonatus)	Tidak melakukan tindakan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi bayi.	Melakukan tindakan sangat terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan (misalnya tidak menjaga kehangatan bayi, tidak melakukan IMD), penjelasan kurang jelas, dan teknik tidak tepat.	Melakukan tindakan cukup baik, sebagian besar langkah benar seperti pengeringan bayi, menjaga kehangatan, pemantauan napas, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan, atau teknik.	Melakukan tindakan secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap meliputi pengeringan bayi, menjaga kehangatan (skin to skin), memastikan jalan napas, pemantauan adaptasi, dukungan IMD, pencegahan infeksi, serta edukasi ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, komunikasi	Menunjukkan perilaku profesional cukup baik, komunikasi	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	diri, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keselamatan bayi dan ibu.	kurang jelas, kurang menjaga kenyamanan atau keamanan bayi.	cukup jelas, memperhatikan kenyamanan dan keamanan bayi, namun masih ada kekurangan kecil.	komunikasi terapeutik baik, menjaga privasi, memperhatikan keselamatan bayi dan ibu, teliti, responsif, serta menunjukkan sikap empatik dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

DOPS (Does)

Observasi Klinik Langsung

- Pengkajian neonates
- Penghangatan
- IMD
- Edukasi

IV. Catatan Penguji

- Fokus pada ketepatan tindakan dan keselamatan neonatus
- Perhatikan urutan tindakan (pengkajian → diagnosis → tindakan)
- Utamakan prinsip **asuhan dasar bayi baru lahir (essential newborn care)**
- Perhatikan komunikasi dan sikap profesional mahasiswa

V. Critical Point (Kegagalan Langsung)

Mahasiswa dinyatakan **tidak lulus** apabila:

- Tidak menjaga jalan napas neonatus
- Tidak melakukan tindakan menjaga kehangatan bayi
- Tidak melakukan pengkajian dasar (APGAR/respirasi)

Keterangan Tambahan (untuk penguatan pemahaman mahasiswa)

Fokus Pengkajian Neonatus (yang dinilai pada skor tinggi)

- Frekuensi napas (30–60x/menit)
- Warna kulit (pink / sianosis)
- Suhu tubuh
- Tangisan & aktivitas
- Refleks neonatal (Moro, rooting, sucking)
- Kemampuan menyusu

- Tanda distress pernapasan

Fokus Implementasi Asuhan Dasar

- Pengeringan bayi segera setelah lahir
- Menjaga kehangatan (skin-to-skin)
- Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- Menjaga kebersihan dan pencegahan infeksi
- Monitoring adaptasi (napas, suhu, warna)

Catatan Penting untuk Penilaian OSCE

- Skor tinggi tidak berarti lulus jika keselamatan bayi tidak terpenuhi
- Kesalahan fatal (misalnya bayi tidak dijaga kehangatannya) → dapat menyebabkan **tidak lulus**
- Fokus utama:
 1. Adaptasi fisiologis neonates
 2. Keselamatan bayi
 3. Tindakan dasar yang benar
 4. Komunikasi dengan ibu

CRITICAL ITEMS (WAJIB LULUS)

Jika tidak dilakukan → TIDAK LULUS

- Hand hygiene
- Menjaga kehangatan bayi
- Pengkajian napas
- IMD
- Identifikasi bayi
- Komunikasi aman

KUNCI PEMBELAJARAN

- Adaptasi neonatus = proses kritis
- Kehangatan = prioritas utama
- IMD wajib dilakukan
- Observasi napas sangat penting
- Keselamatan pasien utama

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Neonatus: Adaptasi Bayi Baru Lahir dan Asuhan Dasar

Tabel 5. 1 Penerapan DOPS pada Asuhan Keperawatan Neonatus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam situasi klinik nyata atau simulasi.	Pembimbing mengamati langsung mahasiswa saat melakukan asuhan awal pada bayi baru lahir di ruang bersalin, seperti pengkajian awal, menjaga jalan napas, pengeringan, dan menjaga kehangatan bayi.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, dan sesuai standar praktik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya memahami konsep adaptasi neonatus tetapi mampu melakukan tindakan prioritas seperti memastikan jalan napas, menilai APGAR, menjaga suhu tubuh, dan mendukung IMD.
Kasus klinik	Kasus diambil dari kondisi nyata yang sering ditemukan dan sesuai kompetensi mahasiswa.	Seorang bayi baru lahir usia 5 menit, menangis lemah, RR 62x/menit, suhu 36°C, terdapat lendir di jalan napas, warna kulit sedikit sianosis pada ekstremitas.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan prosedur klinik secara langsung mulai dari persiapan hingga evaluasi tindakan.	Mahasiswa melakukan hand hygiene, memperkenalkan diri, melakukan pengkajian awal (napas, warna, denyut jantung), membersihkan jalan napas, mengeringkan bayi, melakukan skin to skin, dan menjelaskan kondisi bayi kepada ibu.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan teknis, keselamatan pasien, komunikasi, serta ketepatan prosedur.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam pengkajian APGAR, menjaga jalan napas, pencegahan hipotermia, teknik IMD, edukasi ibu, dan menjaga keselamatan neonatus.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Fokus observasi pembimbing	Menilai apakah mahasiswa melakukan prosedur sesuai standar dan prinsip keselamatan pasien.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa melakukan prioritas ABC (airway, breathing), menjaga kehangatan, tidak menunda pengeringan bayi, serta mampu mengenali tanda gangguan adaptasi.
Umpan balik	Diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik dan konstruktif.	Pembimbing memberikan masukan bahwa mahasiswa sudah baik dalam pengkajian dan tindakan dasar, namun perlu meningkatkan kecepatan respon dan ketepatan prioritas pada bayi dengan napas cepat.
Keputusan penilaian	Digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam keterampilan klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan asuhan dasar neonatus secara sistematis, aman, dan tepat. Perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Remedial jika tindakan tidak sesuai standar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level praktik (does).	Mahasiswa tidak hanya memahami teori adaptasi neonatus tetapi mampu melakukan asuhan dasar secara langsung, cepat, aman, dan profesional sesuai standar praktik klinik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 5. 2 Portofolio pada Asuhan Keperawatan Neonatus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan.	Mahasiswa mengumpulkan bukti praktik asuhan neonatus dari pengkajian hingga edukasi, menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menangani bayi baru lahir.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan dalam melakukan asuhan dasar neonatus setelah mendapatkan umpan balik dari CI/dosen.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio sebagai bukti keterampilan laboratorium dan praktik klinik nyata.	OSCE berisi keterampilan asuhan dasar bayi baru lahir (pengkajian, pengeringan, IMD), sedangkan DOPS berisi observasi langsung tindakan di ruang bersalin.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus yang memuat data penting, masalah, intervensi, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan bayi baru lahir dengan napas cepat, suhu rendah, diagnosis risiko hipotermia, intervensi pengeringan, skin to skin, dan evaluasi kondisi bayi.
Refleksi patient safety	Refleksi tentang kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan pencegahannya.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya menjaga kehangatan bayi dan memastikan jalan napas untuk mencegah komplikasi neonatal.
Feedback CI/dosen	Umpan balik sebagai bukti pembinaan dan peningkatan kompetensi.	CI menyampaikan mahasiswa sudah baik dalam tindakan dasar, namun perlu meningkatkan kecepatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
		respon dan ketelitian pengkajian.
Karakteristik penilaian	Penilaian berkelanjutan, bukan sekali selesai, menekankan konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kasus neonatus yang menunjukkan kemampuan konsisten dalam asuhan bayi baru lahir.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan performa dalam berbagai situasi klinik.	Dari OSCE, DOPS, dan catatan kasus, mahasiswa konsisten mampu melakukan pengkajian, tindakan dasar, dan edukasi pada neonatus.
Makna dalam OBE	Bukti capaian pembelajaran berbasis praktik nyata.	Mahasiswa mampu menerapkan teori adaptasi neonatus secara konsisten, aman, dan profesional dalam praktik klinik.

Tabel 5. 3 Case Report pada Asuhan Keperawatan Neonatus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Hakikat case report	Laporan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa.	Mahasiswa menyusun laporan bayi baru lahir dengan gangguan adaptasi awal.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan masalah adaptasi, tindakan awal, dan perkembangan kondisi bayi.
Isi laporan	Identitas pasien, data subjektif-objektif, analisis, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.	Bayi usia 5 menit, RR 62x/menit, suhu 36°C, diagnosis risiko hipotermia dan gangguan napas, intervensi pengeringan, airway management, IMD, evaluasi kondisi stabil.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa menghubungkan napas cepat dan suhu rendah dengan gangguan adaptasi.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.	Mahasiswa memahami bahwa adaptasi neonatus sangat kritis dan membutuhkan tindakan cepat.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori ke praktik klinik nyata.	Mahasiswa mampu menyusun laporan asuhan neonatus secara komprehensif.

Tabel 5. 4 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Neonatus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan reflektif tentang risiko keselamatan pasien dan pencegahannya.	Mahasiswa menyadari bahwa kegagalan adaptasi neonatus dapat menyebabkan komplikasi serius.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan pasien.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan tindakan dapat menyebabkan hipotermia dan gangguan napas.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, pembelajaran.	Mahasiswa mengidentifikasi risiko hipotermia, asfiksia, dan infeksi.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko hipotermia, gangguan napas, keterlambatan IMD, dan infeksi.
Tindakan pencegahan	Langkah untuk mengurangi risiko.	Pengeringan segera, menjaga kehangatan, memastikan airway, IMD, dan kebersihan tangan.
Pembelajaran mahasiswa	Apa yang dipelajari dan dampaknya pada praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari pentingnya respon cepat, tindakan sistematis, dan keselamatan pasien.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Makna dalam OBE	Bukti perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Mahasiswa mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas asuhan neonatus secara berkelanjutan.

J. RINGKASAN

Asuhan Keperawatan Bayi Baru Lahir: Adaptasi Neonatus & Asuhan Dasar

Bab ini menekankan bahwa periode bayi baru lahir merupakan fase transisi kritis dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin yang memerlukan adaptasi fisiologis cepat pada sistem pernapasan, kardiovaskular, termoregulasi, metabolisme, dan imun. Kegagalan adaptasi ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti asfiksia, hipotermia, hipoglikemia, dan infeksi neonatal. Fokus utama asuhan keperawatan pada bayi baru lahir adalah memastikan keberhasilan adaptasi awal dengan mempertahankan jalan napas, mendukung pernapasan efektif, menjaga suhu tubuh, serta mencegah komplikasi melalui tindakan cepat, tepat, dan aman. Prinsip utama adalah airway, breathing, circulation (ABC) serta pencegahan kehilangan panas.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian neonatus tidak hanya sebatas melihat bayi menangis atau tidak, tetapi harus mencakup kondisi umum bayi, frekuensi dan pola napas, warna kulit, denyut jantung, refleks, suhu tubuh, serta penilaian APGAR pada menit pertama dan kelima. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi tanda gangguan adaptasi seperti takipnea, retraksi dada, sianosis, hipotermia, tangisan lemah, atau penurunan aktivitas. Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat dengan prinsip ABC, dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap kondisi respirasi, suhu tubuh, dan status neurologis bayi. Berdasarkan data tersebut, perawat menentukan masalah prioritas seperti gangguan pola napas, risiko hipotermia, risiko hipoglikemia, dan ketidakefektifan menyusu. Rencana asuhan keperawatan mencakup menjaga jalan napas tetap terbuka, membersihkan lendir bila diperlukan, mengeringkan bayi segera setelah lahir, menjaga kehangatan melalui kontak kulit ke kulit (skin to skin), mendukung inisiasi menyusu dini (IMD), serta melakukan pemantauan ketat tanda vital dan kondisi umum bayi. Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu melakukan tindakan secara sistematis dan aman, seperti melakukan pengeringan segera, positioning bayi, memastikan jalan napas paten, menjaga suhu tubuh, serta

memberikan edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya neonatus. Evaluasi dilakukan dengan menilai stabilitas kondisi bayi, pernapasan efektif, suhu tubuh dalam batas normal, serta kemampuan bayi menyusu. Apabila ditemukan tanda kegawatan seperti apnea, sianosis sentral, hipotermia berat, atau tidak ada tangisan, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi sesuai alur pelayanan. Dengan demikian, inti asuhan keperawatan pada bayi baru lahir adalah respon cepat, pengkajian tepat, tindakan prioritas, serta kemampuan mengenali kegawatan secara dini. Kompetensi ini menjadi dasar penting dalam praktik keperawatan maternitas berbasis keselamatan pasien.

Tabel 5. 5 Red Flags & Eskalasi Keperawatan Neonatus : Adaptasi Bayi Baru Lahir

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tidak menangis / apnea	Gangguan pernapasan / asfiksia	Segera lakukan stimulasi dan resusitasi neonatus
RR > 60x/menit + retraksi	Distres pernapasan	Berikan oksigen, laporkan segera
Sianosis sentral	Hipoksia	Eskalasi emergensi, siapkan resusitasi
Suhu < 36,5°C	Hipotermia	Hangatkan bayi, skin to skin / incubator
Suhu > 37,5°C	Risiko infeksi	Monitoring dan evaluasi segera
Denyut jantung < 100x/menit	Depresi neonatal	Resusitasi segera
Tangisan lemah / tidak aktif	Gangguan adaptasi	Observasi ketat dan eskalasi
Tidak mau menyusu	Risiko hipoglikemia	Evaluasi dan intervensi segera
Kejang	Gangguan neurologis serius	Eskalasi emergensi
Lendir banyak di jalan napas	Obstruksi jalan napas	Bersihkan jalan napas segera
Hipotonia (lemah)	Gangguan neurologis	Monitoring dan eskalasi
Tidak BAK / BAB	Gangguan fungsi eliminasi	Evaluasi lanjut

Form Checklist “Saya sudah bisa...”
Adaptasi Bayi Baru Lahir

Nama Mahasiswa : _____
 NIM : _____
 Tanggal : _____
 Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓)

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep adaptasi neonatus	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian cepat (ABC)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan penilaian APGAR	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengkaji pernapasan neonatus	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menilai warna kulit dan refleks	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengkaji suhu tubuh bayi	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda gangguan adaptasi	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menentukan diagnosis keperawatan	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menjaga jalan napas bayi	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjaga kehangatan bayi	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa membantu IMD	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya neonatus	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan eskalasi	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan ibu	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi keperawatan	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Keunggulan versi ini

Keterangan Skor

Skor	Deskripsi
0	Tidak dilakukan
1	Dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
2	Dilakukan cukup tepat namun kurang sistematis
3	Dilakukan dengan sangat tepat, sistematis, dan lengkap

× Bobot)

IV. Catatan Penguji

- Fokus pada ketepatan tindakan dan keselamatan neonatus
- Perhatikan urutan tindakan (pengkajian → diagnosis → tindakan)
- Utamakan prinsip **asuhan dasar bayi baru lahir (essential newborn care)**
- Perhatikan komunikasi dan sikap profesional mahasiswa

V. Critical Point (Kegagalan Langsung)

Mahasiswa dinyatakan **tidak lulus** apabila:

- Tidak menjaga jalan napas neonatus
- Tidak melakukan tindakan menjaga kehangatan bayi
- Tidak melakukan pengkajian dasar (APGAR/respirasi)

Keterangan Tambahan (untuk penguatan pemahaman mahasiswa)

Fokus Pengkajian Neonatus (yang dinilai pada skor tinggi)

- Frekuensi napas (30–60x/menit)
- Warna kulit (pink / sianosis)
- Suhu tubuh
- Tangisan & aktivitas
- Refleks neonatal (Moro, rooting, sucking)
- Kemampuan menyusu
- Tanda distress pernapasan

Fokus Implementasi Asuhan Dasar

- Pengeringan bayi segera setelah lahir
- Menjaga kehangatan (skin-to-skin)
- Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- Menjaga kebersihan dan pencegahan infeksi
- Monitoring adaptasi (napas, suhu, warna)

Catatan Penting untuk Penilaian OSCE

- Skor tinggi tidak berarti lulus jika keselamatan bayi tidak terpenuhi

- Kesalahan fatal (misalnya bayi tidak dijaga kehangatannya) → dapat menyebabkan **tidak lulus**
- Fokus utama:
 1. Adaptasi fisiologis neonates
 2. Keselamatan bayi
 3. Tindakan dasar yang benar
 4. Komunikasi dengan ibu

Referensi

- Altimier, L., & Phillips, R. (2018). The neonatal integrative developmental care model: Advanced clinical applications of the seven core measures. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 18(2), 56–61. <https://doi.org/10.1053/j.nainr.2018.03.008>
- Altimier, L., & Phillips, R. M. (2020). The neonatal integrative developmental care model. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 20(1), 5–10.
- Astuti, D. D., & Wanda, D. (2023). Continuity of care in premature infants. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*.
- Boundy, E. O., et al. (2016). Kangaroo mother care and neonatal outcomes. *Pediatrics*.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Infant care and breastfeeding recommendations*.
- Cloherty, J. P., et al. (2021). *Manual of neonatal care*. Wolters Kluwer.
- Fisseha, B., et al. (2025). Neonatal mortality in preterm infants: A systematic review and meta-analysis. *Archives of Public Health*, 83(1), 45. <https://doi.org/10.1186/s13690-025-01123-4>
- Fitri, S. Y. R., et al. (2024). Neonatal developmental care practice. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*.
- Gooding, J. S., et al. (2021). Family-centered care in the neonatal intensive care unit. *Pediatrics*, 147(1), e2020038506.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2021). *Wong's nursing care of infants and children* (12th ed.). Elsevier.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2023). *Panduan praktik klinis perawatan bayi baru lahir*. Jakarta: IDAI.
- Julianti, E., et al. (2025). Developmental care in NICU. *Indonesian Journal of Nursing Science*.
- Katheria, A. C. (2023). Evidence-based practices in newborn care. *JAMA Network Open*, 6(5), e2312456.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kesehatan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. <https://www.kemkes.go.id>
- Ledinger, D., et al. (2024). WHO recommendations for care of preterm or low birth weight infants. *Global Health Journal*, 8(1), 45–52.
- Malisa, U., et al. (2024). Neonatal sepsis care. *Arrazi Journal of Health*.

- Meiliana, M., et al. (2024). Nutritional management in neonates: Focus on breastfeeding. *Journal of Pediatric Nutrition*, 10(2), 101–110.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-based practice in nursing & healthcare* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Munthe, N. B. G., & Sembiring, I. M. (2024). Community education on neonatal visits. *Jurnal Pengmas Kestra*.
- OECD, & World Health Organization. (2024). *Health at a glance: Asia/Pacific 2024*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/health_glance_ap-2024-en
- Ohlsson, A., & Jacobs, S. E. (2020). NIDCAP: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Pediatrics*, 145(3), e20191524.
- Oliveira, M. M., et al. (2025). Humanization of neonatal care. *JRG Journal of Academic Studies*.
- Pineda, R., et al. (2017). Environmental stressors and their impact on neonatal intensive care unit infants. *Journal of Perinatology*, 37(7), 755–761.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2021). *Maternity and pediatric nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Rudolph, A. M. (2020). *Congenital diseases of the heart*. Wiley.
- Sawyer, T., & Lee, H. C. (2024). Updates in neonatal resuscitation and newborn stabilization. *Pediatrics*, 153(2), e2023067890.
- Smith, L., et al. (2022). Developmental care interventions in neonatal intensive care units: A systematic review. *Annals of Medicine and Surgery*, 81, 104–112.
- Sweet, D. G., et al. (2019). European consensus guidelines on RDS. *Neonatology*.
- Tan, A., et al. (2020). Family-centered neonatal care. *Journal of Neonatal Nursing*.
- Taye, K., et al. (2024). Predictors of neonatal mortality in low-resource settings: A multicenter study. *BMC Pediatrics*, 24, 237.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- United Nations. (2015). *The Millennium Development Goals report 2015*.
- United Nations. (2021). *Sustainable Development Goals report 2021*.

- United Nations. (2022). *Sustainable Development Goals report 2022*.
- United Nations Children's Fund. (2021). *Programming guidance: Infant and young child feeding*.
- Victora, C. G., et al. (2016). Breastfeeding in the 21st century. *The Lancet*.
- World Health Organization. (2020). *Levels & trends in child mortality*.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on essential newborn care*.
- World Health Organization. (2023). *Newborns: Improving survival and well-being*.
- World Health Organization. (2023). *WHO recommendations on newborn care*.
- Zekarias, W., et al. (2024). Determinants of neonatal mortality. *Heliyon*, 10(2), e12345.
- Zulkarnaen, A. E. P., & Jansen, S. (2026). Nesting care in LBW infants. *Jurnal Ilmiah*.

BAB 6

PERENCANAAN PULANG DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PASCA PERSALINAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Perencanaan Pulang dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pasca Persalinan	6.1 Menyusun perencanaan pulang nifas–neonatus mencakup edukasi, kontrol, dan tanda bahaya.	6.2 Merencanakan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan mencakup konseling dan rujukan layanan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-5

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (MCQ/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar pada blueprint konsep (ruang lingkup, CoC, keselamatan pasien)	10	Lembar jawaban ujian
CPMK-5	OSCE/simulasi keterampilan + penilaian komunikasi	Ketepatan langkah tindakan; keselamatan prosedur; kualitas komunikasi terapeutik; kualitas edukasi (teach-back)	20	Checklist keterampilan; rekaman/video simulasi
CPMK-7	Portofolio klinik/proyek perencanaan pulang	Kelengkapan dokumentasi evaluasi; kelengkapan rencana pulang; kesesuaian rencana layanan reproduksi pascapersalinan	10	Portofolio; format dokumentasi & discharge plan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat ≤50% elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat ≥85% elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien	Identifikasi risiko & tindakan aman	Identifikasi 51–69%; tindakan	Identifikasi 70–84%; keputusan	Identifikasi ≥85%; keputusan aman,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
& etik pada skenario maternitas	$\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	aman ada namun belum lengkap.	aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	terencana ($\leq 50\%$ memadai).			

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

KONSEP PERENCANAAN PULANG

A. Definisi dan Prinsip Perencanaan Pulang

1. Pengertian discharge planning

Discharge planning atau perencanaan pulang adalah proses terstruktur untuk menyiapkan pasien berpindah secara aman dari fasilitas pelayanan kesehatan ke rumah atau ke layanan lanjutan lainnya. Dalam literatur keperawatan, perencanaan pulang dipahami sebagai pendekatan interdisipliner yang mencakup identifikasi kebutuhan, pengkajian, penetapan tujuan, perencanaan, implementasi, koordinasi, dan evaluasi agar kesinambungan pelayanan tetap terjaga setelah pasien meninggalkan rumah sakit (Gonçalves-Bradley & Lannin, 2012). Regulasi pelayanan rumah sakit di Amerika Serikat juga menegaskan bahwa proses perencanaan pulang yang efektif harus berfokus pada tujuan pasien, preferensi terapi, dan melibatkan pasien serta pengasuh sebagai mitra aktif dalam perawatan pascapulang (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2023).

Dalam konteks ibu postpartum, perencanaan pulang bukan sekadar keputusan administratif bahwa ibu dan bayi “boleh pulang”, tetapi suatu proses klinis dan edukatif untuk memastikan bahwa ibu dan bayi stabil, keluarga memahami cara perawatan di rumah, tanda bahaya dikenali, dan jalur tindak lanjut sudah jelas. WHO menempatkan masa postnatal sebagai bagian dari kesinambungan layanan maternal-neonatal dan menekankan bahwa kualitas asuhan tidak berhenti ketika persalinan selesai, melainkan berlanjut hingga periode nifas dan adaptasi awal bayi baru lahir (World Health Organization, 2022).

ACOG juga menegaskan bahwa pelayanan postpartum harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, bukan satu kunjungan terisolasi setelah persalinan (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2018).

2. Prinsip kesinambungan asuhan

Prinsip kesinambungan asuhan berarti bahwa pelayanan kepada ibu dan bayi harus tersambung secara logis, informasional, dan operasional sejak masa kehamilan, persalinan, perawatan postpartum di fasilitas, hingga masa pemulihan di rumah dan kunjungan tindak lanjut. WHO menyebutkan bahwa rekomendasi postnatal harus dilihat dalam kerangka *continuum of care*, yaitu kesinambungan pelayanan dari kehamilan hingga periode postnatal, dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayi baru lahir (World Health Organization, 2022). ACOG menambahkan bahwa pada masa postpartum perlu diidentifikasi siapa tenaga kesehatan yang akan mengambil tanggung jawab utama terhadap perawatan berkelanjutan ibu di layanan primer atau *medical home*, sehingga tidak terjadi kekosongan layanan setelah ibu pulang (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2018).

Kesinambungan asuhan juga berarti adanya transfer informasi yang akurat antart tenaga kesehatan, antara fasilitas dan komunitas, serta antara petugas dan keluarga. Tanpa kesinambungan, terdapat risiko ibu tidak memahami jadwal kontrol, bayi tidak dipantau secara tepat, komplikasi terlambat dikenali, dan kebutuhan psikososial tidak tertangani. NICE menekankan bahwa perawatan postnatal mencakup organisasi dan penyampaian layanan, identifikasi masalah kesehatan rutin maupun serius pada ibu dan bayi, dukungan pembentukan ikatan orang tua-bayi, dan dukungan pemberian makan bayi dalam delapan minggu pertama setelah lahir; ini menunjukkan bahwa perencanaan pulang harus menjadi jembatan antara perawatan di fasilitas dan pelayanan lanjutan di rumah atau komunitas (NICE, 2021).

3. Pendekatan berpusat pada ibu dan keluarga

Perencanaan pulang pada ibu postpartum harus menggunakan pendekatan berpusat pada ibu dan keluarga (*woman- and family-centred care*). Artinya, keputusan dan edukasi tidak hanya didasarkan pada standar klinis, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan unik ibu, kondisi sosial-ekonomi, budaya, preferensi, tujuan reproduksi, kemampuan keluarga, serta dukungan yang tersedia di rumah. WHO menyatakan bahwa pengalaman postnatal yang positif melibatkan perempuan, bayi baru lahir, pasangan, orang tua, pengasuh, dan keluarga sebagai penerima informasi, dukungan, dan reassurance yang konsisten dan relevan (World Health Organization, 2022). Regulasi CMS juga menyebut

bahwa pasien dan pengasuh/support person harus menjadi mitra aktif dalam proses perencanaan pulang (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2023).

Pendekatan berpusat pada ibu dan keluarga juga menuntut penggunaan bahasa sederhana, penghormatan terhadap nilai budaya, serta pengakuan atas hak ibu untuk terlibat dalam setiap keputusan. Dalam konteks postpartum, keluarga sering kali memegang peran besar dalam membantu perawatan bayi, menyusui, transportasi kontrol, pembiayaan, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Karena itu, keluarga perlu dipersiapkan bersama ibu, tetapi otonomi ibu tetap harus dihormati. NICE menekankan bahwa asuhan postnatal perlu disampaikan dengan cara yang individual, jelas, dan sesuai preferensi perempuan, sedangkan NHS England menekankan bahwa setiap perempuan seharusnya memiliki rencana perawatan postnatal yang dipersonalisasi sebelum meninggalkan layanan maternitas, disesuaikan dengan kebutuhan klinis, psikologis, dan sosialnya (NICE, 2021; NHS England, 2026).

B. Tujuan Perencanaan Pulang

1. Menjamin keamanan ibu dan bayi

Tujuan utama perencanaan pulang adalah menjamin bahwa ibu dan bayi meninggalkan fasilitas kesehatan dalam kondisi yang aman secara klinis dan dengan dukungan yang memadai untuk melanjutkan perawatan di rumah. Keamanan ini meliputi stabilitas kondisi ibu, stabilitas kondisi bayi, kesiapan keluarga, dan adanya akses terhadap pertolongan bila terjadi masalah. WHO menekankan bahwa layanan postnatal harus meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayi, bukan hanya mempertahankan kelangsungan hidup, sehingga aspek keamanan pulang harus dilihat secara komprehensif (World Health Organization, 2022). ACOG juga menyatakan bahwa minggu-minggu setelah persalinan merupakan periode kritis bagi perempuan dan bayinya, sehingga dukungan pelayanan yang memadai diperlukan untuk memungkinkan pemulihan dan pengasuhan bayi secara aman (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2018).

Keamanan ibu dan bayi dalam perencanaan pulang tidak cukup diukur dari hasil pemeriksaan sesaat, tetapi juga dari kemungkinan keluarga menjalankan instruksi yang diberikan. Bila ibu pulang tanpa memahami tanda bahaya, tanpa mengetahui kapan harus kembali, atau tanpa akses transportasi dan kontak fasilitas kesehatan, maka keamanan pascapulang menjadi terganggu meskipun kondisi saat pulang tampak stabil. Oleh karena itu, penilaian keamanan selalu harus mencakup dimensi klinis, edukatif, dan sosial (NHS England, 2026; Centers for Medicare & Medicaid Services, 2023).

2. Mencegah komplikasi

Perencanaan pulang bertujuan mencegah komplikasi dengan cara mendeteksi faktor risiko sejak dini, memberikan edukasi yang tepat, dan menjamin adanya tindak lanjut. Pada ibu postpartum, komplikasi yang perlu dicegah antara lain perdarahan sekunder, infeksi, hipertensi postpartum, masalah laktasi, gangguan kesehatan mental, dan komplikasi luka. Pada bayi, fokus pencegahan meliputi infeksi, ikterus, gangguan suhu, kesulitan menyusui, dan masalah pertumbuhan awal. NICE secara jelas menyebutkan bahwa asuhan postnatal harus mencakup identifikasi dan penanganan masalah kesehatan umum maupun serius pada perempuan dan bayi pada delapan minggu pertama setelah kelahiran (NICE, 2021).

Secara konseptual, perencanaan pulang yang baik menutup “celah” antara perawatan rumah sakit dan kehidupan di rumah. Ketika ibu dan keluarga mengetahui apa yang normal, apa yang berbahaya, dan ke mana harus mencari pertolongan, maka risiko keterlambatan penanganan komplikasi menjadi lebih rendah. Itulah sebabnya discharge planning sering disebut sebagai penghubung kritis antara terapi yang diterima pasien di rumah sakit dan perawatan pascadischarge di komunitas (Gonçalves-Bradley & Lannin, 2012).

3. Meningkatkan kemampuan perawatan mandiri

Tujuan lain dari perencanaan pulang adalah meningkatkan kemampuan ibu dan keluarga melakukan perawatan mandiri di rumah. Pada ibu postpartum, kemampuan ini mencakup perawatan diri, perawatan luka, pemantauan perdarahan, pengelolaan istirahat dan nutrisi, menyusui, perawatan bayi baru lahir, serta pengenalan tanda bahaya pada ibu dan bayi. Proses edukasi selama perencanaan pulang harus memberdayakan ibu agar ia tidak hanya menerima instruksi, tetapi juga memahami alasan klinis di balik setiap anjuran. OpenStax/LibreTexts menekankan bahwa edukasi pasien pada masa transisi dari rawat inap ke rawat jalan bertujuan memberdayakan pasien agar mampu berpartisipasi aktif dalam mengelola kesehatannya setelah pulang (OpenStax, 2024).

Dalam konteks postpartum, peningkatan kemampuan perawatan mandiri juga terkait dengan rasa percaya diri ibu dalam menjalankan peran barunya. WHO menempatkan dukungan informasi dan dukungan psikososial sebagai bagian dari pengalaman postnatal yang positif. Karena itu, discharge planning bukan sekadar “memberi tahu”, tetapi membantu ibu dan keluarga merasa mampu merawat diri dan bayinya di rumah (World Health Organization, 2022).

4. Menjamin tindak lanjut layanan

Tujuan penting lain adalah menjamin bahwa ibu dan bayi memiliki rencana tindak lanjut layanan yang jelas. Ini mencakup jadwal kontrol, fasilitas rujukan, siapa tenaga kesehatan yang akan dihubungi, dan langkah yang harus dilakukan bila muncul tanda bahaya. ACOG menekankan bahwa pelayanan postpartum seharusnya mencakup kontak awal dalam beberapa minggu setelah persalinan dan dilanjutkan dengan penilaian komprehensif individual, bukan hanya satu kunjungan tunggal enam minggu (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2018). WHO juga menekankan bahwa asuhan postnatal yang efektif memerlukan keterkaitan antara layanan fasilitas, komunitas, dan dukungan rumah tangga (World Health Organization, 2022).

Dengan adanya tindak lanjut yang terencana, masalah yang muncul setelah pulang dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Sebaliknya, tanpa rencana follow-up yang jelas, perawatan ibu dan bayi menjadi terfragmentasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesinambungan asuhan yang menjadi dasar pelayanan postnatal modern (NICE, 2021; ACOG, 2018).

C. Komponen Utama Perencanaan Pulang

Perencanaan pulang yang baik mencakup penilaian kondisi ibu dan bayi, identifikasi kebutuhan belajar, kesiapan keluarga, dukungan sosial, akses ke fasilitas kesehatan, kemampuan ekonomi, serta kemungkinan risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan perawatan. Perawat memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan edukasi, memastikan pemahaman ibu, memperkuat praktik aman di rumah, dan menyiapkan rencana tindak lanjut yang realistis.

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan dasar dari seluruh perencanaan pulang. Melalui pengkajian, tenaga kesehatan mengidentifikasi status klinis ibu dan bayi, kebutuhan edukasi, faktor risiko, kesiapan keluarga, dan hambatan yang mungkin muncul setelah pulang. Dalam pendekatan discharge planning yang terstruktur, pengkajian bukan dilakukan sekali menjelang pulang, tetapi berlangsung sejak awal perawatan dan diperbarui sesuai perkembangan pasien (Gonçalves-Bradley & Lannin, 2012).

Pada ibu postpartum, pengkajian mencakup kondisi fisik seperti tanda vital, perdarahan, involusi uterus, luka, nyeri, eliminasi, mobilisasi, laktasi, nutrisi, mobilisasi, istirahat, kebersihan diri, kesehatan mental ibu, aktivitas seksual, serta pemilihan kontrasepsi pascapersalinan. Pada bayi, pengkajian mencakup stabilitas suhu, menyusui, berat badan, ikterus, aktivitas, eliminasi, dan tanda bahaya. Selain aspek medis, pengkajian juga harus menilai dukungan keluarga,

kemampuan memahami instruksi, kondisi rumah, transportasi, dan akses layanan. WHO dan NICE sama-sama menekankan bahwa asuhan postnatal yang baik harus bersifat komprehensif, mencakup kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial ibu dan bayi (World Health Organization, 2022; NICE, 2021). Pelayanan ini juga menekankan penghormatan terhadap pilihan ibu, konseling berbasis informasi, dan kesinambungan layanan dari rumah sakit, puskesmas, praktik mandiri bidan, hingga kunjungan rumah bila diperlukan.

2. Edukasi dan konseling

Edukasi adalah komponen inti perencanaan pulang karena menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kesehatan kepada ibu dan keluarga. Isi edukasi pada masa postpartum biasanya mencakup tanda bahaya ibu yang memerlukan pertolongan segera, seperti perdarahan banyak, demam, nyeri perut berat, keputihan berbau menyengat, payudara sangat nyeri disertai demam, sesak napas, sakit kepala hebat, pandangan kabur, bengkak mendadak, suasana perasaan yang sangat menurun, dan pikiran menyakiti diri atau bayi, perawatan luka, perdarahan normal dan tidak normal, nutrisi, istirahat, menyusui, kesehatan mental, aktivitas seksual, kontrasepsi, jadwal kontrol, dan mekanisme mencari pertolongan. Keterlambatan mengenali tanda bahaya dapat memperburuk hasil klinis bagi ibu maupun bayi. NICE menyebut bahwa informasi postnatal harus diberikan dengan cara yang jelas, individual, dan relevan dengan kebutuhan perempuan, sementara WHO memasukkan health promotion dan counseling sebagai bagian integral rekomendasi postnatal (NICE, 2021; World Health Organization, 2022).

Edukasi yang efektif harus mempertimbangkan waktu, kesiapan ibu menerima informasi, tingkat literasi kesehatan, dan keterlibatan keluarga. Tujuan akhirnya adalah bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan pemahaman dan kemampuan menerapkannya di rumah. Karena itu, edukasi sebaiknya berlangsung berulang selama perawatan, tidak ditumpuk hanya pada hari pulang (OpenStax, 2024; NHS England, 2026).

Konseling keluarga berencana pascapersalinan harus diberikan secara bertahap, jelas, dan menghormati preferensi ibu dan pasangan. Pilihan metode kontrasepsi perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi klinis, status menyusui, waktu sejak persalinan, riwayat kesehatan, kenyamanan ibu, serta kemungkinan kepatuhan penggunaan. Perawat tidak sekadar menyebutkan pilihan metode, tetapi membantu ibu memahami manfaat, keterbatasan, efek samping, waktu mulai penggunaan, serta kapan harus kembali untuk evaluasi.

3. Persiapan keluarga

Keluarga adalah komponen penting dalam perencanaan pulang postpartum, terutama karena sebagian besar perawatan lanjutan berlangsung di rumah. Persiapan keluarga mencakup memastikan siapa yang akan membantu ibu, siapa yang memahami tanda bahaya, bagaimana dukungan menyusui diberikan, bagaimana transportasi ke fasilitas kesehatan dilakukan, dan bagaimana keluarga membantu ibu beristirahat serta mematuhi tindak lanjut. Regulasi CMS menyebut bahwa pengasuh atau support person harus dilibatkan sebagai mitra aktif dalam post-discharge care, dan WHO menegaskan peran pasangan, orang tua, dan keluarga dalam pengalaman postnatal yang positif (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2023; World Health Organization, 2022).

Persiapan keluarga juga penting untuk mencegah kesenjangan antara anjuran klinis dan realitas rumah tangga. Bila keluarga tidak siap, ibu mungkin kesulitan beristirahat, menyusui, atau hadir kontrol. Karena itu, pendekatan family-centred tidak berhenti pada memberi informasi kepada ibu, tetapi juga memastikan bahwa keluarga inti memahami perannya dalam pemulihan ibu dan perawatan bayi (NHS England, 2026; NICE, 2021).

4. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut adalah komponen yang memastikan kesinambungan asuhan setelah pulang. Isi rencana ini meliputi jadwal kontrol ibu dan bayi, evaluasi laktasi, pemantauan kondisi khusus seperti hipertensi atau anemia, konseling kontrasepsi, serta instruksi kapan harus datang lebih cepat bila ada tanda bahaya. ACOG menekankan bahwa postpartum care harus berupa proses berkelanjutan, dimulai sejak sebelum ibu meninggalkan fasilitas dan dilanjutkan dengan kontak awal serta penilaian komprehensif individual (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2018).

Rencana tindak lanjut yang baik harus spesifik: ke mana kontrol, kapan, dengan siapa, apa tujuan kunjungan itu, dan langkah apa yang harus diambil bila kontrol rutin tidak memungkinkan. NICE menegaskan bahwa organisasi layanan postnatal dan identifikasi masalah kesehatan ibu-bayi merupakan bagian dari layanan rutin, sehingga follow-up bukan pelengkap, melainkan komponen utama perawatan (NICE, 2021).

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan resmi mengenai hasil pengkajian, edukasi yang diberikan, keputusan klinis, kesiapan ibu-bayi, instruksi pulang, rencana tindak lanjut, dan rujukan bila diperlukan. Dokumentasi yang baik penting untuk keselamatan pasien, komunikasi antartenenaga kesehatan, aspek legal, dan evaluasi

mutu pelayanan. Dalam definisi discharge planning sebagai proses interdisipliner, dokumentasi merupakan bagian dari koordinasi dan evaluasi kesinambungan layanan (Gonçalves-Bradley & Lannin, 2012).

Pada konteks postpartum, dokumentasi juga penting karena ibu dan bayi sering berpindah dari layanan rumah sakit ke layanan primer atau komunitas. Tanpa dokumentasi yang jelas, informasi penting seperti faktor risiko, masalah menyusui, hasil pengkajian bayi, atau rencana kontrasepsi dapat terputus. NICE menekankan pentingnya pengorganisasian layanan dan penyampaian informasi yang sesuai untuk mendukung asuhan postnatal yang aman dan efektif (NICE, 2021).

D. Waktu dan Tahapan Perencanaan Pulang

1. Sejak masuk perawatan

Perencanaan pulang idealnya dimulai sejak pasien masuk perawatan, bukan ditunda hingga hari terakhir. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan mengidentifikasi kebutuhan, faktor risiko, dan hambatan sejak awal, lalu menyusun intervensi secara bertahap selama masa rawat. Literatur discharge planning menyebut bahwa proses ini seharusnya dimulai segera setelah penerimaan pasien, ketika informasi dasar tentang kebutuhan pasien mulai dikumpulkan (Gonçalves-Bradley & Lannin, 2012). Sumber pendidikan keperawatan juga menyatakan bahwa perencanaan pulang secara ideal dimulai segera setelah admisi, karena transisi pulang memerlukan penilaian dan persiapan yang berkelanjutan (OpenStax, 2024).

Dalam konteks maternitas, memulai perencanaan pulang sejak awal memungkinkan identifikasi ibu dengan kebutuhan khusus, misalnya hipertensi, diabetes, operasi sesar, masalah psikososial, keterbatasan ekonomi, atau kurangnya dukungan keluarga. Dengan demikian, tim dapat menyesuaikan edukasi, melibatkan keluarga lebih awal, dan menyiapkan follow-up yang lebih tepat sebelum ibu dan bayi meninggalkan fasilitas (World Health Organization, 2022; NHS England, 2026).

2. Selama perawatan postpartum

Tahap berikutnya berlangsung selama perawatan postpartum. Pada fase ini, tenaga kesehatan terus memperbarui pengkajian, memberikan edukasi bertahap, mengobservasi kemampuan ibu melakukan perawatan diri dan menyusui, serta mengonfirmasi kesiapan keluarga. Edukasi yang diberikan secara berulang selama perawatan biasanya lebih efektif dibandingkan penyampaian sekaligus menjelang pulang, karena ibu postpartum sering masih kelelahan, nyeri, atau fokus pada adaptasi awal dengan bayinya (NICE, 2021; OpenStax, 2024).

Pada fase ini pula discharge planning menjadi proses yang dinamis. Bila muncul masalah baru, seperti ikterus bayi, nyeri luka yang memburuk, bendungan payudara, atau peningkatan tekanan darah ibu, maka rencana pulang harus ditinjau ulang. Prinsipnya, perencanaan pulang tidak kaku, tetapi mengikuti perkembangan klinis ibu dan bayi secara real time (World Health Organization, 2022; ACOG, 2018).

3. Saat menjelang pulang

Tahap menjelang pulang adalah fase finalisasi. Pada tahap ini, tenaga kesehatan menilai ulang kesiapan ibu dan bayi, memastikan edukasi telah dipahami, memverifikasi obat dan instruksi, meninjau tanda bahaya, menegaskan jadwal kontrol, dan memastikan keluarga mengetahui kontak yang dapat dihubungi. NHS England menekankan bahwa setiap perempuan seharusnya meninggalkan layanan maternitas dengan rencana perawatan postnatal yang dipersonalisasi, yang memuat kebutuhan klinis, psikologis, sosial, penanganan kondisi jangka panjang, dan akses ke dukungan komunitas atau spesialis (NHS England, 2026).

Pada titik ini, keputusan pulang harus benar-benar mempertimbangkan kesiapan transisi, bukan hanya ketersediaan tempat tidur atau pertimbangan administratif. Bila masih terdapat masalah klinis, hambatan sosial besar, atau ketidakpahaman yang signifikan, maka pemulangan perlu ditunda atau rencana dukungan harus diperkuat. Regulasi CMS menekankan bahwa discharge planning harus fokus pada tujuan pasien dan kebutuhan pascadischarge, sehingga keputusan pulang harus didasarkan pada kepentingan terbaik pasien, bukan semata-mata pada sistem layanan (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2023).

4. Setelah pulang

Perencanaan pulang tidak berakhir ketika pasien keluar dari rumah sakit; tahap terakhir berlangsung setelah pulang, saat rencana tersebut diimplementasikan di rumah dan dinilai keberhasilannya melalui tindak lanjut. ACOG secara tegas menyatakan bahwa postpartum care harus menjadi proses berkelanjutan, dengan kontak awal dan penilaian komprehensif sesuai kebutuhan masing-masing perempuan (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2018). WHO juga memandang asuhan postnatal sebagai rangkaian intervensi dan dukungan yang berlangsung sepanjang masa postnatal, bukan satu episode layanan singkat (World Health Organization, 2022).

Pada fase setelah pulang, fokus bergeser pada pemantauan adaptasi ibu dan bayi di rumah, kepatuhan terhadap edukasi, keberhasilan menyusui, kemunculan tanda bahaya, dan kehadiran pada jadwal kontrol. Bila ditemukan

red flags, maka sistem rujukan dan komunikasi yang telah direncanakan sebelumnya harus segera diaktifkan. Dengan demikian, tahap setelah pulang merupakan bukti nyata bahwa discharge planning adalah proses transisi perawatan, bukan hanya prosedur pemulangan (Gonçalves-Bradley & Lannin, 2012; NICE, 2021).

Secara ringkas, komponen perencanaan pulang ibu postpartum harus mencakup:

- a. Stabilitas klinis ibu: tanda vital, perdarahan/lochia, involusi uterus, nyeri, luka, eliminasi, ambulasi, nutrisi, tanda infeksi.
- b. Stabilitas klinis bayi: suhu, feeding, aktivitas/refleks, berat badan, infeksi, ikterus, dan kelainan kongenital yang tampak.
- c. Masalah khusus: anemia, hipertensi, diabetes, infeksi, SC, trauma perineum, atau komplikasi obstetri lain.
- d. Laktasi: pelekatan, transfer ASI, nyeri puting, bendungan/mastitis, dukungan menyusui.
- e. Psikologis dan sosial: mood, kecemasan, kelelahan, dukungan keluarga, kemampuan merawat bayi.
- f. Edukasi rumah: kebersihan, luka, aktivitas, istirahat, nutrisi, hidrasi, hubungan seksual, tanda bahaya.
- g. Kesehatan reproduksi: konseling nifas, hubungan seksual sehat, KB pascapersalinan, dan jadwal kontrol.
- h. Akses tindak lanjut: transportasi, pembiayaan, kontak fasilitas, dan rencana kunjungan ulang (WHO, 2022; NICE, 2021; ACOG, 2018; Benitz, 2015).

E. PENGKAJIAN IBU SEBELUM PULANG

Pengkajian ibu sebelum pulang merupakan bagian inti dari perencanaan pulang pada masa postpartum. Tujuannya bukan hanya memastikan kondisi klinis ibu stabil pada saat meninggalkan fasilitas kesehatan, tetapi juga memastikan ibu mampu melanjutkan perawatan di rumah, mengenali tanda bahaya, dan memiliki rencana tindak lanjut yang jelas. WHO menekankan bahwa asuhan postnatal harus mendukung kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan kemampuan ibu menjalani masa transisi setelah persalinan, sedangkan NICE menegaskan bahwa masa postnatal harus mencakup identifikasi masalah kesehatan umum maupun serius pada perempuan dalam 8 minggu pertama setelah melahirkan (World Health Organization, 2022; National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2021).

1. STATUS UMUM IBU

a. Tanda vital

Tanda vital yang harus dinilai meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan frekuensi napas. Penilaian ini penting karena perubahan tanda vital dapat menjadi indikator awal perdarahan, infeksi, gangguan hipertensi postpartum, atau kondisi sistemik lain. Tekanan darah perlu mendapat perhatian khusus karena hipertensi postpartum dan preeklampsia postpartum dapat muncul setelah persalinan, bahkan pada ibu yang sebelumnya tampak stabil. Ibu harus dinilai adanya keluhan seperti sakit kepala berat, gangguan penglihatan, sesak napas, dan nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas, karena gejala tersebut dapat mengarah pada gangguan hipertensi yang membutuhkan evaluasi segera (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2018; Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2024).

CLINICAL PEARLS

- 1) Perdarahan postpartum yang meningkat mendadak harus dianggap sebagai keadaan gawat darurat.
- 2) Edukasi tanda bahaya wajib diberikan sebelum ibu pulang.
- 3) Evaluasi jumlah perdarahan harus dikaitkan dengan kondisi hemodinamik ibu.

a) Perdarahan postpartum

Perdarahan postpartum dinilai dari jumlah darah, warna, frekuensi ganti pembalut, adanya bekuan, serta perubahan pola perdarahan. Sebelum pulang, penting dibedakan antara perdarahan nifas yang masih dalam batas normal dan perdarahan yang mengarah pada komplikasi. NICE merekomendasikan agar bila ibu mengeluhkan perdarahan vagina setelah melahirkan, tenaga kesehatan menilai berat-ringannya perdarahan dan mempertimbangkan faktor risiko perdarahan postpartum. Perdarahan yang sangat banyak, bertambah mendadak, disertai pusing, lemah, sinkop, atau keluarnya bekuan besar harus dianggap serius (NICE, 2021; CDC, 2024).

b) Kontraksi dan involusi uterus

Kontraksi dan involusi uterus perlu dinilai untuk memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan mengalami proses pemulihan normal setelah persalinan. Uterus yang lembek atau involusi yang tidak sesuai dapat berkaitan dengan perdarahan, sisa jaringan, atau infeksi. Dalam asuhan postpartum, evaluasi fundus uteri, nyeri uterus, dan hubungan dengan perdarahan perlu dilakukan secara bersamaan. WHO

menempatkan pemantauan kondisi maternal dan deteksi dini komplikasi postpartum sebagai komponen penting dari asuhan postnatal rutin (World Health Organization, 2022).

c) Lochia

Lochia adalah pengeluaran cairan dari jalan lahir setelah persalinan yang normalnya berubah bertahap dari rubra, serosa, hingga alba. Pengkajian lochia meliputi warna, jumlah, bau, dan perubahan dari hari ke hari. Lochia yang berbau busuk, kembali merah terang setelah sebelumnya berkurang, atau disertai nyeri pelvis dan demam harus diwaspadai sebagai kemungkinan infeksi atau subinvolusi. NICE secara khusus menyoroti pentingnya evaluasi perdarahan dan gejala terkait pada masa postnatal (NICE, 2021).

d) Nyeri

Nyeri postpartum harus dikaji berdasarkan lokasi, intensitas, karakter, durasi, faktor pemicu, dan pengaruhnya terhadap aktivitas ibu. Nyeri dapat berasal dari kontraksi uterus, trauma perineum, luka episiotomi, luka operasi sesar, bendungan payudara, retensi urin, atau komplikasi lain. ACOG menyebut bahwa pada "trimester keempat", perempuan sering mengalami nyeri, kelelahan, dan kesulitan menyusui yang dapat memengaruhi pemulihan, sehingga penilaian nyeri tidak boleh dianggap sekadar keluhan ringan (ACOG, 2018). NICE juga merekomendasikan penatalaksanaan dan evaluasi nyeri perineum atau nyeri luka dengan serius karena dapat mengganggu fungsi sehari-hari (NICE, 2021).

e) Eliminasi

Eliminasi meliputi kemampuan berkemih dan buang air besar secara normal. Ibu harus dikaji apakah ada retensi urin, disuria, inkontinensia, konstipasi, atau nyeri saat defekasi. Masalah eliminasi umum terjadi pada masa postpartum, terutama setelah persalinan pervaginam dengan trauma perineum, penggunaan anestesi regional, atau operasi sesar. NICE memasukkan inkontinensia urin, gangguan dasar panggul, dan masalah buang air besar sebagai isu yang harus dikenali dalam masa postnatal (NICE, 2021).

f) Ambulasi

Ambulasi perlu dikaji untuk memastikan ibu mampu bergerak, berdiri, dan berjalan dengan aman sebelum pulang. Kemampuan ambulasi mencerminkan stabilitas umum, kontrol nyeri, dan kecukupan pemulihan setelah persalinan atau operasi. Ibu yang sulit berjalan karena nyeri hebat, pusing, anemia, atau kelemahan memerlukan evaluasi lebih lanjut. ACOG

menekankan bahwa periode postpartum dapat disertai kelelahan dan nyeri yang memengaruhi fungsi sehari-hari, sehingga kemampuan bergerak harus menjadi bagian dari penilaian kesiapan pulang (ACOG, 2018).

g) Istirahat dan tidur

Istirahat dan tidur perlu dinilai karena kurang tidur dan kelelahan dapat memengaruhi pemulihan fisik, stabilitas emosi, kemampuan menyusui, dan kemampuan merawat bayi. Pada periode postpartum, gangguan tidur sering kali terjadi karena nyeri, frekuensi menyusui, kecemasan, dan penyesuaian terhadap peran baru. ACOG secara eksplisit menyebutkan kurang tidur dan kelelahan sebagai tantangan umum pada masa postpartum, dan kondisi ini perlu ditangani sebagai bagian dari perawatan pascapersalinan, bukan dianggap sesuatu yang harus diterima begitu saja (ACOG, 2018).

h) Nutrisi dan hidrasi

Nutrisi dan hidrasi dikaji melalui asupan makan dan minum, toleransi makanan, nafsu makan, mual muntah, dan kondisi khusus seperti anemia atau menyusui. Kebutuhan nutrisi postpartum meningkat terutama untuk pemulihan jaringan, produksi ASI, dan penggantian kehilangan darah. WHO menerbitkan panduan khusus tentang suplementasi zat besi pada ibu postpartum sebagai intervensi kesehatan masyarakat untuk memperbaiki luaran ibu dan bayi, terutama pada populasi dengan beban anemia tinggi (World Health Organization, 2016). Dalam konteks klinis, penilaian nutrisi juga penting untuk melihat apakah ibu mampu mempertahankan hidrasi dan asupan yang adekuat setelah pulang.

i) Tanda-tanda infeksi

Ibu perlu dikaji tanda infeksi seperti demam, menggigil, nyeri abdomen atau pelvis, lochia berbau busuk, kemerahan atau cairan pada luka, nyeri payudara dengan demam, atau disuria. Infeksi postpartum dapat muncul pada uterus, traktus urinarius, payudara, luka perineum, atau luka operasi sesar. NICE mengaitkan demam, nyeri pelvis atau perineum, dan cairan atau perdarahan berbau dengan kemungkinan infeksi postpartum. CDC juga menekankan bahwa gejala seperti demam, perdarahan abnormal, sesak napas, pusing, atau rasa “ada yang tidak beres” harus diperlakukan sebagai tanda peringatan penting pada periode postpartum (NICE, 2021; CDC, 2024).

2. PENGKAJIAN LUKA

a. Luka perineum

Luka perineum harus dinilai dari integritas jaringan, nyeri, edema, hematoma, kemerahan, bau, cairan, dan kemampuan ibu duduk, berjalan, BAK, dan BAB dengan nyaman. Trauma perineum dapat mengganggu mobilitas, istirahat, eliminasi, dan aktivitas sehari-hari. NICE menempatkan nyeri perineum dan masalah luka perineum sebagai masalah postnatal yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara aktif, bukan dibiarkan sebagai keluhan biasa (NICE, 2021).

b. Luka episiotomi

Pengkajian luka episiotomi pada dasarnya serupa dengan luka perineum lain, tetapi perlu perhatian tambahan pada penyembuhan tepi luka, nyeri saat bergerak atau duduk, tanda dehisensi, dan tanda infeksi. Ibu harus dinilai apakah jahitan tampak baik, tidak ada pembengkakan berlebihan, tidak keluar sekret purulen, dan nyeri masih dalam batas terkendali. Bila nyeri berat menetap, bengkak bertambah, atau luka terbuka, maka perlu evaluasi lebih lanjut. NICE merekomendasikan penanganan masalah nyeri perineum dan gangguan penyembuhan secara adekuat selama masa postnatal (NICE, 2021).

c. Luka operasi sesar

Luka operasi sesar harus dikaji dari kondisi balutan atau bekas luka, kemerahan, edema, nyeri tekan, drainase, bau, dan tanda dehisensi. Selain itu, penting dinilai dampak nyeri luka terhadap kemampuan batuk, mobilisasi, menyusui, dan merawat bayi. ACOG menyatakan bahwa perempuan dengan infeksi luka sesar atau masalah luka membutuhkan tindak lanjut lebih dini dan lebih intensif pada periode postpartum. NICE juga memasukkan nyeri luka dan infeksi sebagai bagian dari masalah kesehatan postnatal yang memerlukan pemantauan (ACOG, 2018; NICE, 2021).

3. IDENTIFIKASI KONDISI KHUSUS

a. Anemia

Anemia postpartum perlu diidentifikasi karena dapat menyebabkan lemah, pusing, palpitasi, intoleransi aktivitas, dan gangguan kemampuan ibu merawat bayi. Penilaian dilakukan melalui riwayat perdarahan, gejala klinis, dan hasil laboratorium bila tersedia. WHO menyoroti bahwa suplementasi zat besi postpartum dapat membantu memperbaiki status zat besi ibu dan menurunkan risiko anemia postpartum, sehingga pada ibu dengan faktor risiko atau gejala anemia, perencanaan pulang harus mencakup terapi, edukasi, dan tindak lanjut yang sesuai (World Health Organization, 2016).

b. Hipertensi

Hipertensi postpartum harus dinilai secara aktif, terutama pada ibu dengan riwayat hipertensi kronik, hipertensi gestasional, atau preeklampsia. Pengkajian mencakup tekanan darah, keluhan neurologis, sesak napas, edema, nyeri epigastrium, dan kepatuhan obat. ACOG menekankan pentingnya tindak lanjut lebih awal bagi perempuan dengan gangguan hipertensi dalam kehamilan, dan CDC memasukkan sakit kepala berat, gangguan penglihatan, nyeri dada, sesak napas, dan pembengkakan hebat sebagai tanda peringatan maternal yang memerlukan evaluasi segera (ACOG, 2018; CDC, 2024).

c. Diabetes

Ibu dengan diabetes pregestasional atau riwayat diabetes gestasional memerlukan identifikasi kebutuhan khusus sebelum pulang. Penilaian meliputi kontrol glukosa, obat yang digunakan, pola makan, risiko hipoglikemia, dan rencana kontrol jangka lanjut. NICE menyatakan bahwa perempuan yang pernah mengalami diabetes gestasional memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi diabetes tipe 2 setelah persalinan, sehingga tindak lanjut glukosa dan konseling gaya hidup perlu direncanakan. Perempuan dengan diabetes sebelum hamil juga perlu kembali ke pengelolaan diabetes rutinya setelah pulang (NICE, 2015/2020).

d. Infeksi

Infeksi sebagai kondisi khusus perlu diidentifikasi baik sebagai diagnosis yang sudah ada maupun risiko yang sedang berkembang. Ini mencakup endometritis, infeksi traktus urinarius, mastitis, infeksi luka, dan infeksi sistemik. Pada ibu menyusui, spektrum mastitis perlu dikenali sejak dini. *Academy of Breastfeeding Medicine* menjelaskan bahwa bendungan, sumbatan, inflamasi, mastitis bakterial, dan abses berada pada suatu spektrum gangguan payudara yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan keberhasilan menyusui. Karena itu, pengkajian nyeri payudara, demam, kemerahan lokal, pembengkakan, dan gangguan menyusui sangat penting sebelum pulang (Mitchell et al., 2022).

e. Komplikasi obstetri lain

Komplikasi obstetri lain yang perlu diidentifikasi sebelum pulang meliputi perdarahan postpartum, tromboemboli, trauma obstetri berat, gangguan kesehatan mental, penyakit kronis yang memburuk, dan kondisi medis lain yang memerlukan tindak lanjut dini. ACOG menegaskan bahwa perempuan dengan kondisi kronis atau komplikasi seperti gangguan kejang, masalah laktasi, depresi postpartum, atau infeksi luka membutuhkan pendekatan postpartum yang lebih intensif. Artinya, identifikasi komplikasi tidak hanya

bertujuan mencatat diagnosis, tetapi juga menentukan kebutuhan follow-up dan rujukan setelah ibu pulang (ACOG, 2018).

4. KESIAPAN FUNGSIONAL IBU

a. Kemampuan mobilisasi

Kemampuan mobilisasi menunjukkan apakah ibu cukup pulih untuk menjalani aktivitas dasar di rumah. Ibu harus mampu bangun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, berpindah posisi, dan bergerak tanpa risiko jatuh atau ketergantungan total. Penilaian ini penting terutama setelah operasi sesar, perdarahan, atau anemia. Bila ibu belum dapat bergerak aman, maka edukasi dan perencanaan pulang belum lengkap. ACOG menyebutkan bahwa nyeri dan kelelahan postpartum dapat sangat memengaruhi fungsi sehari-hari dan harus dipertimbangkan dalam penilaian perawatan lanjutan (ACOG, 2018).

b. Kemampuan menyusui

Kemampuan menyusui perlu dinilai dari pelekatan, posisi, frekuensi menyusui, tanda transfer ASI, kenyamanan ibu, dan adanya keluhan seperti puting nyeri atau bendungan payudara. NICE merekomendasikan penilaian dan dukungan aktif terhadap menyusui pada masa postnatal, sedangkan Academy of Breastfeeding Medicine menekankan bahwa keluhan payudara pada masa awal menyusui perlu dinilai dalam konteks spektrum mastitis agar intervensi tepat dan menyusui tetap dapat dipertahankan (NICE, 2021; Mitchell et al., 2022).

c. Kemampuan perawatan diri

Kemampuan perawatan diri mencakup mandi, mengganti pembalut, merawat luka, makan dan minum, minum obat sesuai aturan, serta mengatur istirahat. Ibu perlu dinilai apakah ia dapat melakukan kegiatan dasar ini sendiri atau memerlukan bantuan. Bila ada keterbatasan, maka keluarga harus dipersiapkan sebagai pendukung utama. WHO menekankan pentingnya dukungan yang memungkinkan perempuan menjalani pengalaman postnatal yang positif dan bermartabat, termasuk dukungan praktis selama masa pemulihan (World Health Organization, 2022).

d. Kemampuan mengenali tanda bahaya

Sebelum pulang, ibu harus mampu mengenali tanda bahaya pada dirinya dan, idealnya, juga pada bayinya. Tanda bahaya pada ibu antara lain perdarahan banyak, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, sesak napas, nyeri dada, demam, nyeri abdomen hebat, luka bernanah, dan rasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak normal. CDC melalui kampanye *HEAR HER* menegaskan bahwa perempuan dan keluarga harus mengetahui tanda peringatan maternal mendesak selama kehamilan dan sampai satu tahun

setelah persalinan. NICE juga menekankan pentingnya pemberian informasi yang jelas tentang kapan harus mencari bantuan medis pada masa postnatal (CDC, 2024; NICE, 2021).

F. PENGKAJIAN BAYI SEBELUM PULANG

Pengkajian bayi sebelum pulang merupakan bagian penting dari perencanaan pulang karena bertujuan memastikan bahwa bayi telah melewati fase transisi awal kehidupan ekstrasuterin dengan aman, mampu menyusu, tidak menunjukkan tanda penyakit serius, dan memiliki rencana tindak lanjut yang sesuai. WHO menempatkan penilaian bayi baru lahir sebagai bagian dari paket asuhan postnatal esensial, sedangkan NICE menegaskan bahwa perawatan postnatal harus mencakup identifikasi masalah kesehatan umum maupun serius pada bayi dalam 8 minggu pertama kehidupan (World Health Organization [WHO], 2022; National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2021). American Academy of Pediatrics (AAP) juga menekankan bahwa keputusan pulang harus didasarkan pada stabilitas bayi, kesiapan keluarga, dan akses terhadap tindak lanjut yang memadai (Benitz, 2015).

1. STATUS UMUM BAYI

a. Suhu tubuh

Suhu tubuh bayi harus dinilai untuk memastikan kemampuan termoregulasi sudah stabil sebelum pulang. Bayi baru lahir mudah mengalami hipotermia karena luas permukaan tubuh besar, cadangan lemak terbatas, dan kemampuan menghasilkan panas yang belum matang. WHO menekankan bahwa bayi harus dijaga tetap hangat dan dinilai adanya tanda "*too hot or too cold*" sebagai bagian dari kewaspadaan dini. Suhu yang tidak stabil dapat menandakan masalah lingkungan, gangguan adaptasi, infeksi, atau gangguan metabolik, sehingga bayi dengan suhu abnormal belum layak dipulangkan tanpa evaluasi lebih lanjut (WHO, 2022; WHO, 2024).

b. Pernapasan

Pernapasan bayi dinilai dari frekuensi, pola, usaha napas, adanya retraksi, grunting, apnea, dan warna kulit selama bernapas. AAP menyebut bahwa banyak masalah kardiopulmoner neonatus akan tampak dalam 12 jam pertama, sehingga penilaian respirasi menjadi syarat penting dalam kesiapan pulang. Bayi dengan napas cepat, henti napas, tarikan dinding dada, atau bunyi napas abnormal memerlukan evaluasi karena dapat mengarah ke penyakit paru, sepsis, penyakit jantung bawaan, atau gangguan transisi neonatal (Benitz, 2015; WHO, 2024).

c. Aktivitas dan refleks

Aktivitas bayi harus tampak sesuai, yaitu bayi bergerak spontan, tonus baik, responsif terhadap rangsang, dan mampu mengisap. Refleks dasar seperti rooting, sucking, Moro, dan genggam memberi gambaran awal tentang integritas neurologis dan kesiapan menyusui. NICE menekankan pemeriksaan lengkap bayi dalam 72 jam pertama, sedangkan pemeriksaan klinis sehari-hari perlu memperhatikan perilaku, postur, dan respons umum bayi. Bayi yang tampak sangat lemah, hipotonia, atau tidak responsif harus dievaluasi segera karena dapat menandakan penyakit serius (NICE, 2021; WHO, 2024).

d. Warna kulit

Warna kulit dinilai untuk melihat perfusi dan oksigenasi. Bayi sehat umumnya tampak merah muda, sedangkan sianosis sentral, pucat, mottling berat, atau kuning yang nyata memerlukan perhatian khusus. WHO memasukkan "yellow palms or soles" sebagai tanda bahaya yang perlu segera dibawa berobat, sedangkan AAP menekankan pentingnya penilaian risiko hiperbilirubinemia sebelum pulang. Karena itu, pengkajian warna kulit bukan hanya observasi umum, tetapi juga cara sederhana mendeteksi hipoksemia, syok, anemia, atau ikterus signifikan (WHO, 2024; Kemper et al., 2022).

e. Berat badan

Berat badan perlu dicatat dan dibandingkan dengan berat lahir untuk menilai adaptasi awal dan kecukupan asupan. Penurunan berat badan awal dapat terjadi, tetapi harus tetap dipantau bersama pola menyusui, frekuensi eliminasi, dan kondisi klinis bayi. NICE merekomendasikan pemantauan berat badan bila ada kekhawatiran terhadap feeding atau kondisi umum bayi. Dalam konteks pulang, berat badan menjadi indikator penting karena penurunan yang berlebihan dapat berkaitan dengan dehidrasi, hipernatremia, atau transfer ASI yang tidak adekuat (NICE, 2021; Benitz, 2015).

2. TANDA BAHAYA BAYI BARU LAHIR

QUICK REVIEW

- 1) Bayi malas menyusui dapat menjadi tanda awal infeksi neonatal.
- 2) Penilaian pelekatan dan transfer ASI harus dilakukan sebelum pulang.
- 3) Follow-up laktasi penting untuk mencegah dehidrasi dan ikterus.

a. Kesulitan menyusui

Kesulitan menyusui adalah tanda bahaya penting karena sering menjadi manifestasi awal penyakit serius pada neonatus. Bayi yang tidak mampu melekat, hisapan lemah, cepat lelah saat menyusui, muntah terus, atau menolak menyusui perlu dievaluasi segera. WHO memasukkan "*not feeding*" sebagai

tanda bahaya utama pada bayi, dan NICE menekankan bahwa masalah pemberian makan harus segera diidentifikasi dalam perawatan postnatal. Kesulitan menyusu dapat menandakan sepsis, hipoglikemia, gangguan neurologis, ikterus berat, atau masalah anatomi mulut (WHO, 2024; NICE, 2021).

b. Kejang

Kejang pada neonatus merupakan kondisi gawat darurat dan tidak pernah dianggap normal. Kejang dapat tampak jelas berupa gerakan tonik-klonik, tetapi juga dapat sangat subtil, misalnya deviasi mata berulang, apnea episodik, atau gerakan mulut yang tidak wajar. WHO menempatkan convulsions sebagai tanda bahaya yang memerlukan pertolongan segera. Pada konteks pulang, bayi dengan riwayat kejang atau kecurigaan kejang tidak boleh dipulangkan sebelum penyebabnya diidentifikasi dan ditangani (WHO, 2024).

c. Sesak napas

Sesak napas pada neonatus mencakup napas cepat, retraksi dada, grunting, apnea, atau sianosis. WHO menyebut "*chest indrawing or fast breathing*" sebagai tanda bahaya, sedangkan AAP menekankan bahwa masalah kardiopulmoner harus sudah dikenali sebelum bayi dipulangkan. Sesak napas dapat berkaitan dengan pneumonia, aspirasi, penyakit membran hialin, kelainan jantung bawaan, atau sepsis, sehingga memerlukan penilaian segera (WHO, 2024; Benitz, 2015).

d. Demam/hipotermia

Baik demam maupun hipotermia pada neonatus harus dianggap serius. WHO memasukkan "*too hot or too cold*" sebagai tanda bahaya pada bayi. Suhu abnormal dapat merupakan petunjuk infeksi, gangguan lingkungan, dehidrasi, atau masalah metabolik. Karena sistem termoregulasi bayi masih belum matang, kestabilan suhu menjadi syarat utama sebelum pulang, dan keluarga perlu diajarkan cara mengenali suhu yang tidak normal di rumah (WHO, 2024; WHO, 2022).

e. Letargi

Letargi berarti bayi tampak sangat mengantuk, sulit dibangunkan, kurang gerak, atau tidak responsif. WHO menyebut "*no movement*" sebagai tanda bahaya yang memerlukan pertolongan segera. Letargi dapat menjadi manifestasi awal sepsis, hipoglikemia, hiperbilirubinemia berat, gangguan neurologis, atau gangguan perfusi. Dalam perencanaan pulang, bayi yang tampak sangat lemah atau kurang responsif harus dievaluasi lebih lanjut dan tidak dianggap hanya "bayi tenang" (WHO, 2024).

f. Ikterus

Ikterus harus dinilai secara sistematis sebelum pulang karena kadar bilirubin dapat meningkat setelah bayi berada di rumah. Pedoman AAP 2022 menekankan bahwa semua bayi usia gestasi ≥ 35 minggu perlu penilaian bilirubin sebelum pulang, dan hasil tersebut harus digunakan untuk menentukan kebutuhan tindak lanjut. WHO juga memasukkan kuning pada telapak tangan atau telapak kaki sebagai tanda bahaya. Ikterus yang muncul dini, tampak progresif, disertai malas minum, atau mencapai ekstremitas distal memerlukan evaluasi segera (Kemper et al., 2022; WHO, 2024).

3. PEMERIKSAAN FISIK DASAR BAYI

a. Kepala sampai kaki

Pemeriksaan fisik dasar bayi dilakukan secara sistematis dari kepala sampai kaki. NICE merekomendasikan pemeriksaan lengkap bayi dalam 72 jam pertama setelah lahir. Pemeriksaan ini mencakup kepala dan ubun-ubun, mata dan *red reflex*, telinga, hidung, mulut dan palatum, leher, dada, jantung, paru, abdomen, tali pusat, genitalia, anus, tulang belakang, ekstremitas, pinggul, kulit, serta status neurologis umum. Tujuannya adalah memastikan tidak ada kelainan yang memerlukan rawat lanjut atau rujukan serta memberikan dasar penilaian apakah bayi aman dipulangkan (NICE, 2021; Benitz, 2015).

b. Kelainan kongenital yang tampak

Kelainan kongenital yang tampak perlu dicari aktif pada pemeriksaan fisik sebelum pulang. NICE mengaitkan pemeriksaan bayi dengan program *newborn and infant physical examination* untuk mendeteksi kondisi seperti kelainan jantung tertentu, kelainan mata, displasia panggul, dan anomali testis. AAP juga menegaskan bahwa pemeriksaan fisik sebelum pulang tidak boleh menunjukkan kelainan yang memerlukan rawat inap lanjutan. Dengan kata lain, adanya anomali struktural yang signifikan dapat mengubah keputusan pulang dan menentukan kebutuhan rujukan (NICE, 2021; Benitz, 2015).

c. Tanda infeksi

Pemeriksaan fisik bayi juga harus mencari tanda infeksi, misalnya suhu tidak normal, napas cepat, retraksi, letargi, malas menyusu, pustula kulit, kemerahan tali pusat, atau perfusi buruk. WHO menekankan bahwa tanda bahaya bayi harus dikenali sejak dini dan menjadi alasan untuk mencari pertolongan segera. Karena infeksi neonatal dapat berkembang cepat dan kadang tanpa demam, kombinasi perubahan perilaku, feeding problem, dan gangguan napas harus diperlakukan serius (WHO, 2024; NICE, 2021).

d. Tanda penyakit genetik atau kelainan bawaan

Pemeriksaan sebelum pulang juga harus mempertimbangkan kemungkinan penyakit genetik, metabolik, endokrin, atau kelainan bawaan yang tidak selalu tampak jelas secara klinis. CDC menjelaskan bahwa skrining bayi baru lahir dilakukan untuk mendeteksi gangguan genetik, endokrin, dan metabolik yang serius sebelum bayi menjadi sakit, dan biasanya dilakukan sebelum pulang dari rumah sakit. Selain skrining darah, bayi juga umumnya disaring untuk gangguan pendengaran dan *critical congenital heart disease* sebelum dipulangkan. Karena itu, dalam konteks kesiapan pulang, penting untuk memastikan skrining yang relevan telah dilakukan atau telah direncanakan tindak lanjutnya (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; HRSA, 2024).

4. KESIAPAN BAYI UNTUK PULANG

a. Stabilitas klinis

Bayi dinyatakan siap pulang bila stabil secara fisiologis dan tidak ada kelainan yang memerlukan rawat lanjutan. AAP menegaskan bahwa kriteria pulang mencakup stabilitas bayi, kesiapan keluarga, dukungan sosial di rumah, dan akses tindak lanjut. Stabilitas klinis berarti suhu stabil, napas baik, sirkulasi baik, pemeriksaan fisik tidak menunjukkan masalah akut, dan tidak ada tanda penyakit yang belum terjelaskan (Benitz, 2015).

b. Pola menyusui

Kesiapan pulang juga ditentukan oleh pola menyusui yang efektif. Bayi harus sudah menunjukkan kemampuan menyusui yang memadai, baik langsung dari payudara maupun dengan metode lain yang direncanakan. NICE menekankan pentingnya dukungan aktif pada feeding dalam periode postnatal, sedangkan AAP menyatakan bahwa keluarga perlu siap dan kompeten merawat bayi di rumah, termasuk dalam feeding. Bila menyusui belum efektif, risiko dehidrasi, hipoglikemia, penurunan berat badan berlebih, dan ikterus meningkat (NICE, 2021; Benitz, 2015).

c. Eliminasi

Eliminasi mencakup buang air kecil dan buang air besar yang sesuai usia neonatus. AAP memasukkan pengamatan adanya urine dan feses sebagai bagian dari kriteria pulang bayi sehat. Eliminasi memberi informasi tidak langsung tentang kecukupan asupan dan adaptasi saluran cerna serta ginjal. Bayi yang belum berkemih atau belum mengeluarkan mekonium sesuai waktunya perlu evaluasi lebih lanjut sebelum pulang (Benitz, 2015).

d. Kebutuhan monitoring lanjutan

Tidak semua bayi yang tampak stabil bebas dari kebutuhan pemantauan lanjutan. AAP menekankan bahwa keputusan pulang harus mempertimbangkan akses ke *follow-up care*, sedangkan pedoman AAP 2022 tentang hiperbilirubinemia menegaskan bahwa hasil bilirubin sebelum pulang harus digunakan untuk menentukan jadwal tindak lanjut pascadischarge. Bayi dengan risiko ikterus, masalah menyusui, berat lahir rendah, prematur akhir, atau temuan pemeriksaan yang meragukan memerlukan monitoring lebih ketat. Dengan demikian, kesiapan pulang tidak hanya berarti “boleh keluar hari ini,” tetapi juga bahwa rencana observasi setelah pulang sudah jelas (Benitz, 2015; Kemper et al., 2022).

G. LAKTASI DAN MENYUSUI DALAM PERENCANAAN PULANG

Laktasi dan menyusui merupakan komponen inti dalam perencanaan pulang ibu postpartum karena keberhasilan menyusui sangat memengaruhi kesehatan ibu, status gizi bayi, risiko ikterus, pertumbuhan awal, bonding, dan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayinya. WHO menempatkan dukungan menyusui sebagai bagian dari asuhan postnatal rutin yang esensial, sedangkan NICE menegaskan bahwa perawatan postnatal harus mencakup *baby feeding* dan dukungan terhadap hubungan orang tua–bayi (World Health Organization [WHO], 2022; National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2021). Pada masa menjelang pulang, penilaian laktasi tidak cukup hanya menanyakan apakah bayi “sudah menyusui”, tetapi harus mencakup penilaian keterampilan, kenyamanan, efektivitas transfer ASI, masalah yang muncul, serta kebutuhan dukungan lanjutan setelah pulang (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2021).

1. Konsep Dasar Laktasi

a. Fisiologi laktasi

Laktasi adalah proses fisiologis pembentukan, pengeluaran, dan pemeliharaan produksi ASI yang dipengaruhi oleh interaksi hormon, pengosongan payudara, dan rangsangan isapan bayi. Setelah persalinan, penurunan kadar progesteron memungkinkan dimulainya laktogenesis tahap II, yaitu peningkatan produksi ASI yang biasanya terjadi dalam beberapa hari pertama setelah lahir. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh seberapa dini dan seberapa sering payudara dikosongkan. ACOG menjelaskan bahwa produksi ASI bekerja berdasarkan prinsip *supply and demand*, semakin efektif ASI dikeluarkan dari payudara, semakin besar peluang produksi ASI dipertahankan (ACOG, 2021). Karena itu, dalam perencanaan pulang, tenaga kesehatan harus menilai apakah proses laktasi awal berlangsung baik atau

terdapat hambatan yang dapat mengganggu produksi ASI setelah ibu berada di rumah.

b. Manfaat ASI bagi ibu dan bayi

ASI memberikan manfaat nutrisi, imunologis, perkembangan, dan psikososial bagi bayi, serta manfaat fisiologis dan kesehatan jangka panjang bagi ibu. NICE menempatkan pemberian makan bayi sebagai komponen penting asuhan postnatal, sedangkan ACOG menegaskan bahwa menyusui berkontribusi terhadap kesehatan ibu dan bayi dan perlu didukung sebagai bagian dari praktik obstetri yang berkualitas (NICE, 2021; ACOG, 2023). Pada konteks perencanaan pulang, pemahaman tentang manfaat ASI penting karena dapat memperkuat motivasi ibu dan keluarga untuk mempertahankan menyusui, sekaligus membantu tenaga kesehatan membingkai dukungan menyusui sebagai bagian dari keselamatan dan kesehatan, bukan sekadar anjuran gaya hidup.

2. Penilaian Menyusui Sebelum Pulang

a. Pelekatan

Pelekatan (*latch*) harus dinilai secara langsung sebelum ibu dan bayi pulang. Pelekatan yang baik biasanya ditandai dengan mulut bayi terbuka lebar, dagu menempel ke payudara, sebagian besar areola masuk ke mulut bayi, hisapan ritmis, dan ibu tidak merasakan nyeri yang bermakna. NICE merekomendasikan observasi menyusui dan bantuan praktis bila ada masalah pada posisi atau pelekatan, karena pelekatan yang tidak adekuat berkaitan dengan puting lecet, nyeri, transfer ASI tidak efektif, dan penurunan kepercayaan diri ibu (NICE, 2021). ACOG juga menekankan bahwa evaluasi teknik menyusui penting ketika ibu melaporkan nyeri, bayi tidak puas, atau kekhawatiran tentang kecukupan ASI (ACOG, 2021). Dalam discharge planning, penilaian pelekatan penting karena masalah kecil yang tidak dikenali di fasilitas dapat berkembang menjadi masalah besar setelah pulang.

b. Posisi menyusui

Posisi menyusui perlu dinilai karena posisi yang tidak tepat dapat mengganggu pelekatan, menyebabkan nyeri, dan mengurangi efektivitas transfer ASI. Penilaian posisi meliputi kenyamanan ibu, orientasi tubuh bayi terhadap ibu, dukungan kepala dan tubuh bayi, serta apakah ibu mampu mengulang posisi tersebut tanpa bantuan penuh dari petugas. NICE menekankan pentingnya pemberian dukungan praktis, bukan hanya nasihat verbal, dalam membantu ibu belajar menyusui pada masa postnatal (NICE, 2021). Ini berarti sebelum pulang, ibu sebaiknya telah memperoleh

demonstrasi dan kesempatan praktik yang cukup agar mampu menyusui dengan posisi yang aman dan nyaman di rumah.

c. Frekuensi menyusui

Frekuensi menyusui harus dinilai sebagai bagian dari kecukupan laktasi. Menyusui dini dan sering membantu merangsang produksi ASI serta mencegah bendungan. WHO menempatkan dukungan menyusui dan konseling sebagai intervensi esensial pascapersalinan, sedangkan ACOG menjelaskan bahwa pengosongan payudara sering merupakan kunci untuk mempertahankan produksi ASI (WHO, 2022; ACOG, 2021). Dalam pengkajian sebelum pulang, tenaga kesehatan perlu menilai apakah bayi menyusu cukup sering, apakah ibu mengenali tanda lapar bayi, dan apakah ada pembatasan jadwal menyusui yang justru mengganggu proses laktasi. Bila frekuensi menyusu terlalu jarang, risiko penurunan asupan bayi, ikterus, dan berkurangnya produksi ASI meningkat.

d. Kecukupan ASI

Kecukupan ASI tidak dapat dinilai hanya dari persepsi ibu bahwa payudara “terasa penuh” atau bayi “sering menangis”. Penilaian harus mencakup observasi menyusu, tanda menelan, kepuasan bayi setelah menyusu, pola berkemih dan defekasi, serta tren berat badan. NICE menegaskan bahwa dukungan feeding pada periode postnatal harus membantu orang tua memahami apakah bayi mendapatkan asupan yang cukup dan kapan harus mencari bantuan (NICE, 2021). ACOG juga menyoroti bahwa keluhan “ASI kurang” sering kali memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap teknik menyusui, frekuensi pengosongan payudara, dan kondisi ibu-bayi, bukan langsung diasumsikan sebagai produksi yang memang rendah (ACOG, 2021). Oleh karena itu, menjelang pulang, keluarga perlu dibekali indikator praktis kecukupan ASI dan kapan harus kembali kontrol bila ada kekhawatiran.

3. Masalah Umum Menyusui

a. Puting nyeri

Puting nyeri merupakan masalah umum pada hari-hari awal postpartum, tetapi tidak boleh dianggap normal begitu saja tanpa evaluasi. Nyeri sering menandakan pelekatan yang buruk, posisi yang salah, trauma puting, atau masalah anatomi bayi. NICE menekankan perlunya observasi menyusui dan intervensi langsung bila ada keluhan nyeri, sedangkan ACOG menyebut bahwa nyeri menyusui sering kali dapat diperbaiki dengan koreksi teknik dan penilaian penyebab spesifik (NICE, 2021; ACOG, 2021). Dalam perencanaan pulang, ibu yang masih mengalami nyeri puting perlu mendapat bantuan

sebelum pulang, karena nyeri yang tidak tertangani dapat menyebabkan penghentian menyusui dini atau penggunaan suplementasi yang tidak perlu.

b. Bendungan payudara

Bendungan payudara terjadi ketika payudara terasa penuh, tegang, nyeri, dan bengkak, biasanya akibat akumulasi ASI dan edema jaringan. Kondisi ini dapat mengganggu pelekatan karena areola menjadi keras dan sulit dihisap oleh bayi. *Academy of Breastfeeding Medicine (ABM)* menjelaskan bahwa bendungan berada dalam spektrum masalah payudara laktasi, dan penanganan yang tepat harus membedakan bendungan fisiologis dari inflamasi yang lebih berat atau mastitis (Mitchell et al., 2022). Dalam pengkajian menjelang pulang, tenaga kesehatan perlu menilai rasa penuh pada payudara, nyeri, kesulitan melekatnya bayi, dan strategi yang digunakan ibu untuk mengatasinya. Ibu harus diberi edukasi tentang menyusui responsif, pengosongan payudara yang efektif, serta kapan bendungan menjadi tanda masalah yang lebih serius.

c. Mastitis

Mastitis adalah kondisi inflamasi payudara yang dapat disertai nyeri, kemerahan lokal, bengkak, gejala sistemik, dan kadang infeksi bakteri. ABM Protocol 36 menegaskan bahwa bendungan, sumbatan duktus, inflamasi, mastitis bakterial, dan abses merupakan spektrum yang saling berhubungan; karena itu, evaluasi klinis harus teliti dan tidak semua kemerahan payudara langsung diasumsikan sebagai infeksi yang memerlukan antibiotik (Mitchell et al., 2022). Dalam konteks perencanaan pulang, ibu perlu diajari tanda mastitis seperti payudara merah, nyeri bertambah, demam, rasa lemah, atau area keras yang menetap, serta diarahkan untuk segera mencari pertolongan bila gejala memburuk. Penilaian dini penting agar gangguan laktasi tidak menghambat keberlanjutan menyusui.

d. Bayi sulit melekat

Bayi yang sulit melekat dapat disebabkan oleh posisi yang salah, bendungan payudara, bayi mengantuk, prematuritas akhir, gangguan anatomi mulut, atau masalah neurologis. NICE menyebut bahwa masalah feeding perlu diidentifikasi secara aktif dalam masa postnatal dan bantuan praktis harus diberikan, bukan hanya saran umum (NICE, 2021). ACOG juga menekankan bahwa kesulitan menyusui harus mendorong evaluasi ibu dan bayi sebagai satu dyad, karena masalah dapat berasal dari salah satu atau keduanya (ACOG, 2021). Sebelum pulang, bila bayi masih sulit melekat, maka keputusan pulang harus disertai rencana dukungan intensif, pemantauan berat badan, dan tindak lanjut laktasi yang cepat.

4. Dukungan Menyusui di Rumah

a. Peran keluarga

Dukungan keluarga sangat menentukan keberhasilan menyusui setelah ibu pulang. WHO menegaskan bahwa pengalaman postnatal yang positif melibatkan pasangan, orang tua, dan keluarga sebagai sumber dukungan informasi dan praktis (WHO, 2022). Dalam konteks menyusui, keluarga dapat membantu ibu beristirahat, menyediakan makanan dan minuman, membantu posisi yang nyaman, mengurangi beban pekerjaan rumah, dan mendorong ibu untuk mencari bantuan bila ada masalah. NICE juga mengakui pentingnya dukungan orang tua dan keluarga dalam feeding bayi. Karena itu, perencanaan pulang sebaiknya tidak hanya mengedukasi ibu, tetapi juga orang terdekat yang akan membantu di rumah.

b. Konseling laktasi

Konseling laktasi adalah bagian penting dari discharge planning, terutama bagi ibu primipara, ibu pascaoperasi sesar, ibu dengan nyeri menyusui, atau bayi dengan masalah pelekatan. NICE merekomendasikan dukungan yang individual, jelas, dan berulang terkait feeding, sedangkan ACOG menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus mengenali tantangan menyusui dan memberikan dukungan yang sesuai atau merujuk ke konsultan laktasi bila diperlukan (NICE, 2021; ACOG, 2021). Konseling yang efektif tidak hanya berisi informasi, tetapi juga observasi, koreksi teknik, pemecahan masalah, dan penguatan kepercayaan diri ibu. Menjelang pulang, perlu dipastikan apakah ibu masih membutuhkan dukungan laktasi lanjutan dan ke mana ia bisa mengaksesnya.

c. Kapan harus mencari bantuan

Ibu dan keluarga harus memahami dengan jelas kapan masalah menyusui memerlukan bantuan profesional. NICE menekankan pentingnya memberikan informasi tentang kapan harus meminta pertolongan, sedangkan ABM menyoroti bahwa gejala payudara yang memburuk dapat berkembang dari bendungan menjadi inflamasi atau mastitis yang lebih berat bila tidak ditangani (NICE, 2021; Mitchell et al., 2022). Bantuan perlu dicari bila bayi sulit melekat, menyusu sangat sedikit, tampak tidak puas terus-menerus, BAK atau BAB berkurang, berat badan menurun berlebihan, ikterus bertambah, puting sangat nyeri atau berdarah, payudara merah dan nyeri, atau ibu mengalami demam. Menentukan titik kapan mencari bantuan merupakan inti dari keselamatan ibu-bayi setelah pulang, karena banyak masalah menyusui muncul atau memburuk justru pada beberapa hari pertama di rumah.

Pengkajian laktasi dan menyusui sebelum pulang harus mencakup penilaian fisiologi dasar laktasi, pelekatan, posisi, frekuensi menyusui, kecukupan ASI, masalah umum seperti puting nyeri dan bendungan payudara, serta kesiapan dukungan di rumah. Perencanaan pulang yang baik memastikan bahwa ibu tidak hanya “sudah mencoba menyusui,” tetapi benar-benar memahami cara menyusui yang efektif, mengenali masalah dini, dan tahu ke mana harus mencari bantuan. Dengan demikian, laktasi menjadi bagian integral dari keselamatan, keberlangsungan nutrisi bayi, dan kualitas pengalaman postpartum ibu (WHO, 2022; NICE, 2021; ACOG, 2021).

H. KESIAPAN PSIKOLOGIS DAN SOSIAL

Kesiapan psikologis dan sosial merupakan bagian penting dari penilaian ibu postpartum sebelum pulang karena pemulihan setelah persalinan tidak hanya ditentukan oleh stabilitas fisik, tetapi juga oleh kesejahteraan emosional, dukungan keluarga, dan kemampuan ibu beradaptasi dengan peran baru. ACOG menegaskan bahwa penilaian postpartum yang komprehensif harus mencakup mood dan kesejahteraan emosional, tidur dan kelelahan, perawatan bayi, serta aspek sosial sebagai bagian dari pemulihan pada “trimester keempat.” NICE juga menyatakan bahwa perawatan postnatal harus membantu orang tua membangun hubungan yang kuat dengan bayinya dan mengidentifikasi masalah kesehatan umum maupun serius, termasuk masalah psikologis. WHO menempatkan kesehatan mental, dukungan sosial, dan pengalaman postnatal yang positif sebagai komponen inti layanan postnatal yang berkualitas.

1. Adaptasi Psikologis Ibu Postpartum

a. Baby blues

Baby blues adalah perubahan emosi ringan yang umum muncul pada hari-hari awal setelah persalinan, biasanya berupa mudah menangis, labil emosi, sensitif, dan cepat lelah. Kondisi ini penting dikenali karena sering dianggap normal, tetapi tetap perlu dibedakan dari gangguan mood yang lebih berat. Dalam praktik klinis, tenaga kesehatan perlu menilai apakah perubahan emosi masih ringan, singkat, dan tidak sampai mengganggu fungsi ibu secara bermakna. NICE menempatkan pengenalan masalah kesehatan mental pada periode postnatal sebagai bagian dari pelayanan rutin, sedangkan ACOG menekankan pentingnya menilai mood dan kesejahteraan emosional selama perawatan postpartum.

b. Depresi postpartum

Depresi postpartum merupakan kondisi yang lebih serius daripada *baby blues* dan dapat ditandai dengan sedih berkepanjangan, hilang minat, rasa

bersalah, tidak berharga, gangguan tidur atau makan, kesulitan merawat diri atau bayi, sampai pikiran untuk menyakiti diri sendiri. ACOG dalam pedoman klinis tentang skrining dan diagnosis kondisi kesehatan mental selama kehamilan dan postpartum menegaskan bahwa gejala depresi, kecemasan, bipolar disorder, suicidality, dan postpartum psychosis harus dikenali secara sistematis. NICE juga memiliki pedoman khusus untuk kesehatan mental antenatal dan postnatal yang menekankan deteksi dini, penilaian, dan rujukan yang tepat untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan selama kehamilan dan hingga satu tahun setelah melahirkan. Dalam konteks perencanaan pulang, ibu yang menunjukkan gejala depresi tidak cukup hanya diberi edukasi umum, tetapi membutuhkan rencana tindak lanjut yang jelas dan, bila perlu, rujukan ke layanan kesehatan mental perinatal.

c. Kecemasan postpartum

Kecemasan postpartum dapat muncul sebagai kekhawatiran berlebihan terhadap kesehatan bayi, kemampuan menjadi ibu, menyusui, tidur bayi, atau keselamatan diri dan keluarga. Walaupun sering tidak sejelas depresi, kecemasan yang menetap dapat mengganggu istirahat, proses menyusui, bonding, dan kemampuan ibu mengambil keputusan. ACOG memasukkan gangguan kecemasan dan kondisi terkait kecemasan dalam panduan skrining kesehatan mental perinatal, sedangkan NICE menekankan bahwa tenaga kesehatan perlu mengenali masalah mental pada masa postnatal dan merujuk sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, saat menjelang pulang, penilaian psikologis sebaiknya tidak hanya menanyakan “apakah ibu sedih,” tetapi juga apakah ibu merasa sangat takut, tegang, panik, atau terus-menerus khawatir hingga mengganggu fungsi sehari-hari.

2. Dukungan Keluarga dan Pasangan

a. Peran pasangan

Pasangan memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ibu postpartum, keberhasilan menyusui, adaptasi peran orang tua, dan pengenalan tanda bahaya. WHO menjelaskan bahwa pengalaman postnatal yang positif melibatkan perempuan, bayi, pasangan, orang tua, dan keluarga sebagai penerima informasi, dukungan, dan reassurance yang konsisten. NICE juga menekankan bahwa perawatan postnatal harus membantu orang tua membangun hubungan dengan bayinya, yang secara implisit menempatkan pasangan sebagai bagian dari sistem dukungan inti. Dalam perencanaan pulang, keterlibatan pasangan dapat berupa membantu ibu beristirahat, mendukung menyusui, menemani kontrol, membantu pengambilan keputusan, dan memperhatikan perubahan emosi ibu.

b. Peran keluarga inti

Keluarga inti, seperti orang tua, saudara, atau anggota rumah tangga lain, sering menjadi sumber bantuan praktis dan emosional setelah ibu pulang. Mereka dapat membantu perawatan bayi, pekerjaan rumah, penyediaan makanan, transportasi ke fasilitas kesehatan, dan memberi kesempatan kepada ibu untuk istirahat. WHO menegaskan bahwa layanan postnatal yang baik harus mempertimbangkan konteks keluarga dan pengasuh, sedangkan NHS England menekankan bahwa rencana perawatan postnatal yang dipersonalisasi harus memperhitungkan kebutuhan klinis, psikologis, dan sosial perempuan setelah pulang. Oleh karena itu, penilaian kesiapan pulang perlu memasukkan pertanyaan tentang siapa yang akan mendampingi ibu di rumah dan seberapa memadai bantuan yang tersedia.

c. Dukungan sosial

Dukungan sosial yang baik dapat menurunkan beban psikologis ibu postpartum dan membantu transisi peran menjadi ibu. Sebaliknya, isolasi sosial atau kurangnya dukungan dapat memperburuk kelelahan, kecemasan, dan risiko gangguan mood. ACOG menyatakan bahwa penilaian postpartum yang komprehensif harus mencakup aspek sosial, sementara WHO dan NICE sama-sama menempatkan dukungan pada orang tua dan keluarga sebagai bagian dari perawatan postnatal yang berkualitas. Dalam konteks discharge planning, dukungan sosial perlu ditanyakan secara konkret: apakah ibu memiliki orang yang bisa dihubungi, siapa yang membantu saat malam hari, siapa yang dapat membawa ibu atau bayi ke layanan kesehatan, dan apakah keluarga memahami kondisi ibu postpartum.

3. Kesiapan Menjalankan Peran Ibu

a. Kepercayaan diri merawat bayi

Kesiapan menjalankan peran ibu tidak hanya berarti ibu “sudah punya bayi”, tetapi juga apakah ia merasa mampu merawat bayinya. Penilaian dapat mencakup keyakinan ibu dalam memegang bayi, menyusui, mengganti popok, menenangkan bayi, mengenali tangisan, dan mengetahui kapan bayi perlu dibawa berobat. NICE menekankan bahwa perawatan postnatal harus membantu orang tua membangun hubungan dengan bayi dan memahami kebutuhan dasar bayi, sedangkan WHO menempatkan dukungan informasi dan keterampilan praktis sebagai unsur penting pengalaman postnatal yang positif. Bila ibu tampak sangat takut, bingung, atau tidak yakin, maka sebelum pulang perlu diberikan dukungan tambahan dan demonstrasi praktis.

b. Kesiapan emosional

Kesiapan emosional mencakup kemampuan ibu menerima peran baru, beradaptasi dengan perubahan tubuh dan rutinitas, serta merespons tuntutan merawat bayi tanpa kewalahan berlebihan. ACOG menekankan bahwa postpartum care harus menilai mood, tidur, kelelahan, infant care, dan kesejahteraan emosional secara terpadu, karena masalah-masalah ini saling berkaitan. Ibu yang sangat kelelahan, menangis terus-menerus, tampak tidak tertarik pada bayi, atau menyatakan tidak sanggup merawat bayi memerlukan penilaian lebih dalam. Pada titik ini, kesiapan emosional tidak boleh diasumsikan hanya dari penampilan luar yang tenang.

c. Kebutuhan bantuan lanjutan

Tidak semua ibu postpartum pulang dengan tingkat kesiapan yang sama. Sebagian ibu memerlukan bantuan lanjutan berupa konseling laktasi, kunjungan rumah, dukungan kesehatan mental, edukasi berulang, atau pemantauan lebih awal. ACOG menyarankan bahwa perawatan postpartum harus dipandang sebagai proses berkelanjutan dengan kontak awal dan tindak lanjut individual, bukan satu kunjungan tunggal. WHO juga menekankan kesinambungan pelayanan antara fasilitas kesehatan, komunitas, dan rumah tangga. Karena itu, pengkajian psikososial sebelum pulang harus diakhiri dengan keputusan praktis: apakah ibu cukup aman pulang dengan dukungan rutin, atau memerlukan pengawasan dan intervensi tambahan.

4. Identifikasi Faktor Risiko Psikososial

a. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau *intimate partner violence* merupakan faktor risiko psikososial yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan mental ibu pada periode postpartum. WHO memiliki pedoman khusus mengenai respons layanan kesehatan terhadap kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual terhadap perempuan, yang menekankan perlunya dukungan emosional, identifikasi yang sensitif, dan rujukan yang sesuai. ACOG juga menyediakan panduan klinis tentang *intimate partner violence* dan trauma-informed care. Dalam konteks perencanaan pulang, keberadaan kekerasan, kontrol berlebihan, ancaman, atau lingkungan rumah yang tidak aman harus dipertimbangkan secara serius karena dapat menghambat pemulihan ibu dan keselamatan ibu-bayi.

b. Konflik keluarga

Konflik keluarga, termasuk hubungan yang tegang dengan pasangan, mertua, atau anggota rumah tangga lain, dapat memperburuk stres postpartum dan menurunkan dukungan yang seharusnya diterima ibu.

Meskipun konflik keluarga tidak selalu muncul sebagai diagnosis medis, dalam praktik perawatan postnatal hal ini penting karena dapat memengaruhi tidur, menyusui, keputusan pengasuhan, serta kesehatan mental ibu. WHO dan NICE sama-sama menekankan pentingnya konteks keluarga dan dukungan terhadap orang tua pada masa postnatal, sehingga konflik keluarga harus dipandang sebagai faktor yang relevan dalam pengkajian kesiapan pulang.

c. Keterbatasan ekonomi

Keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan keluarga memperoleh makanan bergizi, transportasi untuk kontrol, obat, alat kebersihan ibu-bayi, dan akses ke layanan kesehatan lanjutan. NHS England dalam toolkit postnatal menekankan perlunya rencana perawatan yang dipersonalisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial perempuan. ACOG juga menempatkan domain sosial sebagai bagian dari penilaian postpartum komprehensif. Artinya, masalah ekonomi bukan isu “di luar medis”, melainkan faktor yang dapat langsung memengaruhi keselamatan ibu dan bayi setelah pulang.

d. Kurangnya dukungan

Kurangnya dukungan dari pasangan, keluarga, atau lingkungan sosial merupakan faktor risiko penting untuk kelelahan, gangguan mood, hambatan menyusui, dan keterlambatan mencari pertolongan saat ada tanda bahaya. WHO memandang dukungan keluarga dan pengasuh sebagai bagian dari pengalaman postnatal yang positif, sementara ACOG dan NICE sama-sama menekankan pentingnya penilaian menyeluruh terhadap kesejahteraan emosional dan konteks sosial ibu. Dalam discharge planning, kurangnya dukungan harus dicatat secara eksplisit karena dapat mengubah kebutuhan follow-up, misalnya memerlukan kontrol lebih dini, edukasi tambahan, atau rujukan ke layanan komunitas.

Kesiapan psikologis dan sosial ibu postpartum harus dinilai secara aktif sebelum pulang karena sangat memengaruhi kemampuan ibu merawat diri dan bayi, keberhasilan menyusui, kepatuhan terhadap tindak lanjut, dan keselamatan ibu-bayi di rumah. Pengkajian ini mencakup adaptasi psikologis seperti *baby blues*, depresi, dan kecemasan; dukungan pasangan dan keluarga; kesiapan menjalankan peran ibu; serta faktor risiko psikososial seperti kekerasan, konflik keluarga, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya dukungan. Dengan memasukkan aspek-aspek ini ke dalam perencanaan pulang, tenaga kesehatan dapat membuat keputusan yang lebih aman, lebih individual, dan lebih berkelanjutan.

I. PERAWATAN DIRI DI RUMAH

Edukasi perawatan diri di rumah merupakan bagian penting dari perencanaan pulang ibu postpartum karena sebagian besar proses pemulihan berlangsung setelah ibu meninggalkan fasilitas kesehatan. Edukasi ini bertujuan agar ibu dan keluarga memahami apa yang normal pada masa nifas, bagaimana melakukan perawatan sehari-hari dengan aman, kapan harus mencari pertolongan, dan bagaimana mencegah komplikasi. NICE menegaskan bahwa informasi postnatal harus diberikan dengan bahasa yang jelas, dengan waktu dan cara penyampaian yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, sedangkan WHO menempatkan konseling, promosi kesehatan, dan dukungan keluarga sebagai komponen utama pengalaman postnatal yang positif. ACOG juga menekankan bahwa masa postpartum adalah periode pemulihan fisik dan emosional yang memerlukan dukungan berkelanjutan, bukan hanya satu kunjungan setelah persalinan (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2021; World Health Organization [WHO], 2022; American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2018).

1. Personal Hygiene

a. Kebersihan diri

Kebersihan diri pada masa postpartum perlu ditekankan sebagai bagian dari pencegahan infeksi dan pemulihan kenyamanan ibu. Ibu perlu dianjurkan mandi teratur, mengganti pakaian dan pembalut secara rutin, mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi atau mengganti pembalut, serta menjaga kebersihan payudara dan area genital. WHO menempatkan kebersihan dan pencegahan infeksi sebagai bagian dari paket asuhan postnatal, sedangkan NICE menekankan bahwa perempuan harus memperoleh informasi yang praktis dan mudah diterapkan terkait perawatan pascapersalinan. Dalam konteks rumah, kebersihan diri membantu mengurangi risiko infeksi luka, kontaminasi pada perawatan bayi, dan ketidaknyamanan akibat lochia atau keringat berlebih setelah persalinan (WHO, 2022; NICE, 2021).

b. Kebersihan genitalia dan luka

Ibu perlu memahami bahwa kebersihan area perineum dan luka operasi sesar bukan berarti menggunakan banyak antiseptik atau produk khusus, melainkan menjaga area tetap bersih dan kering, mengganti pembalut secara teratur, dan memperhatikan perubahan yang tidak normal. NICE menempatkan identifikasi serta penanganan masalah luka dan infeksi sebagai bagian dari asuhan postnatal rutin, sehingga edukasi kebersihan genitalia harus dikaitkan dengan pengenalan tanda infeksi seperti nyeri memburuk, kemerahan, bengkak, bau tidak sedap, atau keluarnya cairan dari luka. WHO

juga menekankan bahwa ibu harus mampu mengenali tanda bahaya pascapersalinan dan mencari pertolongan tepat waktu (NICE, 2021; WHO, 2022).

2. Aktivitas dan Istirahat

a. Mobilisasi

Mobilisasi dini yang aman penting untuk mempercepat pemulihan, meningkatkan kenyamanan, dan mendukung fungsi tubuh setelah persalinan. ACOG menyatakan bahwa aktivitas fisik pada masa postpartum berkontribusi terhadap pemulihan dan juga bermanfaat bagi kesehatan mental, sementara perempuan yang sehat umumnya dapat kembali secara bertahap ke aktivitas fisik sesuai kemampuan. Pada edukasi pulang, ibu perlu dianjurkan memulai aktivitas ringan secara bertahap, menghindari imobilisasi berkepanjangan, dan menyesuaikan tingkat aktivitas dengan nyeri, kekuatan tubuh, serta jenis persalinan yang dialami (ACOG, 2020; ACOG, 2018).

b. Aktivitas fisik bertahap

Aktivitas fisik pada masa nifas sebaiknya dilakukan bertahap dan individual. Ibu yang melahirkan pervaginam tanpa komplikasi biasanya dapat memulai aktivitas ringan lebih cepat, sedangkan ibu pascaoperasi sesar atau dengan komplikasi lain memerlukan penyesuaian. ACOG menjelaskan bahwa aktivitas fisik postpartum perlu mempertimbangkan kondisi medis, proses persalinan, serta gejala yang muncul selama pemulihan. Dalam edukasi perawatan di rumah, penting ditekankan bahwa kembali aktif bukan berarti langsung melakukan pekerjaan berat, melainkan bergerak secara aman dan bertahap sesuai toleransi tubuh (ACOG, 2020).

c. Kebutuhan tidur dan istirahat

Istirahat dan tidur merupakan bagian penting dari perawatan diri postpartum, tetapi sering terganggu oleh menyusui, nyeri, kecemasan, dan perubahan rutinitas rumah tangga. ACOG menyebut kelelahan dan kurang tidur sebagai tantangan umum pada masa postpartum yang dapat memengaruhi kesejahteraan emosional, pemulihan fisik, dan kemampuan merawat bayi. Karena itu, edukasi pulang perlu menekankan strategi realistis, seperti beristirahat ketika bayi tidur, menerima bantuan keluarga, dan mengurangi beban pekerjaan rumah pada minggu-minggu awal. NICE juga memandang kebutuhan informasi yang disesuaikan secara individual sebagai bagian dari kualitas asuhan postnatal, sehingga saran tentang istirahat perlu disesuaikan dengan kondisi ibu dan dukungan rumah tangga yang tersedia (ACOG, 2018; NICE, 2021).

3. Nutrisi dan Hidrasi

a. Kebutuhan gizi ibu postpartum

Nutrisi postpartum penting untuk pemulihan jaringan, penggantian kehilangan darah, daya tahan tubuh, dan produksi ASI. WHO menyoroti bahwa kesehatan dan kesejahteraan ibu pada masa postnatal dipengaruhi oleh dukungan nutrisi yang memadai, dan pedoman WHO tentang suplementasi zat besi postpartum menekankan peran intervensi nutrisi untuk memperbaiki status kesehatan ibu. Dalam edukasi pulang, ibu perlu dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang kaya energi, protein, zat besi, dan mikronutrien yang mendukung pemulihan (WHO, 2016; WHO, 2022).

b. Diet ibu menyusui

Ibu menyusui membutuhkan dukungan nutrisi yang memadai agar dapat mempertahankan produksi ASI dan kondisi fisik yang baik. Meskipun tidak semua ibu memerlukan diet khusus, prinsip umum yang perlu ditekankan adalah makan teratur, bervariasi, dan cukup. WHO menempatkan dukungan menyusui sebagai komponen penting asuhan postnatal, dan keberhasilan menyusui sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu secara keseluruhan, termasuk kecukupan asupan makanan dan cairan. Edukasi juga perlu menghindarkan ibu dari pantangan makanan yang tidak berdasar dan justru menurunkan asupan nutrisi (WHO, 2022).

c. Pencegahan konstipasi dan dehidrasi

Konstipasi dan dehidrasi dapat terjadi pada masa postpartum karena nyeri perineum, takut BAB, kurang minum, kurang mobilisasi, atau efek obat. NICE memasukkan masalah eliminasi sebagai isu yang perlu dikenali selama masa postnatal. Karena itu, edukasi di rumah sebaiknya menekankan pentingnya minum cukup, makan makanan berserat, bergerak secara bertahap, dan tidak menahan BAB. Pencegahan konstipasi penting terutama pada ibu dengan luka perineum atau episiotomi, karena nyeri saat BAB dapat memperlambat pemulihan dan meningkatkan kecemasan (NICE, 2021).

d. Hidrasi

Hidrasi yang baik penting bagi pemulihan umum, kenyamanan, dan dukungan terhadap menyusui. WHO menempatkan kesehatan umum ibu selama masa postnatal sebagai fokus penting pelayanan, dan asupan cairan yang cukup merupakan bagian dari perawatan dasar di rumah. Edukasi hidrasi perlu bersifat praktis, yaitu minum secara teratur, lebih sering bila merasa haus, menyusui, atau cuaca panas, serta waspada bila terdapat tanda dehidrasi seperti mulut sangat kering, urine sangat sedikit, atau pusing. Pada ibu dengan

perdarahan postpartum sebelumnya, muntah, atau demam, pemantauan asupan cairan menjadi lebih penting (WHO, 2022).

4. Aktivitas Seksual Pasca Persalinan

a. Waktu aman memulai

Aktivitas seksual pascapersalinan perlu dibahas secara terbuka dan individual karena pemulihan tiap ibu berbeda. ACOG menyatakan bahwa masa postpartum melibatkan pemulihan fisik dan emosional yang dapat memengaruhi kenyamanan seksual, dan penilaian postpartum yang komprehensif perlu mencakup seksualitas, kontrasepsi, dan penjarangan kehamilan. Tidak ada satu waktu yang sama untuk semua ibu, tetapi keputusan memulai kembali hubungan seksual perlu mempertimbangkan berhentinya perdarahan, penyembuhan luka, kenyamanan ibu, dan kesiapan emosional (ACOG, 2018).

b. Faktor kenyamanan

Kenyamanan saat berhubungan seksual setelah melahirkan dapat dipengaruhi oleh nyeri perineum, kekeringan vagina, kelelahan, ketakutan akan nyeri, perubahan citra tubuh, dan masalah relasi pasangan. NICE menyebut bahwa masalah kesehatan fisik dan emosional ibu pada masa postnatal dapat memengaruhi kualitas hidup sehari-hari, termasuk aspek intim dan psikososial. Karena itu, edukasi sebaiknya menekankan bahwa ketidaknyamanan adalah hal yang perlu dibicarakan, bukan disembunyikan, dan hubungan seksual sebaiknya ditunda atau dimodifikasi bila ibu belum merasa siap (NICE, 2021; ACOG, 2018).

c. Edukasi kesehatan seksual

Edukasi kesehatan seksual pada masa postpartum perlu mencakup kenyamanan, persetujuan, penggunaan kontrasepsi, serta penjarangan kehamilan. ACOG menegaskan bahwa pembahasan mengenai kontrasepsi dan seksualitas harus menjadi bagian dari pelayanan postpartum komprehensif. Dalam discharge planning, ibu dan pasangan perlu memahami bahwa ovulasi dapat kembali sebelum menstruasi pertama, sehingga hubungan seksual tanpa kontrasepsi dapat menimbulkan kehamilan yang tidak direncanakan. Dengan demikian, edukasi kesehatan seksual seharusnya tidak dipisahkan dari konseling kesehatan reproduksi dan keluarga berencana pascapersalinan (ACOG, 2018).

J. TANDA BAHAYA YANG HARUS DIWASPADAI

1. Pada ibu

Ibu postpartum dan keluarganya harus memahami tanda bahaya yang memerlukan pertolongan segera. CDC melalui kampanye HEAR HER menekankan bahwa tanda peringatan maternal mendesak pada masa postpartum mencakup perdarahan berlebihan, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, nyeri dada, sesak napas, kejang, pembengkakan hebat, demam, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. WHO juga mencantumkan tanda bahaya seperti perdarahan berlebihan, demam, nyeri perut, payudara merah dan nyeri, serta gejala berat lain sebagai alasan untuk segera mencari pertolongan. Edukasi tentang tanda bahaya maternal harus diberikan secara jelas, karena banyak kematian maternal terjadi setelah persalinan dan sering berkaitan dengan keterlambatan mengenali gejala serius (CDC, 2024; WHO, 2024).

2. Pada bayi

Keluarga juga harus mengenali tanda bahaya bayi baru lahir sebelum pulang. WHO mencantumkan tanda bahaya bayi seperti tidak mau menyusu, terlalu panas atau terlalu dingin, napas cepat atau tarikan dinding dada, kejang, tidak bergerak, dan kuning sampai telapak tangan atau telapak kaki. NICE menekankan bahwa pelayanan postnatal harus membantu orang tua mengenali gejala penyakit pada bayi dan mengetahui kapan harus mencari bantuan. Karena banyak masalah neonatal memburuk cepat dalam beberapa hari pertama di rumah, edukasi tanda bahaya bayi harus menjadi bagian wajib dari perencanaan pulang (WHO, 2024; NICE, 2021).

PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PASCA PERSALINAN

Pelayanan kesehatan reproduksi pascapersalinan adalah bagian penting dari asuhan postpartum karena masa setelah melahirkan bukan hanya masa pemulihan fisik, tetapi juga periode penataan kembali kesehatan seksual, fertilitas, kontrasepsi, dan rencana reproduksi berikutnya. WHO menempatkan pelayanan postnatal sebagai bagian dari continuum of care yang harus mendukung kesehatan fisik, mental, sosial, dan reproduksi ibu, sedangkan ACOG menegaskan bahwa perawatan postpartum harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, bukan satu kunjungan tunggal. Dengan demikian, pelayanan kesehatan reproduksi pascapersalinan harus dimulai sejak masa rawat, diperkuat sebelum pulang, dan dilanjutkan melalui tindak lanjut yang terencana (World Health Organization [WHO], 2022; American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2018).

K. Konsep Pelayanan Kesehatan Reproduksi Postpartum

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi postpartum mencakup konseling masa nifas, kesehatan seksual, kontrasepsi pascapersalinan, penjarangan kehamilan, identifikasi kebutuhan reproduksi jangka panjang, serta rujukan bila terdapat masalah klinis atau psikososial. ACOG menyebut bahwa penilaian postpartum yang komprehensif harus mencakup suasana hati dan kesejahteraan emosional, seksualitas, kontrasepsi, dan perencanaan kehamilan berikutnya. WHO juga menekankan bahwa layanan postnatal harus membantu perempuan dan keluarganya memperoleh informasi dan dukungan untuk membuat keputusan reproduksi yang aman dan sesuai kebutuhan mereka.

2. Tujuan

Tujuan pelayanan kesehatan reproduksi pascapersalinan adalah membantu ibu mencapai pemulihan reproduksi yang aman, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan atau terlalu dekat, mendukung kehidupan seksual yang sehat, dan memastikan keputusan kontrasepsi dibuat secara sadar dan sesuai kondisi klinis. WHO menyatakan bahwa keluarga berencana memungkinkan seseorang menentukan jumlah anak dan mengatur jarak kehamilan, sedangkan pedoman WHO tentang *postpregnancy family planning* menegaskan bahwa periode setelah melahirkan adalah kesempatan penting, tetapi sering terlewat, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan berjarak dekat.

3. Prinsip pelayanan komprehensif

Pelayanan reproduksi postpartum yang komprehensif harus bersifat berpusat pada pasien, terintegrasi dengan asuhan maternal-neonatal, berbasis bukti, menghormati hak reproduksi, dan mempertimbangkan kondisi klinis serta preferensi ibu. WHO menekankan pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi dalam pengalaman postnatal yang positif, sedangkan ACOG menyatakan bahwa dukungan untuk keluarga postpartum memerlukan pendekatan berkelanjutan dan individual. Artinya, pelayanan kesehatan reproduksi postpartum tidak boleh dipersempit hanya menjadi "memberi KB", tetapi harus menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan ibu secara utuh.

4. Konseling Kesehatan Reproduksi Pasca Persalinan

Prinsip konseling kesehatan reproduksi pascapersalinan:

- a. Berpusat pada ibu dan keluarga, menggunakan bahasa sederhana, serta menghormati nilai budaya dan keputusan ibu

Konseling kesehatan reproduksi pascapersalinan harus dilakukan dengan pendekatan *woman-centered* atau berpusat pada ibu, sambil tetap

memperhatikan konteks keluarga sebagai sistem pendukung utama. Artinya, kebutuhan, tujuan reproduksi, kondisi klinis, preferensi, tingkat literasi kesehatan, dan situasi sosial ibu menjadi dasar utama dalam penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. WHO menekankan bahwa pengalaman postnatal yang positif terjadi ketika perempuan, bayi baru lahir, pasangan, orang tua, dan keluarga menerima informasi, dukungan, dan reassurance secara konsisten, serta ketika sistem pelayanan menghormati kebutuhan dan konteks budaya mereka (World Health Organization, 2022). NICE juga menegaskan bahwa informasi postnatal harus diberikan dengan bahasa yang jelas, disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi perempuan, bersifat individual, sensitif, suportif, dan menghormati pilihan perempuan (NICE, 2021). Dengan demikian, penggunaan bahasa sederhana bukan hanya strategi komunikasi, tetapi bagian dari praktik pelayanan yang aman dan bermartabat.

b. Mengedepankan *informed choice* dan *informed consent* untuk pemilihan kontrasepsi

Dalam konseling kontrasepsi pascapersalinan, prinsip utama adalah memastikan bahwa ibu membuat keputusan secara sukarela, berdasarkan informasi yang cukup, dan bebas dari paksaan. WHO menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat pilihan yang terinformasi dari berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, dan tenaga kesehatan berkewajiban mendukung proses tersebut melalui informasi yang akurat dan seimbang (World Health Organization, 2022). Sejalan dengan itu, ACOG menyatakan bahwa konseling kontrasepsi yang baik harus menggunakan pendekatan *patient-centered* dan *shared decision making*, sehingga pilihan kontrasepsi benar-benar selaras dengan tujuan reproduksi pasien, preferensi pribadi, pengalaman sebelumnya, dan kondisi kesehatannya (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2022). Prinsip ini sangat penting pada masa postpartum karena periode ini sering menjadi momen kritis untuk membahas jarak kehamilan, metode kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang, serta metode yang sesuai dengan kondisi menyusui.

c. Menilai kesiapan menerima informasi dan menggunakan metode *teach-back* untuk memastikan pemahaman

Tidak semua ibu postpartum berada pada kondisi optimal untuk menerima informasi secara penuh pada saat yang sama. Kelelahan, nyeri, pengaruh obat, stres emosional, dan tuntutan merawat bayi dapat memengaruhi pemahaman. Oleh karena itu, konselor perlu terlebih dahulu menilai kesiapan ibu untuk menerima informasi, memilih waktu yang tepat, lalu memastikan pemahaman dengan teknik seperti *teach-back*. NICE

merekomendasikan agar tenaga kesehatan memeriksa apakah perempuan memahami informasi yang telah diberikan dan bagaimana informasi itu relevan bagi dirinya, serta menyediakan kesempatan yang cukup untuk bertanya (NICE, 2021). Dari perspektif literasi kesehatan, AHRQ menjelaskan bahwa kemampuan seseorang untuk menemukan, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan dipengaruhi oleh keadaan emosional, stres kehidupan, budaya, bahasa, dan kompleksitas informasi itu sendiri; karena itu, verifikasi pemahaman menjadi langkah penting dalam keselamatan pasien (Bakerjian, 2023). Metode *teach-back* mendukung prinsip ini karena meminta pasien mengulang kembali dengan kata-katanya sendiri apa yang telah dipahami, sehingga tenaga kesehatan dapat segera mengoreksi kekeliruan pemahaman sebelum pasien pulang.

d. Menyertakan pasangan atau anggota keluarga utama bila ibu menghendaki

Konseling pascapersalinan sebaiknya tidak secara otomatis hanya ditujukan kepada ibu seorang diri, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan pasangan atau anggota keluarga utama sesuai keinginan ibu. NICE secara eksplisit menyebutkan bahwa perempuan dapat didukung oleh pasangannya pada periode postnatal dan mereka perlu dilibatkan sesuai kehendak perempuan tersebut (NICE, 2021). Pendekatan ini penting karena pasangan atau keluarga sering berperan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, dukungan menyusui, pengasuhan bayi, akses transportasi, penggunaan kontrasepsi, dan pengenalan tanda bahaya. Namun, keterlibatan keluarga tidak boleh mengurangi otonomi ibu. Dalam kerangka konseling kontrasepsi yang berpusat pada pasien, ACOG juga menekankan penghormatan terhadap otonomi pasien dan penghindaran praktik yang mengarahkan pasien pada metode tertentu karena alasan non-klinis atau bias penyedia layanan (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2022). Jadi, pasangan atau keluarga dilibatkan sebagai pendukung, bukan pengambil keputusan utama atas tubuh dan kesehatan reproduksi ibu.

e. Mendokumentasikan edukasi, keputusan ibu, tindak lanjut, dan rencana rujukan bila ada *red flags*

Dokumentasi merupakan bagian esensial dari konseling kesehatan reproduksi pascapersalinan. Semua edukasi yang telah diberikan, pertanyaan atau kekhawatiran ibu, keputusan yang diambil ibu, metode kontrasepsi yang dipilih atau ditunda, rencana tindak lanjut, dan indikasi rujukan harus dicatat dengan jelas. NICE menekankan pentingnya berbagi informasi yang relevan saat terjadi perpindahan layanan pada masa postnatal agar kebutuhan individual ibu dan bayi tetap terjaga dan kesinambungan pelayanan tidak

terputus (NICE, 2022). Dalam rekomendasi postnatal WHO, kesinambungan asuhan dan respons terhadap kebutuhan ibu-bayi menjadi fondasi pelayanan yang aman; karena itu, dokumentasi berfungsi sebagai sarana koordinasi antartugas dan antarjenjang layanan (World Health Organization, 2022). Pencatatan juga penting bila terdapat *red flags* seperti hipertensi postpartum, perdarahan abnormal, gejala depresi, infeksi, nyeri berat, atau masalah laktasi, karena kondisi-kondisi tersebut memerlukan rencana rujukan dan follow-up yang jelas.

Secara praktis, prinsip konseling kesehatan reproduksi pascapersalinan dapat dirumuskan sebagai berikut: konseling harus berpusat pada ibu, sensitif terhadap keluarga dan budaya, menggunakan bahasa sederhana, mendukung shared decision making, menjamin informed choice dan informed consent, menilai kesiapan ibu menerima informasi, memverifikasi pemahaman dengan teach-back, melibatkan pasangan bila ibu menghendaki, serta mendokumentasikan seluruh edukasi, keputusan, tindak lanjut, dan rencana rujukan secara sistematis (NICE, 2021; World Health Organization, 2022; Bakerjian, 2023; American College of Obstetricians and Gynecologists, 2022).

5. Kesehatan Seksual Pasca Persalinan

a. Pemulihan fungsi seksual

Pemulihan fungsi seksual setelah persalinan berlangsung bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, relasional, dan sosial. ACOG menyatakan bahwa penilaian postpartum yang komprehensif harus mencakup seksualitas sebagai bagian dari kesehatan perempuan. NICE juga menempatkan masalah kesehatan fisik dan emosional perempuan pada masa postnatal sebagai bagian dari layanan rutin. Dalam praktiknya, ini berarti pembicaraan tentang seksualitas pascapersalinan harus dianggap normal dan penting, bukan topik tambahan yang diabaikan.

b. Nyeri saat hubungan seksual

Nyeri saat hubungan seksual setelah persalinan dapat berkaitan dengan trauma perineum, luka episiotomi, luka operasi, ketegangan otot dasar panggul, kelelahan, kecemasan, atau kurangnya kesiapan emosional. NICE menyoroti bahwa nyeri perineum dan masalah pascapersalinan dapat berdampak pada fungsi sehari-hari dan kesejahteraan perempuan. Karena itu, edukasi kesehatan seksual harus menegaskan bahwa nyeri bukan sesuatu yang harus diterima diam-diam; bila nyeri menetap atau berat, ibu memerlukan penilaian lebih lanjut.

c. Lubrikasi dan kenyamanan

Kenyamanan saat memulai kembali hubungan seksual sangat penting dalam konseling postpartum. Ibu perlu didorong untuk menunggu sampai merasa siap secara fisik dan emosional, berkomunikasi dengan pasangan, dan menyesuaikan aktivitas seksual dengan kenyamanan tubuhnya. NICE menekankan bahwa pelayanan postnatal harus responsif terhadap kebutuhan dan preferensi perempuan. Dalam konteks klinis, pembahasan tentang kenyamanan juga perlu dikaitkan dengan faktor seperti kelelahan, nyeri luka, rasa takut akan nyeri, dan beban perawatan bayi, sehingga pendekatannya tetap individual.

d. Konseling pasangan

Bila ibu menghendaki, pasangan dapat dilibatkan dalam konseling kesehatan seksual pascapersalinan. Keterlibatan ini bermanfaat untuk membangun pemahaman bersama tentang pemulihan ibu, waktu yang tepat memulai kembali hubungan seksual, pentingnya komunikasi, serta pemilihan kontrasepsi. NICE menyebut bahwa pasangan dapat dilibatkan sesuai keinginan perempuan, dan WHO menekankan peran pasangan dalam pengalaman postnatal yang positif. Dengan demikian, konseling pasangan membantu mengurangi tekanan pada ibu dan mendukung keputusan seksual-reproduktif yang lebih sehat. (NICE)

L. Keluarga Berencana Pascapersalinan

KB pascapersalinan penting karena fertilitas dapat kembali sebelum menstruasi pertama, terutama pada ibu yang tidak menyusui eksklusif. NICE quality statement tentang kontrasepsi setelah persalinan menyebutkan bahwa perempuan yang melahirkan harus diberi informasi tentang semua metode kontrasepsi sesegera mungkin dan paling lambat dalam 7 hari setelah persalinan, karena kesuburan dapat kembali dengan cepat, termasuk pada perempuan yang menyusui. WHO juga menegaskan bahwa *post-pregnancy family planning* bertujuan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan yang berjarak dekat.

1. Waktu mulai kontrasepsi

Waktu mulai kontrasepsi pascapersalinan harus disesuaikan dengan metode yang dipilih, status menyusui, risiko tromboemboli, dan kondisi klinis ibu. CDC *U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024* memperbarui rekomendasi untuk kondisi postpartum dan menyusui, sedangkan *U.S. Selected Practice Recommendations, 2024* memberi panduan praktis mengenai inisiasi dan penggunaan metode kontrasepsi. Secara prinsip, pemilihan waktu tidak boleh seragam untuk semua ibu; metode tertentu dapat dimulai segera setelah

persalinan, sedangkan metode berbasis estrogen memerlukan pertimbangan lebih hati-hati pada periode awal postpartum karena risiko tromboemboli dan pengaruh terhadap laktasi pada sebagian ibu.

2. Metode amenorea laktasi

Metode amenorea laktasi atau *lactational amenorrhea method* (LAM) dapat menjadi pilihan kontrasepsi sementara bila syaratnya terpenuhi, yaitu ibu amenorea, menyusui eksklusif atau hampir eksklusif, dan masih dalam 6 bulan pertama postpartum. WHO menyatakan bahwa keluarga berencana memungkinkan orang mengatur jumlah anak dan jarak kehamilan melalui berbagai metode kontrasepsi, sementara panduan CDC memasukkan LAM sebagai salah satu metode yang dapat digunakan dalam konteks postpartum. Dalam konseling, penting ditekankan bahwa LAM hanya efektif bila kriterianya masih terpenuhi; bila salah satu syarat tidak terpenuhi, ibu perlu beralih atau menambah metode lain.

3. Kontrasepsi hormonal

Kontrasepsi hormonal pada masa postpartum harus dipilih berdasarkan kondisi klinis dan status menyusui. CDC MEC 2024 memberikan klasifikasi kelayakan medis untuk kontrasepsi kombinasi maupun progestin saja pada situasi postpartum, termasuk pada ibu menyusui dan tidak menyusui. Secara umum, metode progestin dapat digunakan lebih dini dibanding metode kombinasi yang mengandung estrogen, karena estrogen memerlukan pertimbangan khusus terkait risiko tromboemboli pada masa awal postpartum. Karena itu, konseling hormonal postpartum harus selalu berbasis kondisi individual, bukan sekadar preferensi metode.

4. AKDR/IUD postpartum

AKDR atau IUD merupakan salah satu metode kontrasepsi reversibel jangka panjang yang dapat dipertimbangkan pada masa postpartum. ACOG menekankan pentingnya akses terhadap metode kontrasepsi efektif, termasuk IUD, dengan konseling yang berpusat pada pasien dan menghormati hak pasien untuk menerima, menolak, atau menunda kontrasepsi. Program ACOG Postpartum Contraceptive Access Initiative juga menyebut bahwa periode segera setelah persalinan dapat menjadi waktu yang sangat baik untuk diskusi dan inisiasi kontrasepsi, termasuk LARC. Meski demikian, konseling tetap perlu membahas manfaat, keterbatasan, kemungkinan ekspulsi bila pemasangan segera postpartum, dan kebutuhan kontrol lanjutan.

5. Implant

Implan juga termasuk LARC yang efektif dan relevan untuk periode postpartum. ACOG menyebut bahwa klinisi perlu menyediakan konseling

berpusat pada pasien mengenai semua opsi kontrasepsi, termasuk implan, dan menghormati hak pasien untuk menolak atau menunda. Dalam kerangka CDC MEC 2024, penggunaan implan postpartum dinilai berdasarkan status menyusui dan kondisi medis ibu, sehingga metode ini dapat menjadi pilihan yang baik pada banyak situasi postpartum bila ibu menginginkannya dan tidak ada kontraindikasi.

6. Metode barrier

Metode barrier, seperti kondom, penting dibahas karena selain mencegah kehamilan, kondom juga merupakan satu-satunya metode kontrasepsi yang sekaligus melindungi terhadap infeksi menular seksual. WHO menegaskan hal ini dalam lembar fakta keluarga berencana/kontrasepsi. Dalam konseling postpartum, metode barrier dapat menjadi pilihan utama atau pelengkap, terutama bila ibu belum siap memilih metode hormonal atau LARC, atau ketika pasangan juga perlu dilibatkan dalam pencegahan IMS.

7. Sterilisasi

Sterilisasi adalah metode permanen yang memerlukan konseling yang sangat hati-hati karena berimplikasi jangka panjang terhadap fertilitas. Prinsip utama yang ditekankan ACOG dalam konseling kontrasepsi adalah *informed choice*, penghormatan terhadap preferensi pasien, dan penghindaran paksaan. Oleh karena itu, bila sterilisasi dipertimbangkan pada masa postpartum, tenaga kesehatan harus memastikan ibu benar-benar memahami sifat permanen metode tersebut, alternatif yang tersedia, dan bahwa keputusan dibuat secara sukarela.

8. Pemilihan metode berbasis kondisi klinis

Pemilihan metode KB pascapersalinan harus berbasis kondisi klinis, termasuk menyusui, hipertensi, diabetes, anemia, tromboemboli, obesitas, pembedahan, dan kondisi medis lain. CDC MEC 2024 secara khusus dibuat untuk membantu klinisi memilih metode kontrasepsi yang aman menurut karakteristik dan kondisi medis pasien. Dengan demikian, inti pelayanan KB postpartum bukan sekadar “memberi pilihan”, tetapi mencocokkan pilihan dengan preferensi dan kelayakan medis ibu.

M. Jarak Kehamilan dan Perencanaan Reproduksi

1. Risiko kehamilan terlalu dekat

Kehamilan yang terlalu dekat setelah persalinan meningkatkan risiko luaran maternal dan perinatal yang kurang baik. ACOG dalam *Interpregnancy Care* menyatakan bahwa perempuan sebaiknya menghindari interval antarkehamilan yang lebih pendek dari 6 bulan, dan perlu dikonseling mengenai risiko interval yang lebih pendek dari 18 bulan. NICE quality statement tentang kontrasepsi

setelah persalinan juga menyebut bahwa pemberian informasi kontrasepsi membantu menghindari komplikasi yang berkaitan dengan interval antarkehamilan kurang dari 12 bulan. Karena itu, pembahasan jarak kehamilan harus menjadi bagian rutin dari pelayanan reproduksi postpartum.

2. Edukasi spacing pregnancy

Edukasi *spacing pregnancy* perlu menekankan bahwa penjarangan kehamilan bukan hanya urusan kontrasepsi, tetapi strategi kesehatan ibu dan bayi. WHO menyatakan bahwa keluarga berencana memungkinkan orang menentukan jarak kehamilan mereka, sementara ACOG menempatkan *reproductive life planning* sebagai bagian awal dari *interpregnancy care*. Edukasi ini sebaiknya dimulai sejak masa rawat postpartum, karena kebutuhan kontrasepsi dan rencana reproduksi sudah relevan bahkan sebelum ibu mengalami menstruasi kembali.

3. Perencanaan kehamilan berikutnya

Perencanaan kehamilan berikutnya perlu dibahas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang proaktif. ACOG menjelaskan bahwa *interpregnancy care* mencakup pengelolaan penyakit kronis, skrining depresi, vaksinasi, perencanaan reproduksi, dan persiapan kesehatan jangka panjang sebelum kehamilan berikutnya. Ini berarti pelayanan postpartum harus membantu ibu bukan hanya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga mempersiapkan kehamilan berikutnya agar terjadi pada waktu yang diinginkan dan dalam kondisi kesehatan yang optimal.

Pelayanan kesehatan reproduksi pascapersalinan mencakup konseling yang berpusat pada ibu, pembahasan kesehatan seksual, keluarga berencana pascapersalinan, serta penjarangan kehamilan dan perencanaan reproduksi jangka panjang. Pelayanan ini harus berbasis hak, berbasis bukti, dan terintegrasi dengan asuhan postpartum secara keseluruhan. Bila dilaksanakan dengan baik, pelayanan reproduksi postpartum dapat membantu ibu pulih dengan aman, membuat keputusan kontrasepsi secara sadar, mencegah kehamilan berjarak dekat, dan menyiapkan kehamilan berikutnya dalam kondisi kesehatan yang lebih optimal (WHO, 2022; ACOG, 2018; Whiteman et al., 2024).

N. TINDAK LANJUT DAN SISTEM RUJUKAN

Tindak lanjut dan sistem rujukan merupakan bagian penting dari perencanaan pulang ibu postpartum dan bayi baru lahir karena keselamatan ibu-bayi tidak berhenti saat meninggalkan fasilitas kesehatan. WHO menegaskan bahwa perawatan postnatal harus dipandang sebagai bagian dari *continuum of care* yang menghubungkan fasilitas kesehatan, rumah, dan layanan komunitas, dengan tujuan

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayi selama masa postnatal. ACOG juga menekankan bahwa pelayanan postpartum harus menjadi proses yang berkelanjutan, bukan satu kunjungan tunggal, sehingga setiap ibu memerlukan rencana kontak, evaluasi, dan tindak lanjut yang jelas sejak sebelum pulang (World Health Organization [WHO], 2022; American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2018).

Dalam konteks discharge planning, tindak lanjut tidak hanya berarti jadwal kontrol, tetapi juga mencakup kesiapan keluarga mengakses layanan, tersedianya jalur komunikasi bila muncul tanda bahaya, kejelasan kapan harus dirujuk, dan bentuk pemantauan setelah pulang, termasuk kunjungan rumah atau telekonsultasi bila sesuai. NICE menempatkan organisasi dan penyampaian layanan postnatal sebagai bagian inti dari asuhan, sedangkan AAP menegaskan bahwa pemulangan bayi sehat hanya aman bila ada tindak lanjut yang tepat waktu dan *medical home* atau layanan lanjutan yang jelas (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2021; Benitz, 2015).

1. Jadwal Kunjungan Ulang

a. Kunjungan nifas

Kunjungan nifas harus dipandang sebagai rangkaian evaluasi berkelanjutan, bukan sekadar “kontrol 6 minggu.” ACOG merekomendasikan agar semua perempuan memiliki kontak dengan tenaga kesehatan dalam 3 minggu pertama postpartum, diikuti perawatan berkelanjutan sesuai kebutuhan, dan diakhiri dengan kunjungan komprehensif tidak lebih dari 12 minggu setelah melahirkan. WHO juga merekomendasikan sedikitnya tiga kontak postnatal tambahan dalam 6 minggu pertama setelah kelahiran, selain perawatan awal di fasilitas, dan menyatakan bahwa kontak tersebut dapat mencakup kunjungan rumah bila memungkinkan (ACOG, 2018; WHO, 2022).

Secara praktis, jadwal kunjungan nifas perlu diindividualisasi. Ibu dengan persalinan tanpa komplikasi tetap memerlukan evaluasi dini untuk menilai perdarahan, tekanan darah, luka, laktasi, kesehatan mental, dan adaptasi peran ibu, sedangkan ibu dengan kondisi khusus seperti hipertensi, infeksi, atau operasi sesar memerlukan evaluasi lebih cepat dan lebih sering. Prinsip ini sejalan dengan penekanan ACOG bahwa layanan postpartum harus disesuaikan dengan kebutuhan individual perempuan, bukan mengikuti satu jadwal seragam untuk semua pasien (ACOG, 2018).

b. Kunjungan neonatus

Bayi baru lahir juga memerlukan tindak lanjut dini setelah pulang. AAP menegaskan bahwa lama rawat ibu dan bayi sehat harus cukup untuk memastikan masalah sudah dikenali dan ibu cukup siap merawat dirinya serta

bayinya di rumah, dan bahwa keputusan pulang harus selalu disertai rencana tindak lanjut yang tepat waktu. Tindak lanjut neonatus penting terutama untuk menilai berat badan, menyusui, ikterus, suhu, dan adaptasi umum pada hari-hari awal setelah pulang (Benitz, 2015).

NICE juga menekankan bahwa perawatan postnatal mencakup identifikasi dan penanganan masalah umum maupun serius pada bayi selama 8 minggu pertama, sehingga kunjungan neonatus bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari pencegahan keterlambatan diagnosis gangguan menyusui, dehidrasi, ikterus, atau infeksi (NICE, 2021).

2. Evaluasi laktasi

Evaluasi laktasi perlu menjadi bagian eksplisit dari tindak lanjut karena banyak masalah menyusui justru muncul setelah ibu berada di rumah. WHO menempatkan konseling menyusui sebagai komponen inti asuhan postnatal, dan NICE menegaskan bahwa dukungan menyusui harus diberikan secara berkelanjutan pada masa postnatal. Karena itu, kunjungan ulang harus menilai perlekatan, nyeri puting, kecukupan ASI, pola eliminasi bayi, berat badan, dan keluhan payudara seperti bendungan atau mastitis (WHO, 2022; NICE, 2021).

3. Evaluasi KB

Evaluasi keluarga berencana pascapersalinan perlu dimasukkan dalam tindak lanjut karena keputusan kontrasepsi dapat berubah setelah ibu berada di rumah, setelah laktasi mulai stabil, atau setelah ibu dan pasangan mendiskusikan kembali rencana reproduksi. NICE quality standard menyebut bahwa perempuan yang melahirkan harus menerima informasi mengenai kontrasepsi sedini mungkin dan paling lambat dalam 7 hari setelah persalinan, karena kesuburan dapat kembali dengan cepat. Karena itu, kontrol postpartum juga menjadi kesempatan untuk menilai kembali pilihan metode, kepatuhan, efek samping, dan kebutuhan ganti metode (National Institute for Health and Care Excellence, 2016).

4. Akses Pelayanan Kesehatan

a. Transportasi

Akses transportasi memengaruhi kemampuan ibu dan bayi hadir pada jadwal kontrol maupun mencari pertolongan saat ada tanda bahaya. WHO menekankan bahwa pengalaman postnatal yang positif bergantung tidak hanya pada intervensi klinis, tetapi juga pada kemampuan perempuan dan keluarganya mengakses layanan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sebelum pulang, tenaga kesehatan perlu memastikan apakah keluarga memiliki sarana transportasi, siapa yang akan mendampingi, dan bagaimana rencana bila keadaan gawat darurat terjadi di luar jam kerja (WHO, 2022).

b. Pembiayaan

Pembiayaan atau jaminan kesehatan juga perlu dipastikan sebagai bagian dari perencanaan tindak lanjut. Hambatan biaya dapat menyebabkan ibu menunda kontrol, tidak membeli obat, tidak melakukan pemeriksaan laboratorium yang dianjurkan, atau datang terlambat saat kondisi memburuk. NICE menekankan bahwa penyelenggaraan perawatan postnatal harus responsif terhadap kebutuhan perempuan dan bayi, yang dalam praktiknya termasuk mempertimbangkan hambatan akses layanan (NICE, 2021).

c. Nomor kontak fasilitas kesehatan

Nomor kontak fasilitas kesehatan, bidan, dokter, konselor laktasi, atau unit gawat darurat perlu diberikan secara jelas sebelum pulang. CDC melalui kampanye *HEAR HER* menekankan bahwa perempuan postpartum harus segera mencari pertolongan bila mengalami tanda bahaya atau merasa ada sesuatu yang tidak normal. Agar anjuran ini dapat dijalankan, keluarga perlu mengetahui dengan tepat ke mana harus menghubungi dan ke mana harus datang saat membutuhkan bantuan (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2024).

d. Dukungan komunitas

Selain layanan formal, dukungan komunitas seperti kader, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, kelompok menyusui, atau layanan sosial lokal juga dapat memperkuat kesinambungan asuhan. WHO menekankan keterkaitan antara fasilitas, komunitas, dan rumah tangga dalam asuhan postnatal, sementara NHS England dalam toolkit postnatal menekankan pentingnya rencana perawatan yang dipersonalisasi dan terhubung dengan dukungan lokal yang relevan. Dengan demikian, discharge planning yang baik tidak hanya menyebut “kontrol ke rumah sakit,” tetapi juga memetakan sumber dukungan praktis yang paling dekat dengan ibu dan bayi (WHO, 2022; NHS England, 2026).

5. Rujukan pada Kondisi Risiko atau *Red Flags*

a. *Red flags* pada ibu

Rujukan atau evaluasi segera diperlukan bila ibu mengalami *red flags* postpartum. CDC mencantumkan tanda peringatan maternal mendesak seperti perdarahan berat, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, sesak napas, nyeri dada, kejang, demam, pembengkakan berat, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. ACOG juga menekankan bahwa minggu-minggu setelah persalinan adalah periode kritis bagi perempuan dan bahwa komplikasi serius dapat muncul setelah ibu pulang, sehingga sistem rujukan harus mampu

merespons keluhan secara cepat dan tidak menunggu jadwal kontrol rutin (CDC, 2024; ACOG, 2018).

Dari sudut pandang klinis, *red flags* pada ibu mencakup perdarahan postpartum sekunder, hipertensi/postpartum preeklampsia, infeksi, tromboemboli, komplikasi luka, dan gangguan kesehatan mental berat. Karena beberapa pasien dapat mencari pertolongan ke unit gawat darurat nonobstetri, ACOG menyoroti pentingnya pengenalan komplikasi obstetri di berbagai setting layanan darurat. Ini menunjukkan bahwa sistem rujukan postpartum harus jelas, cepat, dan lintas layanan, bukan hanya kembali ke unit bersalin tempat ibu melahirkan (ACOG, 2018).

b. *Red flags* pada bayi

Pada bayi baru lahir, *red flags* yang memerlukan rujukan segera meliputi tidak mau menyusu, napas cepat atau tarikan dinding dada, suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, letargi, kejang, serta ikterus yang berat atau progresif. WHO memasukkan tanda-tanda tersebut sebagai bahaya bayi baru lahir yang memerlukan pertolongan segera. AAP juga menegaskan bahwa tindak lanjut dini setelah pulang sangat penting karena keterlambatan evaluasi dapat menunda diagnosis ikterus, kegagalan menyusui, dan gangguan serius lain pada masa transisi neonatal (WHO, 2024; Benitz, 2015).

c. Mekanisme rujukan

Mekanisme rujukan harus dijelaskan sebelum pulang: kapan harus datang ke fasilitas primer, kapan harus ke IGD, siapa yang dihubungi lebih dulu, dan apa yang perlu dibawa. WHO menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan dan akses cepat ke layanan yang sesuai pada masa postnatal. Dalam praktik, mekanisme rujukan yang baik berarti keluarga tidak hanya “diberi tahu kontrol ulang,” tetapi diberi alur keputusan yang jelas bila muncul tanda bahaya di rumah (WHO, 2022).

d. Dokumentasi rujukan

Dokumentasi rujukan penting agar informasi tentang diagnosis, faktor risiko, terapi yang telah diberikan, dan alasan rujukan dapat diterima dengan lengkap oleh fasilitas tujuan. NICE quality standard menekankan pentingnya berbagi informasi yang relevan saat terjadi transisi layanan postnatal untuk menjaga kesinambungan asuhan. Dokumentasi juga memudahkan evaluasi mutu dan mengurangi risiko kehilangan informasi penting antara fasilitas dan tenaga kesehatan yang berbeda (National Institute for Health and Care Excellence, 2022; NICE, 2021).

6. Peran Kunjungan Rumah dan Telekonsultasi

a. Pemantauan pascapulang

WHO menyatakan bahwa setelah perawatan awal di fasilitas, ibu dan bayi sebaiknya menerima sedikitnya tiga kontak postnatal tambahan dalam 6 minggu pertama, dan kontak tersebut dapat mencakup kunjungan rumah bila memungkinkan untuk mendukung transisi ke perawatan di rumah. Ini menunjukkan bahwa kunjungan rumah bukan sekadar tambahan, tetapi bentuk layanan yang sejalan dengan rekomendasi WHO ketika sistem kesehatan mampu menyediakannya. Kunjungan rumah sangat bermanfaat untuk menilai kondisi nyata ibu-bayi di rumah, hambatan menyusui, kebersihan, dukungan keluarga, dan akses terhadap bantuan (WHO, 2022; PAHO, 2022).

b. Edukasi lanjutan

Kunjungan rumah memungkinkan penguatan edukasi secara kontekstual, misalnya cara menyusui dalam lingkungan rumah, perawatan luka, pengenalan tanda bahaya, dan strategi istirahat yang realistis sesuai kondisi keluarga. NICE menekankan bahwa informasi postnatal harus diberikan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan relevan dengan situasi mereka. Dalam hal ini, kunjungan rumah memberi kesempatan untuk menyesuaikan edukasi dengan kondisi riil yang mungkin tidak terlihat saat ibu masih di fasilitas (NICE, 2021).

c. Deteksi dini komplikasi

Kunjungan rumah dan kontak tindak lanjut dini juga mendukung deteksi dini komplikasi, terutama masalah menyusui, ikterus bayi, penurunan berat badan, perdarahan, hipertensi, dan gangguan kesehatan mental. Literatur kualitas pelayanan neonatal menunjukkan bahwa tindak lanjut yang tepat waktu setelah pulang penting untuk mencegah keterlambatan diagnosis masalah serius seperti jaundice dan *breastfeeding failure*. Karena banyak komplikasi muncul pada beberapa hari pertama setelah discharge, sistem yang menyediakan pemantauan dini, termasuk home visit, dapat meningkatkan keselamatan pasien (Benitz, 2015).

d. Telekonsultasi

Telekonsultasi dapat menjadi pelengkap penting dalam tindak lanjut postpartum, terutama untuk *check-in* awal, dukungan laktasi, skrining depresi, evaluasi gejala ringan, dan triase kebutuhan kunjungan langsung. ACOG menyatakan dukungannya terhadap model telehealth untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan obstetri dan ginekologi, selama prinsip etik dan keselamatan tetap dijaga. HHS juga menyebut bahwa layanan postpartum

melalui telehealth dapat mencakup pemantauan umum setelah melahirkan, dukungan menyusui, skrining dan terapi depresi postpartum, serta rujukan ke spesialis bila perlu. Namun, telekonsultasi tidak menggantikan semua kunjungan tatap muka; kasus dengan gejala serius, pemeriksaan fisik yang diperlukan, atau komplikasi akut tetap memerlukan evaluasi langsung (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2025; U.S. Department of Health and Human Services, 2025).

O. DOKUMENTASI DAN ASPEK LEGAL ETIK

Dokumentasi dan aspek legal-etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pulang ibu postpartum dan bayi baru lahir. Dokumentasi yang baik memastikan kesinambungan asuhan, memudahkan komunikasi antarpetugas, dan menjadi bukti bahwa penilaian, edukasi, keputusan klinis, serta rencana tindak lanjut telah dilakukan secara benar. Pada saat yang sama, aspek legal-etik memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan menghormati hak ibu, keselamatan pasien, prinsip profesional, dan standar praktik yang berlaku. WHO menegaskan bahwa asuhan postnatal yang berkualitas harus bersifat person-centred dan berbasis hak, sedangkan NICE menempatkan organisasi layanan, pemberian informasi, dan berbagi informasi saat transisi layanan sebagai bagian penting dari mutu perawatan postnatal (World Health Organization [WHO], 2022; National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2021).

Dalam konteks perencanaan pulang, dokumentasi dan prinsip legal-etik tidak hanya berfungsi administratif. Keduanya menentukan apakah ibu benar-benar telah memperoleh informasi yang cukup, apakah keputusan kontrasepsi dibuat secara sukarela, apakah tanda bahaya telah dijelaskan, dan apakah tindak lanjut serta rujukan sudah direncanakan dengan aman. ACOG menekankan bahwa perawatan postpartum harus menjadi proses berkelanjutan, sehingga dokumentasi dan koordinasi informasi sangat penting agar tidak terjadi putus layanan setelah ibu pulang.

1. Prinsip Dokumentasi Perencanaan Pulang

a. Kelengkapan

Dokumentasi perencanaan pulang harus lengkap, mencakup hasil pengkajian ibu dan bayi, edukasi yang telah diberikan, respons ibu atau keluarga terhadap edukasi, keputusan yang diambil, rencana tindak lanjut, serta indikasi rujukan bila ada. NICE quality standard menekankan bahwa saat perawatan berpindah antarlayanan pada periode postnatal, informasi yang relevan harus dibagikan untuk mendukung asuhan lanjutan. Ini berarti dokumentasi tidak cukup hanya menulis “edukasi diberikan,” tetapi perlu

menjelaskan apa yang dijelaskan, kepada siapa, bagaimana respons pasien, dan apa rencana berikutnya.

Kelengkapan sangat penting karena ibu postpartum dan bayi sering berpindah dari layanan rumah sakit ke layanan primer atau komunitas dalam waktu singkat. Bila informasi tentang hipertensi, ikterus, masalah menyusui, atau kondisi psikologis tidak terdokumentasi dengan baik, maka tenaga kesehatan berikutnya dapat kehilangan konteks penting yang berpengaruh pada keselamatan pasien. WHO juga menekankan pentingnya kesinambungan asuhan antara fasilitas, komunitas, dan rumah tangga, yang secara praktis membutuhkan dokumentasi yang komprehensif.

b. Kejelasan

Dokumentasi harus ditulis dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan dapat dipahami oleh tenaga kesehatan lain. Kejelasan penting agar tidak terjadi ambiguitas pada instruksi pulang, penggunaan obat, tanda bahaya yang harus dipantau, atau jadwal kontrol. NMC Code menegaskan bahwa perawat dan bidan harus membuat dan memelihara catatan yang jelas dan akurat, karena catatan tersebut diperlukan untuk praktik yang aman dan efektif. Standar profesional ini sangat relevan untuk perencanaan pulang, sebab keputusan dan instruksi yang tidak jelas dapat menimbulkan kesalahan tindak lanjut setelah pasien pulang.

Dalam konteks edukasi postpartum, kejelasan juga berkaitan dengan cara dokumentasi mencerminkan isi konseling. Misalnya, bila ibu telah diberi tahu tentang tanda bahaya hipertensi postpartum atau jaundice pada bayi, hal itu perlu ditulis secara spesifik, bukan sekadar dicatat sebagai “penyuluhan dilakukan.” Dokumentasi yang jelas memudahkan audit, komunikasi tim, dan penelusuran klinis bila di kemudian hari muncul pertanyaan tentang pelayanan yang telah diberikan.

c. Keakuratan

Keakuratan berarti isi dokumentasi harus sesuai dengan kondisi klinis, waktu kejadian, intervensi yang benar-benar dilakukan, dan keputusan yang benar-benar diambil oleh ibu atau keluarga. NMC Code menekankan bahwa catatan harus akurat dan tidak menyesatkan, sementara prinsip informed consent menurut ACOG menuntut bahwa informasi yang diberikan kepada pasien harus memuat fakta klinis yang relevan, manfaat, risiko, alternatif, dan konsekuensi bila menolak tindakan. Bila dokumentasi tidak akurat, maka ia bukan hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga dapat melanggar hak pasien dan membahayakan kesinambungan asuhan.

Dalam discharge planning, keakuratan sangat penting untuk hal-hal seperti tekanan darah terakhir, status luka, pola menyusui, hasil skrining, metode kontrasepsi yang dipilih, atau alasan rujukan. Kesalahan kecil pada detail ini dapat menyebabkan keputusan klinis yang salah di layanan berikutnya. Karena itu, dokumentasi harus dibuat segera, berdasarkan pengkajian langsung, dan diverifikasi bila ada informasi yang belum pasti.

d. Kontinuitas informasi

Dokumentasi perencanaan pulang harus mendukung kontinuitas informasi, yaitu kemampuan informasi penting mengalir bersama pasien dari satu layanan ke layanan lain. NICE quality standard menyatakan bahwa penyedia layanan harus memiliki proses yang jelas untuk berbagi informasi ketika perawatan wanita berpindah antar layanan pada periode postnatal. ACOG juga menyatakan bahwa selama periode postpartum, penyedia layanan obstetri dan perempuan harus mengidentifikasi siapa penyedia layanan yang akan mengambil tanggung jawab utama atas perawatan lanjutannya. Kedua prinsip ini menegaskan bahwa dokumentasi discharge planning harus ditujukan untuk penggunaan lintas layanan, bukan hanya arsip internal fasilitas.

Kontinuitas informasi sangat penting pada ibu dengan kondisi khusus, misalnya hipertensi postpartum, diabetes, infeksi luka, depresi postpartum, atau bayi dengan risiko ikterus dan masalah menyusui. Tanpa transfer informasi yang baik, pasien berisiko mengalami keterlambatan evaluasi atau menerima anjuran yang saling bertentangan. WHO memandang kesinambungan layanan sebagai fondasi pengalaman postnatal yang positif, sehingga dokumentasi harus mendukung kesinambungan klinis, edukatif, dan rujukan.

2. Aspek Legal dalam Edukasi dan Konseling

a. Informed choice

Informed choice berarti ibu membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup, seimbang, dan relevan dengan kebutuhannya. Dalam pelayanan postpartum, prinsip ini sangat penting terutama pada topik kontrasepsi, menyusui, tindak lanjut, dan rujukan. ACOG menegaskan bahwa konseling kontrasepsi harus berpusat pada pasien dan mendukung *shared decision making*, sehingga pilihan pasien benar-benar selaras dengan tujuan reproduksi dan preferensinya. WHO juga menekankan pendekatan berbasis hak dalam pengalaman postnatal, yang berarti perempuan berhak menerima informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang sesuai dengan dirinya.

Secara legal dan etik, *informed choice* menuntut tenaga kesehatan untuk tidak mengarahkan pasien secara manipulatif, tidak menyembunyikan

informasi penting, dan tidak memaksakan keputusan karena preferensi penyedia layanan. Dalam dokumentasi, hal ini harus tampak dari adanya catatan bahwa ibu telah menerima penjelasan mengenai pilihan yang tersedia, kelebihan dan kekurangan tiap opsi, serta keputusan akhirnya.

b. Informed consent

Informed consent adalah penerapan praktis dari penghormatan terhadap otonomi pasien dan hak hukum atas integritas tubuh. ACOG menjelaskan bahwa informed consent bukan sekadar tanda tangan pada formulir, melainkan proses komunikasi yang memungkinkan pasien memahami diagnosis, sifat tindakan yang diusulkan, risiko dan manfaat, alternatif, serta konsekuensi bila tindakan ditolak. Dalam konteks postpartum, informed consent relevan pada tindakan seperti pemasangan kontrasepsi, perawatan luka tertentu, rujukan, atau intervensi lain yang memerlukan persetujuan sadar.

NICE juga menegaskan bahwa penggunaan panduan klinis selalu berkaitan dengan hukum dan standar profesional tentang consent dan mental capacity. Artinya, tenaga kesehatan harus memastikan ibu memiliki kapasitas untuk memahami informasi, bebas dari paksaan, dan cukup waktu untuk bertanya sebelum memberi persetujuan. Dokumentasi informed consent harus menunjukkan bahwa proses komunikasi telah terjadi, bukan hanya bahwa formulir telah ditandatangani.

c. Hak ibu dalam pengambilan keputusan

Hak ibu dalam pengambilan keputusan merupakan inti dari perawatan maternal yang bermartabat. ACOG menegaskan bahwa penghormatan terhadap otonomi pasien adalah prinsip dasar etika obstetri dan ginekologi, dan keputusan pasien harus dihormati bahkan ketika pasien menolak rekomendasi medis tertentu, selama ia memiliki kapasitas mengambil keputusan. WHO juga menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perawatan maternal dan newborn yang menghormati pilihan dan martabat perempuan.

Dalam praktik postpartum, hak ini berarti ibu berhak menerima penjelasan yang jujur, berhak setuju atau menolak kontrasepsi, berhak meminta pendampingan pasangan atau keluarga bila ia menghendaki, dan berhak atas privasi serta kerahasiaan. Hak tersebut harus tampak dalam cara tenaga kesehatan berkomunikasi, mendokumentasikan, dan merencanakan tindak lanjut.

3. Aspek Etik Pelayanan Reproduksi Postpartum

a. Otonomi

Prinsip otonomi menuntut penghormatan terhadap kemampuan ibu membuat keputusan tentang tubuh dan kesehatannya sendiri. ACOG menyebut informed consent sebagai aplikasi nyata dari penghormatan terhadap self-determination pasien. Dalam pelayanan reproduksi postpartum, otonomi tampak saat ibu diberi pilihan kontrasepsi secara adil, diperbolehkan bertanya, dan keputusannya dihormati meski tidak selalu sama dengan preferensi petugas.

Otonomi juga penting ketika ibu menolak suatu intervensi. ACOG menegaskan bahwa pendekatan etik yang sesuai dalam obstetri adalah yang mengakui kewenangan keputusan perempuan dan komitmen pada informed consent maupun informed refusal. Karena itu, discharge planning harus menghormati keputusan ibu sekaligus tetap memastikan bahwa ia memahami konsekuensi klinis dari pilihannya.

b. Beneficence

Beneficence berarti tenaga kesehatan bertindak untuk kebaikan pasien. Dalam konteks postpartum, prinsip ini menuntut penyedia layanan memberi edukasi yang bermanfaat, mengantisipasi risiko, menyiapkan tindak lanjut, dan merujuk bila ada tanda bahaya. ACOG dalam pembahasan etika obstetri menyebut beneficence sebagai salah satu prinsip awal penting dalam pengambilan keputusan etik. Pada discharge planning, prinsip ini tercermin dalam upaya memastikan ibu dan bayi benar-benar siap pulang, bukan dipulangkan hanya karena alasan administratif.

c. Non-maleficence

Non-maleficence berarti menghindari tindakan yang dapat mencelakai pasien. Pada pelayanan postpartum, prinsip ini berarti tidak memberikan informasi yang salah, tidak menunda rujukan saat ada *red flags*, tidak memaksakan metode kontrasepsi yang tidak sesuai, dan tidak mengabaikan gejala serius karena dianggap "normal setelah melahirkan." WHO dan NICE menekankan pentingnya pengenalan dini masalah serius pada ibu dan bayi, sehingga kelalaian dalam dokumentasi, edukasi, atau rujukan dapat menjadi bentuk kegagalan memenuhi prinsip ini.

d. Justice

Justice atau keadilan berarti setiap ibu berhak memperoleh informasi, pilihan, dan akses layanan yang adil tanpa diskriminasi. WHO dalam pendekatan berbasis hak dan respectful maternal-newborn care menekankan pentingnya pelayanan yang bermartabat dan bebas dari mistreatment. Dalam

pelayanan reproduksi postpartum, keadilan berarti semua perempuan, termasuk yang muda, miskin, memiliki disabilitas, atau berasal dari latar budaya tertentu, tetap berhak memperoleh konseling kontrasepsi, tindak lanjut, dan rujukan yang setara.

e. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah prinsip penting karena informasi tentang kondisi kesehatan reproduksi, kesehatan mental, pilihan kontrasepsi, dan situasi sosial ibu bersifat sensitif. NMC Code menuntut profesional menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pasien, kecuali bila ada dasar profesional atau hukum yang jelas untuk membagikannya. Dalam discharge planning, kerahasiaan berarti informasi hanya dibagikan kepada pihak yang memang perlu mengetahuinya untuk kesinambungan asuhan, dan pembicaraan sensitif dilakukan dengan menghormati privasi ibu.

Dokumentasi dan aspek legal-etik merupakan fondasi penting dalam perencanaan pulang ibu postpartum dan bayi baru lahir. Dokumentasi harus lengkap, jelas, akurat, dan mendukung kontinuitas informasi. Sementara itu, aspek legal-etik menuntut penghormatan terhadap informed choice, informed consent, hak ibu dalam pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, justice, dan kerahasiaan. Bila prinsip-prinsip ini dijalankan dengan baik, perencanaan pulang tidak hanya aman secara klinis, tetapi juga sah secara profesional, etis, dan menghormati martabat perempuan.

P. PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PERENCANAAN PULANG

Perencanaan pulang pada ibu postpartum dan bayi baru lahir tidak dapat dilakukan oleh satu profesi saja. Masa postnatal adalah periode kritis yang menuntut penilaian klinis, edukasi, dukungan menyusui, pemantauan psikososial, serta pengaturan tindak lanjut dan rujukan secara terkoordinasi. WHO menegaskan bahwa layanan postnatal yang berkualitas memerlukan tenaga kesehatan yang termotivasi, sistem yang fleksibel, dan kesinambungan dukungan bagi perempuan, bayi baru lahir, pasangan, orang tua, serta keluarga. ACOG juga menyatakan bahwa optimalisasi perawatan postpartum membutuhkan perubahan sistem dan koordinasi lintas penyedia layanan agar postpartum care berjalan sebagai proses berkelanjutan, bukan kunjungan tunggal (World Health Organization [WHO], 2022; American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2018).

Dalam konteks ini, tenaga kesehatan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Bidan, perawat, dan dokter berperan pada area yang berbeda tetapi terhubung, sementara keluarga menjadi *caregiver* utama yang menjalankan sebagian besar

perawatan setelah pasien pulang. NICE juga menunjukkan bahwa perawatan postnatal melibatkan transfer ke layanan komunitas, kunjungan bidan, kunjungan *health visitor*, serta berbagi informasi antarprofesional untuk mendukung asuhan lanjutan (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2021).

1. Peran Dokter

Dokter, khususnya dokter obstetri-ginekologi, dokter anak/neonatalog, dan dokter layanan primer, berperan penting dalam memastikan keamanan klinis ibu dan bayi sebelum pulang serta menentukan kebutuhan tindak lanjut medis. ACOG menekankan bahwa selama periode postpartum, perempuan dan obstetrician-gynecologist atau *other obstetric care provider* harus mengidentifikasi penyedia layanan yang akan mengambil tanggung jawab utama untuk perawatan berkelanjutan di *primary medical home*. Ini menunjukkan bahwa dokter tidak hanya berperan dalam penilaian medis saat rawat, tetapi juga dalam penjaminan transisi ke layanan berikutnya (ACOG, 2018).

Pada ibu postpartum, dokter berperan dalam menilai komplikasi atau kondisi khusus seperti hipertensi, diabetes, infeksi, anemia berat, komplikasi luka, kebutuhan obat, dan indikasi rujukan. Pada bayi, dokter berperan dalam memastikan stabilitas klinis, menilai masalah neonatal yang memerlukan observasi atau tata laksana lanjutan, serta menentukan aman tidaknya pemulangan. AAP menegaskan bahwa keputusan pulang pada bayi cukup bulan yang sehat harus mempertimbangkan kestabilan klinis bayi, kesiapan keluarga, dan adanya tindak lanjut yang tepat waktu. Ini memperlihatkan peran dokter dalam keputusan klinis akhir sekaligus dalam merancang *follow-up care* (Benitz, 2015).

2. Peran Perawat

Perawat berperan penting dalam perencanaan pulang karena mereka berada di garis depan pengawasan harian, edukasi, dan persiapan keluarga sebelum pasien meninggalkan fasilitas. Literatur keperawatan maternitas menegaskan bahwa perencanaan pulang dimulai sejak interaksi pertama antara perawat, perempuan, dan keluarganya, lalu berlanjut sampai mereka meninggalkan rumah sakit atau fasilitas bersalin. Dalam konteks postpartum, perawat membantu menyiapkan orang tua untuk kembali ke rumah melalui pendidikan, observasi, dan penguatan keterampilan dasar merawat diri serta bayi.

Ulasan *scoping review* tentang edukasi pulang postpartum yang diberikan perawat menunjukkan bahwa peran perawat sangat penting dalam mempersiapkan perempuan mengenali tanda bahaya komplikasi, melakukan perawatan diri fisik dan emosional, mempersiapkan pengasuhan bayi baru lahir, dan membangun pemberian makan bayi yang efektif. Artinya, perawat bukan

hanya “mengulang instruksi dokter”, tetapi berperan aktif dalam mengubah informasi klinis menjadi kemampuan praktis yang bisa dijalankan pasien di rumah (Bingham et al., 2022).

AWHONN juga menempatkan perawat postpartum dan mother-baby nurses sebagai profesi kunci dalam perawatan berbasis bukti bagi perempuan, bayi baru lahir, dan keluarganya. Sumber AWHONN menegaskan bahwa panduan postpartum untuk perawat mencakup penilaian risiko, edukasi pulang, deteksi tanda bahaya, dan koneksi ke *follow-up care*. Ini sejalan dengan praktik discharge planning, di mana perawat sering memastikan bahwa obat telah dijelaskan, tanda bahaya telah dipahami, dukungan di rumah telah dipetakan, dan keluarga tahu kapan harus menghubungi penyedia layanan (AWHONN, 2020; CPCQC, 2025).

Perawat juga memiliki peran penting dalam pemantauan psikososial. Karena frekuensi kontak mereka tinggi, perawat sering menjadi orang pertama yang melihat tanda kelelahan berat, kesulitan menyusui, kecemasan, atau ketidaksiapan ibu merawat bayinya. Oleh karena itu, perawat berperan sebagai penghubung antara temuan di lapangan dengan kebutuhan konsultasi lebih lanjut, misalnya ke bidan, dokter, konselor laktasi, atau layanan kesehatan mental (Bingham et al., 2022; WHO, 2022).

3. Peran Bidan

Bidan memiliki peran sentral dalam perencanaan pulang karena profesi ini berada sangat dekat dengan ibu dan bayi selama masa transisi postnatal. WHO merekomendasikan model *midwifery continuity of care* sebagai salah satu strategi pelayanan karena mampu meningkatkan kesinambungan hubungan, pengalaman perawatan, dan kualitas asuhan maternal-neonatal. Hal ini menunjukkan bahwa bidan bukan hanya pelaksana tindakan klinis, tetapi juga koordinator dukungan berkelanjutan pada masa nifas (WHO, 2022).

Secara praktis, peran bidan dalam discharge planning mencakup pengkajian kondisi ibu dan bayi, penilaian laktasi, edukasi perawatan diri di rumah, penjelasan tanda bahaya, dan penetapan kebutuhan tindak lanjut. NICE menempatkan kunjungan bidan pertama setelah transfer perawatan sebagai komponen penting layanan postnatal, yang menunjukkan bahwa bidan berperan besar dalam menjembatani transisi dari tempat lahir ke rumah atau komunitas (NICE, 2021).

ICM Essential Competencies for Midwifery Practice 2024 menegaskan bahwa kompetensi bidan mencakup pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan asuhan berkelanjutan bagi perempuan dan bayi baru lahir, termasuk promosi kesehatan, pendidikan kesehatan reproduksi, dukungan menyusui, deteksi komplikasi, dan pengaturan rujukan bila diperlukan. Dengan dasar ini,

bidan pada masa postpartum berperan bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengambil keputusan awal terhadap keamanan pemulangan dan kesiapan ibu-bayi di rumah (International Confederation of Midwives [ICM], 2024).

Selain itu, bidan juga berperan dalam pendekatan yang berpusat pada ibu dan keluarga. WHO mendefinisikan pengalaman postnatal yang positif sebagai pengalaman ketika perempuan, bayi, pasangan, orang tua, pengasuh, dan keluarga menerima informasi, reassurance, dan dukungan secara konsisten dari tenaga kesehatan. Karena bidan sering menjadi tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan ibu postpartum, mereka memegang peran besar dalam membangun kepercayaan, mengidentifikasi hambatan sosial, dan memastikan keluarga memahami perannya dalam pemulihan ibu dan perawatan bayi (WHO, 2022).

Dalam konteks kesehatan reproduksi postpartum, dokter juga berperan dalam konseling kontrasepsi berbasis kondisi medis, pemilihan metode pada ibu dengan komorbid, dan penanganan masalah kesehatan seksual atau reproduksi yang lebih kompleks. ACOG menyebut bahwa postpartum care komprehensif harus mencakup mood, seksualitas, kontrasepsi, dan perencanaan kehamilan berikutnya, sehingga dokter berperan dalam mengintegrasikan temuan klinis dengan perencanaan reproduksi jangka panjang (ACOG, 2018).

4. Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional adalah inti dari perencanaan pulang yang aman. WHO menekankan bahwa kualitas asuhan postnatal tidak hanya bergantung pada intervensi tunggal, tetapi juga pada bagaimana sistem kesehatan mengorganisasi tenaga kesehatan dan kesinambungan pelayanan. NICE secara spesifik menyebut bahwa profesional seperti obstetricians, midwives, health visitors, psychiatrists, dan GPs harus berbagi informasi relevan saat transfer perawatan agar asuhan berlanjut tanpa hambatan (WHO, 2022; NICE, 2022).

Kolaborasi interprofesional berarti setiap profesi menyumbang kompetensinya masing-masing, tetapi tetap bekerja pada tujuan yang sama. Bidan dapat menilai kesiapan ibu dan laktasi, perawat memperkuat edukasi dan observasi harian, dokter menangani masalah klinis dan keputusan medis, sementara tenaga layanan primer dan komunitas melanjutkan pemantauan setelah pasien pulang. NICE juga menunjukkan adanya transisi dari midwifery care ke *community care* dan *health visitor* visits, yang menegaskan bahwa kesinambungan postpartum memang menuntut kerja lintas profesi dan lintas tingkat layanan (NICE, 2021).

Kolaborasi ini sangat penting pada kasus dengan risiko tinggi, misalnya ibu dengan hipertensi, depresi postpartum, masalah menyusui, atau bayi dengan risiko ikterus dan gangguan menyusui. Bila tidak ada koordinasi, informasi dapat terputus dan keluarga menerima pesan yang tidak konsisten. Karena itu, dokumentasi yang baik, komunikasi antarprofesi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas adalah syarat utama discharge planning yang efektif (ACOG, 2018; NICE, 2022).

5. Peran Keluarga sebagai *Caregiver* Utama

Setelah pasien pulang, keluarga menjadi *caregiver* utama yang menjalankan sebagian besar perawatan ibu dan bayi di rumah. WHO menyebut bahwa pengalaman postnatal yang positif adalah pengalaman ketika perempuan, bayi, pasangan, orang tua, pengasuh, dan keluarga menerima dukungan dan *reassurance* secara konsisten, sementara sistem kesehatan menghormati konteks budaya dan kebutuhan mereka. Ini menegaskan bahwa keluarga bukan hanya "pendamping," tetapi bagian aktif dari sistem perawatan postpartum (WHO, 2022).

Peran keluarga mencakup membantu ibu beristirahat, mendukung menyusui, membantu perawatan bayi, mengamati tanda bahaya, menyiapkan transportasi ke kontrol atau rujukan, serta mendukung keputusan reproduksi dan kesehatan mental ibu. NICE juga menekankan bahwa perawatan postnatal bertujuan membantu orang tua membangun ikatan yang kuat dengan bayinya dan mendukung pemberian makan bayi. Dengan demikian, keluarga perlu dilibatkan dalam edukasi pulang agar memahami apa yang harus dilakukan di rumah dan kapan harus mencari pertolongan (NICE, 2021).

Keluarga juga berperan sebagai penguat kepatuhan tindak lanjut. Banyak keputusan pascapulang, seperti menghadiri kunjungan ulang, mematuhi obat, atau mencari pertolongan saat ada gejala bahaya, sangat dipengaruhi oleh dukungan praktis dan emosional keluarga. Oleh karena itu, discharge planning yang efektif harus mengidentifikasi siapa *caregiver* utama, apakah keluarga memahami instruksi, dan apakah ada hambatan sosial yang dapat mengganggu perawatan di rumah (WHO, 2022; CMS, 2023).

Perencanaan pulang postpartum membutuhkan kontribusi yang saling melengkapi dari bidan, perawat, dokter, tim lintas profesi, dan keluarga sebagai *caregiver* utama. Bidan berperan kuat pada kesinambungan asuhan dan edukasi ibu-bayi, perawat pada observasi harian dan penguatan keterampilan praktis, dokter pada penilaian medis dan pengelolaan kondisi khusus, sementara kolaborasi interprofesional memastikan informasi dan tanggung jawab tidak terputus saat pasien berpindah layanan. Keluarga menjadi penopang utama

keberlanjutan perawatan di rumah. Dengan pembagian peran yang jelas dan komunikasi yang baik, discharge planning dapat menjadi proses transisi yang aman, efektif, dan berpusat pada ibu serta keluarga (WHO, 2022; ACOG, 2018; NICE, 2021).

Aktivitas 1 : Knows How

Mini-case tertulis

Seorang ibu usia 27 tahun, hari ke-2 pascapersalinan pervaginam, direncanakan pulang hari ini. Ibu mengeluh nyeri perineum ringan. ASI sudah keluar, tetapi bayi masih sering melepas puting saat menyusui. Lochia rubra dalam batas normal, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,8°C, uterus teraba baik, dan ibu dapat berjalan ke kamar mandi. Ibu mengatakan masih bingung mengenai perawatan luka jahitan, kapan boleh berhubungan seksual, metode KB yang aman saat menyusui, dan kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan. Suami bekerja di luar kota, sementara ibu akan tinggal bersama orang tuanya selama dua minggu pertama.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi data yang menunjukkan bahwa ibu secara klinis relatif stabil untuk dipersiapkan pulang.
2. Tentukan kebutuhan edukasi prioritas yang harus diberikan sebelum ibu pulang.
3. Jelaskan masalah kesehatan reproduksi pascapersalinan yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut.
4. Usulkan rencana konseling KB pascapersalinan yang sesuai dengan kondisi ibu menyusui.
5. Sebutkan tanda bahaya masa nifas yang wajib dipahami ibu dan keluarga sebelum pulang.
6. Jelaskan bentuk tindak lanjut yang perlu direncanakan perawat setelah kepulangan ibu.

Aktivitas 2 : Shows How

Simulasi/skill lab edukasi perencanaan pulang dan konseling kesehatan reproduksi pascapersalinan

1. Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan pasien + verifikasi pemahaman keluarga.
2. Mahasiswa tidak langsung "diuji", tetapi dinaikkan bertahap menuju unjuk kerja kompeten.
3. Karena CP bab berfokus pada kemampuan mendemonstrasikan edukasi dan pengambilan keputusan klinik awal, maka OSCE menjadi metode yang logis.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check, analisis mini-case, dan diskusi kelompok
Shows How	OSCE perencanaan pulang dan konseling kesehatan reproduksi pasca persalinan
Does	DOPS di lahan praktik pada ibu nifas yang benar-benar akan pulang atau kontrol masa nifas

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene dan pencegahan infeksi
2. Identifikasi ibu, privasi, dan persetujuan tindakan edukasi
3. Pengkajian kesiapan pulang dan kebutuhan belajar prioritas
4. Penyampaian tanda bahaya nifas dan red flags reproduksi pascapersalinan
5. Eskalasi bila ditemukan perdarahan abnormal, demam, tanda infeksi, gangguan mental, atau komplikasi lain

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan: nilai tinggi tidak menutup kegagalan pada komponen keselamatan pasien.

SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Perencanaan Pulang dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pasca Persalinan
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus kesiapan pulang, menyusun diagnosis dan rencana keperawatan, serta memberikan edukasi perencanaan pulang dan konseling kesehatan reproduksi pasca persalinan secara aman dan sistematis.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosis dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Nifas 2. Kesehatan reproduksi 3. Edukasi keluarga 4. Keselamatan pasien 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang ibu usia 29 tahun, hari ke-2 pasca seksio sesarea, akan dipulangkan siang ini. Ibu tampak stabil, tanda vital dalam batas normal, nyeri luka operasi skala 3/10, lochia rubra sedikit, menyusui mulai lancar, dan bayi rooming-in. Ibu mengatakan masih takut bergerak terlalu banyak, belum memahami perawatan luka, bingung kapan kontrol, serta ingin mengetahui metode KB yang aman saat

No.	Komponen	Isi
		menyusui. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus kesiapan pulang berdasarkan skenario tersebut pada klien standar. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan dan prioritas edukasi pada lembar jawaban. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban. 4. Lakukan edukasi perencanaan pulang dan konseling kesehatan reproduksi pascapersalinan kepada ibu.
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan: perdarahan, nyeri, eliminasi, ambulasi, luka operasi, laktasi, dukungan keluarga, akses kontrol, dan kebutuhan kontrasepsi. 2. Menilai kemampuan peserta menegakkan masalah/diagnosis keperawatan prioritas, misalnya kesiapan peningkatan manajemen kesehatan atau defisit pengetahuan terkait perawatan nifas dan kesehatan reproduksi pascapersalinan. 3. Menilai kemampuan peserta menyusun intervensi yang sesuai: edukasi tanda bahaya, perawatan luka, mobilisasi, nutrisi, menyusui, aktivitas seksual, KB pascapersalinan, dan jadwal kontrol. 4. Menilai ketepatan komunikasi terapeutik dan teknik teach-back. 5. Memonitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang telah ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	1. Identitas pasien sesuai kasus: ibu usia 29 tahun, hari ke-2 pasca seksio sesarea.

No.	Komponen	Isi
		2. Keluhan utama: masih takut bergerak, nyeri luka ringan, bingung perawatan luka dan KB. 3. Riwayat obstetri: persalinan anak pertama, bayi lahir sehat. 4. Bila ditanya perdarahan: ganti pembalut 3 kali/hari, tidak ada gumpalan besar. 5. Bila ditanya BAK/BAB: BAK lancar, belum BAB sejak kemarin. 6. Bila ditanya dukungan keluarga: suami menemani, ibu mertua akan membantu di rumah. 7. Bila ditanya tentang kontrasepsi: ibu ingin menunda kehamilan 3–4 tahun dan tetap menyusui eksklusif. 8. Klien standar tampak kooperatif tetapi sedikit cemas.
10	Setting station	Ruang perawatan nifas 1. Tempat tidur pasien 1. Klien standar 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Wastafel/handrub 5. Meja alat edukasi 6. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Sarung tangan bersih bila perlu 2. Handrub/hand sanitizer 3. Lembar edukasi pulang 4. Lembar jawaban peserta 5. Alat tulis 6. Model atau kartu pilihan KB pasca persalinan 7. Pembalut nifas contoh 8. Media edukasi tanda bahaya
12	Penulis	Ns. Bestfy Anitasari, M.Kep., Sp. Kep. Mat

No.	Komponen	Isi
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Nursing and Midwifery Council. (2018). <i>The code: Professional standards of practice and behaviour for nurses, midwives and nursing associates</i>. https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code.pdf OpenStax. (2024). <i>Transition and continuity of care</i>. In <i>Medical-surgical nursing</i>. LibreTexts. https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nursing/Medical-Surgical_Nursing_%28OpenStax%29/36%3A_Home_Health_Nursing_and_Rehabilitation/36.04%3A_Transition_and_Continuity_of_Care Pan American Health Organization. (2022, March 30). <i>WHO urges quality care for women and newborns in the critical first weeks after childbirth</i>. https://www.paho.org/en/news/30-3-2022-who-urges-quality-care-women-and-newborns-critical-first-weeks-after-childbirth

**SOP EDUKASI PERENCANAAN PULANG DAN PELAYANAN KESEHATAN
REPRODUKSI PASCA PERSALINAN**

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: handrub, lembar edukasi pulang, media konseling KB, alat tulis, dan lembar dokumentasi				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu				
C	Tahap Kerja (sistematis)				
10	Melakukan hand hygiene				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
11	Mengkaji tanda vital, perdarahan, nyeri, eliminasi, ambulasi, tidur, nutrisi, dan luka				
12	Mengkaji laktasi/menyusui, dukungan keluarga, serta kesiapan ibu menerima edukasi				
13	Menjelaskan tujuan perencanaan pulang dan pentingnya kontrol nifas				
14	Menjelaskan perawatan diri di rumah: kebersihan diri, istirahat, nutrisi, hidrasi, mobilisasi, dan aktivitas aman				
15	Menjelaskan perawatan luka perineum/luka operasi sesuai kondisi ibu				
16	Menjelaskan pola lochia normal dan perubahan yang perlu diwaspadai				
17	Menjelaskan dukungan menyusui, masalah laktasi umum, dan kapan meminta bantuan				
18	Menjelaskan kapan hubungan seksual dapat dipertimbangkan kembali sesuai kondisi klinis dan kenyamanan ibu				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
19	Memberikan konseling kesehatan reproduksi pasca persalinan dan pilihan KB yang sesuai				
20	Membantu ibu memilih metode kontrasepsi secara sadar sesuai kondisi menyusui dan rencana reproduksi				
21	Menjelaskan jadwal kontrol ibu dan bayi serta akses fasilitas kesehatan terdekat				
22	Menjelaskan tanda bahaya masa nifas dan kesehatan mental ibu yang harus segera dilaporkan				
23	Meminta ibu/keluarga mengulang kembali informasi penting (teach-back)				
24	Merapikan alat dan memastikan kebutuhan pulang sudah dipahami				
25	Melakukan hand hygiene setelah tindakan				
D	Tahap Terminasi				
26	Menyimpulkan kegiatan				
27	Mengevaluasi respons ibu secara subjektif dan objektif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
28	Memberikan reinforcement positif				
29	Membuat kontrak tindak lanjut/kontrol				
30	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
31	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, edukasi, keputusan KB, respons ibu, dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
32	Aman, nyaman, teliti, empatik, responsif, dan menghormati keputusan ibu				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: PERENCANAAN PULANG DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PASCA PERSALINAN

No.	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Pengkajian keperawatan	Menggali kesiapan pulang, status nifas, laktasi, dukungan keluarga, serta kebutuhan edukasi reproduksi					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan masalah prioritas dan menyusun rencana edukasi yang relevan					2	
3	Implementasi keperawatan	Melakukan edukasi perencanaan pulang dan konseling kesehatan reproduksi/KB secara tepat dan sistematis					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, privasi, empati, keselamatan pasien, dan etika					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor: 0 = tidak dilakukan; 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap; 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap; 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis.

Rubrik Penilaian OSCE Keperawatan

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
Pengkajian keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus kesiapan pulang	Pengkajian sangat terbatas dan	Pengkajian cukup baik namun masih ada	Pengkajian lengkap, sistematis, dan mampu

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
	atau data tidak relevan.	tidak sistematis.	data penting yang terlewat.	mengidentifikasi kebutuhan edukasi prioritas.
Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Diagnosis tidak sesuai dan rencana tidak tersusun.	Diagnosis ada tetapi kurang tepat; rencana sangat terbatas.	Diagnosis cukup tepat dan rencana cukup sesuai tetapi belum lengkap.	Diagnosis prioritas tepat dan rencana edukasi/intervensi lengkap, relevan, dan realistis.
Implementasi keperawatan	Tidak melakukan edukasi yang sesuai atau tindakan berisiko.	Edukasi dilakukan terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan.	Edukasi cukup baik, sebagian besar langkah benar, namun masih kurang lengkap.	Edukasi dilakukan tepat, aman, sistematis, termasuk teach-back, tanda bahaya, dan konseling KB sesuai kondisi ibu.
Perilaku profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak menjaga privasi/keamanan.	Sebagian kecil perilaku profesional tampak, namun komunikasi dan keselamatan kurang.	Perilaku profesional cukup baik dengan kekurangan kecil.	Perilaku profesional konsisten: empatik, etis, teliti, komunikatif, dan berorientasi keselamatan.

Global Performance

Tidak Lulus	Borderline	Lulus	Superior

Jumlah total skor _____ Nilai akhir = _____
 (Kota), Penguji:

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung saat mahasiswa melakukan edukasi pulang pada ibu nifas di ruang perawatan atau saat kontrol nifas.
2. Menggunakan checklist singkat + umpan balik segera.
3. Keputusan akhir: kompeten / perlu supervisi / remedial.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Pasca Persalinan
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural/klinis mahasiswa pada situasi nyata.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat menyiapkan kepulangan ibu nifas dan memberikan konseling kesehatan reproduksi sebelum pasien pulang.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan integrasi pengkajian, edukasi, clinical reasoning, komunikasi, dan profesionalisme di lahan praktik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya tahu isi edukasi, tetapi juga mampu menyesuaikan materi dengan kebutuhan ibu dan keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di layanan maternitas.	Ibu hari ke-2 pasca persalinan akan pulang, masih membutuhkan edukasi perawatan diri, tanda bahaya, kontrol, dan KB pasca persalinan.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik utuh dari awal sampai penutupan edukasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, menilai kesiapan pulang, menjelaskan perawatan nifas, konseling KB, lalu memverifikasi pemahaman keluarga.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Pasca Persalinan
Aspek yang dinilai	Pengkajian, penalaran klinik, edukasi, komunikasi terapeutik, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa dapat menjelaskan tanda bahaya, kontrol, perawatan luka, laktasi, dan pilihan kontrasepsi dengan benar.
Umpan balik	Diberikan segera, singkat, spesifik, dan berorientasi perbaikan.	Contoh: mahasiswa sudah baik pada komunikasi, namun perlu memperjelas teach-back dan dokumentasi keputusan KB.
Keputusan penilaian	Menentukan tingkat performa mahasiswa di lahan.	Mahasiswa dinyatakan kompeten bila mampu melakukan edukasi pulang secara aman, runtut, komunikatif, dan sesuai kebutuhan pasien.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Topik Ini
Hakikat portofolio	Portofolio adalah kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi secara bertahap dan berkelanjutan.	Portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu menyiapkan kepulangan ibu nifas dan memberikan konseling reproduksi secara konsisten.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuannya setelah memperoleh masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	Memberi bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE menilai simulasi edukasi pulang; DOPS menilai praktik langsung saat ibu akan pulang.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan pasien, data penting, masalah, intervensi, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu nifas dengan kebutuhan edukasi perawatan diri dan kontrasepsi pasca persalinan.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahannya.	Mahasiswa merefleksikan risiko perdarahan, infeksi luka, kegagalan laktasi, atau keterlambatan mengenali depresi pasca persalinan.
Feedback CI/dosen	Menjadi bukti pembinaan dan area perbaikan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa komunikatif, namun

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Topik Ini
		perlu lebih teliti mendokumentasikan teach-back dan rencana kontrol.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tampak dalam performa berulang.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan edukasi pulang di berbagai situasi klinik.

Tabel 6. 1 Case Report pada Perencanaan Pulang dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pasca Persalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Topik Ini
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa menyusun laporan tentang ibu pascapersalinan yang membutuhkan edukasi pulang dan konseling KB.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan data pengkajian, masalah, intervensi, implementasi, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan data nifas, kebutuhan edukasi, keputusan KB, dan respons ibu setelah edukasi.
Isi laporan	Identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran.	Laporan memuat status luka, lochia, laktasi, dukungan keluarga, kebutuhan kontrol, dan pilihan kontrasepsi ibu.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, logika penalaran klinik, relevansi intervensi, dan evaluasi hasil.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data dengan kebutuhan edukasi prioritas secara tepat.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Topik Ini
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning, dokumentasi, dan refleksi praktik.	Mahasiswa belajar bahwa discharge planning harus individual, tidak generik, dan harus diverifikasi pemahamannya.
Makna dalam OBE	Bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke analisis kasus nyata secara sistematis.	Mahasiswa membuktikan kemampuan klinis sekaligus tanggung jawab dokumentasi.

Tabel 6. 2 Refleksi Patient Safety pada Perencanaan Pulang dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pasca Persalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Topik Ini
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa keputihan ibu tanpa edukasi memadai dapat menyebabkan keterlambatan penanganan komplikasi nifas.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien adalah bagian dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa edukasi yang kurang jelas dapat membahayakan ibu dan bayi di rumah.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran.	Mahasiswa menuliskan risiko perdarahan, infeksi, masalah menyusui, depresi pasca persalinan, dan kegagalan tindak lanjut KB.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien bila tidak dikenali.	Perdarahan berlebih, demam, luka bernanah, tekanan darah tinggi, nyeri kepala berat, atau putus obat/putus kontrol.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Topik Ini
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Teach-back, pemberian kontak layanan, jadwal kontrol tertulis, edukasi tanda bahaya, dan melibatkan keluarga.
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari dan pengaruhnya pada praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari pentingnya komunikasi sederhana, verifikasi pemahaman, dan dokumentasi keputusan ibu.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan berpikir kritis.	Mahasiswa membuktikan tidak hanya mampu melakukan tindakan, tetapi juga mengevaluasi risikonya.

Q. RINGKASAN

Perencanaan Pulang dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pasca Persalinan

Bab ini menekankan bahwa kepulangan ibu pascapersalinan merupakan fase transisi klinik yang harus dikelola secara aman, terencana, dan berpusat pada kebutuhan ibu serta keluarga. Perencanaan pulang dimulai sejak awal perawatan dan bertujuan memastikan ibu siap secara fisik, psikologis, sosial, dan edukatif sebelum melanjutkan perawatan di rumah. Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada ibu pascapersalinan tidak cukup hanya melihat kondisi umum dan tanda vital, tetapi juga harus menilai involusi uterus, perdarahan, lochia, nyeri, luka perineum atau operasi, eliminasi, ambulasi, nutrisi, istirahat, laktasi, kesehatan mental, dukungan keluarga, akses kontrol, serta kebutuhan kesehatan reproduksi. Penilaian ini menjadi dasar untuk menentukan apakah ibu siap pulang dan edukasi apa yang paling dibutuhkan.

Pelayanan kesehatan reproduksi pascapersalinan mencakup edukasi masa nifas, aktivitas seksual sehat, konseling kontrasepsi, dukungan menyusui, serta pengenalan tanda bahaya. Ibu perlu mengetahui cara merawat diri di rumah, kapan harus kembali kontrol, bagaimana mengenali masalah menyusui, serta pilihan KB yang sesuai dengan status menyusui dan rencana reproduksi. Kualitas edukasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat berkomunikasi secara sederhana, empatik, dan menghormati keputusan ibu. Alur asuhan dimulai dari pengkajian

kesiapan pulang, dilanjutkan dengan identifikasi masalah prioritas seperti defisit pengetahuan, nyeri akut, risiko infeksi, gangguan laktasi, atau kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Setelah itu, perawat menyusun dan melaksanakan edukasi yang terstruktur, memverifikasi pemahaman ibu melalui teach-back, mendokumentasikan keputusan penting, serta memastikan terdapat rencana tindak lanjut yang realistis.

Inti pembelajaran pada bab ini adalah bahwa discharge planning dan pelayanan kesehatan reproduksi pascapersalinan harus dilakukan secara individual, tidak generik, dan selalu berorientasi pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori masa nifas, tetapi juga mampu mengedukasi, melakukan eskalasi bila ada red flags, serta berkolaborasi agar ibu dan bayi tetap aman setelah pulang.

Temuan Klinis	Tindakan
Perdarahan postpartum meningkat	Eskalasi segera dan evaluasi hemodinamik
Tekanan darah >140/90 mmHg	Observasi preeklampsia postpartum
Bayi tidak menyusu	Evaluasi neonatal dan observasi laktasi
Ikterus progresif	Rujuk pemeriksaan bilirubin

Tabel 6. 3 Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan banyak atau pembalut cepat penuh	Dapat menunjukkan perdarahan postpartum sekunder atau komplikasi lain	Segera laporkan ke tenaga kesehatan, nilai kondisi umum, dan siapkan rujukan/emergensi sesuai alur layanan
Demam, menggigil, atau lochea berbau menyengat	Mengarah pada kemungkinan infeksi masa nifas	Eskalasi segera untuk evaluasi medis dan tindak lanjut terapi
Nyeri perut hebat atau nyeri luka makin berat	Dapat menandakan infeksi, hematoma, atau komplikasi lain	Laporkan segera dan lakukan observasi lebih lanjut

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Sakit kepala hebat, pandangan kabur, bengkak mendadak, atau kejang	Tanda bahaya hipertensi/preeklamsia postpartum	Eskalasi emergensi segera sesuai protokol
Sesak napas atau nyeri dada	Dapat menandakan emboli, edema paru, atau gangguan serius lain	Aktifkan bantuan segera dan rujuk emergensi
Puting/luka payudara berat, bendungan hebat, atau mastitis	Mengganggu laktasi dan berisiko infeksi	Laporkan, beri dukungan laktasi, dan rujuk sesuai kebutuhan
Sedih berat, gelisah ekstrem, bingung, atau pikiran menyakiti diri/bayi	Mengarah pada gangguan mental pasca persalinan yang serius	Jangan tinggalkan ibu sendiri; laporkan dan rujuk segera untuk penanganan lebih lanjut
Luka operasi/perineum kemerahan, bernanah, atau terbuka	Tanda infeksi atau penyembuhan luka terganggu	Segera evaluasi, dokumentasikan, dan eskalasi
Ibu tidak dapat BAK, konstipasi berat, atau nyeri saat BAK	Menandakan gangguan eliminasi atau infeksi saluran kemih	Laporkan dan lakukan evaluasi lebih lanjut
Ibu tidak memahami sama sekali instruksi pulang atau tidak memiliki dukungan	Risiko tinggi ketidakpatuhan, putus kontrol, dan komplikasi di rumah	Tunda kepulangan bila perlu, libatkan keluarga, dan koordinasikan tindak lanjut yang aman

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab Perencanaan Pulang dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pasca Persalinan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep dasar perencanaan pulang pada ibu pasca persalinan.	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus kesiapan pulang pada ibu nifas.	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengkaji perdarahan, lochia, nyeri, eliminasi, dan ambulasi.	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengkaji kondisi luka perineum atau luka operasi.	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menilai kesiapan laktasi dan kebutuhan dukungan menyusui.	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengenali kebutuhan edukasi kesehatan reproduksi pasca persalinan.	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya masa nifas kepada ibu dan keluarga.	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa memberikan edukasi perawatan diri di rumah secara sistematis.	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menjelaskan jadwal kontrol ibu dan bayi.	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan konseling dasar KB pasca persalinan sesuai kondisi menyusui.	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menggunakan teach-back untuk memverifikasi pemahaman ibu.	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa menentukan kapan perlu melakukan eskalasi atau melapor.	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan ibu dan keluarga.	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat discharge planning secara tepat.	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan empatik.	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Agency for Healthcare Research and Quality. (2015). *AHRQ health literacy universal precautions toolkit* (3rd ed.). In C. Brach (Ed.). <https://psnet.ahrq.gov/issue/ahrq-health-literacy-universal-precautions-toolkit-2nd-edition>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2018). *Optimizing postpartum care*. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2018/05/optimizing-postpartum-care>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2019). *Interpregnancy care*. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/obstetric-care-consensus/articles/2019/01/interpregnancy-care>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period*. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/04/physical-activity-and-exercise-during-pregnancy-and-the-postpartum-period>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). *Practice advisory to update the duration of breastfeeding*. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2023/02/duration-of-breastfeeding-update>
- Benitz, W. E. (2015). Hospital stay for healthy term newborn infants. *Pediatrics*, 135(5), 948–953. <https://publications.aap.org/pediatrics/article/135/5/948/33740/Hospital-Stay-for-Healthy-Term-Newborn-Infants>
- Bingham, D., Jones, R., Howell, E. A., & Chervenak, J. (2022). Scoping review of postpartum discharge education provided by nurses. *MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0884217522000326>
- California Perinatal Quality Care Collaborative. (2025). *Postpartum discharge education guide for nurses*. <https://cpcqc.org/wp-content/uploads/2025/07/Discharge-check-list.pdf>
- Centers for Medicare & Medicaid Services. (2023). *42 CFR § 482.43 Condition of participation: Discharge planning*. Electronic Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-42/chapter-IV/subchapter-G/part-482/subpart-C/section-482.43>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Urgent maternal warning signs and symptoms*. <https://www.cdc.gov/hearher/maternal-warning-signs/index.html>

- Gonçalves-Bradley, D. C., & Lannin, N. A. (2012). Discharge planning. *International Journal of Integrated Care*, 12(Spec Ed Integrated Care Pathways), e043. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1873959812000695>
- HRSA. (2024). *Newborn screening information center*. <https://newbornscreening.hrsa.gov/>
- International Confederation of Midwives. (2024). *ICM essential competencies for midwifery practice*. <https://www.internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN-ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf>
- Kemper, A. R., Newman, T. B., Slaughter, J. L., Maisels, M. J., Watchko, J. F., Downs, S. M., Grout, R. W., Bundy, D. G., Stark, A. R., Bogen, D. L., Cashore, W. J., Hamrick, S. E. G., Martin, C. R., & Bhutani, V. K. (2022). Clinical practice guideline revision: Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. *Pediatrics*, 150(3), e2022058859. <https://publications.aap.org/pediatrics/article/150/3/e2022058859/188726/Clinical-Practice-Guideline-Revision-Management-of>
- Mitchell, K. B., Johnson, H. M., Rodríguez, J. M., Eglash, A., Scherzinger, C., Zakarija-Grković, I., Cash, K. W., Berens, P., & Miller, B. (2022). Academy of Breastfeeding Medicine clinical protocol #36: The mastitis spectrum, revised 2022. *Breastfeeding Medicine*, 17(5), 360–376. <https://www.bfmed.org/assets/ABM%20Protocol%20%2336.pdf>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2015, updated 2020). *Diabetes in pregnancy: Management from preconception to the postnatal period* (NICE Guideline NG3). <https://www.nice.org.uk/guidance/ng3>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2016). *Contraception* (Quality standard QS129). <https://www.nice.org.uk/guidance/qs129>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2021). *Postnatal care* (NICE Guideline NG194). <https://www.nice.org.uk/guidance/ng194>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2022). *Postnatal care* (Quality standard QS37). <https://www.nice.org.uk/guidance/qs37/resources/postnatal-care-pdf-2098611282373>
- NHS England. (2026). *Improving postnatal care: A toolkit for integrated care boards, partners and providers*. <https://www.england.nhs.uk/long-read/improving-postnatal-care-a-toolkit-for-integrated-care-boards-partners-and-providers/>
- Nursing and Midwifery Council. (2018). *The code: Professional standards of practice and behaviour for nurses, midwives and nursing associates*. <https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code.pdf>

- OpenStax. (2024). *Transition and continuity of care*. In *Medical-surgical nursing*. LibreTexts. [https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nursing/Medical-Surgical Nursing %28OpenStax%29/36%3A Home Health Nursing and Rehabilitation/36.04%3A Transition and Continuity of Care](https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nursing/Medical-Surgical_Nursing_%28OpenStax%29/36%3A_Home_Health_Nursing_and_Rehabilitation/36.04%3A_Transition_and_Continuity_of_Care)
- Pan American Health Organization. (2022, March 30). *WHO urges quality care for women and newborns in critical first weeks after childbirth*. <https://www.paho.org/en/news/30-3-2022-who-urges-quality-care-women-and-newborns-critical-first-weeks-after-childbirth>
- U.S. Department of Health and Human Services. (2025). *Telehealth and postpartum care*. Telehealth.HHS.gov. <https://telehealth.hhs.gov/providers/best-practice-guides/telehealth-for-maternal-health-services/telehealth-and-postpartum-care>
- Whiteman, M. K., Zapata, L. B., Curtis, K. M., Tepper, N. K., Jamieson, D. J., Marchbanks, P. A., & Morrow, B. (2024). *U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use, 2024. MMWR Recommendations and Reports, 73*(4), 1–126. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/rr/rr7304a1.htm>
- World Health Organization. (2013). *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. <https://www.who.int/publications/b/31321>
- World Health Organization. (2016). *Guideline: Iron supplementation in postpartum women*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549585>
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>
- World Health Organization. (2024). *Danger signs: Baby danger signs mother* (Parent guide). <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mca-documents/nbh/enc-course/revised-resources/core-materials/web-who-enc-2---parent-guide---international---may-2024.pdf>
- World Health Organization. (2025). *Scaling up postpregnancy family planning: Practical guide*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240111073>

Profil Penulis



Ns. Hairunnisa, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Sintang, Kalimantan Barat, 10 Januari 1983. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan bapak M.Jupridin dan ibu Siti Hamisah. Pendidikan yang di tempuh oleh penulis yaitu pendidikan formal pada program kelas khusus (S1) keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan program magister (S2) pada pasca Sarjana Keperawatan Peminatan Maternitas di FIK UMJ. Pengalaman bekerja penulis yaitu di Akper Pemprov Kalbar di Sintang tahun 2007 – 2011, Politeknik Hang Tuah Jakarta sejak Mei 2011 – September 2024, STIKes Persada Husada Indonesia sejak Oktober 2024 sampai dengan sekarang. Penulis aktif sebagai penulis buku dan publikasi ilmiah, pembicara/pengajar bimbel UKOM, mengajar di prodi keperawatan, Prodi Administrasi Rumah Sakit, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan serta konselor laktasi dari Sentra Laktasi Indonesia (SELASI). Penulis dapat di hubungi melalui e-mail hairunnisaku@gmail.com

Motto : “Mendidik dengan hati, membina dengan rasa, mengukir dengan cinta”



Ns. Yuli Erlina, S.Kep., M.Kes.

Lahir pada 08 Juli 1979 di Batam Kepulauan Riau. Menyelesaikan Pendidikan D III Akademi Keperawatan RSIJ (2000), S1 Ners di UMJ lulus 2003. Melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia lulus 2012. Sejak Tahun 2005 mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan di Universitas Batam, Akper Yang Tuah Tanjung Pinang (2006), Stikes Ilmu Kesehatan Medika Cikarang, (2009-2020) dan saat ini Penulis aktif mengajar di Akademi Keperawatan RS Efarina. Penulis dapat di hubungi melalui Email, yulierlina554@gmail.com Motto : InsyaAllah, Alloh bantu urusan kita

Profil Penulis



Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

lahir di Jakarta 01 Januari 1974. Telah menyelesaikan studi DIII Keperawatan RS Islam Jakarta, strata satu di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (1998-2001). Lulus strata dua di Program Studi Ilmu Keperawatan dan Spesialis Maternitas Universitas Indonesia (2010-2014). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Akper Hermina Manggala Husada (2001-sekarang). Pernah menjabat Direktur (2014-2020). Ketua UPMI (2021- 2023). Saat ini sudah berubah perguruan tinggi menjadi Institut Kesehatan Hermina Pengampu mata kuliah Maternitas 1,2, Promosi Kesehatan, KDK. Jenjang Jabatan Akademik : Lektor Kepala , Organisasi yang diikuti PPNI Komisariat RS Hermina jatinegara, IPEMI DKI Jakarta, ILUNI UI FIK UI, WEC UI , DKLPT, ADI. Dosen Optimal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: suryanihartati02@gmail.com



Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.

lahir di Jombang Jawa Timur, 15 Maret 1963. Lulus Akper Soetomo Surabaya tahun 1992. Tahun 1994 lulus program Bidan di Akper Sutopo Surabaya, lulus dari PSIK UNPAD Bandung tahun 2000, menyelesaikan Magister KIA Kespro di UGM Jogjakarta tahun 2007. Terakhir mengikuti Pendidikan Doktorat Kesehatan di UNAIR tahun 2016. Penulis tinggal di Kabupaten Jombang Prov. Jatim. Karir penulis diawali mulai sebagai ASN di DinKes Kabupaten Jombang dan ditempatkan di Puskesmas tahun 1984 sampai 1994, selanjutnya pindah ke SPK Pemkab Jombang sampai tahun 2006. Tahun 2016 pindah ke Departemen Riset dan Teknologi dan ditempatkan di Stikes Pemkab Jombang dengan tugas tambahan sebagai Kaprodi Sarjana Keperawatan, tahun 2016 sebagai Wakil 1 Bidang Akademik sampai tahun 2023, saat ini sebagai dosen Prodi S 1 Keperawatan Stikes Pemkab Jombang dengan jabatan fungsional Lektor. Penulis memberikan kuliah Maternitas, manajemen dan Metodologi, serta membimbing mahasiswa profesi ners. Aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis tersertifikasi dosen dan aktif sebagai fasilitator kegiatan Perchepthorship yang dilakukan oleh Kemenkes melalui Badan Diklat DPW PPNI Provinsi Jawa timur. Penulis juga aktif di DPW PPNI Provinsi Jawa Timursaat ini sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan periode 2022-2026, sekaligus sebagai wakil Ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI). Sebagai Ketua Dewas di RSKM Jombang, selain itu juga aktif di Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai sekretaris untuk wilayah Mojokerto-Jombang. Email: sestu.retno@yahoo.com

Profil Penulis



Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Lahir di Kediri, 20 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan S3 pada Prodi Doktoral Ilmu Kedokteran Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 bekerja di RS.William booth Surabaya, tahun 1992 bekerja di RS Catherine Booth Makasar, tahun 1995 bekerja di STIKES William Booth Surabaya hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIKES William Booth Surabaya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan gerontik, Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional terindeksi sinta maupun internasional terindeks scopus, pembicara seminar nasional maupun internasional, serta mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat dari kemnristekdikti . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ethyca.sari@yahoo.com Motto: "Success begins with self-belief"



Ns. Bestfy Anitasari, M.Kep. Sp. Kep. Mat, Ph.D.

lahir di Soppeng 01 Desember 1984. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Muchtar, S.Pd (Alm) dan Tahira (almh). Meraih gelar sarjana keperawatan pada Tahun 2007 dan gelar Ners pada Tahun 2008 di Universitas Hasanuddin. Kemudian mencapai gelar Magister Keperawatan pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 mencapai gelar Ners Spesialis Keperawatan Maternitas di Universitas Indonesia. Di tahun 2026 mencapai gelar Philosophy of Doctor dalam bidang keperawatan (PhD in Nursing) di Philippine Women's University. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Kurnia Jaya Persada Palopo. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan maternitas, Kesehatan Reproduksi dan Keperawatan Anak. Motto: Hidup adalah proses belajar tanpa akhir; setiap kesulitan mengajarkan kesabaran, setiap kegagalan mengajarkan keteguhan, dan setiap keberhasilan mengajarkan rasa syukur.

Sinopsis

Buku Ajar *Keperawatan Maternitas* ini disusun sebagai sumber pembelajaran yang sistematis, komprehensif, dan aplikatif bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami serta menerapkan asuhan keperawatan pada ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam keperawatan maternitas, mulai dari asuhan keperawatan persalinan kala I, asuhan pada kala IV dan nifas dini, perawatan nifas lanjut yang mencakup laktasi dan kesehatan mental ibu, penanganan kegawatdaruratan maternal, asuhan dasar neonatus, hingga perencanaan pulang dan pelayanan kesehatan reproduksi pasca persalinan. Seluruh materi disajikan untuk membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman teoritis, keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan yang aman, holistik, humanis, dan berpusat pada ibu, bayi, serta keluarga.

Pada bagian awal, buku ini menguraikan asuhan keperawatan persalinan kala I dengan menekankan pentingnya pengkajian kondisi ibu dan janin, pemantauan kemajuan persalinan, manajemen nyeri, dukungan emosional, serta komunikasi terapeutik selama proses persalinan. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan pada asuhan keperawatan kala IV dan nifas dini yang berfokus pada pemantauan kondisi ibu setelah persalinan, meliputi tanda-tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan, kenyamanan ibu, serta deteksi dini terhadap kemungkinan komplikasi. Buku ini juga membahas asuhan keperawatan nifas lanjut, khususnya terkait keberhasilan laktasi, teknik menyusui, masalah umum dalam pemberian ASI, serta kesehatan mental ibu pascapersalinan, termasuk pengenalan baby blues, kecemasan, dan depresi postpartum.

Selain membahas asuhan rutin, buku ini juga menyajikan materi mengenai kegawatdaruratan maternal, khususnya perdarahan postpartum dan syok, yang merupakan kondisi serius dan memerlukan penanganan cepat, tepat, serta kolaboratif. Pembahasan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai deteksi dini, tindakan keperawatan awal, prinsip keselamatan pasien, serta pentingnya kerja sama tim dalam mencegah komplikasi yang mengancam jiwa ibu. Pada aspek keperawatan neonatus, buku ini menjelaskan adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar rahim, pengkajian awal neonatus, pencegahan hipotermia, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pemantauan tanda bahaya, serta pemberian asuhan dasar yang mendukung keselamatan dan kesehatan bayi.

Pada bagian akhir, buku ini membahas perencanaan pulang dan pelayanan kesehatan reproduksi pasca persalinan sebagai bagian penting dari kesinambungan asuhan keperawatan. Materi ini mencakup edukasi perawatan ibu nifas dan bayi di rumah, pengenalan tanda bahaya, jadwal kunjungan ulang, konseling menyusui, serta pelayanan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga setelah persalinan. Dengan penyajian materi yang terarah dan sesuai kebutuhan pembelajaran, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa keperawatan, dosen, pembimbing klinik, serta praktisi keperawatan dalam meningkatkan kompetensi dan mutu pelayanan keperawatan maternitas secara profesional, beretika, dan berkesinambungan.

Buku Ajar Keperawatan Maternitas ini disusun sebagai sumber pembelajaran yang sistematis, komprehensif, dan aplikatif bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami serta menerapkan asuhan keperawatan pada ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam keperawatan maternitas, mulai dari asuhan keperawatan persalinan kala I, asuhan pada kala IV dan nifas dini, perawatan nifas lanjut yang mencakup laktasi dan kesehatan mental ibu, penanganan kegawatdaruratan maternal, asuhan dasar neonatus, hingga perencanaan pulang dan pelayanan kesehatan reproduksi pasca persalinan. Seluruh materi disajikan untuk membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman teoritis, keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan yang aman, holistik, humanis, dan berpusat pada ibu, bayi, serta keluarga.

Pada bagian awal, buku ini menguraikan asuhan keperawatan persalinan kala I dengan menekankan pentingnya pengkajian kondisi ibu dan janin, pemantauan kemajuan persalinan, manajemen nyeri, dukungan emosional, serta komunikasi terapeutik selama proses persalinan. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan pada asuhan keperawatan kala IV dan nifas dini yang berfokus pada pemantauan kondisi ibu setelah persalinan, meliputi tanda-tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan, kenyamanan ibu, serta deteksi dini terhadap kemungkinan komplikasi. Buku ini juga membahas asuhan keperawatan nifas lanjut, khususnya terkait keberhasilan laktasi, teknik menyusui, masalah umum dalam pemberian ASI, serta kesehatan mental ibu pascapersalinan, termasuk pengenalan baby blues, kecemasan, dan depresi postpartum.

Selain membahas asuhan rutin, buku ini juga menyajikan materi mengenai kegawatdaruratan maternal, khususnya perdarahan postpartum dan syok, yang merupakan kondisi serius dan memerlukan penanganan cepat, tepat, serta kolaboratif. Pembahasan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai deteksi dini, tindakan keperawatan awal, prinsip keselamatan pasien, serta pentingnya kerja sama tim dalam mencegah komplikasi yang mengancam jiwa ibu. Pada aspek keperawatan neonatus, buku ini menjelaskan adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar rahim, pengkajian awal neonatus, pencegahan hipotermia, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pemantauan tanda bahaya, serta pemberian asuhan dasar yang mendukung keselamatan dan kesehatan bayi.

Pada bagian akhir, buku ini membahas perencanaan pulang dan pelayanan kesehatan reproduksi pasca persalinan sebagai bagian penting dari kesinambungan asuhan keperawatan. Materi ini mencakup edukasi perawatan ibu nifas dan bayi di rumah, pengenalan tanda bahaya, jadwal kunjungan ulang, konseling menyusui, serta pelayanan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga setelah persalinan. Dengan penyajian materi yang terarah dan sesuai kebutuhan pembelajaran, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa keperawatan, dosen, pembimbing klinik, serta praktisi keperawatan dalam meningkatkan kompetensi dan mutu pelayanan keperawatan maternitas secara profesional, beretika, dan berkesinambungan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-52-7 (PDF)



9

786347

756527